

Compiladores:

CARLOS E. SLUZKI

ISIDORO BERENSTEIN

HUGO H. BLEICHMAR

IGNACIO MALDONADO ALLENDE

Patología y terapéutica del grupo familiar

Actas del Primer Congreso Argentino de Psicopatología
del Grupo Familiar
Buenos Aires, junio de 1970

acta

FONDO PARA LA
SALUD MENTAL

Buenos Aires, 1970

Índice general

Prólogo	11
Palabras de apertura del Congreso. (<i>Carlos E. Sluzki</i>)	13

Relatos y correlatos especiales

Familia y estructura familiar. Consideraciones clínicas, teóricas y técnicas. (<i>Isidoro Berenstein</i>)	17
Correlato del trabajo: "Familia y estructura familiar", del doctor Isidoro Berenstein. (<i>Guillermo Ferschtut</i>)	37
Correlato del trabajo: "Familia y estructura familiar", del doctor Isidoro Berenstein.	
Un modelo transaccional de las relaciones familiares del paciente esquizofrénico. (<i>Cloë Madanes Sojit</i>)	46
Terapia familiar. Un cambio radical. (<i>Jay Haley</i>)	57
Correlato sobre el trabajo "Terapia familiar. Un cambio radical", de Jay Haley.	
Consideraciones acerca de la articulación de lo intrapsíquico y lo interpersonal y sobre el <i>insight</i> en la terapia familiar. (<i>Hugo B. Bleichmar</i>)	71
El doble vínculo como situación patogénica universal. (<i>Carlos E. Sluzki</i>)	78
Correlato del trabajo "El doble vínculo como situación patogénica universal", de Carlos E. Sluzki. (<i>Jorge Canestri</i>)	91
Correlato del trabajo de Carlos E. Sluzki "El doble vínculo como situación patogénica universal". (<i>Harold A. Hammond</i>)	98
Los esquizofrénicos y sus familias. Orientaciones y hallazgos de investigaciones recientes. (<i>Lyman C. Wynne</i>)	103
Correlato del trabajo "Los esquizofrénicos y sus familias", de Lyman C. Wynne. (<i>Janine Puget</i>)	117

Conferencias especiales

Psicoterapia familiar de impacto múltiple. (*Harold A. Goolishian*) 125

Una teoría del abordaje de la prevención en el grupo familiar. (*Enrique J. Pichon Rivière*) 136

Técnicas terapéuticas

Diagnóstico situacional-histórico para la planificación terapéutica con encuadre familiar. (*Valentín Arroyo, Osvaldo Devries, Lilian Fisher y Norma Schwartz*) 143

Encuadre familiar. (*Valentín Arroyo, Lilian Fisher, María R. Moré, Virginia Schejter, Silvia Weingierman y Silvia Zeigner*) 145

Notas sobre técnica en psicoterapia de grupo familiar. (*Sara P. de Berenstein, Alberto G. Marticorena y Norberto C. Marucco*) 148

Terapia familiar en comunidad terapéutica. Grupo familiar múltiple y grupo familiar nuclear. (*J. E. García Badaracco, N. Proverbio y A. A. Canevaro*) 150

Dramatización de afectos en situaciones límites. Una técnica de laboratorio para la resolución de crisis familiares. (*Florinda S. de Glocer*) 153

Algunos aspectos de la psicoterapia de familia según Bowen. (*Javier Horacio Gurvich*) 160

Motivo de indicación de grupo psicoterapéutico familiar. (*Martha Frydman de Lerman*) 165

El análisis de las relaciones de dinero como técnica de abordaje para el tratamiento psicológico del grupo familiar. (*Horacio C. Mac Dougall*) 167

Tratamiento de las crisis familiares. (*Beatriz A. F. Moreno y Pedro Kusmin*) 169

Grupo familiar con niños

La psicopatología del grupo familiar y el hijo adoptivo. (*Susana M. E. Blanco*) 175

La psicoterapia del binomio madre-hijo en la simbiosis patológica. (*Emilce Dio de Bleichmar*) 177

La orientación psicológica de padres como factor de cambio en las relaciones familiares. (*Fanny Levinton de Baranchuk*) 182

Un enfoque para el diagnóstico del grupo familiar con niños. (*Mabel M. de Burin, Dora V. de Saráchaga y Carol D. de Hosne*) 184

Estudio comparativo del dibujo "Mi familia" en 20 preescolares con presencia o ausencia de trastornos de conducta. (*B. García Casal, F. E. Moisin y E. H. Pontoriero*) 189

Funcionalidad del niño psicótico en la familia. (*Juana B. de Guiter y Beatriz B. de Berger*) 198

Comentario de entrevistas realizadas a dos familias con niños mellizos. (*Lidia K. de Ravaschino y Raquel Soifer*) 200

Elección de la psicoterapia de grupo familiar con niños. Posibilidades que ofrece en la práctica clínica. (*Graciela F. de Resnicoff*) 203

Fundamentos de la psicoterapia familiar con niños y juguetes. (*Raquel Soifer*) 206

Posibilidades del grupo familiar con niños como elaborador para una tarea de psicohigiene: el problema de la desprotección de la familia contemporánea. (*Raquel Soifer y Graciela F. de Resnicoff*) 211

Algunas consideraciones sobre la psicoterapia del vínculo madre-hijo. (*Ana Lia Kornblit, Jaime S. Szwarcstein, Isabel Barreiro y Susana M. Bendersky*) 214

Grupo familiar con miembros psicóticos

La reacción terapéutica negativa y la influencia familiar. (*J. E. García Badaracco y A. A. Canevaro*) 221

La coterapia y el grupo familiar. (*J. E. García Badaracco, A. A. Canevaro y O. Czertok*) 226

Las alianzas familiares en las terapias de familias de psicóticos. (*J. E. García Badaracco, A. Canevaro y O. Czertok*) 230

Comentarios sobre una experiencia clínica con un grupo plurifamiliar de familias con miembros psicóticos. (*Eduardo Mandelbaum, Beatriz Alazraqui y Silvia Koziol*) 232

Patología familiar y esquizofrenia. Un caso clínico. (*Edmundo Zimmerman y José Kuten*) 235

Parejas

Test interpersonal proyectivo para parejas (TIPP). (*Hugo Bleichmar, Carlos E. Sluzki y Gloria Smola*) 241

"Los inviolables": Una pareja y su mito. (*María L. L. de Schugrensky, Helena Lygo y Samuel Krynski*) 247

Tema general

Las variables tiempo-casa-identidad en algunos grupos familiares. (<i>Gisela G. de Ahlin y Jaime S. Szwarstein</i>)	255
Psicoterapia de grupo familiar: Una aproximación teórica. (<i>Sara P. de Berenstein, Alberto G. Marticorena y Norberto C. Marucco</i>)	259
Patología del carácter y estructura familiar. (<i>Mario Fuks y Alberto Goldin</i>)	263
Intento de aplicación del análisis fenomenológico al psicodiagnóstico y psicoterapia del grupo familiar. (<i>Stella M. A. de Jiménez de Asúa</i>)	269
Comunicación de una experiencia de grupo familiar en un hospital psiquiátrico. (<i>Luis Giménez y Miciadés Soto</i>)	272
Análisis de un grupo familiar en una obra teatral. (<i>Susana Huler, Ruth Podetti y Mario Wasserman</i>)	274
Técnica proyectiva para el diagnóstico del grupo familiar. (<i>Luis J. Juri</i>)	276
Familia marginal y desarrollo de la identidad en adolescentes mujeres. Una experiencia grupal. (<i>Diana Lerner, Eduardo Luxardo, Elisa Marino, Juan C. Nocetti, María I. Punta y Leonardo Rodríguez</i>)	282
Mito y familia. (<i>Miguel Méndez Elizalde</i>)	289
Grupo familiar e intentos suicidas en la adolescencia. Un modelo para el estudio de la agresión. (<i>O. Fernández Mouján, Roberto Illeyasof y Silvia T. de Peyrou</i>)	294
Aportes para una nosología del grupo familiar. (<i>O. Fernández Mouján y Silvia T. de Peyrou</i>)	300
Un principio homeostático de la interacción. La variable orden-desorden en los grupos familiares. (<i>Carlos E. Sluzki, Alejandro Tarnopolsky y Diana Valdemarín</i>)	307
Enfoque patogénico en la alteración de la personalidad de la familia. (<i>Héctor J. Vázquez, Susana Calero y Juan J. Vázquez</i>)	316
Pathology and therapy of the family group (Summary of the first four papers)	319
Lista de autores	

Prólogo

Este volumen contiene el material presentado en el curso del Primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, que tuvo lugar en Buenos Aires, entre los días 18 y 21 de junio de 1970.

Se transcriben in extenso los cuatro relatos, seis de los ocho correlatos y la mayoría de las aportaciones libres, y en forma resumida el resto de las aportaciones, exceptuando aquellas con las que el Comité Organizador no pudo contar por escrito.

Buena parte de lo que fue característica del Congreso, a saber, la discusión activa e interesada de los trabajos presentados, necesariamente queda excluida de estas Actas, al no haberse registrado en grabaciones las actuaciones del Congreso. Particularmente lamentable es la ausencia de las discusiones que siguieron a los relatos oficiales: el diálogo relator-correlator así como los nutridos intercambios que éstos sostuvieron posteriormente con los demás asistentes al Congreso. Tampoco aparecen en estas Actas, muy a pesar nuestro, dos correlatos: los de Eliseo Verón y Eduardo Colombo. Nuestra reiterada exhortación a que transcribieran por escrito sus intervenciones se vieron superadas por la falta de tiempo de los nombrados.

Debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento a las siguientes instituciones representativas del quehacer psiquiátrico y psicológico del país, cuyo auspicio respaldó las actuaciones del Comité Organizador del Congreso: Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Agrupación de Psicología Dinámica (Córdoba), Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Asociación Argentina de Psiquiatría Social, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Asociación de Psicólogos de La Plata, Asociación de Psiquiatras de la Capital Federal (regional de la F.A.P.), Asociación Psicoanalítica Argentina, Ateneo Psiquiátrico de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Psiquiátricas (Lanús), Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Salud Mental n° 1, Centro Piloto del Hospital Esteves (Lomas de Zamora), Instituto Bene Berith de Orientación Familiar, Instituto Médico de ACTA, OSE Argentina, Primera Escuela Privada de Psicología Social, Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico Aráoz Alfaro (Lanús), Sociedad Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach, Sociedad Interamericana de Psicología —rama Argentina—, Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática (A.M.A.).

C.E.S.
I.B.
H.R.B.
I.M.A.

Palabras de apertura del Congreso

CARLOS E. SLUZKI

Estimados colegas:

Cada paso que se da en un nuevo camino que se explora permite entrever el monto de la propia ignorancia, la magnitud del camino a recorrer, las múltiples bifurcaciones de su curso, y activa el ineludible duelo por el tiempo perdido en la acumulación de conceptos irrelevantes con que camouflamos los interrogantes sin responder. Sólo la fascinación que depara la exploración, la experiencia renovada del descubrimiento, y el convencimiento de que se está participando en un proceso de cambio apoya y justifica el esfuerzo de recorrerlo.

No es tarea fácil trabajar en el tema "familia". No sabemos bastante, queda mucho por explorarse, se anticipan muchas disyuntivas claves de las que a priori no puede preverse respuesta, y se debe lanzar por la borda un monto importante de información acumulada, a veces pertinente para otro campo pero irrelevante para éste, a veces no pertinente, de hecho, para ningún campo. Pero es fascinante trabajar en el tema "familia". El campo que abre para la comprensión de la experiencia humana es insólito, el enriquecimiento de la percepción y la posibilidad de integración de procesos hasta ahora alienados entre sí es inmenso, el potencial de cambio que encierra justifica todo esfuerzo.

El cambio se refleja en el impacto del enfoque familiar tanto sobre las teorías etiopatogénicas como sobre los criterios terapéuticos. Cuando se lo asume, se experimenta una modificación cualitativa: las cosas ya no son las mismas, tambalean muchos modelos referenciales auto-sostenidos, y se reestructura toda estrategia de acción.

Hoy comienza lo que esperamos sea una experiencia intensa. A algunos de nosotros nos tocará ocupar circunstancialmente el estrado, pero a todos nosotros nos toca escuchar. Esperemos que podamos tener la inspiración suficiente como para poder escuchar con mente clara, libre de hojarasca prejuiciosa, tino como para dejar sedimentar lo escuchado antes de tamizarlo con nuestra crítica, y valentía como para poder confrontar lo nuevo con lo conocido de una manera ecuánime.

Declaro inaugurado con estas palabras el Primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar.

Relatos y correlatos
oficiales

Familia y estructura familiar.
Consideraciones clínicas, teóricas y técnicas

ISIDORO BERENSTEIN *

0. **Introducción.** Este trabajo comprende una justificación (*ítem 1*), la presentación de un material clínico (*ítem 2*), en el que describo una de las muchas sesiones que componen un tratamiento psicoterapéutico de un grupo familiar, aportes teóricos (*ítems 3, 4, 5, 6 y 7*) en los que me dedico a construir un modelo regulador de las relaciones en la citada familia, afirmaciones técnicas (*ítem 8*) y a manera de conclusión (*ítem 9*) algunos comentarios de la sesión tomada como ejemplo. Los datos fueron obtenidos de la sesión, y de una ficha familiar registrada en entrevistas previas al tratamiento. Un extracto de la ficha figura como anexo al final. Lógicamente opera en mí la información obtenida en todas las sesiones previas y posteriores a la que nuestro.

1. **Justificación.** Las relaciones familiares son aquellas perceptibles empíricamente en diversas unidades de observación. La estructura familiar se refiere al modelo regulador de estas relaciones; al "sistema relacional latente" ¹. Un relato no es la sesión sino que la representa. La familia que tenemos ante nosotros en sesión no es la familia que sin nosotros convive diariamente sino que también la representa.

Las relaciones familiares, las relaciones conmigo y este relato guardan entre sí una relación isomórfica a nivel de su estructura con distintas transformaciones hasta llegar a este relato. Se trata de una construcción teórica compleja pero el relato de una familia acerca de sus relaciones también lo es. La idea de los integrantes acerca de su funcionamiento puede estar a una distancia mayor o menor, pero siempre a distancia del funcionamiento real. Podemos observar severas distorsiones en el funcionamiento de un grupo y sin embargo sus integrantes tener la idea de un funcionamiento coherente y armónico. En

* Instituto Médico ACTA, Santa Fe 3651, Buenos Aires.

este sentido no hay más que recordar las brillantes descripciones de las familias de esquizofrénicos basadas en los conceptos de doble vínculo y la homeostasis familiar del grupo de investigadores del Mental Research Institute de California⁵ o las descripciones de Lidz y Fleck sobre "skew families" y "schism families"¹⁰, o las de Laing⁷ y otros autores.

Al estudiar las familias debemos considerar que estamos en un tipo de organización que puede conocerse, pero nunca totalmente, a través de sucesivas aproximaciones a los diversos niveles en los cuales se expresa su estructura: el de las relaciones empíricas, el de las ideas acerca de ella, las ideas acerca de las ideas de las relaciones empíricas y así sucesivamente. Otro nivel es el de la descripción clínica y otro más el de la confección de un modelo aplicado a tal descripción.

Frecuentemente se titula a estas familias como desorganizadas; y sus integrantes pueden coincidir en este sentido con el observador.

Cuando se habla de desorganización pasamos por alto que se trata de una percepción egocéntrica, de un ego-observador que se mantiene ajeno al sistema familiar negando la existencia de un orden a nivel de su estructura y con una coherencia similar a las de otras familias, pero de un orden diferente y a nivel no perceptible a simple vista.

En definitiva cabe enmarcar nuestra tarea como eminentemente teórica, rescatando este término de la valoración peyorativa a que su mal uso llevó. Haremos a lo largo de este trabajo una construcción intelectual, basada en la noción de sistema, con algunos datos significativos de los acontecimientos empíricos.

2. La sesión del grupo familiar. Sus integrantes son: el padre, Lorenzo Francisco Fernández; la madre, Elvira Cristina de Fernández; el hijo, Lorenzo Ramón, y la hija, Cristina Elvira. El observador es el doctor Osvaldo Apréda y el coordinador el doctor Isidoro Berenstein. En las sesiones familiares se denominaban: Lorenzo, Elvira, Lorenzo, Elvira o Elvirita o Elvi. Yo los denominaba y aquí seguiré haciéndolo como: Lorenzo padre, Elvira Madre, Lorenzo hijo y Elvira hija.

Es la trigésima séptima sesión. La madre, la hija y el padre llegaron quince minutos tarde. Nos saludaron y se sentaron.

La madre nos informó que se quedaron abajo esperando al hijo, pero como no llegaba decidieron subir. Lorenzo hijo estuvo con ellos en la casa pero se fue primero para otro lado. El padre confirmó verbalmente lo dicho por la esposa. La hija expresó que tampoco tuvo ganas de venir, no podía alejar su impresión de estar en este tratamiento sólo por la enfermedad del hermano. No obstante vino por temor de que "le bajaran la caña". Esta conducta sometida la explicó diciendo que tenía un juez adentro. La madre no entendió lo de "bajar la caña" y así se lo dijo. A lo que aquélla respondió que eran

cosas de ella. Mientras tanto Lorenzo padre las miraba. Interpreté que me estaban comunicando una forma de organización escindida y la describí como una oposición entre Lorenzo padre, Elvira madre y Elvira hija por un lado y por el otro Lorenzo hijo. Cuando trataron de venir juntos descartaron mostrarse de otra manera pero no pudieron lograrlo, entonces se asimilaron al hijo con la llegada tarde y el observador y yo nos convertimos en el resto de la familia esperando. Esta dificultad para reunirse la referí a mis interpretaciones de la sesión anterior, aunque yo sabía que ellos pensaban que se debía específica y únicamente a Lorenzo hijo. Este llegó en ese preciso momento (quince minutos después de sus familiares), y preguntó en tono natural de qué hablaban. El padre, calmamente, le informó que habían dicho que su ausencia dejaba al grupo desarticulado y sin sentido. El recién llegado respondió airadamente acusando al padre de ponerlo siempre como centro de la enfermedad y afirmó que todos estaban enfermos pero canalizaban la enfermedad hacia él. El padre se hizo la reflexión de cómo hablar en las sesiones: si libremente o previendo el impacto que las palabras podían causar en los demás. Conectando este material con el de la sesión anterior interpreté esta interacción como un intento de reorganizarse en un doble sistema: familia/Lorenzo hijo, que se ponía en evidencia cuando se reunían. Aparentemente esta organización solucionaba el problema de cómo contener la idea de tratarse conmigo en tanto terapeuta con apellido judío. La hija respondió diciendo que tenía la sensación de que hablar traía sensaciones terribles, y puso como ejemplo la que el hermano le había impuesto, después que expresó, en sesiones anteriores, su aprobación por la ruptura entre el hermano y la novia, Raquel, por ser ésta judía. El castigo consistió en no hablarle. También estaba sancionada luego de una conversación que tuvieron en la casa entre la última sesión y ésta, acerca de una pared medianera. El padre planteó el problema en términos de que el vecino les había robado. Discutieron quién se haría cargo del asunto: si el hermano por sus mayores conocimientos técnicos o ella por sus mayores conocimientos legales.

Estaba pensando una interpretación, cuando dejaron de ocuparse explícitamente de la medianera y comenzaron a disputar entre ellos y a explicar por qué disputaban. Lorenzo hijo manifestó que la hermana y el padre habían dialogado como dos personas solas excluyendo a todos los demás. Luego él habló con el padre, pero la hermana mostró tanta rivalidad que fue difícil no pensar que entre los hijos se estaban disputando al padre. Intercambiaron entre los dos hermanos sobre cómo empezó la conversación y nuevamente se embarcaron en diversas hipótesis: si es que Elvirita se enojó porque Lorenzo no la miraba o el padre al hablar en forma impersonal fomentaba esta rivalidad, porque no precisaba a quién iban dirigidos los mensajes. Los hijos se pusieron de acuerdo acerca de lo limitado del cariño de los padres, concluyendo con criterio de cantidad, que no había para todos.

Lorenzo padre respondió que quería a todos los hijos igual, pero la forma de exteriorizarlo era diferente porque a su vez cada hijo era diferente.

Mirando a todos los integrantes del grupo, vi que el observador tenía los ojos somnolientos. Pensé que se aburría. Me llamó la atención esta ocurrencia porque contrastaba con mi interés. Les interpreté que lo mejor que podían darme eran explicaciones sobre los hechos pero no los hechos, como por ejemplo lo de la medianera, y de esa manera podían protegerse de la emergencia de aspectos de ellos mismos que sentían no era tiempo aún de exteriorizar. La medianera eran las explicaciones con lo cual en la sesión se organizaban como una familia ahora unida y separada de los vecinos, obviamente el observador y yo. El padre enfatizó lo interesante de mi interpretación para traer a colación nuevamente lo del cariño de los padres hacia los hijos. El hijo no estuvo de acuerdo con la interpretación de mi interpretación y a su vez retradió mi mensaje como que ellos debían tratar de contar los hechos objetivamente. Proponía por lo tanto seguir discutiendo lo de la medianera. Elvira hija afirmó que cuanto menos dijera sería mejor para que el hermano no se desquite luego con ella. Como ejemplo recordó un episodio infantil: una vez le echó la culpa por algo al hermano y éste en represalia le pegó. Por diversos motivos no podía hablar libremente en la sesión y entonces se sentía como un cero a la izquierda. Interpreté esto como la idea sobre la cual se agruparon: Elvira hija se ubicó como observadora, efectivamente a la izquierda mía, así como estaba el observador y de esta manera evitaba la sensación de robo de la información y de la tranquilidad. Suponía que era esto lo que les había llevado a construir una medianera de explicaciones. La sesión terminó después de una discusión entre los hijos y el padre acerca de que hablar no tenía mucho sentido y lo mejor hubiera sido callarse la boca, como efectivamente hizo la madre desde poco antes de la mitad de la sesión.

3. El tiempo de la sesión. Se desprende de la presentación que este grupo familiar está en un tratamiento de larga duración, con días y horas fijadas de antemano. El hecho de haberlo acordado conmigo no es óbice para la llegada tarde o para que no todos vengan. El tiempo remite a un plano de la organización social. El encuadre del tratamiento al ofrecer un marco temporo-espacial da la posibilidad de exteriorizar esta configuración de los vínculos. Así como un dibujo necesita de un papel, la estructura necesita de un encuadre para manifestarse.

El tiempo de la sesión está dividido en tres partes: a) los primeros quince minutos: sólo estamos el observador y yo; b) los quince minutos siguientes: están con nosotros tres de los cuatro integrantes, c) el resto del tiempo: están todos. Esta estructuración del tiempo es negada por la configuración dualista que surge cuando explican la tardanza.

Notaremos que las informaciones de los distintos integrantes pertenecen al tipo de explicación que más oscurece que aclara este dato. No podemos saber por qué quedaron abajo los tres integrantes, ni por qué quince minutos fue el límite de espera. El tiempo está distribuido de acuerdo a la manera de pensarse la familia, pero la construcción propuesta por ellos encubre esta configuración y enfatiza en cambio otra de neto corte dualista. Para esto es necesario negar la evidencia de los primeros quince minutos, cuando ningún integrante familiar estuvo. Esta oposición entre el tiempo que estuvieron ausentes y el que estuvieron presentes es dejada de lado y remarcada otra oposición entre los segundos quince minutos y el resto. Esta última es equivalente a la oposición entre familia/miembro enfermo (véase "Motivo de la consulta" en la ficha familiar), equivalente a su vez a la ordenación del día de semana y fin de semana. Esta información es la más próxima al nivel convencional, mas no por eso desdeñable.

4. El sistema de denominaciones*. Comprende dos subsistemas: el de los nombres propios y el de las denominaciones de parentesco. Me ocuparé aquí sólo del primero.

Los padres me informaron que la elección de los nombres para los hijos obedeció a ciertas costumbres tradicionales en su grupo étnico donde ponen a los hijos los nombres de los padres tal como había ocurrido con los propios padres. Pero surge otra significación cuando se los considera en relación a los otros nombres con los cuales forma un sistema. El padre se llama Lorenzo Francisco y el hijo Lorenzo Ramón. El abuelo paterno se llamaba Lorenzo. Es posible establecer con estos tres nombres una serie donde los primeros nombres establecen la máxima correlación, ya que son el mismo, en tanto el segundo establece la diferencia y oposición.

Lorenzo > Lorenzo Francisco > Lorenzo Ramón

Coloquialmente establecieron una igualación.

Lorenzo = Lorenzo = Lorenzo

La madre se llama Elvira Cristina y la hija Cristina Elvira.

La abuela materna se llamaba Elvira.

Entre la abuela y la madre hay la misma operación descripta que para el abuelo y el padre.

Elvira > Elvira Cristina

* Agradezco a la licenciada Dora Orlansky y al doctor Héctor Kravov por su inestimable ayuda en la elaboración de los ítems 4-5-6 y 7.

Pero entre la madre y la hija hay una permutación en la ubicación de los nombres.

Cristina Elvira $\times$ Elvira Cristina

Esta permutación está enderezada en el uso coloquial porque ya vimos que madre e hija se denominaban con el mismo nombre que la abuela materna.

Elvira = Elvira = Elvira

Agrupando en serie los primeros y los segundos (fig. 1), veremos que para los primeros el peso de la línea materna y paterna es equivalente. Al considerar la segunda serie la equivalencia deja de tener efecto, porque Ramón es un hombre perteneciente a la rama materna (dos colaterales de la madre tienen idéntico nombre). Considerando también al hijo menor tenemos que el segundo nombre es el del abuelo materno, en tanto el primero no tiene que ver con ningún otro familiar.

FIGURA 1

Series	Línea paterna	Línea materna	
Primer nombre	Lorenzo (3)	Elvira (3)	Manuel
Segundo nombre	Francisco (1)	Cristina (2)	
		Ramón (1)	
		Prilidiano (1)	

En este grupo familiar el uso informa de un equilibrio encubridor y consciente en relación al desequilibrio inconsciente determinado por el predominio de la rama materna evidenciado a través de la filiación.

Una sola persona tiene un nombre paterno y uno materno: Lorenzo Ramón.

Lorenzo Francisco > Lorenzo Ramón > Elvira Cristina

El sistema de denominaciones informa que el hijo mayor tiene una función mediadora entre las ramas paterna y materna. El mediador contiene la dualidad que ha de superar.

Considerando las denominaciones como un sistema de significación hemos de ampliar la estructura familiar hasta incluir la familia materna,

existente en la conciencia de los integrantes sólo por las denominaciones, ocultas por un modelo consciente (normas sobre la asignación de los nombres en el grupo étnico) que los aleja de la significación sistemática subyacente en el inconsciente, no obstante regular otros tipos de relación, como veremos.

Cuando Lévy-Strauss se refiere a la estructura elemental de parentesco dice que lo realmente elemental no es la familia sino su *relación* con otra *. Podemos desprender dos consecuencias. Una es de tipo comunicacional y se deriva de la pérdida de los atributos semánticos de los nombres **. El uso coloquial de dos nombres entre cuatro personas obliga a reforzar el mensaje incluido en el nombre, debilitado por la pluralidad. Para este uso se puede recurrir a las denominaciones de parentesco. Así superé este inconveniente durante el tratamiento.

Los integrantes de la familia habían codificado la comunicación. En el caso de los hijos denominando a los padres por el parentesco, según el uso social. En el caso de los padres el uso social no se apoya en el parentesco para denominar al hijo, sino en el nombre o diferenciándolo con un diminutivo o con un sobrenombre.

Si el padre se refiere a Elvira deberá sintetizar el tono de voz, o los gestos o el contexto delimitará al receptor del mensaje. Lo propio ocurrirá si la madre se dirige a Lorenzo. Están creadas así las condiciones para todo tipo de descalificación, porque el emisor puede desdiseñarse del mensaje diciendo que estaba dirigido al otro miembro del mismo nombre, como ocurrió muchas veces en el curso del tratamiento. Nunca se podrá cuestionar la validez de esta maniobra.

Otra consecuencia tiene que ver con la organización de este grupo familiar. El uso de sólo dos nombres transforma a las cuatro personas

* "Para que exista una estructura de parentesco es necesario que se hallen presentes los tres tipos de relaciones familiares dadas siempre en la sociedad humana, es decir, una relación de consanguinidad, una de alianza y una filiación: dicho de otra manera, una relación de hermano a hermana, una relación de esposo a esposa y una relación de progenitor a hijo." En esta descripción el autor muestra la familia como un sistema de intercambio derivado de la prohibición del incesto, y por lo cual en la sociedad humana son los hombres quienes intercambian a las mujeres. De ahí la importancia fundamental que signa el autor al representante del grupo de la cual proviene el bien intercambiado, que en algunas culturas es el tío materno (relación avuncular). Esta estructura deja de ser predominante cuando se complejiza el sistema, pero retorna con toda nitidez toda vez que el sistema está cerca de una crisis ⁸.

** Ullmann señala que desde el punto de vista semántico los nombres propios tienen las siguientes características: 1) Unicidad: en el habla efectiva los nombres se usan con referencia a una persona. 2) Identificación: un nombre singulariza una persona u objeto de entre entidades semejantes. 3) Denotación: un nombre nombra sin atribuir significado a diferencia de los nombres comunes que connotan atributos de los objetos. 4) Sonido distintivo: acentuado en los nombres propios y con lo cual se acentúa la diferencia de un conjunto donde las semejanzas predominan. 5) Criterio gramatical: aunque varía en las distintas lenguas con respecto al uso de artículos no obstante la gran mayoría de los nombres propios no usa el plural, merced a las dos primeras características ¹¹.

en una pareja. Cabe plantear la hipótesis de que entre las cuatro personas: padre, madre, hijo e hija han de resolver una contradicción implícita en este sistema familiar, negada durante años y resurgida con el casamiento y alejamiento del hijo menor. De acuerdo a la nomenclatura el padre se continúa en el hijo mayor y la madre en la hija. La duplicación de esta pareja tiene por misión trasladar el intercambio de la relación marido-mujer a la relación hermano-hermana. Con la traslación se invierte la dirección de la cual proviene la mujer: el padre recibió mujer y a través del hijo la devuelve en forma de hija.

Lorenzo Ramón cumplía una doble mediación: entre las ramas paterna y materna como vimos anteriormente, y entre el pasado y el presente.

5. El sistema religioso. Cuando en la entrevista inicial interrogué sobre religión me informaron de la siguiente manera; padre: "católico no profesante", madre: "católica no profesante", hijo mayor: "ninguna", hija: "católica no profesante". Del hijo menor me informaron: "ninguna". "No profesante" implica una connotación que rebaja el sentido de "católico". El máximo de connotación está representado por el hijo mayor. Más allá o más acá de los significados particulares de las respuestas, tomándolas como un sistema aparece otro tipo de significación. En la familia, Lorenzo hijo se opone al resto de los integrantes, ya vimos esta oposición y la relacionamos con el modelo de organización familiar más consciente. Pero si el sistema se amplía hasta incluirme podemos construir una oposición más significativa, con distintas mediaciones. Los integrantes de la familia sospechaban que mi apellido era judío. Entonces es posible establecer la siguiente ordenación donde cada término es opuesto y correlativo del anterior:

católico > católico no profesante > ninguna > judío

El cuadro siguiente es un desarrollo del sistema ampliado.

En el cuadro se verán una serie de categorías y entre paréntesis sus representantes. Puede leerse de izquierda a derecha, o de arriba-abajo por columnas. En la parte superior, en la misma línea figuran en los extremos las categorías "católico" y "familia", equivalentes entre sí. De la misma manera en la parte inferior figuran "no católico" y "no familia". Efectivamente todos los integrantes del grupo familiar son católicos y los integrantes extrafamiliares son no católicos. Así como en la línea superior "católica" se transforma en católico no profesante, en la inferior "no católico" se transforma en "judío". De esta manera la familia mantiene su catolicismo y la "no familia" experimenta una transformación hacia la categoría "judío", pasando por una categoría intermedia "medio católica medio judía" representada por la esposa del hijo menor. Ha de llamar la atención la inclusión de los hijos varones

FIGURA 2

Católico	Serie 1 "familia actual"	Serie 2 "hijo menor"	Serie 3 "hijo mayor"	Serie 4 "hijo mayor enfermo"
	Católico (Familia pasada)	Católico no profesante (Padre-madre-hija)	Católico no profesante (Padre-madre-hija)	Católico no profesante (Padre-madre-hija)
	Católico no profesante (Familia actual)	Ninguna (Hijo menor)	Ninguna (Hijo mayor)	Ninguna (Hijo mayor)
No católico	Ninguna (Hijos varones)	Medio católica Medio judía (Esposa)	Judía (Novia)	Judía (Terapeuta)
				No familia

en la línea "no familia".* El menor, casado, vivía en otro país. El mayor fue el miembro sancionado.

La denominación "no familia" indica la falta de reconocimiento del proceso por el cual se estableció la oposición familia/miembro ausente o familia/enfermo mental. El segundo de los términos reaparece pero convencionalmente es considerado como ajeno a su grupo de origen, como un hecho natural y espontáneo* y no como una estructura organizada con un antes y un después.

Leída verticalmente la primer columna señala la transición entre la familia del pasado, católica y la actual: católica no profesante como intermedio de la categoría siguiente representada por los hijos. En la segunda columna y en las demás los hijos varones establecen la mediación entre las dos categorías opuestas (superior e inferior) representadas a nivel religioso por la familia del hijo y por la esposa o novia correspondiente. En la cuarta columna la oposición es entre familia y terapeuta, incluido como la esposa del hijo menor o la novia del mayor en el exogrupo, identificándose esta categoría con la de "judío".

Esta fue una manera de plantear una solución lógica al problema surgido después de organizarse como un sistema dual, para resolver otro tipo de problemas difíciles como veremos posteriormente. A todas luces el conflicto respecto a la religión con el tercer hijo no fue tan importante como respecto al mayor. Este observable de la estructura es uno de los que surgió como material en una sesión anterior y motiva algunas de las interpretaciones de la que mostré en 2.

6. La circulación del dinero. Todo el grupo familiar dependía económicamente del padre a pesar de que la madre percibía un aporte jubilatorio, el hijo mayor trabajaba y la hija tenía ingresos por su profesión. Los tres últimos destinaban esos ingresos a sus propios gastos. Esta descripción aunque verdadera es parcial, porque informa de una economía familiar estática.

En el año 1964 Lorenzo padre dio una cantidad de dinero a la hija para invertir en la empresa de un familiar por la rama materna. En realidad el planteo fue más alambicado y el modelo consciente explicaba la cesión del dinero como un préstamo. Pero para resguardarlo y para ayudar al mismo tiempo a la hija figuró como inversión. A la larga hubo complicaciones y ese dinero nunca brindó beneficios y no fue devuelto, ni siquiera pedido.

Cuando casó el hijo menor el padre obsequió a la joven pareja una elevada cantidad de dinero. Curiosamente y luego de invertir ese dinero los intereses fueron cedidos a la suegra de Manuel.

La circulación del dinero partía del padre y concluía en la familia

* Los padres frecuentemente relataron su extrañeza por el distinto desarrollo de los hijos.

* Este desarrollo es isomórfico con el de la cultura y su activo desconocimiento de las condiciones generadoras de las perturbaciones culturales.

materna. En ese sentido la madre de la esposa del hijo representaba a la rama materna y repetía la estructura familiar en la que se aseguraba la circulación del dinero en una dirección contraria a la circulación de mujeres (de la familia materna al padre), equivalente a la circulación del sistema de nombres como vimos en el 4.

Lorenzo Ramón siguió el modelo inconsciente en la búsqueda de mujer. Era una muchacha de familia humilde como había sido la madre. Además de sus motivaciones personales, su función en el sistema familiar consistía en mediar entre la rama paterna y la rama materna (como vimos cuando analizamos el sistema de nombres) mediación desplazada luego a la oposición familia/no familia (como vimos en el sistema religioso). La oposición católica/judía existente en la conciencia de los integrantes encubría otra más inconsciente y leída en el tipo de circulación del dinero, donde reaparecía el intercambio entre los hijos varones subrogados del padre y la esposa o novia, subrogada de la madre.

En este sentido el hermano menor no trajo tanto conflicto: su mujer figuraba como medio católica-medio judía y de esta manera podía pertenecer a la familia y a lo paterno. No así Lorenzo hijo, cuya novia judía transparentaba el riesgo de establecer la oposición inicial pero también incluía un alejamiento del peligro del incesto. La conexión con el dinero creaba un camino facilitado para conectar inconscientemente la rama materna con lo judío representativo a su vez de lo exogámico. No sólo esta conexión sino el sistema en la cual se incluía pertenecía al grupo de producciones inconscientes cubiertas por modelos conscientes tendientes a ocultar su exteriorización, no obstante regular las relaciones reales entre los miembros.

La empresa de Lorenzo Francisco era del padre. Para hacerse cargo de ella dejó de ejercer su profesión; estaba asociado con otro familiar paterno. En realidad se trataba de una empresa familiar, transmitida por sucesión. Los padres insistieron permanentemente para que los hijos sucedieran al padre, como éste había hecho a su vez con su propio padre.

Esto nos permite describir la circulación del dinero en la rama paterna como vertical (natural) y en la rama materna como horizontal (social), pasando a otros grupos familiares, en un sistema de intercambio, después de haber recibido las mujeres (la madre, la muera, la novia). A nivel del miembro sancionado se oponían dos modelos de funcionamiento: uno consciente y otro inconsciente. El primero seguía una distribución sucesoria, endogámica, natural, en conflicto con el segundo, indicador de un intercambio, exogámico, social. La estructura daba otro giro sobre sí misma, pero con una transformación: materno en judío, a favor de la conexión con el dinero. Éste se había incrementado durante el desarrollo del grupo familiar.

7. El sistema de ocupaciones. El padre era empresario y aunque no ejercía poseía un título profesional. Como queda dicho al hacerse

FIGURA 3

	Padre	Hija		Madre	Hijo menor
Empresario	+	—	Ama de casa	+	+
Profesional	—	+	Docente	—	

cargo de la fábrica del padre relegó la profesión. La madre había sido docente. En la actualidad era ama de casa. El hijo mayor trabajaba como empleado en una empresa y aunque con dificultades detenía la denominación de estudiante. La hija era profesional y accesoriamente empresaria como vimos antes. El hijo menor se había licenciado y cumplía la doble función: ejercicio de su quehacer y docencia. En el cuadro siguiente el signo (+) indica la ocupación en estado de actividad actual o principal y el signo (—) indica la ocupación pasada o subsidiaria.

Entre el padre y la hija hay una permutación por la cual la hija endereza el juego de ocupaciones paterno.

Entre la madre y el hijo menor hay una permutación parcial. A través de su segunda actividad continúa la actividad pasada de la madre. En cambio, el hijo mayor tiene como ocupación primera una opuesta a la actual del padre y como subsidiaria una opuesta a la actividad pasada de la madre.

Empleado/Empresario Estudiante/Docente

Si incluimos todas las ocupaciones según su grado de productividad económica, tendremos

Empresario > Profesional > Licenciado
(Lorenzo padre) (Elvira hija) (Manuel)

Empleado > Ama de casa
(Lorenzo hijo) (Elvira madre)

Entre el máximo de actividad económicamente productiva representada por el padre y la mínima actividad económicamente productiva representada por la madre, los hijos ofician de intermediarios.

Podemos excluir la profesión de la hija por ser débilmente productiva y la del hijo menor por hallarse ausente. La serie anterior queda:

Empresario > Empleado > Ama de casa

El empleado es económicamente productivo como el empresario, pero tan dependiente como el ama de casa. Reencuentramos a Lorenzo Ramón en una función intermediaria entre el padre y la madre tal como surgió en el análisis de la circulación del dinero, del sistema religioso, y como estaba impreso en su doble denominación. Interrumpe aquí las consideraciones estructurales.

Creo haber mostrado suficientemente a través de diversas configuraciones la estructura de este sistema familiar a través de las relaciones cuyo sistema subyace en lo inconsciente. A continuación hare algunos comentarios técnicos en un intento de relacionarlo con los aspectos clínicos y teóricos.

8. La psicoterapia del grupo familiar. Consiste en un tratamiento de todos o algunos de los integrantes de un grupo familiar* con un especialista en psicoterapia, en su consultorio privado o institucional o eventualmente en la casa de la familia.**

La frecuencia de las sesiones es de una a dos veces por semana. Su duración entre 75 y 90 minutos. Por lo general la familia paga honorarios por la prestación del servicio psicoterapéutico. No doy entrevistas individuales a los integrantes del grupo. Las sesiones se realizan con por lo menos dos miembros, independientemente del número de integrantes comprometidos en la terapia**. El tratamiento es sin plazo fijo. Estas especificaciones son comunicadas a la familia, en la primer entrevista.

La participación verbal de los integrantes de la familia es según la libre asociación, la del terapeuta es casi exclusivamente interpretativa. Excluye así consejos, dictado de otras normas que las del encuadre y otras intervenciones directas en la vida cotidiana de los fami-

* Aunque brevemente, definiremos el grupo familiar. Es la unidad compuesta por la pareja de padres y el o los hijos, esto es donde se desenvuelven tres tipos de vínculos: el de alianza (entre esposo y esposa), el de filiación (entre padre o madre e hijo), y el consanguíneo (entre hermanos). En este sentido coincidiría con la familia biológica o la defectuosamente llamada familia nuclear. A los efectos de la psicoterapia también incluiríamos a otras personas del grupo familiar inmediato si la familia expresa interés en que formen parte. Así podrán incluirse abuelos, novios/as, yernos, cuñados/as, etcétera. Todos ellos forman parte del grupo familiar vivido. Por mi parte considero también el grupo familiar pensado, esto es el que resulta de considerar a través de la alianza la relación entre las familias biológicas o al decir de Lévy-Strauss aquello que hace de la familia una entidad social.

** Este criterio técnico se basa en el concepto de estructura familiar, por lo cual cualquier integrante puede brindar datos, desde que forma parte de ella y la mínima presencia forma parte de la configuración familiar con la máxima. No acepto no sólo integrante porque según nuestra experiencia esta situación es aprovechada para un tipo de conducta particularmente nociva para el terapeuta: la confesión de un secreto con el compromiso implícito de no revelarlo y con el pretexto de ayudar para la terapia. Tal "ayuda" consiste en ubicar al terapeuta en una situación donde teniendo que interpretar libremente, no puede hacerlo para no descubrir el secreto. En otros términos, se trata de un ataque a la capacidad intelectual del analista.

liares. Incluye intervenciones no interpretativas como preguntas, pedido de aclaraciones tendientes al logro de la información necesaria para la interpretación. Esto da cuenta de lo ocurrido en el grupo (obviamente incluidos el terapeuta y el observador). Procuramos no hacer interpretaciones individuales, pero las usamos señalando a su vez a qué configuración pertenece esta necesidad. De la misma manera no hacemos especial hincapié en la curación de alguno de los integrantes, aunque siempre el tratamiento haya comenzado por ese motivo.

El terapeuta hace uso de teorías y normas técnicas. A las teorías del terapeuta los familiares oponen normas y a las normas del coordinador los otros integrantes del grupo oponen teorías. Las normas son teorías de otro tiempo ahora coaguladas y excluidas de la posibilidad de ser cuestionadas. En este sentido los familiares y el terapeuta usan el mismo tipo de operaciones. El encuadre procura un espacio virtual donde el grupo familiar expresará su estructura a través de diversas configuraciones. Para posibilitar este efecto el elemento quizá más importante es la estabilidad inestable de las normas terapéuticas oponiéndolas a la inestabilidad estable de las normas familiares*. A manera de hojas en blanco la familia inscribirá en vueltas sucesivas, cómo piensa sus relaciones, tornándose evidentes en la consideración del tiempo, del espacio, de las denominaciones de parentesco, etc. Formando parte de la estructura también aparecerán los modelos conscientes, que a manera de explicaciones consolidadas como normas, procuran mantener lejos de la conciencia los elementos de la estructura más inconsciente.

Cualquier interpretación cuestiona aquello que informa la familia. El cuestionamiento da lugar a la emergencia de modelos diferentes relacionados con aspectos estructurales distintos.

La misma interpretación ofrece un modelo distinto y que el terapeuta se incluya en la misma, alienta a los distintos miembros a discutir referentes empíricos y explicaciones débilmente consistentes, como ejemplo véase la respuesta del hijo al padre cuando éste explicó mi interpretación de la medianera de explicaciones.

Cuando claudica el diálogo terapéuticamente libre, o éste se ve perturbado, se reenfatarán las normas dadas por el terapeuta.

En una supervisión un colega planteó el problema de una familia donde cualquier diálogo era seguido de un criterio infernal y donde no podía hacerse oír. Sugerí al colega les dijese que el consultorio no era la casa y que en razón de su presencia debían hablar corrientemente para que todos pudieran escuchar y el terapeuta entender e in-

terpretar. En síntesis con las intervenciones (normas o interpretaciones dirigidas a señalar el ataque al encuadre) tratamos de facilitar la ya de por sí difícil tarea del terapeuta de familias.

Algunas someras consideraciones merece el tema de la transferencia-contratransferencia. Someras no de acuerdo a su importancia sino de acuerdo al tiempo de que dispongo para este relato. Estoy en desacuerdo con el concepto emitido por Jackson y Weakland⁶ pero pienso también que el desacuerdo está basado en un distinto concepto de transferencia-contratransferencia. Los autores dicen que la transferencia se relaciona con la inactividad prescrita para el tratamiento psicoanalítico. Oponer inactividad con actividad en la terapia familiar, pero actividad entre los miembros familiares fomentada por el terapeuta. Supongo que se refieren a actividad predominantemente verbal. Afirman además: "si se la administra con destreza la interacción tiene lugar mayormente entre los miembros de la familia y no con el terapeuta".

Independientemente que en nuestro medio por lo general, en los tratamientos psicoanalíticos somos activos desde el inicio del tratamiento, las afirmaciones de los citados autores desconsideran el conjunto formado por los integrantes y el terapeuta. Por su misma definición: sistema es un conjunto donde no puede haber modificación de uno de los integrantes sin entrañar modificación en los demás. No puede pensarse que el terapeuta integrante del tratamiento no se considere incluido en un sistema determinado precisamente por él y en intercambio con los otros integrantes.

En mi actividad como terapeuta individual estos conceptos ocupan una posición central. Convencido de esto no veo razón suficiente para desecharlos al tratar grupos familiares. Individuo y familia son dos sistemas no isomorfos. Por lo tanto es necesario hacer una reformulación. En un grupo terapéutico la transferencia consistiría⁴ en la "sustitución de una persona anterior por la de alguno de los miembros significativos del grupo, sea el terapeuta u otro de ellos. En el grupo, el objeto de la transferencia, es el grupo "en sí mismo". Obviamente en un grupo preformado como la familia, el problema se complica, por la posibilidad de una coincidencia de la imagen proyectada con la persona real, como resultaría de proyectar la imago materna en la madre. Podría decirse que la proyección corresponde a la representación de la madre de la infancia en la persona de la madre actual, mas pienso que hay algo más. Para ser coherente con la noción de la familia como sistema redefiniré la transferencia-contratransferencia como: el proceso por el cual los integrantes del grupo familiar reproducen en la situación actual de la sesión un conjunto de relaciones vigentes en el pasado o aún fuera de la sesión, tratando de confirmar la validez a través de la conducta de los miembros, creando las condiciones para que el terapeuta sienta y funcione como un integrante más de la familia del pasado o del presente. Este proceso es tendiente a convalidar el modelo propuesto y desconocer la estructura de la sesión con

* Estabilidad inestable: define lo central como primer término y admite la posibilidad de alteraciones, como ejemplo: suspensión de una sesión, aumento en los honorarios, etcétera. Esto último denotado por la segunda palabra.

Inestabilidad estable: el segundo término denota la regularidad y constancia de la inconstancia y de ahí la dificultad de estipular concordancias o acuerdos y mantenerlos duraderamente.

su desnivel natural entre el terapeuta y el resto. Jackson y Weakland en el artículo citado mencionan un claro ejemplo de participación emocional, para nosotros definible como compromiso contratransferencial. Dicen textualmente los autores * acerca de una sesión con la familia de un paciente esquizofrénico: "Los padres conservan el tema centrado en el paciente y así evitan hablar de ellos mismos y de su relación. El paciente a menudo contribuye a ello "poniéndose bobo", haciéndose más notoriamente lo cual ayuda a que se lo siga rotulando como el paciente; esto ocurre especialmente cuando los padres, en efecto, se acercan a algún tema candente para ellos y esto es tan fuerte que hasta el propio terapeuta volcará su atención sobre el paciente, desentendiéndose de los padres, *sin tener conciencia*,** de lo que hace". En este caso el terapeuta interviene inconscientemente en un proceso donde es un integrante más de la familia y el grupo familiar convalida un modelo de funcionamiento habitual, al ubicar al terapeuta en el nivel de un integrante familiar desconociendo el desnivel natural entre aquél y el resto.

9. Algunos comentarios a manera de conclusión acerca de la sesión y de la familia presentada en este trabajo. Procuré mostrar la significación incluida en un modelo regulador de las relaciones familiares. Lo he hecho a través de un solo caso, mas éste, contiene muchas otras familias tratadas por mí en el curso de los últimos años. Traté de unir la operación terapéutica derivada del psicoanálisis aplicado a los grupos familiares con un ordenamiento teórico procedente de aquél y del análisis estructural. La familia del ejemplo se presentó como todas las que tienen un miembro mentalmente enfermo, organizadas y polarizadas como una organización dualista * a ambos lados del eje salud-enfermedad. Vimos la coincidencia en el miembro sancionado de varias funciones mediadoras: entre pasado y presente, entre organización consciente e inconsciente, entre las ramas paterna y materna. Esta correla-

* "The parents keep their discussion centered on the patient and by this avoid talking of themselves and their relationship. The patient often helps them in this by some of over 'goofing up' or going too far which aids in keeping him labeled as the patient; this occurs especially at points when the parents do happen to approach some topic that is hot for them, and so strongly that even the therapist is likely to turn on the patient, away from the parents, without quite noticing what he is doing." 6

** El subrayado es mío.

* "Esta expresión define un sistema en el que los miembros de la comunidad-tribu o aldea se reparten en dos divisiones, las cuales mantienen entre sí relaciones muy complejas que van desde la hostilidad declarada hasta una intimidad muy estrecha y donde en general, se encuentran asociadas diversas formas de rivalidad y de cooperación." Más adelante: "... presentan la organización dualista menos como una institución identificable según rasgos precisos que como un método aplicable a la solución de problemas múltiples". Más adelante: "Venimos así cómo se deslindan, sobre un plano puramente empírico, las nociones de oposición y correlación cuya pareja fundamental define el principio dualista, el cual no es otra cosa que una modalidad del principio de reciprocidad". 6

ción surgió tomando en cuenta la experiencia empírica de las sesiones y los modelos conscientes e inconscientes que ellos usaban para explicarse las relaciones sociales. Realicé una construcción similar, es decir del tipo de los modelos, aunque quizá de mayor generalización. Para ello fue de extrema utilidad analizar mi inserción en el sistema terapéutico y esto a través de los conceptos de transferencia y contratransferencia.

En la sesión vimos que tres integrantes llegaron tarde y el cuarto más tarde aún. Tres integrantes se sentaron juntos y un cuarto alejado. El cambio de personas no modifica el sistema de relaciones en la organización del sistema. La interpretación está centrada en evidenciar el sistema no evidente en forma perceptible. Les agregué además que había dos explicaciones: la de ellos y la mía, pero yo, a diferencia de ellos, aceptaba que pudieran pensar distinto.

Al comienzo de la sesión demostraron que la demora fue provocada por Lorenzo hijo, no obstante la evidencia de que independientemente de él, los otros tres también habían llegado tarde.

La interpretación agrega cómo lo atribuido al hijo mayor describe una conducta grupal (gracias a la estabilidad del encuadre) siempre y cuando se tome como referencia al terapeuta. Esto agrega un elemento inédito: un integrante cuestiona su relación con el resto. La interpretación es tendiente a evidenciar relaciones no perceptibles por la conciencia de las personas. Mi intervención siguiente mostró cómo la organización escindida solucionaba el malestar producido por la percepción de que si se pensaban como un sistema, podían sentir hostilidad hacia uno de sus integrantes (el terapeuta). La "medianera de explicaciones" tenía esa función, estaba compuesta por un conjunto de normas pobremente explicativas de las particularidades estructurales y sí ricamente capacitadas para impedir percibir las. La medianera separa y opone la familia y la no familia. No es tampoco perceptible el requerimiento del sistema para que los hijos se hagan cargo de la mediación; se puede reconocer en la cercanía de la hija a nosotros (el observador y yo) como por el hecho que el hijo enfermo los aproximó a mí. El desconocimiento del cual me hacen objeto se exterioriza en el silencio de la madre, en la reflexión del padre acerca de la norma técnica propuesta al comienzo de la terapia (hablar libremente), y en la conducta de los hermanos cuando explicaban por qué disputaban. La situación edípica exaltada por todos los integrantes podría haberse interpretado como la competencia dentro del grupo por el "papá" analista, que en efecto habla impersonalmente. Pero pienso que aunque cierta, esta interpretación es parcial si no se la incluye como parte de una totalidad que surge al comprender cómo un grupo se escinde cuando no puede contener ciertas ideas o emociones indeseables, existentes, negadas y vueltas a surgir cuando el grupo se actualiza en el tiempo y espacio de la sesión.

Por qué los dos hijos eligieron mujeres judías, así como todo el

grupo eligió un terapeuta de apellido judío resultaría enigmático a menos de incluir el enigma en un sistema general de intercambio donde, como vimos, las familias proveedoras de mujeres recibían a cambio, dinero respetando el principio de reciprocidad básicamente establecido entre la familia paterna y la familia materna continuada en sus subrogados: la familia de la novia del hijo mayor y de la esposa del hijo menor. "La historia tiende al sistema."⁸

Tratarse conmigo supone la posibilidad de establecer una mediación a un nivel diferente que el logrado a través de la enfermedad mental.

ANEXO

Extracto de la Ficha Familiar

2. Motivo del tratamiento familiar. En los últimos meses se había agudizado la mala relación de Lorenzo Ramón con el resto de la familia. Huraño, retraído, expresaban una mutua actitud de rechazo. Aquél rehuía comer con sus familiares, así como salir con ellos en el fin de semana. O no hablaban o si lo hacían les era difícil no terminar con mutuos reproches. A raíz de intensificarse esta conducta consultaron, sin que el hijo mayor lo supiera, al colega que finalmente los derivó para tratarse como familia. Le conocían por haber tratado a Lorenzo Ramón en 1964, por un trastorno que no supieron describirle y cuyo tratamiento consistió en inyecciones de insulina. Lorenzo afirmó que lo llevaron engañado, pero aceptó la terapia.

En las primeras entrevistas, aunque verbalmente expresara desacuerdo la actitud del miembro sancionado, concordaba con la del resto, era el enfermo y por él decidieron tratarse como grupo familiar.

3. Acontecimientos significativos en la historia del grupo familiar.

- 1936. Casamiento de Lorenzo Francisco y Elvira Cristina.
- 1937. Nacimiento de Lorenzo Ramón.
- 1940. Fallecimiento de la madre de Elvira Cristina.
- 1940. Nacimiento de Cristina Elvira.
- 1941. Nacimiento de Manuel Prilidiano.
- 1941. Fecha probable del primer brote de psoriasis en Lorenzo Francisco.
- 1942. Fallecimiento del padre de éste. Primera mudanza a un barrio de clase media.
- 1954. Fallecimiento de una cuñada de Elvira Cristina por un derrame cerebral.
- 1956. Segunda mudanza a un barrio de clase media alta. Comienzan las dificultades de Lorenzo Ramón en sus estudios universitarios.
- 1957. Fecha probable de comienzo de hipocuesia bilateral en Lorenzo Francisco.
- 1962. Fallecimiento de una cuñada de Elvira madre, por cáncer de mama.
- 1963. Fallecimiento de un cuñado de Lorenzo padre. Fue una muerte poco clara, algunos familiares sospecharon un suicidio.

- 1964. A mediados de año se recibió Cristina Elvira. Dos meses después abandonó toda práctica religiosa. Había sido muy beata y educada en colegio de monjas. A raíz de una crisis depresiva los padres decidieron llevarla a pasear al extranjero durante varios meses. El hijo mayor tuvo síntomas persecutorios. Comenzó la relación con la que fue novia: una muchacha judía. El hijo menor estaba ya noviendo con una chica descripta como mitad judía, mitad no. Hacia fin de este año se programó su casamiento.
- 1965. Casamiento de Manuel Prilidiano. Se fueron al extranjero para dedicarse a su quehacer. Fallecimiento de una hermana de Lorenzo padre y también de Prilidiano, hermano de Elvira madre.
- 1966. Fallecimiento de un hermano de Elvira Cristina. Una hermana de ésta tuvo una hemiplejía.
- 1967. Inician las consultas para hacer un tratamiento familiar.

4. Integrantes de la familia global.

1. Parentesco	2. Nombre	3. Edad	4. Nacionalidad	5. Religión
1. Padre	Lorenzo Francisco	63	Argentino	Católico "no profesa"
2. Madre	Elvira Cristina	61	Argentina	Católico "no profesa"
3. Hijo mayor	Lorenzo Ramón	29	Argentino	Ninguna
4. Hija	Cristina Elvira	27	Argentina	Católica "no profesa"
5. Hijo menor	Manuel Prilidiano	25	Argentino	Ninguna
5b. Hija política	Nidia	24	Argentina	Medio católica, medio judía
3b. Novia	Raquel	24	Argentina	Judía

(Siguen 34 interrogantes más)

6. Estado civil	7. Ocupación	8. Causa de enfermedad o muerte	9. Misceláneas
1. Casado	Empresario	Patología digestiva	
2. Casada	Profesional que no ejerce Ama de casa	Patología digestiva	
3. Soltero	Empleado estudiante	Patología digestiva	
4. Soltera	Profesional empresaria	Sin particularidades	
5. Casado	Licenciado docencia	Patología digestiva	
5b. Casada	Licenciada docencia	Sin particularidades	
3b. Soltera	Estudiante	Sin particularidades	

5. Relato de un día tipo del grupo familiar, en el momento de la consulta.

6.30 hs.: Se levantan Lorenzo padre y Lorenzo hijo. Desayunan solos. El padre ocasionalmente desayuna con la hija. 7.15 hs.: El hijo se va a su trabajo, mientras el padre lee el diario en otra parte de la casa, a las 8.15 hs. se va. Elvira hija se levanta más tarde y sale a las 10 hs. La madre se levanta a las 9 hs. y se dedica a su casa o hace compras.

Al mediodía almuerzan juntos el padre, la madre y la hija. El hijo llega más tarde y come solo. Los padres luego duermen. Lorenzo padre va a su empresa, o leen o salen. Elvira hija se va a su estudio.

A las 23.30 hs. cenan el padre, la madre y la hija juntos. El hijo llega más tarde y cena solo. Ocasionalmente se prepara la cena. En tanto los tres que cenaron juntos, ven televisión, Lorenzo se retira a su habitación.

Entre las 23 y 23.30 hs. se acuesta el hijo. Entre las 23.30 y 24 hs. se acuestan los padres. A la 1 h. se acuesta la hija.

6. Relato de un día sábado o domingo en el momento de la consulta. Los sábados se van a la quinta Lorenzo padre, Elvira madre y Elvira hija, junto con otros familiares maternos. Desde hace varios años el hijo no participa de este programa familiar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BASTIDE R. y otros. — *Sentidos y usos del término estructura en las ciencias del hombre*. Buenos Aires, Paidós, 1968.
2. BERENSTEIN I. — El grupo familiar. *Proceso psicoterapéutico y encuadre*. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, 1968, 14, 238.
3. BERENSTEIN I. — Una ficha familiar según una teoría estructural de las relaciones familiares. *Inédito*.
4. FERSCHUT G. — Notas acerca de la mentalidad y el "acting out" grupales y de su interpretación transferencial. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, 1969, 15, 324.
5. JACKSON D. D. (ed.). — *Therapy, Communication and Change*, vols. 1 y 2, Science and Behavior Books, California, 1969.
6. JACKSON D. D. y WEAKLAND J. H. — *Conjoint Family Therapy: Some Considerations on Theory, Technique, and Results*, en Jackson D. D. (ed.): *Therapy, Communication and Change*, vol. 2. Science and Behavior Books, California, 1969.
7. LAING R. D. y ESTERSON A. — *Cordura, locura y familia*. Fondo de Cultura Económica, México, 1967.
8. LÉVI-STRAUSS C. — *Antropología estructural*. Buenos Aires, Eudeba, 1968.
9. LÉVI-STRAUSS C. — *Las estructuras elementales de parentesco*. Buenos Aires, Paidós, 1969.
10. LIDZ T., FLECK S. y CORNELISON A. R. — *Schizophrenia and the Family*. International Universities Press, Inc. New York, U. S. A., 1965.
11. ULLMAN S. — *Semántica*. Madrid, España, Aguilar, 1969.

Correlato del trabajo "Familia y estructura familiar" del doctor Isidoro Berenstein

GUILLERMO FERSCHUT *

El hecho de haber sido elegido por el doctor Berenstein para la redacción de este correlato, me pone en la incómoda situación de sentirlo "como de la familia", rol que en este Congreso parece ser el tema del diálogo que nos une, de manera tal, que desde ya pido disculpas por entender que mi exposición estará obviamente cargada con las profundas emociones primarias de amor, odio y ambivalencia en las que me siento involucrado desde mi árbol genealógico hasta mi descendencia.

El doctor Berenstein nos ofrece, con su relato, un buen marco de referencia para comprender algunos aspectos de psicología genética que abarcan diferentes momentos de la vida del grupo.

Otro de sus méritos es llevar rápidamente al lector a la noción profunda del sentido de "proceso" en la integración grupal. Los enfoques multidimensionales demuestran que ningún hecho deja de ser influido por el otro durante el crecimiento y el desarrollo de esta familia.

Es cierto que nos habla de una construcción teórica compleja; en efecto, creo que lo es y que ello se debe al intento de articular dos teorías en el enfoque de la psicoterapia del grupo familiar. Me refiero a la teoría estructural y a la teoría analítica.

Sobre este punto deseo detenerme especialmente.

Para ubicarme en el problema haré una primera división: la de Grupo Familiar en general y la de Grupo Familiar en Terapia. Podríamos decir esquemáticamente que el grupo familiar es una unidad social, en la que cada uno de los miembros que la componen, unidos por lazos consanguíneos, utilizan esa unidad a los efectos del desarrollo y la maduración, al colaborar en la elaboración de sus respectivas crisis de identidad, que a lo largo del curso vital forman un sistema en la estructura psicosocial de la cultura en que vive.

* Bernardo de Irigoyen 146, Buenos Aires.

Ahora bien, en el grupo familiar como tal, es decir, sin terapia, se dan también las leyes generales en términos del inconsciente, propias de la dinámica de todo grupo, es decir, es una estructura psicosocial con sus propias leyes, fuerzas, roles, etc., que mantienen un equilibrio, que es continente a las normales modificaciones y tensiones del curso vital, que soporta cambios, mantiene su identidad como grupo y permite el crecimiento de sus miembros.

Pero, desde el punto de vista de la terapia, el grupo familiar requiere, para la discusión de la teoría general de su tratamiento, cierta discriminación que es necesario hacer desde el comienzo para evitar cualquier malentendido al respecto.

Primero, el grupo familiar pertenece a la categoría de los así llamados Grupos Preformados, que, dinámica y estructuralmente, tienen características que los diferencian de cualquier otro tipo de grupo terapéutico.

Segundo, tenemos que diferenciar, dentro de la terapia grupal familiar, aquellas técnicas que enfocan al grupo familiar "en terapia", como una unidad de por sí, y al terapeuta como un simple elemento de comunicación y enlace (conmutador telefónico, agente de tránsito, etc.) interaccionista, de otras técnicas que jerarquizan y utilizan la relación emocional profunda, en la que también está involucrado el terapeuta. Aquí el terapeuta sería más "un agente de cambio", un miembro más del grupo, pero dotado de características específicas avaladas por el contrato terapéutico dio origen al vínculo.

En esta última técnica se jerarquizarán fenómenos tales como la transferencia, la contratransferencia, la regresión, la fantasía inconsciente, etcétera.

En el primer caso, el grupo sería el mismo frente a cualquier terapeuta.

En el segundo caso, en cambio, un grupo presenta características distintas como respuesta a los estímulos que le representan "estar en terapia con ese terapeuta", y a los aciertos o desaciertos estratégicos, tácticos y técnicos del terapeuta, que favorecen u obstaculizan sus disposiciones latentes a la curación.

Creemos que este trabajo está ubicado preponderantemente en la segunda línea, es decir, en la terapia grupal psicoanalítica, pero que el autor utiliza a la vez otro modelo teórico, unido al psicoanalítico que tiene que ver con la teoría estructural.

Como mi aporte en este correlato se basa esencialmente en el punto de vista clínico, quiero aclarar que voy a dejar de lado, provisoriamente, todos aquellos aspectos que considero pertenecen a la teoría estructural, para pasar a ocuparme específicamente de aquellos problemas clínicos en relación con la teoría psicoanalítica en el tratamiento de los grupos familiares y con la atinencia de las hipótesis estructurales, tal como me las ha planteado el doctor Berenstein, para la comprensión de la psicoterapia del grupo familiar.

Un grupo preformado como el caso de la familia, viene a la consulta porque tiene algún grado de consciencia de que hay mecanismos que fallan en la manutención de su estructura, pero dentro de sus características, es un grupo que tiene un lenguaje, una cultura, roles ya establecidos e internalizados entre sus miembros, es decir, no hay anonimato.

El terapeuta es visto como alguien en quien está depositada la esperanza mesiánica de recuperar la antigua estructuración, pero a la vez, esta esperanza idealizada tiene la contrapartida en el hecho que el terapeuta también puede ser visto como un elemento peligroso que, al indagar, puede llegar a cambiar o deshacer los roles y por lo tanto mutar los elementos funcionales que mantienen la estructura.

En un grupo preformado, esquemáticamente hablando, hay que deshacer para volver a hacer con todo lo resistencial que presupone este tipo de tareas; en cambio, en un grupo que forma el terapeuta el slogan sistemático sería "tenemos que empezar a hacer, para ver cómo se están haciendo". Aquí hay que ver qué es lo que les está impidiendo a personas que no se conocen, integrarse como grupo. En el grupo preformado habría que ver qué es lo que les está impidiendo separarse como grupo, con una estructura, aunque sea instrumentalmente, para poder verse de manera diferente.

El grupo preformado aparece como una organización con cierto grado de consciencia de enfermedad, con un paciente decretado como tal "el miembro enfermo", lo cual presupone una fijeza de objetivos y todo un sistema que se condiciona al servicio de ese intento.

A su vez, las adjudicaciones de roles ofrecidos y otorgados al terapeuta pueden coincidir con funciones que, por dinámica de grupo, ese mismo grupo necesite para cubrir determinada carencia interna.

Por ejemplo, el terapeuta puede ocupar el lugar del hijo varón esperado, o el de una madre tierna y consoladora, por el solo hecho de brindar, en ese momento, para esa estructura y en la circunstancia de la consulta, una determinada disposición tranquila y el tiempo-espacio que esa familia necesite, factores éstos que pueden llegar a confundir los objetivos de la consulta.

Con ello quiero significar que, a las complejidades que presenta toda terapia de grupos, aquí se agregan dos más: la que tiene que ver con el hecho de ser un grupo preformado, como los grupos de trabajo que vienen a la consulta, y que, además, los miembros del grupo tienen entre sí estructuras fijas que mantienen desde el inicio del vínculo terapéutico; por ello, a mi juicio, la terapia de grupo familiar tiene bastante parecido con la terapia de la psicosis, por el profundo impacto transferencial, el grado de compromiso contratransferencial que provoca, así como la mayor exigencia personal del terapeuta para captar y copar las notables complejidades de esta tarea.

Vayamos ahora al trabajo del doctor Berenstein. Una lectura detenida del mismo muestra que lo más denso del trabajo que el autor nos anuncia como una construcción teórica compleja, se ocupa de compren-

der descriptivamente la modalidad del funcionamiento de un grupo, pero, a nuestro entender, no tanto acerca de la forma de operar terapéuticamente sobre él.

La ubicación dentro de las ordenadas, tiempo, espacio, espacio social, fines de semana, sistema de denominaciones, sistema religioso, circulación del dinero, y su organización en series y cuadros, me parece fascinante. Estimo que pertenecen a la teoría estructural y no me siento capacitado para el comentario, porque no conozco tanto de dicha teoría como para esbozar un análisis. Intentaré sólo un acercamiento cuando me ocupe de la noción de "dato".

En el trabajo que comento, necesitaríamos una idea más precisa acerca de la metodología de la curación de un grupo familiar a través de un tratamiento psicoterapéutico.

Entendemos que hay también un problema metateórico que tiene que ver con el hecho de articular dos teorías: la estructural y la psicoanalítica. Queríamos saber si el autor trabaja con dos teorías, a niveles distintos, o entiende que una enriquece a la otra en la práctica diaria, o si la teoría estructural es utilizada como un modelo teórico de comprensión y de transmisión a colegas, o los aspectos de la teoría estructural pueden ser instrumentados en la práctica del aquí y ahora de la sesión.

En otras palabras, si son dos niveles de abstracción, incompatibles o no, o si pueden unirse técnicamente dentro de la sesión.

Existen diferentes intentos de integración entre estructuralismo y teoría psicoanalítica, como los de Lacan, Green, y entre nosotros, Liendo.

A primera vista, el autor procura hacer un intento similar, pero en su trabajo ambas teorías parecen tener un desarrollo paralelo más que integrado.

Entiendo que la aplicación de la teoría estructural, como cualquier otra teoría que tienda a explicar hechos, salvando todas las distancias de confusiones conceptuales, esquemas referenciales, etc., puede servir para ampliar nuestra comprensión de los hechos que ocurren en la clínica, pero me pregunto si una ampliación de la comprensión, tal como se expone en este trabajo, puede surgir de la práctica clínica, y estar en condiciones, por lo tanto, de ser sometida a pruebas de validación o refutación, que es lo único que puede justificar que una teoría merezca ser considerada científica.

En función de esto sería útil poder preguntarse, o bien preguntarle al autor, qué es lo que podemos considerar nosotros como datos de observación. Si tomamos como dato de observación todo lo conocido por el terapeuta de ese grupo familiar a través del test, informes, fichas, preguntas directas, antecedentes, etcétera, o si tomamos como noción de dato todo aquello observable dentro de los límites de la sesión terapéutica. En el primer caso se trataría más de una ciencia al estilo Lévi-Strauss, antropológica, aunque entiendo que dicho autor no se ocupó de familias en terapia; en el segundo, de la psicoterapia de grupo fami-

liar. Comprendiendo esto podemos llegar a la idea de que no todos los esquemas conceptuales pueden llegar a ser útiles, según qué categoría de datos tomemos. ¿Cuál es el peligro que existe cuando una teoría no es totalmente pertinente para explicar datos correspondientes a otro nivel? En esto concordamos con Copi, cuando dice que: "Una hipótesis debe ser atinente al hecho que pretende explicar, esto es, el hecho en cuestión debe ser deducido de la hipótesis propuesta. Una hipótesis que no es atinente al hecho que pretende explicar, simplemente no puede explicarlo y sólo puede considerarse que ha fracasado en el cumplimiento de la función para la cual se la destinaba".

Entiendo que la teoría estructural se limita a proponer una descripción de un fenómeno, formalizando las relaciones que lo constituyen.

Una teoría de la psicoterapia de grupo familiar, en cambio, debe dar cuenta, no sólo de una descripción de la dinámica inconsciente del grupo, sino además de una explicación de sus motivaciones y una comprensión de sus finalidades inconscientes también.

Sólo así es posible elaborar una estrategia, una táctica y técnica interpretativa adecuada.

Pasemos ahora a otro aspecto del trabajo del doctor Berenstein: su enfoque teórico-técnico terapéutico, que de alguna manera puede inferirse o que se encuentra explícito en diversos pasajes de su trabajo, especialmente al final.

Estoy en un todo de acuerdo con el autor en lo referente a su encuadre, actitud interpretativa, fomento de la libre asociación, exclusión de consejos y evitación de la cura sintomática en el grupo, lo mismo que la integración de las interpretaciones individuales en el contexto del suceder grupal.

Me parece muy feliz su comparación de que, a las teorías del terapeuta los integrantes oponen normas, y que dichas normas seguramente son el resultado de teorías de otro tiempo y actualmente coaguladas. Sólo agregaría que las viejas teorías, actualmente normas, son el resultado de crisis que han tenido una determinada forma de resolución en otro momento y que por el propio proceso de cambio actualmente han perdido vigencia.

El estudio de la sesión presentada por el doctor Berenstein, me ha llevado a desarrollar algunos comentarios. En ese sentido, los párrafos que siguen apuntan a un bosquejo rudimentario de esclarecimiento de uno de los problemas que considero básico en psicoterapia de grupo familiar: me refiero al malentendido entre los integrantes del grupo, que se relaciona íntimamente con su patología.

Pienso que una de las labores del terapeuta consiste en esclarecer cómo en el grupo existen utilizaciones y comprensiones distorsionadas de la situación terapéutica grupal, y cómo a consecuencia de la elaboración de todo esto puede llegarse a una redistribución de roles entre sus integrantes.

Veo esta sesión como una operación de tipo comando, pero que fracasa en su objetivo terapéutico por no ser el mismo para todos y desconocer la fuente del peligro que lo acecha.

Toda esta formulación permite plantearse diversos problemas de técnica interpretativa. El autor nos anuncia que, debido a la confusión de presentarse con los nombres, debido al parecido que tienen y con el objeto de evitar más confusiones en el grupo y al lector, los va a denominar como Lorenzo-padre, Elvira-madre, Lorenzo-hijo, Elvira-hija.

De aquí surge la pregunta: ¿queríamos saber si este arreglo de la nominación fue visto dentro del grupo como un aspecto confuso entre los integrantes y utilizado entre ellos para fines defensivos, o fue una resolución espontánea o instrumental del terapeuta.

En el primer caso correspondería dicho arreglo a una solución grupal de un conflicto cuyo origen, por supuesto, está en la confusión de fondo, y nos agradaría saber cómo se desarrolló.

En el segundo caso, la decisión del terapeuta corresponde a la actuación de una contraidentificación proyectiva que nos inclinaría a pensar en núcleos psicóticos de la estructura grupal, cuyo pronóstico, como se entiende, es diferente.

Concordamos con el autor en el sentido de la actuación que de entrada tiene el grupo, al mostrar la escisión y depositación en el equipo terapéutico, del rol de familia que espera; sin embargo creo que, aparte de hacerle vivir a él la espera del miembro enfermo, estaban ubicando en el equipo terapéutico el temor a enloquecerse si venían sin el hijo.

Con la espera y la disociación sancionaban nuevamente al miembro enfermo, sanción que, dentro del resto del grupo parecía estar ubicada en la hermana, que traía el temor de que "le bajaran la caña" si hablaba y el sentimiento de un juez adentro, de su superyó internalizado que la sometía.

Cuando llega el hijo, el padre le distorsiona la información al decirle que habían hablado de que su ausencia (la del hijo) dejaba al grupo desarticulado y sin sentido. Ése no era el tipo de comunicación que ellos habían dado al terapeuta ni el terapeuta a ellos, ya que según vimos, el terapeuta les había informado a través de la interpretación de una nueva articulación y de un nuevo sentido que tenía para ellos la espera.

Quiero destacar este elemento para poner énfasis en el concepto de complicidad, ya que en este tipo de grupo entiendo que es la situación más frecuente por la que pasa un terapeuta: lo hacen cómplice de cosas que no han ocurrido en realidad. A su vez, esta complicidad es el resultado de la asunción de roles que obligan a los miembros de un grupo, en contra de sus disposiciones conscientes y que tienen el sentido de contener la enorme confusión y ansiedad surgida de los mensajes contradictorios dados a través de los reforzamientos selectivos y las respuestas

tangenciales tan bien estudiadas en la teoría del doble vínculo y en las transacciones descalificadoras.

Creo que la complicidad se vincula con el tema del *acting out* grupal, conducta a la cual en otros trabajos he considerado como una característica esencial en los grupos terapéuticos.

Así nos explicamos la ansiedad y la agresión despertada en el hijo y la respuesta sometida, disfrazada de tono reflexivo que da el padre. Con ello pide ayuda y permiso al terapeuta, a quien delega a través de una actuación el liderazgo por fracaso en su función.

Vemos aquí los esfuerzos del terapeuta en tratar de reorganizar nuevamente el sistema y traer un elemento histórico del proceso terapéutico dado por el emergente surgido en la sesión anterior, es decir, su condición de judío. Pienso que aquí está tratando de reunir el grupo en función de la ansiedad transferencial adjudicada que lo obliga a traer una interpretación, en este caso histórica. El contenido de dicha interpretación representa algo que, para el *aquí y ahora* del grupo parece fuera de lugar, pero que significa un pedido de ayuda a la memoria como elemento de cohesión, y que sigue la línea del grupo familiar que busca apoyo en lo viejo, ante la imposibilidad de poder enfrentar lo nuevo, con el sentido de integración. Aquí surge la agresión de la hermana, contenta con la ruptura de su hermano con la novia y el temor al castigo, que consiste en no hablar, induce a pensar que este grupo utiliza los modelos de comunicación al servicio de la metacomunicación en función de premios y castigos.

El problema de la medianera surge como un intento de separación de este grupo del afuera y como expresión de una defensa de ellos frente al equipo terapéutico; concordamos con esta interpretación, pero nos preguntamos —y en ese sentido preguntamos al autor— si él no pica que precisamente el problema de la medianera no está a su vez representando la dificultad que tienen los miembros de este grupo para poder discriminarse entre sí como personas, estableciendo entre ellos divisiones instrumentales útiles que les permitan estar unidos y separados al mismo tiempo.

Quiero decir, que la medianera como contorno de este grupo familiar frente al afuera, está en discusión por la dificultad de establecer adecuadas discriminaciones y separaciones entre ellos, como puede verse, por ejemplo, a través del problema de los nombres que no están separados y no tienen entre sí medianeras.

Medianeras que, de alguna manera, y en función del parecido con los nombres, denotan el fondo incestuoso que tiene el problema de este grupo familiar.

Creo que esto puede inferirse desde el nivel de la contratransferencia, ya que el autor nos informa que entre él, que estaba interesado, y el observador, que estaba aburrido, había percibido una separación, pero que dicho impacto contratransferencial alcanzó a ser transmitido al grupo como problema de división frente a lo externo y no como

defensa frente a lo interno. Queríamos saber la opinión del autor en este sentido.

Vemos al final de la sesión y luego de la última interpretación del terapeuta, la ubicación que cada uno de los miembros toma con respecto a la comunicación y a la absorción de la interpretación. La madre queda en silencio, el padre se somete al terapeuta enfatizando lo interesante de la interpretación, el hijo la rechaza y la hermana lamenta haber hablado, por las represalias que a través del recuerdo infantil (el hermano que le pegó), inducen a pensar que todo el grupo vive al terapeuta como un agresor que resquebraja o altera la precaria estabilidad de este grupo.

En este contexto, el silencio de la hermana aparece como un inductor de la regresión y puede conducir a un enquistamiento autista grupal.

La sesión termina con una discusión en donde parecen decir que el hablar no tiene mucho sentido, con lo cual, a nuestro juicio, el grupo repite el problema planteado desde el principio de la sesión, sancionando en el *aquí y ahora* al terapeuta como el miembro enfermo que introduce la discordia.

Por eso estamos de acuerdo con el autor cuando nos dice que la práctica clínica muestra que el enfermo mental es segregado y no reconocido como propio y producido por su familia y su cultura.

A través de lo que vemos en esta sesión, el grupo trata de evacuar, en la figura del terapeuta, la segregación, la confusión, la espera y el abandono a que lo somete.

Entendemos que comprender así el proceso terapéutico integrado, como lo hace el doctor Berenstein, sus sanciones y su rol dentro del proceso, es lo que permite a través de las sucesivas interpretaciones el logro del *insight* necesario para la adecuada elaboración del problema grupal.

Observamos aquí una clara integración de la técnica interpretativa y la teoría referida a la misma, cuando el autor alude a sus hipótesis acerca de la relación transferencia-contratransferencia.

En este sentido, vuelvo a estar de acuerdo con el doctor Berenstein. Considero que el fenómeno transferencia y contratransferencia es una piedra fundamental de toda terapia que aspira a una modificación de estructura.

Con todo, queríamos saber algo más de esto.

¿Cómo ve el autor el proceso de curación en un grupo? ¿Toma en cuenta la regresión en función de la enfermedad grupal y el proceso terapéutico?

Personalmente seguimos las líneas básicas de Melanie Klein, la Escuela Inglesa, Ezriel, Bion y de Pichon Rivière. Este último toma la enfermedad grupal familiar como un momento de un proceso más amplio, que tiene una situación patogénica inicial (duelo central) y una situación patoplástica instrumental como defensa frente a las ansiedades paranoides, depresivas y confusionales que surgen como consecuencia

de la elaboración de la situación primitiva. Dicha elaboración se da en las tres áreas: mente, cuerpo y mundo, y evoluciona de acuerdo a los particulares estereotipos de conducta detectados a través de la fantasía inconsciente de la sesión.

Las interpretaciones del terapeuta tienden a hacer conscientes y manifiestos distintos aspectos que permanecen inconscientes del *aquí y ahora* a través del aboraje de microsituaciones, dentro del grupo, que actúan como representantes del o los aspectos del conflicto central.

El *insight* logrado redistribuye, reubica roles y fragmenta la deposición de la ansiedad del conflicto entre los miembros y no en uno solo de ellos todo el tiempo. Con ello, al evitar la fijeza y la segregación, se disminuye el nivel psicótico y omnipotente de recuperación patológica y culpa persecutoria instalada en la estructura grupal.

Aquí nos encontramos ante otro problema: ¿Cuándo se da por terminada una terapia de grupo familiar? ¿Dependerá de los objetivos de la primera entrevista? ¿La redistribución de roles, podrá incidir en otro miembro y ser éste el que verdaderamente necesite terapia?

Es un buen tema para discutir en este Congreso.

Agrego un punto más acerca de la transferencia. Creo que la transferencia grupal tiene tres niveles que se dan simultáneamente. Con la figura central del terapeuta, con los otros integrantes del grupo y finalmente con el grupo en sí mismo, como estructura, como ente abstracto. No voy a desarrollar este punto, sólo quiero señalar que la integración triádica, con el tercero incluido, forman la base de la situación social que se incluye como objeto al cual se transfieren y contratransfieren pulsiones.

Felicitó a los organizadores y espero que como resultado de este Congreso la terapia del grupo familiar reciba el espaldarazo definitivo en nuestro medio.

Correlato del trabajo "Familia y estructura familiar"
del doctor Isidoro Berenstein

Un modelo transaccional de las relaciones familiares
del paciente esquizofrénico

CLOË MADANES SOJIT *

El doctor Berenstein nos presentó un interesante modelo para el estudio de familias. A través de un ejemplo clínico, nos mostró cómo la misma estructura escindida y el uso de mediadores se manifiestan en diferentes planos de la organización familiar: en la dimensión temporal y espacial; en el sistema de denominaciones; en el sistema religioso; en la circulación del dinero y en el sistema de ocupaciones. El modelo del doctor Berenstein se basa fundamentalmente en los conceptos de estructura y sistema de relaciones. Con el objeto de ampliar esta perspectiva, voy a presentar un modelo para el análisis de la interacción en familias de esquizofrénicos, basado en conceptos derivados de teoría de los juegos y de teoría de la comunicación.

Todo modelo implica una simplificación de la realidad, ya que es necesario limitarlo a un número finito de variables específicas. De otra manera, es imposible derivar conclusiones que se puedan someter a pruebas empíricas. Una vez elegidas las variables que se incluirán en un sistema, debemos admitir que si se hubiera elegido otro conjunto de variables, nuestro modelo podría haber sido bien diferente. En otras palabras, no hay nada absoluto respecto a ningún modelo en particular. Dos modelos pueden utilizar variables diferentes sin que ninguno de los dos esté necesariamente equivocado.

Hecha esta aclaración, veamos cuáles son los conceptos más importantes sobre los que se basa nuestro modelo de la interacción en familias de esquizofrénicos.

Consideramos que cada individuo en cada momento de su vida tiene un número limitado de cursos de acción alternativos. Llamamos grados de libertad de la conducta al número de estas alternativas de

acción posibles para un sujeto en un momento dado. A veces, la limitación en el número de alternativas está dada porque un sujeto sólo aprendió determinada forma de relacionarse con los demás y las otras formas no entran dentro de su universo de posibilidades. A veces, las alternativas de acción de los demás interfieren con las de uno y las limitan. La diferencia entre salud y enfermedad mental podría así definirse en términos de grados de libertad de la conducta, donde la mayor patología correspondería al número de grados de libertad más reducido. Es aquí donde ubicamos al paciente esquizofrénico, considerando que el número de cursos de acción alternativos que se le presentan es sumamente reducido. Para poder definir cuáles son estas alternativas, es necesario tomar en cuenta los siguientes conceptos de teoría de los juegos.

Se llama a un individuo "racional", si toma en cuenta las consecuencias de los diferentes cursos de acción alternativos que se le presentan en una situación dada; si tiene un cierto orden de preferencias entre las alternativas, y si elige aquella que, a su parecer, llevará a la consecuencia más preferida. A veces, el resultado depende de los cursos de acción que otros individuos elijan, cuyo orden de preferencias puede ser muy distinto, y sobre los cuales nuestro sujeto puede no tener control alguno. Un individuo es "racional" si toma estas cuestiones en consideración y si, a su vez, imputa racionalidad a los otros. Llamaremos "juego" a una contienda en la cual se asume la completa racionalidad de los contrincantes.

Se supone que los diferentes resultados de las elecciones que realiza un sujeto tienen asociadas diferentes magnitudes de una cantidad llamada "utilidad". Por ejemplo, si el orden de preferencias de un sujeto en materia de helados es: chocolate, crema y frutilla; podemos asignar una utilidad más alta al chocolate que a la crema y a la crema que a la frutilla. Se asume, además, que en cada situación de juego, el objetivo de un individuo "racional" es maximizar su utilidad esperada, tomando en cuenta los esfuerzos de los otros jugadores "racionales", que tratarán de hacer lo mismo. Puede ser imposible determinar el valor "verdadero" de las utilidades por medio de ningún experimento, pero esto es irrelevante. Es suficiente construir una escala de intervalos, donde el punto cero y la unidad pueden ser arbitrarios.

La situación donde hay dos jugadores cuyos intereses son diametralmente opuestos, se llama juegos de suma igual a cero. Cada uno de los contrincantes en este juego puede realizar una elección entre varias alternativas, ignorando cada uno la elección que el otro va a realizar. Cada par de elecciones así realizadas determina un beneficio para cada jugador. El juego se llama de suma igual a cero si el beneficio de cada jugador es la pérdida del otro. Ningún resultado depende exclusivamente de un jugador, sino que, aunque cada uno controla sus propias elecciones, no controla las elecciones del otro. La llamada "solución" de este juego es un resultado que ambos jugadores

* Quintana 2017, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

pueden forzar y que no se puede esperar que sea mejor desde el punto de vista de ninguno de los dos. Una estrategia comúnmente seguida en juegos consiste en elegir conservadoramente la jugada en que, si se pierde, se puede perder menos. Esta estrategia se llama "minimax".

El modelo que voy a presentar se refiere al juego en el que se ven envueltos el esquizofrénico y sus padres, que es un juego sin salida, en el que se perpetúa la enfermedad del paciente. Llegamos a este modelo deductivamente, en el sentido de que, partiendo de las características observables de la comunicación en estas familias, dedujimos de ellas cuáles podrían ser las alternativas y las reglas del juego que llevarían a este tipo de interacción. La elección de las variables que tomamos en cuenta se basó en la integración de los siguientes puntos de vista conceptuales acerca de la esquizofrenia. Consideramos que las múltiples incongruencias observadas por numerosos autores en la comunicación en estas familias, son especialmente críticas cuando se refieren a la identidad del paciente. Consideramos, siguiendo a Haley, que lo que caracteriza la comunicación del paciente esquizofrénico es la constante desafiación o negación de sus propios mensajes hasta el punto de negar que él es el que habla, de desafiar quién es él y qué es. Consideramos que el dilema fundamental del esquizofrénico es el de su identidad. Pensamos que el esquizofrénico es particularmente dependiente de sus padres en el sentido de solicitar su aprobación y confirmación; y que los padres son particularmente dependientes de la dependencia del paciente, que es perpetuada al negarle esa aprobación y confirmación. Pensamos que el esquizofrénico se ve particularmente afectado en su identidad por las características de la comunicación de los padres, porque sabe cuáles son las pautas culturalmente aceptadas para la interacción entre padres e hijos. O sea que un factor crítico es que a las incongruencias internas de la familia se suma la incongruencia entre las pautas familiares y las de la sociedad.

En vista a estas consideraciones, vamos a formular la pregunta que nos interesa, no en términos de etiología, sino en términos de la situación actual del paciente en el momento de la hospitalización. ¿Cuáles podrían ser los cursos alternativos de acción y las elecciones de padres e hijo ante la posibilidad de hospitalización del paciente? Las disyuntivas más importantes para el paciente en ese momento consisten en ser loco o no serlo, y presentar o no determinados síntomas o señales que corresponden a estos rótulos. Esta correspondencia entre la definición de la identidad del paciente (loco o no loco) y los síntomas o señales que lo caracterizan, puede ser congruente o incongruente con lo que es aceptado culturalmente como loco y no loco y como señales que corresponden o no a la locura. De aquí en adelante, llamaremos síntomas sólo a aquellas señales que corresponden a lo que es culturalmente aceptado como índice de locura.

Consideremos, entonces, que el paciente esquizofrénico puede elegir sólo entre cuatro alternativas que son las siguientes:

- 1) Ser loco y no presentar los síntomas correspondientes.
- 2) Ser loco y sí presentar estos síntomas.
- 3) No ser loco y no presentar los síntomas.
- 4) No ser loco y sí presentar los síntomas.

Supongamos que los padres del esquizofrénico también tienen sólo estas cuatro alternativas con respecto a la definición que ellos hacen del paciente. (Para aclarar el contenido de estas alternativas, un ejemplo de no ser loco y sí presentar los síntomas sería decir: "Yo sé que no estoy loco porque me lo dijo Napoleón".)

Supongamos también que los padres y el hijo están jugando un juego de suma igual a cero en el cual sus intereses son diametralmente opuestos. Es decir, cada una de las alternativas tiene determinada utilidad para cada jugador y esa utilidad es la inversa de la utilidad que tiene para el contrincante. Por ejemplo, si el paciente elige la jugada "no estar loco y no tener síntomas", y los padres también eligen la jugada "el hijo no está loco y no tiene síntomas", la combinación de estas dos jugadas del hijo y de los padres tiene un valor positivo para el paciente, por ejemplo de cuatro y un valor negativo de cuatro para los padres.

Asignamos valores o utilidades a cada una de las alternativas del paciente sobre la base de las siguientes hipótesis:

El paciente esquizofrénico valora más que ninguna otra cosa, el acuerdo con sus padres. En segundo lugar, valora el ser consistente con lo que es aceptado culturalmente. En tercer lugar, el esquizofrénico prefiere no estar loco a sí estarlo. Es decir, el paciente prefiere ser inconsistente con los valores culturales y estar loco pero no estar en desacuerdo con los padres. Si el paciente tiene que elegir entre no estar loco, siendo la definición de locura incongruente con la aceptada culturalmente, y estar loco, siendo esta definición la aceptada culturalmente, prefiere estar loco. Siendo las demás condiciones iguales, prefiere no estar loco a estarlo. Cuando el paciente está en desacuerdo con los padres, prefiere que el desacuerdo sea acerca de los síntomas y no acerca de lo que él es, de su identidad expresada por un rótulo. Lo que menos prefiere es estar en desacuerdo con los padres acerca de ambas cosas.

El juego consiste en un total de 16 alternativas representadas en esta matriz de doble entrada. Los valores indican los beneficios de cada par de jugadas para el paciente, los beneficios de los padres son exactamente a la inversa. Como se ve en el cuadro, las cuatro alternativas más valoradas por el paciente son aquellas en que hay total acuerdo con los padres, y dentro de éstas, la mejor es la alternativa en la que todos están de acuerdo en que el paciente no está loco y no tiene síntomas. Las cuatro menos valoradas por el paciente son aquellas en que hay desacuerdo con los padres tanto respecto al rótulo como a los síntomas. De estas cuatro peores

PACIENTE	PADRES			
	LOCO NO SÍNTOMAS	LOCO SI SÍNTOMAS	NO LOCO NO SÍNTOMAS	NO LOCO SI SÍNTOMAS
	+ 1	- 1	- 2	- 4
	- 1	+ 3	- 5	- 2
	- 2	- 6	+ 4	- 1
	- 3	- 2	- 1	+ 2

alternativas, la menos mala es aquella en que el paciente afirma que no está loco y que sí tiene síntomas y los padres sostienen lo contrario.

¿Cómo se jugará entonces este juego entre el esquizofrénico y sus padres? Consideremos el punto de vista del paciente. A él le gustaría jugar a que no está loco y no tiene los síntomas correspondientes, ya que esta alternativa es la primera en su escala de preferencias. Pero si hace esta jugada corre el riesgo de que los padres jueguen a que sí está loco y sí tiene síntomas, y esta combinación de jugadas es la que tiene el valor más bajo para él. El paciente decide, entonces, jugar la jugada en la que, si pierde, tiene posibilidades de perder menos. Esta jugada es afirmar que no está loco pero que sí tiene los síntomas correspondientes a la locura. Ahora consideremos el punto de vista de los padres. Si el paciente elige, como dijimos, la alternativa de afirmar que no está loco pero que sí tiene síntomas, a los padres les conviene elegir la alternativa de afirmar que sí está loco y no tiene síntomas, ya que es esta combinación de jugadas donde el paciente tiene más pérdida. Realizada esta jugada, al paciente le conviene elegir la misma alternativa que los padres, ya que es en el acuerdo con los padres donde está su mayor beneficio. El paciente afirmará, entonces, que sí está loco y que no tiene los síntomas correspondientes. En este caso, los padres elegirán la alternativa de afirmar que

no está loco y que sí tiene los síntomas. Entonces el paciente afirmará lo mismo y jugará a que no está enfermo y sí tiene síntomas, en cuyo caso los padres elegirán la alternativa de que sí está enfermo y no tiene síntomas, y así las jugadas vuelven a repetirse y el juego no tiene salida o solución.

En términos de diálogo, la interacción sería de este tipo:

Paciente: No estoy loco. Oigo voces.

Padres: Estás loco. No oís voces.

Paciente: Sí, estoy loco, no oigo voces.

Padres: No, no estás loco, ya sabemos que oís voces.

Paciente: No estoy loco. Oigo voces.

Y así se completa el ciclo y la interacción vuelve a repetirse.

Este diálogo sirve para ejemplificar el conflicto en el que se ven envueltos los personajes, pero este modelo no se refiere de ninguna manera a un diálogo en particular ni a un diálogo que se repite muchas veces en la vida del paciente. El modelo no representa un corte transversal sino un corte longitudinal en las relaciones en estas familias. Aunque es posible encontrar conversaciones concretas entre esquizofrénicos y sus padres que se adecuan a este patrón, el modelo representa en forma condensada la interacción que tiene lugar en el transcurso de un largo período. Pueden transcurrir meses y años para que el círculo de esta comunicación se complete y vuelva a repetirse. Esto es el aspecto crucial de nuestra teoría.

El juego se repite siempre de la misma manera, independientemente de quién haga la primera jugada y de cuál sea la primera elección.

A través de nuestro modelo teórico hemos llegado a un diálogo concreto que es muy similar a los descritos por otros autores. Veamos en qué consisten estos parecidos y cuáles son las similitudes y las diferencias con algunas teorías acerca de estas familias.

Este modelo es similar pero no idéntico a la hipótesis del doble vínculo. El doble vínculo se refiere a un corte transversal en la conducta; se postula que la esquizofrenia aparece en una persona que ha sido expuesta durante la infancia al impacto repetido de cierto patrón de interacción de naturaleza contradictoria. Nuestra hipótesis se refiere a un corte longitudinal, a una configuración constituida por múltiples diálogos que constituyen, a lo largo del tiempo, una particular forma de interacción. La incongruencia a la que se refiere el doble vínculo ocurre en un momento del tiempo, en una conversación tipo que se repite; las contradicciones en nuestro modelo se refieren principalmente a períodos más largos y pueden abarcar muchas conversaciones diferentes.

Los autores de la hipótesis del doble vínculo enfatizan que lo importante es la repetición de este patrón de interacción y no el contenido de la comunicación. Nosotros enfatizamos que las incongruencias en la comunicación son particularmente críticas cuando se refieren a la identidad del paciente.

		PADRES	
		LOCO	NO LOCO
PACIENTE	LOCO	- 2	- 1
	NO LOCO	+ 2	+ 1

El doble vínculo se refiere a la dificultad del paciente para discriminar entre mensaje y meta-mensaje. Nuestro modelo se refiere a la dificultad para relacionar designación y significado. La diferencia entre la designación (por ejemplo: loco) y el significado (cierto conjunto de síntomas) puede ser considerada un caso particular de la diferencia entre mensaje y meta-mensaje. Los autores de la hipótesis del doble vínculo enfatizan la importancia que tiene para el paciente el responder adecuadamente. Nosotros enfatizamos la importancia que tiene para el paciente el estar de acuerdo con los padres respecto a qué constituye su identidad, y la importancia que tiene para los padres el estar en *desacuerdo* con el paciente.

En una formulación posterior de la teoría, Bateson señala que la incongruencia en los mensajes de los padres es más clara cuando una mitad del comportamiento de los padres precede a un acto del paciente y la otra mitad lo sigue. La primera mitad de la conducta de los padres parece corresponder a determinada modalidad de relaciones interpersonales, mientras que la segunda mitad es una negación de esta modalidad y la sustitución por otra. Esta formulación es más parecida a nuestro modelo.

Es necesario aclarar que, tanto en la hipótesis del doble vínculo como en nuestro modelo, no se trata de contradicciones directas del tipo: A es igual a No A. Estas son evidentemente absurdas y fácilmente descartables. Los autores de la hipótesis del doble vínculo mostraron cómo las contradicciones no son directas debido al uso de maniobras comunicacionales como, por ejemplo, las descalificaciones. Sin excluir

estas maniobras, en nuestro modelo planteamos que si el lapso de tiempo entre la afirmación A y la afirmación No A es lo suficientemente largo, la contradicción no es evidente.

Laing tomó el concepto de mistificación de Marx para describir el efecto de los padres de esquizofrénicos sobre el paciente. Mistificación es la adistorsión de lo que está ocurriendo o de lo que se está haciendo al servicio de los intereses de un grupo sobre otro. Laing señala que este proceso es particularmente potente cuando una persona tiene el derecho de determinar la experiencia del otro. El derecho de los padres es uno de los supuestos en nuestro juego, ya que el tema de la interacción es la identidad *del paciente* y ya que lo más valorado por el paciente es el acuerdo con los padres. En este sentido, las jugadas de los padres son mistificadoras, pero no así las del paciente en cuyas alternativas no existe la posibilidad de opinar acerca de la identidad de los padres.

Voy a presentar, a título de ejemplo, un fragmento de una entrevista con una paciente esquizofrénica y su familia.* Quiero aclarar que este diálogo se refiere sólo a uno de los momentos de la interacción circular. Debido a que el círculo completo de este tipo de comunicación se cumple a través de un largo período de tiempo, no es posible presentar aquí más que un sólo momento del ciclo. Esta conversación ilustra el fragmento de interacción en el que los padres dicen: "Estás loca, no tienes síntomas", y la paciente responde: "Sí, estoy loca y no tengo síntomas"; e inmediatamente los padres comienzan a afirmar que la paciente sí tiene síntomas. En este caso, los padres están representados por el padre y el hermano, pero esto no altera el juego. En este tipo de interacción, es más importante el mantenimiento del juego que la identidad de los jugadores. Se trata del final de una entrevista familiar.

Padre: El doctor tiene que saber qué te desagrada de esta clínica, qué recuerdos feos tenés. (*Este mensaje implica que la paciente es una enferma mental que está en tratamiento con un médico.*)

Paciente: Bueno, yo, eso creo que lo conté ante dos psiquiatras...

Padre: (*interrumpiendo*) Y con respecto al instituto, nena, ¿por qué no te gustaría volver al instituto?

Hermano: ¿Están todos locos?

Padre: No, locos no. Quizás confabulando contra vos.

Paciente: Algunos.

(Aquí vemos cómo el padre y el hermano se refieren a aquellas señales que el terapeuta consideraría que son síntomas, como si no lo

* Quedo agradecida por esta entrevista a la sección Familias del Servicio de Psicopatología del Policlínico "Arión Alfaro", Laus.

fuera, como si fuera posible que se tratara de una percepción correcta de la realidad, y la paciente está de acuerdo con ellos.)

Hermano: Y otros están de acuerdo con vos.

Paciente: Es algo referido a la política.

Hermano: Unos por la izquierda y otros por la derecha.

Paciente: El problema está en que yo me pase a la izquierda o a la derecha. Y yo no me voy a pasar a ninguna de las dos.

(Sigue el mismo juego, aquello que nosotros llamaríamos síntomas es definido como no síntomas y la paciente está de acuerdo.)

Padre: Pero vos te ponés en centro de una observación general.

Paciente: Sí, me pongo en centro de una observación general.

Padre: Pero, ¿hay otras personas también observadas como vos?

Paciente: Puede haber otras personas observadas como yo. Las hay.

Hermano: Pero, ¿quiénes te observan? ¿Los demás compañeros?

Paciente: Los demás, y la gente en los colectivos y todo el mundo.

Soy más conocida que la ruda.

Hermano: ¿Y cómo te creo que te hiciste popular?

(En este mensaje del hermano: ¿Y cómo te creo que te hiciste popular?, es donde más claramente se ve como, después de haber definido a la paciente como loca, y en el contexto de una clínica donde de hecho es definida como loca, el hermano rotula aquellas señales que son justamente las que hacen a la definición de loca, como no síntomas, y pone en duda el que la paciente sea "popular".)

La paciente contesta: Yo creo que me hicieron popular.

Y este diálogo justamente muestra cómo el padre y el hermano inducen el delirio de la paciente, sin definirlo como tal. Unos seis intercambios más adelante, el padre comenta: "Yo creo que es una falsa impresión que tenés vos. ¿Quién te va a observar?" Ahora, lo que antes era definido como no síntomas y directamente sugerido por el padre, comienza a llamarse síntoma, el padre dice "falsa impresión", y ya se comienza a pasar al otro momento de la interacción que precedimos, en el que después que la paciente expresó su acuerdo con ser loca y no tener síntomas, el padre dirá que no es loca y sí tiene síntomas.

¿De qué estrategias podría valerse el terapeuta para modificar este juego en el que se ven envueltos el esquizofrénico y su familia? Una de las posibilidades, a título puramente especulativo, sería la siguiente.

El terapeuta podría comenzar cambiando las reglas del juego, en el sentido de prohibir las jugadas en las que hay incongruencias entre designación y significado. Se eliminarían así las jugadas: "Ser loco y no presentar síntomas", y "No ser loco y sí presentar síntomas". Esta estrategia coincide con el tipo de intervención que haría un terapeuta orientado hacia los procesos de comunicación, ya que éste probablemente señalaría las incongruencias en los mensajes de padres e hijo e intentaría eliminarlas.

Una vez excluidas estas jugadas, quedarían sólo las dos alternativas siguientes:

- 1) Ser loco y sí presentar síntomas.
- 2) No ser loco y no presentar síntomas.

Estas dos alternativas se reducen a: 1) Ser loco y 2) No ser loco, ya que, no siendo incongruentes la designación y el significado, no es necesario referirse a los síntomas.

El terapeuta podría, entonces, cambiar la escala de preferencias del paciente, de manera que el paciente valore más que ninguna otra cosa el acuerdo *con el terapeuta*. Para lograr este acuerdo, el paciente deberá valorar no ser loco y estar en *desacuerdo* con los padres. Supongamos que los valores de los padres siguen siendo diametralmente opuestos a los del paciente.

¿Cómo se jugará, entonces, este nuevo juego entre el esquizofrénico y sus padres? Consideremos el punto de vista de los padres. A ellos les gustaría jugar a que el paciente está loco, ya que esta alternativa es la primera en su escala de preferencias, pero si hacen esta jugada corren el riesgo de que el paciente juegue a que no está loco, y esta combinación de jugadas es la que tiene el valor más bajo para ellos. Los padres deciden, entonces, jugar la jugada en la que si pierden, tienen posibilidades de perder menos. Esta jugada es la de afirmar que el paciente no está loco. Ahora, consideremos el punto de vista del paciente. Si los padres eligen la alternativa de afirmar que el paciente no está loco, al paciente le conviene elegir también la alternativa de que no está loco, ya que lo que más valora es el no estar loco. Por otra parte, si los padres hubieran elegido la alternativa de afirmar que el paciente sí está loco, al paciente le hubiera convenido aún más jugar a que no está loco, ya que el paciente valora en primer lugar el no estar loco y en segundo lugar el desacuerdo con los padres. De manera que la solución de este juego sería la combinación de jugadas en las que tanto el paciente como los padres afirman que el paciente no está loco; y el terapeuta logra así su objetivo de que el paciente no se defina como loco ni manifieste los síntomas correspondientes y de que haya acuerdo entre padres e hijo.

Esta es una de las hipotéticas soluciones a nuestro juego. Algunas otras salidas, de orden menos especulativo, que se pueden encon-

trar, serían, por ejemplo, lograr que el esquizofrénico se dé cuenta de que no tiene que elegir *sólo* entre estas cuatro alternativas, y que considere otras posibilidades, como por ejemplo, no ser loco ni no loco, sino ser artista o psicólogo. Otra posibilidad es la de ubicar al paciente en hogares adoptivos. Así, con otros "padres", el juego cambia radicalmente.

Quiero enfatizar que éstas no son en absoluto soluciones mágicas al alcance del terapeuta. Considero que lo más importante de este enfoque es que es una fuente de ideas para aumentar nuestra comprensión de la naturaleza de los conflictos interpersonales. La utilización de los conceptos de estrategia, utilidad y juego abren nuevos caminos al terapeuta. En cuanto a la puesta en práctica de la terapia, ésta es otra cuestión.

Volviendo al trabajo del doctor Berenstein, veamos algunas de las similitudes y diferencias. Se trata de dos modelos no excluyentes, ya que se refieren a dos niveles diferentes de análisis. Es así como algunos aspectos de mi modelo podrían expresarse en términos de análisis estructural y algunos de los conceptos del doctor Berenstein podrían formularse en términos de teoría de los juegos. Ambos nos referimos a un sistema relacional latente que está más o menos lejos de la conciencia de los participantes. Ambos reconocemos en ciertas familias la existencia de un orden especial a nivel difícilmente perceptible. Ambos reconocemos la existencia de complejas reglas tácitas que regulan las relaciones. El modelo que yo presenté se adecúa a los conceptos de Berenstein, en el sentido de que se podría considerar que el juego de las familias de esquizofrénicos corresponde también a una organización dualista polarizada a ambos lados del eje salud-enfermedad y donde esta organización es parte de un método aplicable a la solución de múltiples problemas. En el modelo del doctor Berenstein, el paciente tiene una función mediadora, de manera que en una formulación en términos de teoría de los juegos, se trataría de un juego donde los intereses no son diametralmente opuestos y donde es posible la colaboración. En mi modelo, no se considera la existencia de mediadores y la colaboración es imposible. Por último, sólo el sometimiento a pruebas empíricas podrá indicar si se justifica la simplificación de la realidad a la que ambos nos vimos obligados para la confección de nuestros esquemas.

Terapia familiar - Un cambio radical

JAY HALEY *

En los últimos veinte años el campo de la psicoterapia ha experimentado dos nuevas evoluciones. Una aproximación tiene su origen en la teoría del aprendizaje y está representada por las diversas terapias tituladas "condicionantes". La otra aproximación tuvo como punto de partida, tal vez, la teoría de los sistemas y se manifiesta en la variedad de diferentes terapias familiares que se practican actualmente. De las dos, la terapia familiar es la que más se aparta de las viejas ideas. Las terapias condicionantes ponen un nuevo énfasis en el cambio de la conducta, ofrecen un conjunto sistemático de operaciones para producir cambios y han dado un nuevo ímpetu a la evaluación de resultados de la terapia. Sin embargo, en las terapias por condicionamiento la unidad del problema y el foco del tratamiento continúa siendo el individuo. Un terapeuta con experiencia psicodinámica podrá estar en desacuerdo con la terapia "condicionante" pero no encuentra ninguna dificultad en comprenderla. Por el contrario, la terapia familiar requiere nuevas formas de pensamiento respecto de los dilemas humanos y de la actitud a tomar frente a ellos.

Generalmente un aprendizaje se desarrolla a partir de lo que los estudiantes aprenden de sus maestros y de la posterior construcción de ideas basadas en otras ya existentes. El campo del conocimiento cambia a medida que las ideas se descartan o se suman, pero el proceso es acumulativo porque el esquema referencial básico se mantiene siempre igual. Sin embargo, en un campo de trabajo se produce ocasionalmente un cambio discontinuo. Cuando esto sucede, las viejas ideas dejan de ser ladrillos para convertirse en piedras en el camino que impiden alcanzar una nueva forma de pensamiento. Muchos innovadores de la terapia familiar dicen que su aproximación constituye un ladrillo insólito respecto de las ideas del pasado. La terapia familiar no es meramente un nuevo método de tratamiento: está basado en una nueva serie de premisas. Desde el punto de vista familiar, lo que

* Philadelphia Child Guidance Clinic, 1800 Bainbridge Street, Philadelphia, Pa., U.S.A.

una vez fue considerado terapia "individual" es entendido como una manera de intervenir en una familia o en otro grupo natural.

Para esclarecer este cambio, se puede oponer al punto de vista familiar la forma tradicional de entender la terapia. Tradicionalmente la unidad de diagnóstico y tratamiento era una persona. El diagnóstico consistía en clasificar a un paciente dentro de un tipo determinado y la terapia era un intento por cambiarlo. Se consideraba que lo que motivaba a un paciente a hacer lo que hacía era una idea, emoción o fuerza existente en su interior, y su situación interpersonal era secundaria. Lo importante lo constituían las formas en que una persona percibía su situación, las expectativas que tenía y de qué manera respondía a las imágenes interiorizadas que traía del pasado. La terapia psicodinámica se basó en una teoría de represión y se centró en gran medida en hacer consciente a una persona de sus motivaciones y sus dinámicas internas. La terapia condicionante buscó cambiar las percepciones aprendidas y la conducta de respuesta que han sido "programadas" en el individuo por sus experiencias pasadas. La terapia grupal con grupos artificiales de desconocidos se basó en la idea de cambiar cada unidad individual dentro del grupo.

Durante la primera mitad de este siglo, muchos terapeutas fueron entrenados en esta estructura de la teoría individual y compartieron la premisa básica de que el individuo era el problema y el objeto de la terapia. Hacia la mitad del siglo se produjo un cambio. La unidad de diagnóstico y tratamiento se convirtió de una persona en una diada. Esto puede parecer un cambio menor, pero llevado a sus conclusiones lógicas se requiere una revisión revolucionaria del enfoque clínico.

No resulta demasiado claro por qué se produjo un cambio en los años 50. Decir que en el campo de la psiquiatría la causa fue una insatisfacción con la unidad individual, resultaría demasiado simple aunque fuera cierto. Mucha gente consideraba, para entonces, que el sistema de diagnóstico psiquiátrico era inadecuado. Era necesaria para los textos de estudio y para la documentación médica, pero las categorías de diagnóstico no podían enfrentar la complejidad de las variaciones individuales ni la conducta cambiante de personas que simplemente no se mantenían dentro de esas categorías. Aún más, se trataba de un sistema de clasificación irrelevante para la terapia. Para esa época también existe insatisfacción acerca de los resultados de los tratamientos individuales. La evaluación de los resultados terapéuticos recién estaba en sus comienzos, pero ya resultaba obvio que la terapia individual no curaba a una cantidad suficiente de personas como para justificar el tiempo y los gastos. Los terapeutas, enfrentados al aumento de fracasos terapéuticos, comenzaron a experimentar con innovaciones. Unas pocas personas estaban comenzando a notar también que cuando el paciente cambiaba con la terapia individual, había consecuencias entre los otros miembros de su familia.

Parece más probable que el apartarse de la unidad individual en

psiquiatría formó parte de otro cambio más general, que puso el acento en las unidades sociales. En los años 50, diferentes campos comenzaron a adquirir una orientación más social. El campo de la etología se desarrolló cuando los investigadores de la conducta animal dejaron de observar al animal individual en el zoológico o en el laboratorio y comenzaron a examinarlo en su ambiente natural. En los experimentos psicológicos, se estudió la relación entre el sujeto y el experimentador a través de las investigaciones sobre distorsión intencional de la experiencia por el investigador. Los hospitales comenzaron a ser considerados como instituciones totales. En las empresas comerciales y en otras organizaciones se intentó poner más énfasis en el sistema que en el individuo y su carácter. Las ideas de la cibernética respecto de los sistemas penetraron en una variedad de campos en las ciencias sociales, dando importancia creciente al contexto de una persona y a sus relaciones con los otros.

La diada. En psiquiatría el cambio se produjo en un buen número de áreas. El primer paso fue un cambio en la explicación de la esquizofrenia. El esquizofrénico era considerado por todos como una unidad aislada: se había apartado de la realidad y había caído en un mundo de fantasías; por lo tanto, su situación interpersonal carecía de relevancia. Con todo, fue en el campo de la esquizofrenia donde se produjeron los mayores cambios cuando se descubrió que los esquizofrénicos tenían madres. En 1948, Frieda Fromm-Reichmann acuñó el término "madre esquizofrenógena" y en 1951 John Rosen incluyó en su libro un capítulo titulado "La madre perversa". La importancia de esta idea no radicaba simplemente en el hecho de que las madres estaban perdiendo prestigio: la unidad del problema estaba cambiando en una persona a una diada.

Cuando se sugirió por primera vez que la psicosis era un producto de la relación madre-hijo, la teoría era sólo etiológica. La madre había hecho algo durante la infancia que había dejado cicatrices en el niño y afectado su desarrollo posterior. Bastante rápidamente comenzó a considerarse que la conducta psicótica era la respuesta del niño —que bien podría tener 40 años— a lo que la madre había hecho con él en aquel momento. Una vez que se planteó la hipótesis de que la esquizofrenia era el producto de una cierta clase de relación, apareció un problema. No había ningún lenguaje para describir relaciones, ni modelos teóricos; ni manera alguna de testar las relaciones entre dos personas. Pero, si se quería investigar si una madre y un hijo esquizofrénico se relacionaban entre sí de una manera distinta que una madre y un hijo normal, era necesario efectuar mediciones acerca de sus conductas mutuas.

El mismo cambio en la unidad se produjo con referencia a patologías menos severas. Los síntomas de una persona comenzaron a describirse como una conducta de respuesta a otra persona. Por ejemplo,

una mujer que sufría una fobia y no podía salir sola de su casa, dejó de ser considerada como alguien que padeció un miedo interno: el cuadro clínico comenzó a incluir a partir de entonces a su esposo. Su "síntoma" fue considerado un acuerdo de la pareja matrimonial respecto de los límites geográficos de la conducta de la mujer. Para decirlo de otro modo, un "síntoma" o un "problema" comenzó a ser definido como un tipo de comunicación con alguien más.

En la década del 50, en el campo de la psicoterapia tuvieron lugar dos cambios: la terapia individual se definió como un intercambio entre dos personas y los terapeutas comenzaron a tratar de cambiar una relación más que un individuo. Con anterioridad a 1950 era posible leer descripciones de terapias en las que resultaba difícil enterarse de lo que el terapeuta dijo o hizo. Se describían los pensamientos, sueños, sentimientos, fantasías o miedos del paciente pero quedaba afuera el terapeuta, excepto en tanto proyección del paciente. Cuando se comenzó a grabar y a filmar las terapias, se hizo obvio que el terapeuta actuaba tanto como el paciente. El paciente respondía a sus ideas internas pero también al interés, desinterés, palabras, movimientos y silencios del terapeuta. Se observó que aun los sueños de los pacientes se adecuaban a los sesgos ideológicos del terapeuta. A muchos terapeutas les resultó incómodo que se los describiera como parte del intercambio con el paciente y prefirieron enfatizar de qué manera el paciente los percibía erróneamente debido a las distorsiones transferenciales.

Con la idea de una diada como unidad, los terapeutas comenzaron a incluir dos personas en las sesiones de tratamiento. Madres e hijos, y marido y mujer, fueron tratados conjuntamente en la misma habitación. Con este cambio, la finalidad de la terapia pasó a ser un intento por cambiar a una persona a tratar de cambiar secuencias de conducta entre miembros de una familia. Los terapeutas buscaron influenciar a una madre y un hijo, o a un marido y una mujer, para que se entendieran entre sí de diferente manera. No había ningún precedente para esta clase de terapia. Al principio los terapeutas utilizaron las mismas ideas desarrolladas en la terapia individual, tratando al marido y a la mujer juntos pero pensando en ellos como individuos e intentando darle a cada uno insight de procesos inconscientes. Más tarde se pasó a ayudar a cada esposo a darse cuenta de lo que le estaba haciendo al otro. Con el tiempo, los terapeutas comenzaron a pensar en la unidad como una diada y no como dos personas. También dudaron cada vez más si el insight y el tomar conciencia provocaban cambios en las pautas de la diada.

Como ilustración, se notó que una pareja sigue reglas en su conducta mutua y que estas reglas pueden requerir un repertorio muy limitado de conductas. Por ejemplo, una pareja podría seguir la regla de que la mujer critica al marido y que él se defiende. Si se ignorara el contenido de lo que dicen y se observara esta pauta, la regla surge

con claridad independientemente de que estuvieran hablando del sexo, del trabajo, de sus suegros o de cualquier otra clase de temas. Se puede poner a prueba la regla señalándosela a la pareja. Uno podría decir, por ejemplo: "Noto que usted critica a su esposo y que él se defiende". La respuesta de la mujer sería: "Bueno, cómo no lo voy a hacer si él nunca hace lo que debe". El esposo podría agregar: "Bueno, yo trato". Hacer que la gente se da cuenta de la regla, a menudo parecía incrementar la conducta y, de hecho, le agregaba un nuevo apoyo. El terapeuta podría ir más lejos y pedir un cambio mediante una directiva. Podría decir al marido: "Quisiera que criticara ahora a su esposa". El marido se esforzaría por pensar alguna y luego podría decir: "Bueno, mi esposa habla bastante". La esposa respondería: "Esa no ha sido una crítica demasiado buena"; y el marido diría: "Es la mejor que se me ocurrió". La pauta se ha restablecido fácilmente. El problema de cómo cambiar esa pauta pasaría a ser el nuevo objeto de la terapia.

La triada. A medida que muchos terapeutas comenzaron a captar la idea de la diada, y a medida que los científicos sociales enfocaron la relación entre dos personas, la unidad comenzó a trasladarse a una mayor. Con más y más frecuencia se oyó hacer referencia a unidades triangulares, a una triada más que una diada. Este cambio coincidió con el descubrimiento de que los esquizofrénicos tenían padres. Cuando se intentó explicar por qué una madre y un hijo se comportaban como lo hacían, la descripción parecía incompleta a menos que se incluyera al padre. Se notó que, cuando la madre se comportaba de manera desesperanzada con su hijo, su conducta desesperanzada estaba en función de su relación con el esposo. Por ejemplo, si ella manejaba bien al chico, el marido dejaba de ocuparse, pero si su trato con el hijo era inadecuado el marido se comprometía más con la familia. Algunas descripciones sobre otras unidades (no familiares) resaltaron una unidad de tres como explicación de ciertas conductas. Stanton y Sewartz en su libro sobre el hospital psiquiátrico en 1953, comentaron que un paciente tuvo un episodio psicótico cuando se produjo un desacuerdo encubierto entre su terapeuta y el coordinador de la sala. Esta observación fue hecha independientemente de las realizadas en la terapia familiar en familias de esquizofrénicos, donde se comunicó que un niño se comportaba en forma psicótica cuando existía un conflicto encubierto entre sus padres.

Con este cambio a una unidad de tres, quedó claro que el niño podía estar respondiendo no solamente a su madre o a su padre sino a la relación entre ambos, aun cuando no estuviera presente en el momento. Un niño podría fracasar al dejar la casa para ir a la universidad y ese fracaso podría responder, al menos parcialmente, a la disrupción existente en su casa cuando él se fue.

El lenguaje adecuado para individuos o diadas resultó inadecuado para hablar de tres personas. Por ejemplo: era posible dividir a las

relaciones diádicas en dos clases: *simétrica*, donde ambos intercambiaban la misma clase de conductas, y *complementaria* donde intercambiaban diferentes conductas. Pero, ¿cómo usar ese lenguaje cuando la unidad que se describía era de tres personas? Para esta nueva unidad fue necesario adecuar nuevos modelos. En una triada es posible hablar de coaliciones de dos contra uno lo cual era imposible en una descripción individual o diádica. Los conceptos de la Teoría de los Juegos comenzaron a incorporarse al campo junto con aportes de la Teoría de los Roles, Teoría de la Información y Teoría de la Comunicación.

El repertorio de innovaciones terapéuticas posibles se amplió juntamente con la gama de aproximaciones teóricas. En los años 50, un buen número de terapeutas comenzó a llevar a tratamiento a familias enteras con el objeto de cambiar las relaciones entre los miembros de la familia. Con frecuencia se dio el que un terapeuta comenzara a hacer esto sin saber que otros también lo estaban haciendo. En pocos años, se desarrollaron alrededor de diez o doce "escuelas" distintas de terapia familiar y hasta hoy continúan apareciendo diferentes enfoques. Estos diferentes terapeutas de familia no comparten necesariamente un método, pero comparten la idea de que la unidad problema consiste en más de una persona y muchos de ellos han pasado a la unidad triádica o mayor aún.

Los terapeutas "condicionantes" han comenzado a ampliar su unidad y realizan tratamiento familiar. Anteriormente, un terapeuta "condicionante" ayudaba a un niño a corregir su conducta. Ahora, los terapeutas "condicionantes" están entrenando a una madre o a un padre para que condicionen al niño. En lugar de pensar en ayudar a una persona están pensando en una ayuda recíproca: la respuesta de una persona es el estímulo para otra que a su vez provoca una respuesta. Sin embargo, los "condicionantes" no han abordado a una unidad de tres; tal vez porque la teoría del aprendizaje no tiene una unidad triádica. Un "condicionante" no describe de qué manera un niño es utilizado en un conflicto entre sus padres: sólo puede describir de qué manera la madre o el padre se entienden con el hijo. Sus descripciones familiares consisten en un juego de diadas y, por lo tanto, su aproximación difiere de la de los terapeutas familiares que han incorporado unidades mayores.

Ejemplo de diferentes puntos de vista. Para explicar de qué manera el diagnóstico cambia si se piensa en diferentes unidades, es posible presentar un ejemplo. Digamos que un adolescente comete algún acto delictivo, como robar un automóvil. Es un muchacho de una correcta familia de clase media y no un delincuente de gavilla. Cuando tratamos de explicar sus motivos para cometer este acto, nuestra explicación diferirá según nuestra unidad de observación.

Si nuestra unidad es el chico, debemos explicar que robó el auto

por algo de sí mismo y de su naturaleza. Podríamos decir que es un inmoral, que tiene una conciencia débil, que está expresando sentimientos de rebelión adolescente contra el "establishment" o que carece de control sobre sus impulsos. También lo podemos explicar en términos de sus necesidades o decir que es un irreflexivo, o podemos considerar qué significado simbólico tiene un auto para él. La variedad de posibilidades causales tendrían necesariamente que incluir sólo a él puesto que se le ha definido como el que tiene el problema.

Si pensamos en términos de una diada, deberíamos incluir en nuestra descripción a por lo menos dos personas. Podríamos decir que el acto fue realizado en complicidad con un igual, o podríamos decir que su madre o su padre no fueron lo suficientemente firmes en darle una disciplina correcta. La madre fue demasiado permisiva con él, o el padre está alentando esta clase de conductas porque obtiene una satisfacción vicaria del mal comportamiento del hijo. Nuestra explicación podría variar, pero el problema serían el chico y otra persona.

Si el investigador realizara su descripción en términos que incluyeran a tres personas, describiría el acto como parte de un intercambio triangular. Por ejemplo, muchos terapeutas familiares dicen que cuando una pareja matrimonial está por disolverse y buscar el divorcio, el hijo de alguna manera se pondrá en dificultades. Los padres se unirían nuevamente para tratar el problema y el matrimonio se estabilizaría. Desde este ángulo, el niño está ayudando a mantener la unión de la familia a través de su acto delictivo. Esta es sólo una de las muchas posibles explicaciones de conducta triangular, pero ilustra la manera en que muchos terapeutas familiares ven la función de un problema del hijo dentro de la relación matrimonial. Consideran al hijo como un vehículo de comunicación entre los padres. Otro ejemplo: el padre y la madre podrían estar en conflicto acerca de la masculinidad del padre pero resultarles imposible tratar directamente entre sí el problema. Por lo tanto, están en desacuerdo en cuanto a si el hijo es o no demasiado afeitado, la madre diciendo que lo es y el padre que no. El hijo debe comportarse de manera lo suficientemente afeitado como para otorgar sentido a la posición de la madre y lo suficientemente masculino como para apoyar el punto de vista del padre. Cuando los padres pueden tratar directamente entre sí este conflicto, el hijo queda libre de ser diferente.

Resultaría evidente que cada una de estas explicaciones de un problema es "cierta" según cuál unidad de observación se considere. Sin embargo, la elección de la intervención terapéutica se determinará de acuerdo con la explicación que se utilice.

Desde estos diferentes puntos de vista, el mismo encuentro terapéutico adquiere características muy distintas. Por ejemplo, un terapeuta puede estar tratando a una mujer por accesos de ansiedad. Si piensa en términos de unidad individual, observa su problema como una expresión de su naturaleza interna: tiene miedos relacionados con su pasado.

Un observador que piensa en díadas incluiría dos personas en la descripción de la mujer. Podría decir, por ejemplo, que la ansiedad cumple una función en la relación de la paciente con su esposo. O argumentar que la mujer continúa teniendo ansiedad porque debe tener algún problema en la continuidad de su vínculo con el terapeuta. La suposición sería que "los períodos de ansiedad" son una manera de comunicación entre dos personas.

Si el observador pensara en unidades de tres, tomaría como su unidad a la compuesta por el terapeuta y la mujer y su esposo. Diría que viendo en la terapia a la mujer sola, el terapeuta ha estado interviniendo en su matrimonio de una manera particular. Podría suponer que el marido ha estado pagando al terapeuta para que viera a su mujer con la intención de que ella no exija demasiado de él. O podría describir las consecuencias que trae al marido el hecho de que su mujer vaya a hablar sobre él con otro hombre. Podría enfatizar el efecto que produce en la lealtad de un matrimonio que un terapeuta vea solamente a uno de los esposos. Por ejemplo, podría mostrarse intranquilo respecto de lo que sucede en una pareja cuando la mujer le cuenta a su terapeuta experiencias que no comenta con su marido. La "ansiedad" podría inclusive describirse como la reacción de una mujer que se encuentra en una situación triangular con su esposo y el terapeuta, cualquiera hayan sido las razones anteriormente atribuidas a la "ansiedad" que originariamente la llevaron a la terapia.

Todos estos observadores estarán hablando del mismo caso. Sus ideas sobre qué está mal y qué necesita ser modificado variará de acuerdo a la unidad descriptiva que elijan. Cada uno de ellos opinará que quien enfoca su descripción en otra unidad peca de superficial y pasa por alto los factores importantes del caso. Que se produzcan o no acuerdos, dependerá, hasta cierto punto, de la mayor o menor discontinuidad que presente cambiar el criterio de una unidad de uno por el de una unidad de dos y por el de una unidad de tres o más.

La unidad mayor. En los últimos años la unidad ha alcanzado números aún mayores. Hacia fines de la década del 50, los terapeutas mencionaron la importancia de los demás familiares y durante la década del 60, se enfatizó el marco ecológico de la familia. Algunos terapeutas familiares están disconformes con la palabra "familia" porque están interesados en cualquier grupo natural, todo grupo que comparte un pasado y un futuro. Esta variante significó el tratamiento de varias generaciones y también entrevistas con la familia más otras personas que estuvieran relacionadas significativamente con ella, incluyendo otros auxiliares profesionales. Con el agrandamiento de la unidad se produjo la invasión del campo por teorías sociológicas. Durkheim propuso en el siglo pasado que cada grupo necesita un miembro desviado, a función del desviado es comportarse inadecuadamente para que el resto de los miembros del grupo pueda conocer las reglas de conducta

apropiadas. Asegura que si un grupo no tuviera un miembro desviado, produciría uno para poder funcionar. Si es así, entonces cada grupo natural —una familia, o cualquier otra clase de grupo— necesitará siempre un miembro desviado. Los terapeutas que producen un cambio en este miembro, estarán forzando al grupo a producir otro miembro desviado. Esta idea tiene tales implicancias para la terapia que quizás hubiera sido mejor no haberla considerado.

Así como la década del 50 incorporó el contexto familiar del individuo, la década del 60 tuvo en consideración el contexto social de la familia. Hubo una creciente toma de conciencia de que la familia no es más que uno de los múltiples grupos sociales que deben tenerse en cuenta en la terapia. Por ejemplo, en el caso de un chico con fobia escolar, el problema podría residir en la familia o en la escuela o en interjuego de la familia y la escuela. La conducta de un delincuente puede implicar a su familia o a su grupo de compañeros o al conflicto que existe entre ambos. El desarrollo de centros comunitarios de salud mental y un nuevo interés por las familias de medios pobres creó la necesidad de considerar contextos sociales más numerosos que la familia. La intervención de un programa gubernamental de bienestar social dentro de una familia, la privación de un vecindario o las reglas culturales propias de una familia, forman parte del cuadro de un problema psiquiátrico. Un síntoma puede no solamente envolver a dos o tres personas, sino que puede ser producto de una condición de vivienda hacinada que afecta adversamente a toda la gente que la padece. En este período los terapeutas están aprendiendo a pensar en la influencia de la comunidad y también están adquiriendo experiencia trabajando en enfrentamientos de grupos en conflicto. La calle, el trabajo o el hogar deberían ser el encuadre donde actúa el terapeuta, y los terapeutas que se ocupan de los jóvenes con problemas de drogas, deberían realizar la terapia en el parque donde se reúnen los grupos de gente joven. Los terapeutas se están mudando de sus consultorios a la comunidad, con consecuencias para su práctica y para sus esquemas teóricos.

Diferentes premisas. El terapeuta que ha modificado su pensamiento de la consideración de una persona como problema a la de una díada o tríada o una unidad más numerosa está cambiando también una serie de premisas sobre los dilemas humanos y sus soluciones. Algunas de esas premisas pueden ser opuestas a aquellas con que fue entrenado. Las premisas de los terapeutas familiares pueden ser sintetizadas, sin olvidar que los terapeutas familiares constituyen un grupo heterogéneo y que difieren en sus conceptos tanto como en sus modos de trabajar con familias. Existen actualmente terapeutas que recién empiezan a trabajar con familias y que tienen una ideología individual que puede estar en desacuerdo con la de terapeutas con muchos años de experiencia en el trato con familias. Dando por sentado los dife-

rentes puntos de vista a medida que adquieren experiencia, la mayoría de los terapeutas tienden a compartir un punto de vista; en parte porque la lógica del cambio de unidad los conduce a premisas comunes. Puede describirse algunos de los puntos de vista en común haciendo referencia a las maneras en que un terapeuta familiar recoge información, hace un diagnóstico e interviene para producir el cambio.

Recolección de información. Durante la entrevista, el terapeuta familiar desea descubrir lo que está sucediendo en ese momento en la vida de la familia. Puesto que asume que la psicopatología es una respuesta a una situación actual, dedica poco tiempo a revisar la historia o a examinar el pasado. Para recoger información prefiere observar a los miembros de la familia interactuando entre sí. Aunque no suele tratar a la familia como grupo, prefiere tener aunque sea una sesión para poder observar su interacción. Debido a su interés en las secuencias y pautas de conducta de la familia, se dedicará más a observar que a escuchar el relato de una persona sobre su familia. Lo que alguien dice acerca de sí mismo y su familia puede o no estar relacionado con lo que está realmente sucediendo y a menudo provee escasa información relevante para planear una intervención terapéutica.

Cuando los miembros de la familia hablan, el terapeuta familiar los escucha de una manera especial. No toma lo que dicen como un mero relato sobre sus estados internos o sus percepciones, sino que le interesa entender qué función cumple el planteo dentro de la situación. Por ejemplo, si una mujer dice: "No soy feliz", no lo toma como una simple manifestación acerca de sus sentimientos, sino como un mensaje dirigido hacia los demás. Puede ser un pedido de que otra persona haga algo al respecto, o puede ser una propuesta para establecer una coalición con el terapeuta contra otros miembros de la familia, y así sucesivamente. El "tercer oído" del terapeuta familiar está atento al efecto que produce el planteo de una persona en los otros.

Lo que más interesa al terapeuta familiar es la información estructural. Quiere saber si hay una fractura de líneas generacionales, como por ejemplo un padre uniéndose a un hijo contra otro, o un marido uniéndose a su madre contra su mujer. Quiere saber de qué manera el hijo es utilizado como vehículo de comunicación entre sus padres. Está tan interesado en la coalición del hijo dentro de su estructura fraternal como en la participación financiera o de cualquier otro tipo, de pacientes más lejanos. Cuando trata con una familia pluritratada, quiere saber cuántos profesionales intervienen en la familia y de qué manera.

Para un terapeuta familiar, la información más importante tal vez, es los modos en que la familia responde a sus intervenciones. Es de crucial importancia cómo la familia lo usa en sus peleas, así como si cumplen o no sus instrucciones. Por ejemplo, si el padre dice que tiene dificultad en hablar con su hijo adolescente, el terapeuta familiar puede

desea información observable acerca de esta dificultad. Le pedirá al padre y al hijo que hablen juntos allí, en la sesión, para que él pueda entender cómo se tratan entre sí y en qué medida la madre se inmiscuye con ellos. Solamente observando la acción puede el terapeuta obtener esta información. Idealmente, la recolección de información y la intervención para producir un cambio ocurren simultáneamente en la sesión terapéutica.

Diagnóstico familiar. Muchos terapeutas se han vuelto renuentes a pensar en un individuo como normal, neurótico o psicótico y con este cambio abandonan el diagnóstico individual. Es aceptado que una persona llamada neurótica se comporta de manera diferente a una definida como normal porque está respondiendo a una situación distinta. Cuando una situación — y no una persona — es considerada psicótica, la inevitable pregunta que surge es si una persona normal, ubicada en una situación psicótica, sería o no diagnosticada como psicótica. El hecho de que los psicóticos parezcan comportarse de formas tan extremas se vuelve explicable cuando se examina la situación extrema en que viven.

Cuando se acepta la idea de que un problema abarca a más de una persona y es una respuesta a una situación actual, necesariamente se llega a entender que la conducta sintomática es la conducta apropiada. El síntoma tiene una función adaptativa en las relaciones íntimas de la persona y no es irracional ni desadaptado. La pregunta diagnóstica es: qué clase de situación está provocando esta clase de adaptación. Por ejemplo, si una persona está deprimida, la pregunta que debe hacerse el terapeuta familiar no es qué tipo de persona es esa o qué experiencias pasadas lo llevaron a esa conducta. La pregunta es: qué función tiene la depresión en la situación actual y de qué manera es adecuada a lo que está sucediendo.

Desde el punto de vista familiar, si los síntomas persisten es porque perdura la situación social que los exige. También se acepta que los cambios "espontáneos" en los síntomas pueden ocurrir porque con el tiempo la vida familiar cambia. Las familias no sólo tienen estructuras que difieren unas de otras, sino que cada familia debe pasar por etapas que tienen características diferentes. Por ejemplo, un joven puede presentar varios problemas, incluyendo conductas psicóticas, cuando vive en una situación social particular con sus padres. Cuando se casa puede cambiar, si ese matrimonio lo ayuda a desligarse de sus padres de una manera exitosa, creando una nueva estructura social que incluye una base normal fuera de la familia.

La lógica del enfoque familiar conduce a una inversión del pensamiento tradicional sobre la causa de las conductas. Más que asumir que una persona tiene una predisposición a caer en la anormalidad ante situaciones de stress, se acepta que la situación de stress es diferente para cada persona. De la misma manera, más que asumir que

una persona busca cierta clase de relaciones debido a sus dinámicas internas, se acepta que sus dinámicas son un resultado de las relaciones en las que vive. Lo que era considerado beneficio primario y secundario está invertido.

La unidad de diagnóstico para el terapeuta familiar no es ya el individuo, pero tampoco es la familia. Tal terapeuta considera que la forma en que se comporta la familia está influenciada por cómo él mismo la trata y, por lo tanto, se incluye en la unidad diagnóstica. Así como tiene la premisa de que la familia o el medio hospitalario influyen en la conducta psicótica, asume que el contexto terapéutico contribuye a determinar lo que se dice o hace. No examina simplemente cómo los miembros de la familia reaccionan entre sí, sino cómo reaccionan en su presencia. Desde este punto de vista, la formulación de un "problema" familiar es inevitablemente una aventura conjunta entre el terapeuta y la familia.

Para un terapeuta familiar tal vez la premisa más importante sobre diagnóstico es el detectar hasta qué punto una familia es cambiante. El diagnóstico se centra en la manera en que la familia responde a sus intervenciones terapéuticas. Como lo expresó un terapeuta familiar: "Diagnosticar es observar cómo se mueve una familia cuando uno la empuja". Puesto que el interés del diagnóstico reside en cómo responde la familia al terapeuta, el diagnóstico sólo puede darse como un resultado de la acción terapéutica.

Cómo producir cambios. Cuando la unidad con el problema está definida como de dos o más personas, inevitablemente la terapia busca lograr un cambio en la forma en que la gente interactúa entre sí. La secuencia de comunicación entre familiares es el foco del cambio. Desde este enfoque, las ideas sobre levantar la represión, expresar emoción al estar solo con un terapeuta, o tomar conciencia de cómo uno se entiende con otras personas, son cuestiones marginales. Las causas del cambio se centran en la forma en que el terapeuta interviene en la familia y requiere una secuencia de conductas diferentes entre los miembros. Puede que el terapeuta familiar tenga una entrevista con una persona, o con la familia completa, pero de hecho está exigiendo activamente conductas diferentes.

En la breve historia de este arte han existido pocas explicaciones de por qué la gente cambia con la terapia. Existió la idea de que el insight de los procesos inconscientes dentro de un sistema transferencial produce el cambio. Luego existió la noción de que cuando se ayudaba a una persona a tomar conciencia de cómo se entendía con otra gente se favorecía el cambio asumiendo que podía controlar conscientemente su conducta. Cuando la unidad está compuesta por más de uno, la causa del cambio debe incluir a más de una persona. Habitualmente, el terapeuta familiar habla a los miembros de la familia acerca de comprenderse mutuamente porque ellos esperan eso, aun

cuando no considere que esto los conducirá necesariamente a cambiar. Tiende a considerar que el cambio sucede por el modo en que se ha introducido en la red íntima de una persona. La clave para el cambio está dada por la forma en que el terapeuta se alía con diferentes miembros de la familia, cómo los estimula o les exige comportarse de manera diferente entre sí y cómo devuelve la responsabilidad del cambio a la familia.

El enfoque familiar se aparta de manera radical de muchas concepciones previas. Asume que expresando hostilidad o explorando las conductas indeseables en la familia puede impedir más que alentar el cambio. Enfatiza la necesidad de crear un sistema positivo dentro del cual los miembros de la familia pueden sentirse motivados a entenderse entre sí de manera diferente. Se enfatiza asimismo más los resultados que el proceso de la terapia. Si el cambio no se produce, la terapia no anda bien, no importa lo adecuadamente que la familia hable de su problema o exprese sus emociones. Como corolario, en parte del énfasis en los resultados, muchos terapeutas familiares tienen un enfoque centrado en el problema que en el método. Lo que hacen con la familia depende de cada familia. Puede que entrevisten a un marido y a su mujer por un problema, al núcleo familiar por otro y aún a toda la familia incluyendo los demás parientes y otras personas significativas por otro.

Por lo tanto, la terapia familiar no es tan fácil de describir como el psicoanálisis o la terapia de la conducta, donde hay una serie de métodos a seguir, cualquiera sea el problema.

Puesto que el terapeuta familiar entiende a la conducta anormal como una adaptación a una situación anormal, asume que la persona no puede cambiar a menos que cambie su situación. También asume que la conducta anormal puede reaparecer nuevamente si una situación así lo exige. Ha abandonado la ilusión de que la terapia va a "aclarar" una neurosis o una psicosis del interior de una persona y que ésta nunca volverá a ser anormal otra vez. Cuando se observa a la gente en tanto responde a situaciones sociales y se comprueba cómo son impulsados por las respuestas de otras personas, el problema del libre albedrío adquiere nueva forma. Los terapeutas, tanto como los pacientes, son considerados respondiendo a su situación. Por ejemplo es posible que un terapeuta tenga la ilusión de que puede cambiar su teoría terapéutica y su práctica si así lo quiere. Sin embargo, su contexto interpersonal determinará en gran medida tanto sus ideas como la clase de terapia que hará.

El efecto en las profesiones. Como parte de los cambios en las premisas sobre la naturaleza de un problema y qué hacer con él debe producirse un cambio en las profesiones asistenciales. Tradicionalmente, un problema psiquiátrico era considerado un problema médico. Por lo tanto era correcto que un psiquiatra entrenado médicamente

fuera la autoridad principal y tuviera el mayor status y salario. Los asistentes sociales y los psicólogos eran considerados personal auxiliar. Desde el momento en que la unidad pasa ser una persona a ser dos o más, el esquema referencial médico debe ser abandonado. Los problemas psiquiátricos pasan a ser definidos como dilemas sociales. Si la unidad es un marido y una mujer, una madre y un hijo, o toda la familia, no es apropiado pensar en un modelo de enfermedad, o pensar en términos de salud y enfermedad.

Como la unidad de tratamiento cambió y el problema se ha redefinido, inevitablemente las profesiones deben cambiar. Por ejemplo, en un Servicio de psiquiatría infantil, cuando la unidad del problema era un niño, el tratamiento se realizaba dentro de un sistema médico y todos los profesionales tenían una función que estaba relacionada con su entrenamiento. Habitualmente, el psiquiatra de niños trataba al chico, que era la unidad enferma, el asistente social veía a los padres y el psicólogo hacía los tests, si era necesario internar al niño, era cuidado por la enfermera psiquiátrica, bajo supervisión médica. En un Servicio de psiquiatría infantil actual, el psiquiatra de niños trata a toda la familia, el asistente social trata a toda la familia y el psicólogo trata a toda la familia. También existen varios programas de especialización para enseñar terapia familiar a las enfermeras. En las clínicas de adultos puede comprobarse el mismo cambio y las diferencias entre profesiones están desapareciendo. ¿Qué tiene que ver el entrenamiento profesional tradicional con este nuevo tipo de terapia? Puesto que ninguna de las profesiones ha demostrado mayor habilidad o mejor entrenamiento en terapia familiar, ¿por qué habrá de tener una de ellas más status o salario que otra? Actualmente se juzga al terapeuta por su mérito: el éxito de su tratamiento y no en base a sus antecedentes profesionales. Este es tal vez el cambio más radical que ha introducido en nuestro campo la terapia familiar.

Correlato sobre el trabajo "Terapia familiar - Un cambio radical" de Jay Haley.

Consideraciones acerca de la articulación de lo intrapsíquico y lo interpersonal y sobre el insight en la terapia familiar

HUGO BLEICHMAR *

Jay Haley es un autor no convencional, que se problematiza acerca de cuestiones que habitualmente se dan resueltas y como no merecedoras de nuevos interrogantes. Su trabajo presentado en este Congreso constituye un nuevo ejemplo de esa actitud intelectual y por ello le debemos agradecer el obligarnos a pensar sobre lo que aparentemente es sólido para nosotros. No me detendré en los múltiples aspectos de su trabajo, con los que concuerdo, sino en aquellos que, a mi juicio, pueden dar lugar a una polémica fructífera. Para ello, examinaré dos grandes temas que se pueden seguir a lo largo de la presentación de Haley: en primer término el problema de cómo interactúan en la determinación de la conducta normal y patológica de un individuo su estructura de personalidad y la red de relaciones interpersonales en que se halla inmerso y en segundo lugar cuáles son los distintos medios que se pueden utilizar para producir cambios en las relaciones familiares.

Comencemos por el primero de los puntos señalados, o sea la relación entre estructura de personalidad e influencias interpersonales en la determinación de la conducta. Dice Haley al respecto: "la mayoría de las terapias de familia han llegado a ser reacios a pensar en un individuo normal, neurótico o psicótico y con este cambio abandonan la mayoría de los diagnósticos individuales", y agrega, como posición que contrapone a la de los diagnósticos individuales: "se supone que una persona a la que se denomina neurótica, se comporta de una manera diferente a la de una persona definida como normal porque ella está respondiendo a una situación diferente". Poco más adelante sostiene Haley: "El hecho de que los psicóticos parezcan comportarse de manera tan extrema se hace explicable cuando es exami-

* Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Servicio de Psicopatología y Neurología. Policlínico "Arzobispo Alfaro", Luján, Provincia de Buenos Aires.

nada la extrema situación en que viven". O sea que para esta concepción la situación determinaría lineal y unilateralmente la respuesta del individuo que se halla en esa situación. Enfatizo lo de lineal y unilateralmente pues no cabe duda y está fuera de toda cuestión que la situación externa influye de modo esencial en la estructuración de la conducta de un individuo. Lo que parece cuestionable es convertido en el único factor, en desechar la estructura de la personalidad como una "variable interviniente" ubicada entre el estímulo y la respuesta. Si no todos los individuos colocados ante situaciones externas similares reaccionan de igual manera quiere decir que hay algo más que la situación externa al individuo para definir el sentido que toma la conducta. Ese algo es la estructura de la personalidad. Pensar de otro modo es suponer que todo individuo es tan inestructurado en su personalidad y con una gama tan amplia de posibles respuestas de modo tal que pueda moldearse en base a los factores externos siguiendo las características de esos factores. Pero a esta altura de la exposición se me puede formular un interrogante. ¿No estaré malentendiendo a Haley y lo que él nos quiere decir es que un niño devendrá en neurótico o psicótico si es sometido en forma reiterada a situaciones neuróticas o psicóticas? Con esto sí podría concordar, pero Haley se encarga de disipar las dudas; no habla en realidad exclusivamente del niño y de su plasticidad frente al medio sino que se refiere al adulto como en el caso del psicótico de 40 años de edad, o cuando dice explícitamente: "Desde el punto de vista del terapeuta de familia si los síntomas persisten es que está perdurando la situación social que requiere de los síntomas". Es decir, que para Haley no es que el pasado haya quedado interiorizado en forma de patrón de conducta, cristalizado en la estructura de personalidad del individuo, sino que es indispensable que en el presente se estén dando las circunstancias externas que determinen tal conducta. El pasado interiorizado desaparece y sólo cuenta el presente. Si esto fuera cierto, cómo explicar entonces que el psicótico siga alucinando o delirando en el consultorio del terapeuta cuando está a solas con él y sin que el terapeuta se comporte como los miembros de su familia original. Para explicar esto es necesario admitir que independientemente de cuál ha sido la causa por la cual un individuo llegó a alucinar o delirar se puede alcanzar un momento en que su conducta adquiere cierta autonomía con respecto a la causa y se transforma en una estructura que tiende a auto-perpetuarse, aún cuando no exista un reforzamiento externo. Está fuera de cuestión que en el presente esté actuando algún tipo de estímulo que funcione como disparador para actualizar ese pasado y no otro. Lo que no comparto es que se deban dar en el presente todas las circunstancias externas que convierten a la conducta sintomática en mera respuesta apropiada. El disparador puede ser para un psicótico algo tan nimio como el tono de voz de la persona con la que está hablando, que le resuena como una acusación de sus padres y como indicio de

ataque inminente. El psicótico ha interiorizado una expectativa con respecto al mundo y tiende a leer las conductas de los demás dentro del código que él posee. Queda claro pues, que no discuto que la psicosis pueda ser el producto de haber vivido en una familia en que las situaciones creadas eran psicóticas sino la afirmación de Haley de que "Cuando una acepta la idea de un problema comprende a más de una persona y es una respuesta a una situación actual, se deriva necesariamente que la conducta sintomática es conducta apropiada". De acuerdo a nuestro punto de vista, el psicótico lo es *no* por responder a una situación psicótica con una conducta psicológica *apropiada* sino precisamente por tener tal tipo de conducta psicótica ante situaciones que no lo son. Más aún, si adoptamos la premisa que la estructura de personalidad de un individuo y las condiciones externas en que se halla *codeterminan* la conducta del mismo, es posible suponer que un individuo será tanto más enfermo cuanto más independiente sea su conducta de las condiciones externas, o dicho en otros términos, cuando más dependa de sus condiciones internas.

Ahora bien, hasta aquí hemos sostenido que la estructura de la personalidad y las condiciones externas codeterminan la conducta. Pero esto no es suficiente y se hace necesario precisar cómo se engarzan, cómo se articulan ambas variables. Valgámonos para este examen del ejemplo aportado por Haley acerca del niño cuyos padres se están por separar y él crea dificultades con la finalidad de unirlos, evitando el divorcio. El enfoque interaccionista cosecha, con lo que concuerda, el explicar la conducta del niño simplemente como derivada de impulsos delictivos propios de su personalidad que no tienen nada que ver con la situación. Se supone que si la situación de separación de los padres no existiera el niño no delinquiría, ya que éste es el medio de unirlos. Pero esta explicación no agota el análisis del fenómeno. Ante la amenaza de separación de los padres el niño tiene por lo menos dos conjuntos de posibles conductas: aquellas que tienden a unirlos y las que tienden a separarlos. Por lo tanto se hace indispensable recurrir a examinar qué es lo que ocurre en el niño, el porqué tiene ansiedad frente a la separación y no satisfacción, el por qué ante su deseo de que no se separen recurre a un hecho delictivo y no a otra conducta cualquiera, una enfermedad por ejemplo, que podría conducir a un resultado similar. La separación de los padres pone en marcha un proceso que es propio *de ese* niño, en razón de su individualidad, de sus tipos prevalentes de conflictos, de fantasías, de sus mecanismos defensivos. Cualquier explicación que no tuviera en cuenta lo propio del niño aun cuando cierta en el aspecto parcial del que da cuenta mutila, por esa misma parcialidad, la comprensión del fenómeno.

Pase a las reservas anteriores al enfoque de Haley, que fueron planteadas como diferencias tajantes para facilitar la confrontación, creo con todo que sus ideas nos traen algo verdaderamente importante: por un lado, una reacción frente a las explicaciones extremas en que

se hace derivar la conducta de un individuo de fuerzas internas —de los instintos por ejemplo—, relegándose a un lugar secundario el papel de las relaciones interpersonales, y por el otro el mostrar que las interpretaciones exclusivamente históricas de las conductas patológicas dejan de lado muchas veces el reforzamiento continuo que aquella pueda estar recibiendo y que contribuye a su mantenimiento. Lo que me resultaría difícil de compartir es que para evitar la postura radical de explicar todo en función del individuo y de los hechos del pasado debamos caer en otro radicalismo que consiste en desechar lo intrapsíquico y la influencia de las experiencias del pasado que pueden perdurar aún cuando ya no actúan más las condiciones que contribuyeron a generarlas.

El segundo gran tema que Haley encara en su trabajo es el de por qué cambia un paciente y cuáles son los recursos que tiene el terapeuta para producir modificaciones en el sentido deseado. Nos dice Haley "Dado que el terapeuta de familia ve la conducta anormal como adaptativa a una situación anormal, él supone que la persona no puede cambiar a menos que su situación cambie". Si uno no concuerda con la primera parte de la afirmación de Haley, la de que la conducta anormal es adaptativa a una situación anormal, como me he preocupado de destacar anteriormente, tampoco lo hará con su consecuencia lógica. Una persona puede cambiar aún cuando el resto de los miembros de la familia no cambien. De no ser así no sería posible la terapia individual. Pero lo que sí es cierto es que el cambio será más difícil si no se crean condiciones en las redes interpersonales significativas para esa persona que hagan posible el ejercicio de nuevas conductas resultantes del cambio. De no ser así no sería necesaria la terapia familiar. La afirmación de Haley que citamos recién nos conduce, si queremos mantener la coherencia lógica de la argumentación, a una total subordinación de la posibilidad de cambios intrapsíquicos en un individuo a la posibilidad de cambios de la red interpersonal a la que pertenece. O dicho en otros términos, convierte a la situación en la variable independiente y al individuo en la dependiente. Creo que el mismo esquema interaccionista se opone a una tal dicotomía y subordinación dado que, si se producen modificaciones intrapsíquicas en una persona, aquéllas se exteriorizarán en una variación de la conducta para con los otros, y por lo tanto en un cambio de la situación en que se halla, al ser él parte de la situación y no ajeno y exterior a la misma. Como vemos, por otro camino hemos llegado nuevamente a la necesidad de la articulación de lo intrapsíquico con lo interpersonal, articulación que, a mi juicio, descuida el planteo interaccionista a ultranza. Esto ya nos va indicando que las diferencias con el trabajo presentado por Haley no son solamente alrededor de puntos aislados sino sobre una base teórica más general, precisamente la de la articulación de lo intrapsíquico con lo interpersonal. Tal es así que no llama la atención que el insight no desempeñe en la estrategia terapéutica de Haley el

rol princeps que tiene en las teorías psicodinámicas. Haley nos dice acerca de los clínicos que pasaron el enfoque individual al diádico: "Ellos también cada vez más dudaron si el insight y el tomar conciencia causaban el cambio en los patrones de conducta de una diada", y cuando más adelante analiza el ejemplo de la pareja en que la mujer critica al marido afirma "Hacer tomar conocimiento a la gente de la regla a menudo pareciera solamente incrementar la conducta y en verdad añadir nuevo apoyo a la misma". Es por ello que los terapeutas interaccionistas tales como Haley o Paul Watzlawick, preconizan toda otra serie de recursos terapéuticos en que lo esencial no es que la familia tome conciencia de los conflictos que transcurren en su seno sino que, en la situación de terapia y gracias a la presencia activa del terapeuta, se rompan de hecho los patrones estereotipados de conducta *sin necesidad de apelar a interpretaciones*. El examen de esta proposición me enfrenta con una dificultad que consiste en que mi crítica esencial se tendría que hacer desde "adentro" de la teoría psicoanalítica, objetándole al interaccionismo radical de que no sea capaz de producir tal o cual resultado que es imprescindible, en función de los supuestos de la teoría, para conseguir una modificación *verdaderamente* significativa. Dado que Haley no comparte los supuestos psicoanalíticos mi argumentación carecería de fuerza lógica, ya que una vez que probase por ejemplo que tal o cual intervención interaccionista no levanta la represión, Haley con todo derecho podría contestar, ¿y qué importancia tiene la represión y el levantarla?. El diálogo científico requiere colocar la discusión en un área compartida por lo que renunciaré a hacer una crítica desde la perspectiva psicodinámica a las terapias interaccionistas no basadas en el insight y más bien me ocuparé de mostrar las importantes posibilidades que abre la utilización del mismo en el proceso terapéutico. Si logro hacerlo, por implicación, dejaré sentado que las terapias que lo excluyen se privan de un instrumento terapéutico indispensable.

Cuando el terapeuta mediante la interpretación* pone al descubierto actitudes y motivaciones que escapaban previamente al conocimiento de la familia, no solamente está mostrando esas actitudes y motivaciones en particular, sino que está aportando un modelo más general ya que metacomunica entre otros los siguientes mensajes: el observar lo que sucede, el tratar de desentrañar sus causas, el hablarlo dentro de un clima de tolerancia, es bueno dado que yo figura investida de toda la autoridad que me da el hecho de ser el terapeuta lo hago. También implícitamente está diciendo: hablar de los temas que hasta ahora eran tabú no es peligroso dado que se habla y no pasa nada de lo temido, que impedía hacerlo. Difícilmente puede sobreestimarse

* Hablo de "la interpretación" en forma genérica pero obviamente incluyo bajo esta denominación todo un conjunto de esclarecimientos que hace el terapeuta y pueden ir desde los niveles más fácilmente observables hasta los de motivaciones más profundas y por lo tanto inferidas.

el efecto benéfico que tiene tal proceso de aprendizaje en mejorar la comunicación y las relaciones dentro de la familia. Lo anterior me conduce a una orientación diferente que la de Haley cuando respalda la posición de que "...poner al descubierto la hostilidad o las conductas desagradables en la familia, pueden impedir antes que favorecer el cambio". En mi experiencia, en la terapia familiar se puede llegar a poner en descubierto los sentimientos más hostiles siempre que uno no se limite simplemente a señalar su existencia sino que también evidencie el por qué de los mismos y las ansiedades que le subyacen en el miembro que los posee. En los casos en que uno puede mostrar cómo el mismo individuo, que agrede a otro de su familia está por ejemplo, lleno de miedos que lo impulsan a ser agresivo para tratar de contrarrestarlos o sea que detrás del presunto victimario se puede hallar en verdad una persona asustada, es notable cómo se hace factible promover un clima de empatía dentro de la familia. La conducta deja de ser motivo de crítica para convertirse en medio de comprensión.

Por otra parte si el terapeuta ocultase los sentimientos hostiles en la familia y enfatizase sólo los de amor, no estaría procediendo como esos padres que no toleran la hostilidad de los hijos y les hacen un "lavado de cerebro", diciéndoles "No, nene, no es que vos tenés rabia, vos te equivocás, lo que vos sentís es cariño por papá y mamá"? Si es cierto, como ha sido sostenido por algunos autores que no pertenecen precisamente al campo psicoanalítico, que tal tipo de maniobra es "esquizofrénica" o por lo menos confusional, un proceso correctivo, como intenta ser la psicoterapia, debe evitar cuidadosamente cualquier tipo de intervención que pueda hacer leer equivocadamente sus conductas a la familia ya que la salud mental depende de una percepción adecuada de la realidad por más desagradable que ésta sea. Pero quisiera dar aún otro argumento en favor de las terapias de esclarecimiento. Me valdré, como punto de partida, de una situación en que el concepto involucrado en la interpretación no es de raigambre psicoanalítica sino interaccionista, para mantenerme en el área compartida de la que he hablado antes. En una familia con un hijo esquizofrénico señalé en varias oportunidades durante el curso del tratamiento cómo tanto el hijo como otros miembros eran expuestos a situaciones que reunían las características "del doble vínculo" como así mismo las razones por las cuales debían apelar a esto. Al cabo de tres meses de terapia el hijo esquizofrénico dijo, refiriéndose a una conducta del padre: "Pero mirá lo que me pedís: me pedís que te diga todo lo que piense, que no te oculte nada pues un hijo debe de ser sincero con el padre, pero me decís también: por favor no me digas nada que me haga sufrir". El hijo había incorporado gracias a las interpretaciones una forma de analizar las conductas y estaba en condiciones de verbalizarlo, de decírselo al padre, desbaratando de este modo distintas situaciones de "Doble vínculo", con lo que podía escapar de su acción patológica.

El hijo había también aprendido a partir de situaciones singulares que existía una "clase", en el sentido en que los lógicos usan el término, clase que podía ser llenada una vez que se la conocía con los innumerables miembros que la componen, como evidenció con la actitud frente al padre. Pero, y he aquí lo más importante, las "clases" provistas por las interpretaciones se hallan en el nivel simbólico del "pensamiento operatorio formal" de Piaget². Se diferencia en cuanto a sus consecuencias terapéuticas de la clase de los "hábitos" o "automatismos", ya que el cambio de un hábito por el ejercicio de otro no tiene como bien lo han mostrado los estudios de Piaget todas las posibilidades "combinatorias" y de "reversibilidad" de las operaciones. Las interpretaciones implican pues la economía psicológica del pensamiento conceptual. Pero es precisamente en razón de que se basan en el pensamiento conceptual que se ha esgrimido el argumento de que no son aplicables a todos los individuos o familias. Salvador Minuchin ha estudiado la dificultad que presentan las familias que se encuentran en el extremo inferior de la estratificación socioeconómica de la sociedad norteamericana. Para poder beneficiarse con las terapias basadas en el insight dada su dificultad en el uso del lenguaje y de los niveles más elevados de simbolización¹. Esta objeción a las terapias de insight, por su solidez, merece nuestra máxima consideración pero no debe ser tomada como una crítica global contra el insight sino una delimitación del universo al que sería aplicable. Salvo en los casos extremos, similares a los consignados por Minuchin, lo considero la herramienta terapéutica primordial.

Hasta aquí mi examen de algunos aspectos del relato de Haley. Para terminar quisiera hacerlo con una reflexión de orden más general. De los excesos de la psicología introspeccionista surgió el behaviourismo radical de Watson; de los excesos de la psicología individual se ha originado el enfoque interaccionista. La vieja polémica entre introspeccionistas y behaviouristas dio lugar a una síntesis fecunda de la verdad contenida en ambas posiciones. Ha llegado el momento de que otro tanto ocurra con la oposición planteada entre la psicología interaccionista y la psicodinámica. Espero haber podido encauzar mi discusión al claro y valioso trabajo de Haley dentro de ese deseo de acercamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MINUCHIN S. — Psychoanalytic Therapies and the Low Socioeconomic Population, en Marmor J.: *On Modern Psychoanalysis*. New York, Basic Books Inc., 1968.
2. PIAGET J. — *Psicología de la inteligencia*. Buenos Aires, Psique, 1960.

* Están usados en el sentido que les da Piaget.

El doble vínculo como situación patogénica universal

CARLOS E. SLUZKI *

1. Hace pocos meses comencé el tratamiento individual de un joven universitario que, de acuerdo con la nosología vigente, es decididamente un neurótico y decididamente no un psicótico. Este paciente arrastraba un problema de estudio, que consistía en que a pesar de su interés y esfuerzo, se distraía ni bien se sentaba frente a un libro de estudio. Era un lector voraz de todo tipo de libros, pero cuando se trataba de un texto de estudio, aparecía el bloqueo. Se quedaba horas frente a los libros, pensando en la luna, haciendo esfuerzos inútiles de concentración. Nadie lo obligaba a estudiar, si bien hay que registrar que la cultura familiar carga de valencias muy positivas al estudio y que ambos padres son graduados universitarios.

En resumen, el problema es que quiere estudiar pero no puede. En una sesión comenta, como cosa banal, que tiene un problema ligado con cepillarse los dientes: sabe que debe hacerlo pero utiliza triquiñuelas para eludirlo porque no le gusta, si bien no sabe bien por qué. Los recursos empleados son del tipo de ir postergando esa actividad hasta que, cuando llega el momento de salir de la casa, "se le va a hacer tarde si se lava". Es un truco que él mismo reconoce y cataloga de irracional. Comenta después que cuando era chico le dolián las encías y rehuía como podía el lavado de dientes, a pesar de que tanto el padre como la madre hacían hincapié en la necesidad, conveniencia e importancia de hacerlo. Los argumentos de refuerzo que utilizaban los padres, dice el paciente, eran, para el problema del lavado de dientes como para buena parte de las actividades que imponían, que al realizar por propia iniciativa esa tarea era valioso indicio de "ser grande", es decir, autónomo. El paciente comenzó a recurrir en su infancia a trucos tales como mojar el cepillo y cambiar de lugar la pasta dentífrica, para hacer creer que se había lavado los dientes, cosa que, para gran asombro y admiración suya, engañaba a los grandes. El sujeto relata como una experiencia fascinante el descubrimiento de la trampa. Comparemos ahora esa reconstrucción con el problema actual sobre el lavado de dientes: ambos fenómenos son estructuralmente idénticos, a

no ser por una diferencia: en el caso actual la instrucción viene de adentro. Y no escapará que también son estructuralmente idénticos al problema motivo de consulta, el del estudio. En ambos problemas actuales, el banal del cepillado de dientes y el penoso del estudio, la instrucción proviene del mismo sujeto, pero es tratada como si proviniera de una fuente externa, a la que no se puede enfrentar con una negativa, pero sí engañar. ¿Cómo engaña, por decir así el sujeto? Plantando una suerte de "yo quiero, pero no puedo", mediante el que no puede ser acusado de no seguir la instrucción, y al mismo tiempo no la sigue. Y ¿cuál es el mensaje original reconstruido para los padres en el modelo de socialización referido al aprendizaje del cepillado? Por de pronto: "tenés que cepillarte los dientes". Y, además, que "querer lavarse los dientes es cosa de grande", buena, autónoma, valorada. En resumen, "tenés que hacer lo que te decimos por propia iniciativa", paradoja que puede completarse con los agregados "si no nos hacés caso nos enojamos, y si lo hacés porque te lo decimos también, porque lo bueno es ser autónomo" (es decir, querer hacerlo por propia voluntad). La instrucción es terrible, ya que específicamente exige que se confunda la fuente externa con una interna. Pero también se podría decir de ella que es un modelo casi universal de internalización de normas. Con todo, el hecho de que sea tan común no le resta ese sabor maligno. ¿Cuál sería la manera de eliminar su efecto? Enfrentarla como instrucción externa. Pero al respecto existía en el medio de este paciente otra regla: el enfrentamiento con los padres era considerado un acto de maldad que generaba enojos y acusaciones de desamor. Cosa, acotemos, también bastante común. Con lo que la instrucción explícita "tenés que hacernos caso" se reforzaba con el adjudicar a los actos de rebelión una carga negativa muy intensa. De modo que no hay salida: el hacer caso es bueno, porque cumple la premisa de obediencia, y es malo porque no cumple la premisa de la autonomía, y el no hacer caso, por el contrario, implica autonomía —positiva— pero contraría la instrucción de obediencia. Finalmente, la instrucción "esto lo tenés que querer por propia voluntad" —constreñida por las otras instrucciones— condujo a que se internalizara no sólo la fuente de instrucciones sino todo el complejo vincular derivado de la paradoja que la fuente emite. El querer lavarse los dientes pero "no tener tiempo" y el querer estudiar pero "no poder" resume la única salida legítima que cubre tanto el hacer caso como el no hacerlo, es decir, la premisa de la obediencia y la de la autonomía.

Todo hace suponer que se trata de una estructura recurrente que ha operado en múltiples facetas del aprendizaje del paciente, y que, por el proceso de deutero —aprendizaje inherente a toda situación de aprendizaje, ha conducido a que el sujeto identificara toda situación en que se emiten instrucciones de cierta característica como miembro de la clase de situaciones paradójicas aplicadas por su medio socializante, cuya fórmula general acabamos de describir.

* Centro de Investigaciones Psiquiátricas. Servicio de Psicopatología y Neurología Policlínico "Prof. G. Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son los componentes esenciales de este fenómeno? La recurrencia, el que se dé de un medio significativo, la necesidad de discriminar (dada la relevancia del conflicto dependencia-autonomía), el que no pueda abandonar el campo (dada la dependencia inherente a la infancia), el que no se pueda pedir aclaraciones que resuelvan la incongruencia (en razón del carácter inasible propio de la paradoja, y tal vez por el valor de "rebelión" que se haya adjudicado a ese tipo de intervenciones), y el que se trate de un mensaje que contenga una instrucción acerca de un hecho concreto y una instrucción acerca de ese tipo de hechos que es contradictoria con la primera. Tenemos así listado el conjunto de elementos que se han considerado componentes esenciales del "doble-vínculo" (double-bind), pilar de la teoría comunicacional patológica de la esquizofrenia.

2. Siguiendo los lineamientos generales de este modelo de razonamiento reconstructivo, pasaré a desarrollar de manera muy sucinta un cuerpo de hipótesis producido en el curso de una investigación empírica sistemática acerca de los estilos comunicacionales de pacientes neuróticos efectuada por Eliseo Verón y yo¹. Puede adelantarse que esta aproximación conducirá a entender al modelo del doble-vínculo desde un nuevo ángulo, como una teoría patológica universal y en modo alguno específica de la esquizofrenia.

Deseo aclarar que en lo que sigue de este trabajo utilizaré el plural cuando hable en primera persona. Cuando se ha trabajado durante mucho tiempo en conjunto alrededor de ciertas ideas, tal como lo hemos hecho Verón y yo, resulta difícil poder establecer en forma desglosada las autorías. Me resulta claro que, en el desarrollo de los modelos genéticos de las neurosis que sigue, el aporte de Verón lo pone indiscutiblemente como primer autor. En la última parte de esta presentación se encontrarán ideas en las que reconozco mi impronta y otras en las que prima la de Verón, para resultarme en muchas otras imposible discriminar méritos, ya que se tratan literalmente de productos conjuntos. Me decido así por una justa primera persona del plural.

En el curso de la mencionada investigación acerca de la producción verbal de pacientes con diagnóstico de neurosis histérica, fóbica y obsesiva, hemos desarrollado un conjunto de hipótesis referidas a la génesis de las modalidades de comunicación que definen y diferencian esos tres grupos diagnósticos².

La perspectiva general adoptada define a la neurosis como "una técnica (o sistema de técnicas) de manipulación de los significados transmitidos en situaciones interpersonales" (Verón y Sluzki, 1970). El

¹ Lo que sigue en esta sección 2 es una versión resumida y reordenada del capítulo 9 del libro de Eliseo Verón y Carlos E. Sluzki (1970).

² Estas hipótesis fueron posteriormente validadas en el curso del análisis sistemático del discurso de las pacientes de nuestra muestra. La extensión y complejidad del procedimiento obligan a referir la validación al trabajo original, ya mencionado en la anterior nota al pie.

neurótico, por lo tanto, procesa la información de acuerdo con un conjunto de reglas de codificación que no son otra cosa que "normas de atribución de significados a los objetos del 'mundo real' (incluido el propio sujeto y sus conductas) y simultáneamente normas que definen las relaciones entre estos significados" (*ibid.*). Por otra parte, consideramos que la descripción de las reglas de interacción, que nos hablan de la "concepción del mundo" que posee el sujeto, nos permite asimismo efectuar inferencias acerca de las situaciones de socialización que las produjeron.

El desarrollo de nuestras hipótesis genéticas, que configuran una suerte de esbozo de teoría comunicacional de las neurosis, fue realizado integrando al modelo comunicacional recién mencionado las postulaciones de Ronald Fairbairn acerca del desarrollo del psiquismo infantil (Fairbairn, 1962).

Como se recordará, según ese autor, la organización del psiquismo infantil presenta tres estadios evolutivos: 1) de *dependencia infantil*, con relativa indiferenciación yo-no yo, en que predomina el incorporar o "tomar" los objetos; 2) de *transición*; y 3) de *dependencia madura*, caracterizado por "relaciones entre dos seres independientes, completamente diferenciados" (Fairbairn 1962:52), en que predomina el "dar".

La etapa de transición corresponde al comienzo de la elaboración del dilema capital del desarrollo psíquico: *dependencia versus autonomía*. La orientación del conflicto en el sentido de abandonar la seguridad de la unión con el objeto en favor de la necesaria incertidumbre de la independencia se apoya en forma capital en el proceso de socialización: los padres tienden —teóricamente al menos— a estimular el impulso a la autonomía y neutralizar el de la dependencia. El proceso es complejo, ya que los padres de un niño en crecimiento deben redefinir casi cotidianamente, y evitando superposiciones, las áreas de dependencia (en las cuales hacer, salvo órdenes, está mal), de independencia (en doble hacer sólo siguiendo instrucciones está mal), y experimentales (definibles como de "experiencia vigilada de independencia". No escapará que estas redefiniciones operacionales serán tanto más difíciles cuanto más conflictiva resulte para los padres el área particular en definición en ese momento. Pero no debe olvidarse que esas dificultades mayores o menores se dan recortadas en un fondo, el del estilo caracterológico de los agentes socializadores, que condicionen de por sí el predominio de una modalidad de socialización.

De esta manera, el conflicto universal dependencia-independencia adquiere formas particulares en cada caso: según cuál sea el modelo de aprendizaje privilegiado por el medio familiar será la respuesta adaptativa del sujeto a ese medio³.

³ "Lo decisivo en un modelo de aprendizaje es la estructura de relaciones significativas dentro de las cuales se define un sistema de reglas de distribución de gratificaciones y frustraciones, y cómo se insertan en esta estructura los comportamientos del sujeto." (Verón y Sluzki, 1970.)

En las primeras etapas del aprendizaje, la búsqueda de las respuestas "adecuadas" conducirá a una categorización de conductas, es decir, a un sistema de codificación incipiente, en términos de bueno y malo, o efectivo e inefectivo. Esta codificación se irá reforzando en la medida en que las respuestas sigan mostrándose adaptativas, dada la situación y los recursos del paciente, y se convertirá en el encuadre interpretativo óptimo para comprender al mundo.

No escapará que este modelo tiene en cuenta la hipótesis, comprobada de múltiples maneras, de que en las situaciones concretas de aprendizaje se transmiten también las reglas implícitas en la organización de la situación de aprendizaje. Estamos hablando, en última instancia, de los fenómenos de adquisición de la predisposición (learning-set), o de lo que Bateson llamó deuterio-aprendizaje, es decir, el aprender a aprender (Bateson, 1942)⁴. Subrayemos que el "aprender a aprender" corresponde a un nivel lógico más complejo que el "aprender". Y que este proceso tiene lugar en un nivel de abstracción más elevado que el del mensaje, a saber, el de los metamensajes, que tienen como referente a conjuntos, a *clases* de situaciones o de mensajes de contenido determinado.

Aplicando esta noción a lo planteado previamente, la situación de aprendizaje correspondiente al período de transición puede presentar, además del conflicto al *nivel del contenido* (el problema básico expresado en el dilema "dependencia o independencia"), múltiples conflictos a *nivel de la estructura*, a saber, las contradicciones o incongruencias que pueden existir en los modos en que los agentes socializadores definen la situación de aprendizaje, contradicciones que derivan de los propios conflictos de los agentes socializadores, tal como se expresan en su relación con el niño. "La convergencia de estas dos fuentes de conflictos —el dilema dependencia-independencia (en sus múltiples variantes) y los conflictos de los padres— producirá en cada caso particular, un modo específico de organización de la interacción en el

⁴ *Predisposición* es un concepto originario de la psicología experimental del aprendizaje: la exposición reiterada de un sujeto a una situación de aprendizaje determina en el sujeto la formación de una "predisposición" que reduce drásticamente la etapa de ensayo-error cuando el sujeto es sometido a nuevas situaciones del mismo tipo. El hecho de que el organismo no sólo aprenda sino también aprenda a aprender configura lo que Bateson denominó *deuterio-aprendizaje* (Bateson, 1942 y 1951). En estos fenómenos se aíslan dos niveles distintos de procesamiento de información por parte del organismo en situación de aprendizaje: información sobre los contenidos de que se trata y, a un *nivel lógico más complejo*, información acerca del tipo de tarea o situación.

Cabe recordar qué sucede cuando, una vez establecida una predisposición, el experimentador define nuevas situaciones que son del mismo tipo pero que de hecho contradicen dicha predisposición: Bateson describe en esos términos la situación de "neurosis experimental" de los experimentos pavlovianos. Sin la existencia de esos dos niveles de aprendizaje —el del contenido y el de la forma o estructura, que permite la formación de la predisposición— el fenómeno de contradicción del que surge la neurosis experimental no podría tener lugar.

aprendizaje (...). La forma en que estos conflictos se traducen en pautas regulares de interacción dará lugar, a largo plazo, a trastornos neuróticos determinados" (Verón y Sluzki, 1970). Dicho en otras palabras, la contradicción presente originalmente en la estructura recurrente de las situaciones de aprendizaje determinará respuestas que el niño encuentra como las más "adaptativas", lo que se traducirá en un conjunto de reglas de codificación que éste aprende a aplicar al mundo; es decir, éste acaba por "reconocer" estereotipadamente en las situaciones nuevas la estructura de la contradicción que definió el contexto de su aprendizaje; por esto mismo, en dichas situaciones inducirá conductas en los demás que refuercen y "justifiquen" su propia modalidad interaccional.

Este conjunto de afirmaciones posee un grado importante de abstracción, y exige progresivas especificaciones. En un intento de lograrlo resumiré a continuación los razonamientos que hemos seguido para definir la estructura de la contradicción específica de las situaciones de aprendizaje que generan a las modalidades de conducta histérica, fóbica, y obsesiva.

Los sujetos con diagnóstico de *neurosis histérica* tienen una orientación positiva hacia objetos del mundo exterior y una evaluación negativa de partes de sí⁵. La conducta de exhibicionismo y seducción indica tanto lo primero —ya que está destinada a atraer al objeto externo— como lo segundo —puesto que caracteriza al histérico una falta de conciencia, una suerte de ceguera selectiva ante sus propios mensajes de seducción. A su vez, cuando al objeto externo es atraído por esa conducta debe ser rechazado, ya que se orienta hacia los aspectos evaluados negativamente. Pero ese rechazo sólo puede ser transitorio, ya que renunciar a atraer al otro es renunciar al objeto valorizado. Como se ve, la contradicción genera un ciclo que tiende a repetirse indefinidamente. El histérico define su propio rol como pasivo —sufre la consecuencia de los actos de los demás—; los demás manifiestan *actividades* y él evidencia *estados*. A otro nivel podría decirse que los histéricos instrumentan sus estados para obtener conductas de los otros.

¿Qué modelo de socialización puede conducir a que el sujeto internalice ese sistema de codificación de sus conductas y de las ajenas? La dinámica del aprendizaje consistiría, en un nivel explícito de definición de la situación, por una parte en castigar al sujeto cuando realice conductas orientadas activamente a obtener resultados, y, por la otra, en gratificarlo cuando manifieste estados que resulten de actividades de los padres. Actividad se asocia a frustración y pasividad a gratificación⁶. Ahora bien, todo medio socializador exige en algún momento

⁵ Según Fairbairn, en el histérico el objeto aceptado o "bueno" es externo y el rechazado o "malo" es interno.

⁶ El modelo genético expuesto parece responder al "contexto pavloviano clásico", como lo llamó Bateson (1942), se excluye toda especificación de lo que el sujeto debe *hacer* como parte de la secuencia de hechos que caracteriza a la situa-

la movilización de ciertas acciones del sujeto. En estas circunstancias, los padres metacomunicarán al niño exigencias referidas a cosas que se esperan de él y que contradicen la definición explícita de la "regla del juego". El único modo viable para no violar las normas explícitas y al mismo tiempo responder a las exigencias implícitas —cuya violación también contiene la amenaza de frustración o castigo— será el *cumplimiento indirecto* de estas exigencias bajo la forma "permitida" por el modelo explícito: aprender progresivamente a instrumentar sus propios estados como medio de insertarse en la situación. "Cuando a la acción se le niega su carácter centrífugo, queda reducida a un estado o modalidad de sujeto, *supuestamente* marginado del campo de la comunicación, es decir, de sus posibles receptores" (Verón y Sluzki, 1970). Ejemplo de ello es el niño que, cuando reclama explícitamente la atención de los padres, obtiene como respuesta "no molestes" y, cuando reacciona con un berrinche o conducta similar, consita la atención de los padres. Así, los padres sólo prestan atención a la clase de conductas que no la reclaman de modo explícito y viceversa.

Intentando reducir a un mensaje las instrucciones contradictorias y paradójicas del medio socializante que produce la histeria, podemos llegar a formularlo así: "*ten iniciativas a condición de que aprendas que está prohibido tener iniciativas*".

Pasemos ahora a la *neurosis fóbica*. El problema básico del fóbico es discriminar entre situaciones peligrosas y situaciones tranquilizantes, ya que para él el mundo nunca deja de ser potencialmente peligroso⁷.

¿Qué modelo de socialización podríamos adscribir al fóbico? En un nivel explícito, la situación de aprendizaje estimulará determinados comportamientos por parte del sujeto, cosa que lo impulsará a progresar en el camino de la anatomía. El mundo, sin embargo, es visto por los agentes socializantes como un mundo lleno de peligros. En un nivel implícito, entonces, los padres transmitirán al niño el metamensaje "el mundo es muy peligroso". Esta visión implica normas que prohíben al sujeto correr todo riesgo y que lo gratifican cuando lo evita⁸. La copresencia de ambos mandatos encierra una incongruencia: el refuerzo (explícito) de la autonomía está en contradicción con las normas (implícitas) de evitar los peligros magnificados, puesto que, por definición, el mundo autónomo es peligroso. No queda más sabida que actuar

ción de aprendizaje. Simultáneamente el sujeto se inserta en la secuencia en tanto se espera sólo que los hechos provoquen no una respuesta activa destinada a modificar la situación sino una *automodificación* (salivación, dolor, etc.).

⁷ Según Fairbairn, en la neurosis fóbica tanto el objeto aceptado como el rechazado son externos al sujeto.

⁸ El contexto explícito del aprendizaje del fóbico parece coincidir con el modelo de la "recompensa instrumental" (Bateson, 1942): la secuencia específica conductas que el sujeto que aprende debe realizar *activamente* para ser gratificado. La situación de aprendizaje reconoce y estimula la autonomía del sujeto. Pero, a nivel implícito, el modelo es el de la "evitación instrumental" (para una explicación de este modelo, cf. nota al pie 11).

antemanamente sólo en los campos previamente definidos como seguros por los padres, es decir, con una ficción de autonomía.

Toda interacción del fóbico puede ser vista a la luz de esta interpretación del proceso de socialización. Cuando el sujeto interactúa con otras personas, su propia definición de la situación y de sí mismo corresponden a la de un mundo "adulto". El surgimiento súbito de la reacción evitativa es tanto un mecanismo destinado a verificar la seguridad que lo rodea como un intento de definir al interlocutor a través del mensaje que metacomunica: "no soy adulto, necesito protección". Esta respuesta adaptativa es tan contradictoria como la paradoja que la generó, que puede compendiarse en el mensaje: "*Sé autónomo dependiendo de mí*".

Consideremos ahora el caso de la *neurosis obsesiva*. Estos sujetos califican algunas de sus propias acciones con valores positivos y otras con valores negativos⁹. Tanto el peligro como la posibilidad de controlarlo son internos. Uno de los rasgos esenciales de la técnica obsesiva es, pues, utilizar conductas propias "aceptadas" o "buenas" para controlar o neutralizar las conductas "rechazadas" o "malas". Las conductas aceptadas, por lo tanto, se "vacían de sentido", ya que no tienen fin propio sino que están *en lugar de*, sustituyendo a las acciones rechazadas: el estar ocupado en la repetición de conductas aceptadas controla la emergencia de las rechazadas. Esto está en la base de los rituales compulsivos¹⁰. La extrema necesidad de evitar acciones malas se potencia con el hecho de que pensar algo es como haberlo hecho. La aparición de ideas o conductas malas, en tanto son identificadas con conductas rechazadas, pone en marcha un mecanismo reequilibrador, el ritual de anulación: es necesario realizar tanta acción aceptada como acción rechazada se ha hecho con el pensamiento. Este proceso se ve complicado por el carácter contaminatorio de "lo malo", que produce el cambio de signo de ciertas conductas hasta entonces neutras o buenas, y fuerza por lo tanto la redefinición de los rituales.

Trataremos de establecer las condiciones de la situación de socialización que estaría en la génesis de la neurosis obsesiva. El niño es impulsado hacia la conquista de la autonomía mediante el establecimiento de la regla de que, si quiere evitar el castigo, debe aprender a "hacer las cosas que se deben hacer". El aprendizaje es definido como bueno, pero no hay gratificación instrumental: si el niño hace cosas "malas" o deja de hacer "lo que se debe hacer", es castigado por los padres. Si se porta de acuerdo con las instrucciones no es recompen-

⁹ Este es el correlato conductal de la afirmación de Fairbairn de que, en la neurosis obsesiva, tanto el objeto aceptado como el rechazado son internos.

¹⁰ "La obligación de hacer lo bueno —o lo no malo— es el disfraz de la prohibición de hacer lo malo, prohibición que no es reconocida porque genera angustia, ya que toda prohibición implica, por definición, el reconocimiento de la posibilidad de hacer lo que se prohíbe." (Verón y Sluzki, 1970.)

sado sino que se tiende a considerar simplemente que ha cumplido con su deber ¹¹.

Pero, mientras en un plano se estimula al niño a asumir deberes como forma de "autonomía", por otro lado se le trasmite el metamenaje que implica que él es *intrínsecamente malo* (tal como lo expresado por la frase: "Claro, qué otra cosa se podía esperar de vos"). El que se defina como buena la conducta autónoma y se estimule al sujeto a realizarla, y que al mismo tiempo se lo defina como necesariamente malo y sólo pasible de acciones malas, produce una situación incongruente.

Esta incongruencia nace, probablemente, de la introducción prematura de ciertas disciplinas: si se impone al sujeto exigencias desmedidas en relación con sus capacidades presentes, necesariamente fracasará. Si el medio socializador no atribuye los fracasos a la inmadurez del sujeto sino a su ineffectividad, evaluará las fallas reiteradas como "maldad". Esto desencadenará el castigo, contextualizado, como incumplimiento de normas o deberes ¹².

Dado que el pasaje a la autonomía supone el ejercicio de la propia iniciativa, y que sus acciones espontáneas han sido definidas como necesariamente malas, la aparición de lo malo configura un peligro constante. Este conflicto puede resumirse en la instrucción paradójica "*Sé autónomo aunque por supuesto eres incapaz de serlo*".

3. Indudablemente, el proceso de socialización humano es intrínsecamente complejo, ya que exige una progresiva y armónica redefinición por parte de los padres acerca de cuál es el área de la autonomía y cuál el de la dependencia, a medida que el niño progresa en su aprendizaje. Esto permite comprender que diferentes padres podrán llevar adelante esa redefinición hasta diferentes momentos del desarrollo, en que entran en juego determinadas áreas que resultan conflictivas para los mismos padres (para uno de ellos o para ambos). Entonces se expresará su propia ambivalencia a través de los mensajes contradictorios, que establecen primero y consolidan luego la situación paradójica. Debe quedar claro que un mismo modelo de aprendizaje puede ser aplicado a cada una de las áreas de socialización. Ejemplificando, la incongruencia "*sé autónomo aunque por supuesto eres incapaz de*

¹¹ El modelo coincide con el de la "evitación instrumental", en que el estímulo condicionado es seguido de una experiencia desagradable —una descarga eléctrica, por ejemplo—, a menos que el sujeto realice antes una determinada acción. El sujeto aprende así a insertar su conducta en la secuencia para evitar una experiencia frustradora. La gratificación consiste en evitar el castigo.

¹² "Un elemento adicional importante es el que el medio socializador supe-dita las instrucciones y los castigos a entes abstractos tales como 'lo que debe hacerse', es decir, se define como mero intermediario entre el sujeto y las normas. Esto conducirá a que el sujeto tienda a una adscripción formal a las instrucciones." (Verón y Sluzzi, 1970.)

serlo" puede operar tanto para el aprendizaje del control de esfínteres, como para el de la lectura, como para el de los deportes.

Es indudable que la *fórmula* de la "instrucción paradójica" no es más que un modelo teórico de síntesis: la norma contradictoria puede encarnarse de múltiples maneras distintas, en función de los diversos canales comunicacionales, los personajes y las situaciones que integran el vasto repertorio de las situaciones de aprendizaje ¹³.

Por otra parte, cuando se afirma que las reglas de codificación incorporadas en el curso del proceso de socialización privilegian en el sujeto una "lectura" del mundo, se está implicando que el neurótico enfrenta una y otra vez conflictos con los caracteres paradójicos de la situación original, ya que *para él* están dadas las condiciones de producción de ese fenómeno en tanto cada situación que active el dilema dependencia-independencia, en cualquiera de sus múltiples formas reactiva asimismo las reglas paradójicas para su resolución. Esto pone en marcha la respuesta más adaptativa posible a la contradicción que adscribe a la situación: la conducta neurótica. El hecho de la recurrencia de esta experiencia habla acerca del refuerzo circular —es decir, de la retroalimentación positiva— de la situación patológica. La paradoja tiene así para el sujeto el doble carácter de "histórica" y "actual", por lo que la neurosis tiende a autoperpetuarse.

Nuestra reconstrucción tomó como punto de partida rasgos de conducta que caracterizan a cada una de las tres entidades estudiadas y delinean un modelo predominante. Es indudable, con todo, que el proceso de socialización expone al sujeto a diferentes modelos de aprendizaje, en distintos momentos, en distintos medios, y frente a aprendizajes de distintas facetas de la realidad. Las conductas habituales de un sujeto dado son el resultado de la combinatoria de distintos modelos internalizados. Con todo, parece razonable considerar modelos (y paradojas derivadas de éstos) principales y subsidiarios, criterio isomorfo con el de describir rasgos de conducta predominantes y accesorios.

¹³ Los mensajes mutuamente incompatibles y a diferente nivel lógico que configuran la paradoja pueden ser emitidos: a) ambos en un mismo canal —verbal lingüístico, verbal extralingüístico, gestural, contextual— o bien uno en cada uno de los canales; b) ambos por una misma persona o bien por más de una (cf. Wackland, 1969); c) incorporados a un modelo de aprendizaje o bien producidos por el contraste entre modelos de aprendizaje; d) en forma coexistente o bien sucesiva.

Asimismo las paradojas podrían ser diferenciadas de acuerdo con el elemento del sistema comunicacional de la situación de aprendizaje a que se refiere cada término de la contradicción. Ejemplos de distintos referentes: a) ambos términos se refieren al destinatario (tal es el caso de las paradojas referidas a las tres neurosis); b) ambos términos de la paradoja se pueden referir a la fuente (tal como: "Sólo cuando sufro soy feliz"); c) un término se refiere al código en tanto que el otro define de manera incompatible la fuente (esto ocurre, por ejemplo, en la "paradoja del mentiroso" correspondiente a la afirmación de Epiménides de Creta: "Todos los cretenses son mentirosos"). Para una introducción al problema de la paradoja en la pragmática de la comunicación humana, cf. Watzlawick (1965), y Watzlawick, Beavin y Jackson (1967).

A título de mero listado puede enunciarse múltiples variables intervinientes "externas" al proceso de socialización —tales como rasgos básicos de personalidad del sujeto (genéticamente adquiridos), intensidad de componentes instintivos, etc.—, así como diversas variables "internas", específicamente referidas a las modalidades de aprendizaje, que pueden intervenir para condicionar intensidad, persistencia, virulencia de cada estilo caracterológico del cuadro clínico, y aun la presencia de uno u otro tipo de cuadro. Estas últimas son: I) la combinatoria simultánea o sucesiva de modelos de aprendizaje predominantes; II) la precocidad de la utilización de modalidades paradójales; y III) la intensidad y característica de las múltiples posibles experiencias correctivas provenientes ya del mismo medio familiar, ya del entorno significativo extrafamiliar.

Recapitemos ahora cuáles son los rasgos en común de los modelos de socialización propuestos. En primer lugar, la copresencia de mensajes contradictorios correspondientes a distintos niveles lógicos: un mensaje contiene una instrucción y el otro transmite una instrucción o información opuesta a la del anterior, pero referida a la *clase* de instrucciones de la que la primera es miembro, o a la clase de mensajes del que es miembro el que contiene la primera. Además, se dan en un contexto significativo —el medio familiar— ineludible, y en el que al sujeto le resulta fundamental discriminar significados. Finalmente, la experiencia es reiterada, ya que reaparece como contexto de diferentes aprendizajes concretos, y genera una predisposición por la que comienzan a configurarse situaciones de tal característica aún en ausencia de elementos esenciales de la situación original.

Este conjunto de rasgos contiene todos los ingredientes que los diversos autores consideran esenciales para definir la situación de doble-vínculo (*cf.*, por ejemplo, Bateson *et al.* 1956, y Sluzki *et al.*, 1966).

A partir de lo planteado y de lo esbozado en las partes generales de la sección 2, se puede proponer la hipótesis de que la teoría del doble-vínculo posee un carácter no de teoría etiológica específica de la esquizofrenia sino de *situación patogénica universal*: toda patología a nivel psicológico —y por ende interaccional— tendría como antecedente necesario una situación de socialización configurada de acuerdo con las premisas planteadas hace 13 años por el grupo de Palo Alto¹⁴.

Recordemos que la formulación original del doble-vínculo fue propuesta en 1956 por Bateson, Jackson, Weakland, y Haley como una hipótesis explicativa de la etiología de la esquizofrenia. A la fascinación primera provocada por esa hipótesis, que conmovió al mundo psiquiátrico, siguió hasta el presente una continua polémica centrada a

veces en la indudable distancia existente entre esa formulación y el nivel de los observables, y otras en el mero hecho de que desde la formulación original, ha existido muy poca producción científica que la enriqueciera. Cabe acotar que, a nuestro entender, ha contribuido en forma capital a este estancamiento la carencia de una metodología para el análisis del discurso de pacientes, tanto para la reconstrucción de modelos genéticos como para la validación de hipótesis en este sentido.

Nuestra proposición hace de la teoría del doble-vínculo una hipótesis sin duda más abarcativa. Pero proponemos algo más: que el primer paso tendiente a aproximarse a una validación del modelo en su nueva dimensión sea reconstruir el tipo predominante de socialización de cada uno de los cuadros nosológicos, especificando la paradoja inicial de modo coherente con la patología. Proponemos para ello una modalidad reconstructiva que aplicamos aquí para ciertas neurosis. Dicho en otras palabras, se debe introducir niveles de transformación intermedios entre la teoría general del doble-vínculo —la que tal vez, como dijo Bateson, es más una epistemología— y cada cuadro psiquiátrico. La teoría del doble-vínculo tiene que ser aun enriquecida a nivel conceptual. Recién entonces se podrá, en un segundo paso, efectuar la tarea de operacionalizar los conceptos validados en estudios sistemáticos del discurso de pacientes y, finalmente, investigar en diseños longitudinales a largo plazo. Nos parece posible que la falta de investigaciones longitudinales siguiendo los modelos del doble-vínculo se deba no sólo a la dificultad inherente a tal tipo de diseño, sino a la ausencia de niveles de transformación intermedios, es decir, de especificación de la teoría.

Uno de los replanteos teóricos que deriva de la hipótesis acerca del carácter patogénico universal de la situación de doble-vínculo se refiere al status de esta teoría en relación con la esquizofrenia. Resulta plausible suponer que, en las esquizofrenias tipo "desarrollo", es decir, en las que la afección diagnosticada presenta una suerte de continuidad de un estilo habitual del sujeto, la expresión sintomática del cuadro permitirá inferir de qué incongruencias intrínsecas de las reglas del proceso de socialización es respuesta el cuadro que presenta el paciente. Representan un apasionante desafío criptológico, pero, insisto, parece *prima facie* asequible. No ocurre lo mismo cuando se plantea el problema de las esquizofrenias de tipo "proceso", es decir, el cuadro que aparece bruscamente en un momento de la vida del paciente como una discontinuidad de la modalidad adaptativa del sujeto. La psicosis, en este caso, ¿es una expresión de una técnica adaptativa? ¿O lo fue la modalidad *previa* a la aparición del brote? ¿O son dos alternativas "legítimas" de un mismo proceso de socialización?

La tarea de intentar plantear hipótesis específicas para la esquizofrenia nos excede, al menos por ahora. Cabe sugerir con todo la posibilidad de que se oriente la pesquisa hacia la reconstrucción de meta-reglas, es decir, de reglas de relación entre modelos de aprendizaje,

¹⁴ La hipótesis de que la situación de doble vínculo se halla en la base de otros cuadros psicopatológicos distintos de la esquizofrenia posee algunos antecedentes. Ferreira (1960) detectó dobles vínculos en los orígenes de la conducta delincente, y Watzlawick (1969) propuso una correlación entre las áreas en que se focalizan los mensajes contradictorios y distintos cuadros psiquiátricos.

productos tal vez de una aplicación consistentemente inconsistente de modelos de aprendizaje por parte de los padres. Es decir, la aplicación inconsistente de modelos de socialización —o, lo que es lo mismo, la metacomunicación errática de las expectativas—, puede que conduzca a que el sujeto incorpore la regla acerca de la falta de reglas para interpretar la realidad, cuyo efecto en el sujeto sería la adjudicación de significados que no se adecúan al contexto en que se dan los mensajes: la conducta definida como "loca" puede que sea la salida "legitimada" por una instrucción "Debes discriminar qué esperamos de ti independientemente de lo que digamos", o sea "Debes aprender a discriminar desconfiando de tus sentidos".

Esta presentación posee —cómo podría ser de otra manera— al menos dos niveles: uno corresponde al explícito del discurso, en el que se aportó modelos de aprendizaje y se planteó diversas hipótesis, problemas conceptuales generados por éstas, y líneas de investigación tendientes a esclarecerlas; el otro corresponde a un nivel implícito (que deja de serlo al hacer este comentario), el de la metacomunicación de nuestra modalidad o estilo de razonamiento reconstructivo, cosa que, por el proceso de deuterio-aprendizaje incluíble en toda transmisión de información, hará su parte para facilitar el camino hacia el establecimiento progresivo de hipótesis genéticas específicas para cada uno de los trastornos mentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATESON, G. — Social Planning and the Concept of Deutero-Learning. En Newcomb y Hartley (eds.): *Readings in Social Psychol.* New York, Holt, 1942.
- BATESON, G. — Las convenciones de la comunicación: cuando la validez depende de las creencias. Cap. 8 de Ruesch y Bateson: *Communication*, New York, Norton, 1951 (ed. castellana: Buenos Aires, Paidós, 1965).
- BATESON, G., JACKSON, D. D., HALEY, J., y WEAKLAND, J. — Toward a Theory of Schizophrenia. *Behav. Sci.*, 1956, 1(4):251.
- FAIRBAIRN, W. R. D. — *Estudio psicoanalítico de la personalidad* (ed. castellana). Buenos Aires, Paidós, 1962.
- FERRERIA, A. — The Double-Bind and Delinquent Behavior. *Arch. gen. psychiat.*, 1960, 3:359.
- SLUZKI, C. E., BEAVIN, J., TARNOPOLSKY, A., y VERÓN, E. — Transacciones descalificadoras: investigación sobre el doble vínculo. *Acta Psiquiat. psicol. Amér. lat.*, 1966, 12:329.
- VERÓN, E., y SLUZKI, C. E. — *Comunicación y neurosis*. Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1970.
- WATZLAWICK, P. — Paradoxical Predictions. *Psychiatry*, 1965, 128, 368.
- WATZLAWICK, P. — Familia y patología. *Acta Psiquiat. psicol. Amér. lat.*, 1969, 15, 334.
- WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. H., y JACKSON, D. D. — *Pragmatics of Human communication*. New York, Morton, 1967 (ed. castellana: Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, en prensa).
- WEAKLAND, J. H. — The Double-Bind Hypothesis of Schizophrenia and Three-Party Interaction. En Jackson, D. D. (ed.): *The Etiology of Schizophrenia*. New York, Basic Books, 1960.

Correlato del trabajo

"El doble vínculo como situación patogénica universal".
del doctor Carlos E. Sluzki

JORGE CANESTRI *

En el libro *Pragmatics of Human Communication* Watzlawick, Beavin y Jackson postulan que en una secuencia comunicacional todo intercambio de mensajes estrecha el número de las siguientes movidas posibles, y que el contexto puede ser más o menos restrictivo, pero siempre determina las contingencias hasta cierto punto. Este contexto no está construido solamente de factores externos, sino también de los mensajes intercambiados.

Nos gustaría entender este trabajo como un mensaje de una larga secuencia, ubicado dentro de un contexto, determinado, como en la definición previa, por todos los factores normativos que implica un Congreso, la situación que se vive, los mensajes científicos y no científicos que circulan.

Se desprende de lo anterior que el campo debe haberse estrechado a esta altura, que hay una cierta expectativa de respuesta por parte de los que integran el circuito comunicacional de esta presentación, más todos los que escuchan y participarán en la discusión.

Podría afirmarse, sin riesgo excesivo de error, que los que exponen conocen tales expectativas y responderán de alguna manera a ellas, además de expresar sus ideas. Es conocido asimismo que no hay movidas inocuas, de forma tal que cualquiera que se adopte implicará una cierta caracterización de la situación y de quien la plantea.

Esto no es novedad, en el trabajo que escuchamos se habla de la metacomunicación de la modalidad de reconstrucción del autor de nivel de abstracción más elevado que implica, dado que los metamensajes hablan de los conjuntos y de las clases de situaciones. Hay una metacomunicación explícita y una implícita. Esta última define con la modalidad de reconstrucción una correlativa definición de ciencia.

Una de las intenciones primordiales de nuestro trabajo teórico y

* Servicio de Psicopatología y Neurología, Policlínico "Prof. G. Arízoz Alfaro". Lanús, Provincia de Buenos Aires.

técnico es acordar inteligibilidad a la conducta alienada. Laing en su artículo "Lo obvio" describe una progresión en la búsqueda de inteligibilidad del individuo al contexto de la familia. Allí estamos hoy. ¿Por qué?

Si uno se pregunta por la irracionalidad de la familia, como hace Laing, en las redes más amplias que la abarcan, trata de ubicarla dentro de un sistema más inclusivo. Descubre entonces a la familia como una estructura sobre cuya necesidad de perduración insisten los sistemas en vigencia. Observa que todas nuestras definiciones sobre ella implican la aceptación del susodicho sistema tácitamente o no. Y se pregunta si la teoría y la práctica que se levantan sobre tales condiciones no tienden, por lo menos en parte, a posibilitar la persistencia del mismo; siguiendo la regla de que el sistema tiende a dar pasos aproximativos cada vez más cercanos a la realidad, pero naturalmente, hasta los límites que le son propios, más allá de los cuales se plantearía la ruptura del conjunto.

Vemos entonces el quehacer propuesto guiado por intereses pragmáticos precisos y a la teoría como especulación sobre un fin que, indudablemente no ha sido criticado, a veces ni puesto al descubierto.

Este tipo de teoría contribuye al conocimiento, pero hasta aquí, su dimensión esencial circula en el sentido de la finalidad que asume, sin discutirla.

Que no quepan dudas acerca de que el sentido de este comentario no es el de criticar la recuperación de una doctrina o una técnica por el sistema, ni su utilización ideológica, esto es inevitable. Hasta cierto punto, es incluso, la explicación de la dinámica de este conocimiento y de la regla propuesta como dictum.

La crítica se dirige más bien a las subrepciones que deslizamos permanentemente en la construcción de la teoría, por plegarnos a un mundo paradójico con un pensamiento que excluye la categoría de totalidad. Nos parece imprescindible adoptar algún punto de vista frente al problema de la relación del hombre con el conocimiento.

Planteamos la posibilidad de conocimiento real en el respeto a la exigencia formulada en las Tesis sobre Feuerbach de comprender la esencia humana no como una abstracción inherente a cada individuo, sino como su realidad, que es el conjunto de las relaciones sociales, y su pertenencia a una forma particular de sociedad. (Tesis VII y VI.)

El marxismo constituye su epistemología alrededor de los sucesivos conceptos que Marx va elaborando, cuyo listado parece hoy innecesario, pero que ubican frente a un tema reiterativo en su obra, el diálogo del científico con la historia. En un cierto tipo de participación, en que el conocimiento paulatinamente adquirido dependerá de esa realidad y del carácter de la inclusión en ella que aquel aporte.

A través de estas formulaciones se arriba a la crítica de un sistema y se esboza otro, que funciona de referente y de proyecto. Este es el punto central, pero aquí nos detendremos.

Hay un campo más inmediato, el que se articula alrededor del desbrozamiento de los elementos científicos y los ideológicos en toda teoría. Esta delimitación se inserta en distintos niveles de análisis. En el metodológico no parece buena guía hacer algunas elecciones sin decir oficialmente por qué han sido eliminados parámetros que deberían intervenir. Sería útil hacer una discusión previa de cuál es el análisis de sentido común científico que lleva a la construcción de una hipótesis.

Estaría justificado en estos momentos donde la moda teórica y la oficialización se agudizan, si fuera necesario apoyar de algún otro modo la común exigencia metodológica.

El psicoanálisis a su vez diseña trabajosamente su propia referencia epistemológica, que lo va alejando de la psicología habitual hasta Freud. El desenclavamiento del inconsciente, sus leyes y su lenguaje, sobre todo su lenguaje, que se expresa en los síntomas y los sueños, en la neurosis y la psicosis: en la vida cotidiana, y así sucesivamente a través de los símbolos. Todo esto en el terreno de la experiencia analítica, esencialmente intersubjetiva. Y, además, en referencia a un sujeto con un lugar social determinado.

Pero configura una proposición epistemológica porque propone además una particular relación con el conocimiento y construye los instrumentos necesarios para leerse a sí mismo críticamente.

No se puede negar que el psicoanálisis no reveló una excesiva preocupación sobre el tema, y que las pocas preguntas que se hace en este orden de cosas proviene del psicoanálisis lacaniano y de alguna que otra publicación aislada de la escuela de K. Popper en Inglaterra.

En el relato oficial se habla de la teoría del doble-vínculo como de una epistemología. Ello ha decidido en parte este comentario. A. Lalande, en su *Vocabulario técnico y crítico de la Filosofía*, define el término como el "estudio crítico de los principios, las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, destinado a determinar su origen lógico, su valor y su alcance objetivo".

No creemos necesario discutir que la teoría del doble-vínculo no es una epistemología en el sentido antedicho.

Sin embargo diríamos que la teoría comunicacional contiene propuestas epistemológicas, que trataremos de esbozar como lo hicimos para el marxismo y el psicoanálisis.

A nuestro entender, el principio epistemológico de la teoría de la comunicación puede rastrearse específicamente en sus aportes al problema del metalinguaje y la metaciencia.

Esta idea, que está anidada en casi todas las paradojas lógicas de que nos habla la historia, cobra cuerpo específico al plantear B. Russell la paradoja que lleva su nombre y que induciría a G. Frege a dudar de la posibilidad de otorgarle una base lógica a la aritmética.

Consistió en sus versiones más moderadas en definir que el lenguaje también es objeto de investigación, diferenciando el lenguaje objetivo del lenguaje que lo analiza o metalenguaje.

En la Introducción a la versión castellana a los *Metálogos* de G. Bateson, Sluzki, que reconoce la afinidad de éste con Russell, habla de los *Metálogos* como una "suerte de asociación libre que permite presenciar diversos pasos del proceso del descubrimiento". La preocupación esencial de Bateson a lo largo de los *Metálogos* y de sus trabajos sobre doble-vínculo y esquizofrenia parece anclar en el campo de pensar la posibilidad de pensar, pensar la posibilidad de conocer y sus límites, formular la conceptualización del conceptualizar y así en adelante con el aprender a aprender o deuteroprendizaje.

Este mismo proceso lo lleva a Sluzki a metacomunicar ciertas modalidades de trabajo y definir explícita e implícitamente un ámbito y sus características relevantes.

Este tema es epistemológico en la medida en que la teoría de la comunicación aporta elementos en la línea de la definición propuesta. También es cierto que el único trabajo donde la teoría funciona con carácter de intento epistemológico es en los *Metálogos*, y que aún en ellos hay más material referente al contexto del descubrimiento científico que otra cosa.

No podríamos ocultar que el tomar la teoría de la comunicación como única referencia nos resultaría empobrecedor del campo, por lo cual nos referimos a otro marco epistemológico al comienzo, como foco ineludible de centralización del objetivo con el que estudiamos la realidad y nos acercamos al problema del conocimiento.

No parece, por lo menos para nuestro nivel de comprensión, incompatible la utilización del enfoque comunicacional con otros. En el trabajo dos aproximaciones teóricas se enlazan. La psicoanalítica con la interaccional. Tampoco parece haber oposición hasta cierto grado de desarrollo de la teoría que esta última genera.

Es más, el enriquecimiento de la teoría del doble vínculo tiene que ver con la adopción de un nivel de contenido que implica un modelo del funcionamiento mental, en este caso el modelo psicoanalítico fairbairniano. Podría inferirse el estancamiento de la teoría del doble vínculo no solo de la carencia de una "metodología para el análisis del discurso de pacientes", sino también de su limitación intrínseca a un campo pragmático puro tal como estaba formulada primitivamente.

No por nada Sluzki habla del modelo en su nueva dimensión. Otra discriminación, capital a nuestro entender, que efectúa el autor, es entre la teoría del doble-vínculo comprendida como situación patogénica universal, conjunto de hipótesis acerca de los procesos de socialización, y, por consiguiente, de aprendizaje y lectura del mundo y lo que sería una teoría etiológica en el sentido clásico.

Esta discriminación se realiza diferenciando niveles estructurales

y niveles de contenido y privilegiando la sobredeterminación causal. Es en esta lectura de la sobredeterminación donde se dejan fuera consideraciones acerca del contexto socializador global que a nuestro parecer son fundamentales.

Caso contrario el investigador es una muestra más de lo que el mismo autor relata como que "las reglas de codificación incorporadas en el curso del proceso de socialización privilegian en el sujeto una 'lectura' del mundo, enfrentando una y otra vez conflictos con los caracteres paradójicos de la situación original". Aquí la codificación y los caracteres paradójicos la aporta el sistema total, y la lectura del científico debería superarlos.

En los mismos términos de la teoría del doble-vínculo, Watzlawick, Beavin y Jackson agregan la descripción de la reacción esquizofrénica, que estipula el bloqueo de los "inputs", fenómeno de la "defensa perceptual".

En nuestros términos, el aislamiento de la realidad social redundaría en una auténtica alienación del científico y del concepto emitido.

Como naturalmente, este tipo de comunicación es circular, este mensaje a su vez es alienante del sentido.

Sigamos a Sluzki en sus proposiciones. La primera se refiere a la validación del modelo en su nueva dimensión, tratando de reconstruir el tipo predominante de socialización de cada uno de los cuadros nosológicos.

Creemos no equivocarnos al afirmar que la misma parte de la lectura del doble sentido del signo en cada momento del discurso, a través de una exégesis que le da inteligencia y crea una perspectiva genética para llenar el hueco o sustituir el sentido alienado que trae el paciente. Este método es el psicoanalítico y entendemos que su solidez lo hace indispensable en todo intento de reconstrucción. De aquí puede provenir buena parte del incremento conceptual de la teoría.

La segunda propuesta tiene relación con la operacionalización de los conceptos validados en estudios sistemáticos por un lado, y de su instrumentalización en diseños longitudinales de largo plazo por el otro. Éste parece siempre uno de los mayores obstáculos. La proporción de estudios sobre series espaciales, donde el interés radica en la estructura y relación de las variables tal como se dan en un momento determinado o en un breve intervalo de tiempo es significativamente mayor que la de series temporales analizadas.

Esta debilidad por los estudios instantáneos que impide el ordenamiento de la información recogida en una serie temporal continua es probable tenga relación con lo que se dice en el trabajo acerca de la ausencia de niveles de especificación de la teoría. Quizá sin embargo valga la pena puntualizar qué se busca con esos estudios muy claramente.

La tercera proposición tiene como tema la relación de la teoría con la esquizofrenia. La sugerencia de Sluzki acerca de la metacomu-

nicación errática de las expectativas, con la incorporación de una regla, por parte del sujeto, acerca de una ausencia de reglas para interpretar la realidad nos parece brillante. Además adecuada a la experiencia clínica con familias. Nos hace pensar asimismo en una visión que tiene el terapeuta de la visión fragmentaria del sujeto, con adjudicaciones erráticas de los significados, pero, de acuerdo al relato, sustancialmente en una falsa adecuación al contexto en que se da el mensaje.

Al pensar los dos modelos de instrucciones esbozados como: "Debes discriminar qué esperamos de ti independientemente de lo que digamos", o sea "Debes aprender a discriminar desconfiando de tus sentidos", recordamos un juego que querríamos plantear aquí. El juego puede explicarse así: se crea un código cualquiera que otorga sentido al mensaje que se emite y se construye un discurso respetando el código, que es conocido de todos menos de un participante. Éste es instruido acerca de la existencia del código y de la necesidad que tiene de descubrirlo para librarse del juego. Se le aclara que teniendo en cuenta lo anterior no debe leer literalmente los mensajes. Nosotros pensamos este juego como reformulación del mensaje del trabajo. Su constitución sería como sigue:

- 1) No es un juego, es la realidad, y la subsistencia está de por medio.
- 2) Debes desconocer la literalidad de los mensajes referidos a las expectativas que tenemos de ti ("no puedes confiar en tus sentidos").
- 3) Debes tratar de efectuar la lectura del código subyacente: "qué esperamos realmente de ti".
- 4) Obviamente la existencia del código es implícita pero además desconocida para el codificador.
- 5) La respuesta condiciona un proceso semejante en el codificador que a su vez desconoce múltiplemente el sentido del código original que implantó y la respuesta.

Esto aproxima al sentido de "reconstrucción de mundo" de la psicosis, al problema de la interacción en el sistema familiar y sus condicionamientos sucesivos, y a la idea de Laing del sentido de la conducta del codificador. Por ejemplo: "La manera normal en que los padres consiguen que los hijos los amen consiste en aterrorizarlos... porque no te mato, demuestro que te quiero... Y se preocupan porque los hijos no dan señales de gratitud".

También acerca de la idea de Winnicott del espejo. Lo que antecede al espejo es la madre, su rostro, si lo mira a uno, pero, y si se mira a sí misma, y así sucesivamente. Uno de los muchos méritos del trabajo de Sluzki es explicar las mediatizaciones de todo esto a través del lenguaje. Además, este problema está esbozado cuando se habla de los conflictos de los padres en el relato.

Finalmente nos interesaría la línea de ver la familia como una mediatizadora de la ideología del sistema. Si esta madre de la que habla Winnicott no es como dice Laing la que arroja la mirada y usa el lenguaje que le restituye a uno su individualidad, sino la que expresa su conflicto e impone su código, no es a la vez ella misma objeto de otro sujeto, que es la sociedad, de la cual recibe a su vez su alienación y la expresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALTHUSSER L. — *La revolución teórica de Marx*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1967.
2. BATESON G. — *Metáforas*. Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1969.
3. BATESON G, JACKSON D., HALEY J. y WEAKLAND J. — *Towards a Theory of Schizophrenia*, en *Communication, Family and Marriage*. Science and Behavior Books, 1968.
4. *Idem*. — A Note on the Double-Bind Theory. *Idem*.
5. *Cahier pour l'Analyse*. 9. *Généalogie des Sciences*, 1968.
6. FAIRBAIRN W. R. D. — *Estudio psicoanalítico de la personalidad*. Buenos Aires, Hormé, 1962.
7. LACAN J. — *Ecrits*. Aux Ed. du Seuil, 1966.
8. LAING R. D. y ESTERSEN A. — *Sanity, Madness and the Family*. Vol. 1. Tavistock Publications, 1966.
9. LAING R. D. — *Lo obvio. Dialéctica de la liberación*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1969.
10. NAGEL E. — *La estructura de la ciencia*. Buenos Aires, Paidós, 1968.
11. POPPER K. — *La lógica de la investigación científica*. Ed. Tecnos, 1962.
12. RAPAPORT D. — *Structure of Psychoanalytic Theory*. *Psycholog. Issues*. 1960, vol. 2, 2.
13. JONES S. — *Treatment or Torture*. Tavistock Publications, 1968.
14. SERAG I. — *Marxismo y estructuralismo*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1969.
15. VERÓN E. y otros. — *Lenguaje y comunicación social*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1969.
16. VIRIEUX-RAYMOND A. — *L'épistémologie*. P.U.F. 1966.
17. WATZLAWICK P., BEAVIN y JACKSON. — *Pragmatics of Human Communications*. Norton, 1967.
18. WATZLAWICK P. — *A Review of the Double-Bind Theory*. En: *Communication, Family and Marriage*. Science and Behavior Books, 1968.
19. Editado por LOMAS P. — *The Predicament of the Family*. The Hogarth Press, 1967.

Correlato del trabajo

"El doble vínculo como situación patogénica universal",
del doctor Carlos E. Sluzki

HAROLD A. HAMMOND *

Quisiera resumir cómo he entendido el núcleo de la tesis del autor.

El individuo neurótico es un sujeto que tiene un modo especial o preponderante de atribuir significados a las cosas y situaciones del mundo externo, incluyendo sus propias conductas. Ese modo particular es el resultado de un aprendizaje en las situaciones de socialización que sus padres le han determinado.

El punto nodal del autor es el hecho que los padres o sistemas de socialización definen la situación de aprendizaje y las reglas de aprender con mensajes contradictorios o doble-vínculo, resultado de sus propios conflictos personales, ambivalencia. El resultado es que el hijo trata de resolver las contradicciones a partir de conductas que estructura como las más adecuadas y que suponen una codificación determinada: la codificación neurótica.

Las situaciones de aprendizaje determinadas contradictoriamente, son las que tratan el dilema autonomía-dependencia. Entendiendo así la tesis, mi opinión me lleva a diferir con la preponderancia de los mensajes contradictorios y por ende con la hipótesis de situación universal patogénica.

Comenzaremos estudiando los tres ejemplos de modelos de socialización. Previo a ello, para mi uso personal, reformularé el concepto de autonomía. Hablaremos de dos tipos de actividades, por acuerdo y por iniciativa personal; de cada una de ellas puede derivarse la autonomía correspondiente. Ambos conceptos están planteados por el autor en diferente status en la tesis. La primera sería la versión oficial, y la segunda es el fundamento para llegar a la conclusión que la primera es una ficción y la base de su idea de doble-vínculo.

Tomemos el fóbico. Considero que no existen mensajes contradictorios —seguimos al autor—, al hijo se lo estimula a un número de

actividades que pueden llegar a la autonomía; además en esta área se metacomunica que la relación es tranquilizadora y segura, no angustiante. Estamos en la actividad por acuerdo. En determinados momentos, el hijo lleva a cabo actividades espontáneas (correr, pelearse, alejarse de la madre, masturbarse, etc.) que provocan en el sistema de socialización una redefinición de la situación con mensajes descalificadores, rechazantes, que además metacomunican que la situación entre ellos es angustiante, intranquilizadora. Luego estas actividades espontáneas que podrían haberse desarrollado como autonomía por iniciativa propia, son rechazadas y calificadas con otros significados. En cada clase de hechos no hay en los mensajes contradicciones con lo que metacomunican. Hay dos clases de hechos que tienen sus propias definiciones y reglas que permiten al hijo llevar a cabo conductas acordes con las reglas de juego. En este ejemplo vemos cómo para el autor la autonomía por acuerdo es entendida como una ficción y rechazada como una solución legítima. No obstante, el sistema de socialización da elementos al hijo para que se adecúe y entienda la situación definida por los padres, hecho que rebate la idea de doble-vínculo.

En el caso del obsesivo, creo que mi razonamiento se repite. Es importante acotar que el autor en este ejemplo incluye la autonomía por iniciativa propia, que considera la legítima.

Volvamos al modelo de socialización. El sistema de socialización determina en un nivel (creo que es más adecuado decir en un área), que el hijo debe seguir una regla. Es bien explícito cómo entendemos autonomía por acuerdo —"haz lo que debes hacer"—, y se le metacomunica algo a través de la no gratificación instrumental. En otras áreas, aparecen actividades espontáneas o desviadas de la regla, obteniendo inmediatamente su descalificación y rechazo, además de calificarlas de malas. Se metacomunica el odio o enjuiciamiento de los padres, que puede dar un significado de castigo al cumplimiento de los deberes sin gratificación instrumental, ya que los castigos no se premian. Nuevamente nos encontramos con dos clases de hechos que son significados por el sistema de socialización de manera distinta y sin contradicción entre sí. La situación a partir de los padres es clara en su definición.

Finalmente llegamos al histérico. En principio el caso es más complicado y creo aquí el autor deja entender una relación. Sigamos con nuestro razonamiento hasta donde sea posible. Existen una serie de actividades que son descalificadas a través de mensajes de rechazo y prohibición, y donde se metacomunica el desagrado y lo conflictivo que deviene la relación padres e hijo. Existen otras actividades o hechos reclamados por el sistema de socialización; estas actividades serían las determinadas o estimuladas por ellos. Se configuran así dos clases distintas de situaciones con su correspondiente definición. En este nivel no existen a mi entender situaciones tipo "Quiero que me mandes". No obstante, tomando la clase de situaciones bajo acuerdo o dependencia, donde el sistema de socialización le reclama pasividad o actividad, po-

* Callao 463, 10° D, Capital Federal.

dría existir una semejanza con mensajes contradictorios. No sabemos si el sistema de socialización tiene definidas unas situaciones reclamando actividad y otras reclamando pasividad. Si es así, el hijo tiene suficientes elementos definitorios para actuar acorde con el sistema de socialización.

En este ejemplo hay una relación que me parece determinante para el autor. El hecho es la existencia de conductas pendulares de tipo atracción-repulsión que el histórico lleva a cabo. Creo que esta forma de la conducta plantea al autor con un enfoque conductista de tipo neurosis experimental, que la causa deben ser estímulos contradictorios (mensajes contradictorios). Me planteo si las conductas de este tipo con sus razonamientos también pendulares, como es todo razonamiento de un neurótico, no es resultado como Fairbairn establece de la ambivalencia del paciente. En este caso determinadas por sus sentimientos hacia el objeto, los genitales. Esta serie de reflexiones me plantean si el autor establece que la ambivalencia del niño está en gran parte determinada por mensajes contradictorios del sistema de socialización.

Quisiera agregar unos comentarios sobre el ejemplo clínico. Cuando el padre dice: "tenés que hacerlo por propia iniciativa", lo cual quiere decir: que el hijo tendría ya que hacer esto que le han enseñado por un mecanismo automático (internalización de normas); sin que en cada momento al paciente, al no hacerlo, plantea su iniciativa y obliga a los padres a nuevamente definir la situación, vale decir, plantear las actividades por acuerdo. Existe, sí, un nivel explícito con reclamo de actividades por acuerdo, y un nivel implícito con descalificación de la iniciativa propia del paciente. No existen mensajes contradictorios.

Quisiera ahora plantearme las dudas que emergen de estos comentarios, y que me llevan a disentir de lo postulado por el autor.

Creo que los problemas que me llevan a no aceptar la tesis podrían centrarse en dos hechos:

- a) La no existencia de isomorfismo entre el modelo del autor y el modelo original del doble-vínculo;
- b) El uso de un término de significado ambiguo, que encierra dos clases de hechos.

El autor, para mantener un cierto isomorfismo con el modelo primitivo, necesita modificar la situación donde se dan los mensajes contradictorios. Esta modificación es una extensión del campo donde dos mensajes adquieren el sentido de ser contradictorios: esta extensión abarca la relación total de padres e hijo. Tal es el grado de extensión del área donde deben darse mensajes para que sean contradictorios, de esta manera los doble-vínculos son realmente clases de mensajes que serían contradictorios entre sí, que él llama síntesis teórica. Ade-

más, la extensión podría no limitarse a la relación padres e hijo sino incluir la sociedad y tipo de cultura que supone contradicciones en cuanto a calificar las situaciones; creo que este tipo de extensión de la situación y la modificación de mensajes contradictorios a clases de mensajes contradictorios entre sí no es lícito en cuanto no se respeta el isomorfismo de los modelos; luego no se puede usar el concepto de doble vínculo que tiene sentido en un modelo pero no en el otro.

La segunda objeción está alrededor de la palabra "autonomía". Esta tiene un significado ambiguo. Podemos aceptarla en el plano de padres e hijos, pero para esta comunicación se necesita clarificarla. Ese fue el motivo de mi reformulación cuando comencé a estudiar los tres ejemplos de modelos de socialización. Creo además que el autor tiene in mente estos dos significados y posiblemente su no esclarecimiento haya sido una de las causas de lo que para mí no es un razonamiento claro sobre la tesis. Tenemos así que el grado de extensión que el autor ha dado al área donde los mensajes adquieren el sentido de ser contradictorios incluye toda la relación padres-hijos; para el autor en esta área los mensajes serían contradictorios en cuanto a estimulación o demanda de la autonomía, pero ésta, está nombrando dos clases distintas de hechos; luego los mensajes no son contradictorios ya que tratan de clases distintas de cosas. En los ejemplos estudiados he señalado cómo cada una de las autonomías es definida y calificada. Desde el punto de vista de los sistemas de socialización no existen a mi juicio, mensajes contradictorios que lleven al hijo a una situación de no-discriminación. Esto no excluye la existencia de factores de confusión, pero no es a partir de los mensajes contradictorios —como es el supuesto del doble vínculo—.

Finalmente, un último comentario sobre este problema. El modelo tiene un cierto carácter tautológico, en cuanto todo aprendizaje se lleva a cabo en la relación de dependencia y se supone al hijo como una figura pasiva, luego no son necesarios los ejemplos para confirmar algo que está definido de entrada en el tipo de aprendizaje que lleva a la autonomía.

Para finalizar mi comunicación, quisiera agregar una idea que me surge en especial de la descripción de los fóbicos y los obsesivos, y con la finalidad de tratar de aventurar una respuesta a los otros factores que determinan la confusión y la imposibilidad de razonar o razonamientos contradictorios que efectivamente están en la base de los síntomas neuróticos.

Veamos en los fóbicos que cuando en la etapa de dependencia con su sistema de socialización llevan adelante actividades por iniciativa propia, que ellos vivencian, califican o significan como buenas, propias o no angustiantes, se encuentran con los padres que no sólo descalifican esa conducta en función de ser por iniciativa propia, a través de mensajes de rechazo, etc., sino que le metacomunican al hijo

cómo la relación con ellos ha adquirido una carga de angustia y de intranquilidad manifiesta frente a los otros tipos de conducta que hacen una relación tranquilizante. O recordando al obsesivo, metacomunican una relación de enjuiciamiento, odio y rechazo.

Vemos que estos significados que aparecen en la metacomunicación, pasan a ser los significados que constantemente trata el neurótico de aplicar o descartar de sus conductas y sentimientos. Podemos decir que se ha internalizado toda la situación de aprendizaje. La relación entre el sistema de socialización y las actividades por iniciativa propia del hijo ha quedado encerrada en identificaciones.

Quiero aventurar una hipótesis desde el punto de vista del pensar que debe agregarse a las conocidas por la teoría analítica. El paciente frente a la contradicción de dos significaciones, la suya y la del sistema de socialización, no puede comprender; luego lleva a cabo la primera operación para comprender: la identificación. Se identifica, luego incorpora esas significaciones; a manera de una analogía, "aprendo de memoria". ¿Por qué esta incapacidad de entender? Creo que es atribuible a que las significaciones que la madre le metacomunica pertenecen al mundo privado, narcisístico de su madre.

Esta idea me la inspira el escuchar pensar a los pacientes con razonamientos de tipo automáticos, de los cuales no se dan cuenta muy a menudo; y que la detención y vuelta sobre ellos lleva al paciente a la sorpresa de sus errores. Usando una idea de Rodrigué, son enfoques que funcionan automáticamente, locus en la mente con su stock de significados y razonamientos nunca replantados.

También me hacen recordar a las palabras en los sueños, donde sólo son un indicio, un rasgo de una identificación o sentimiento. Esto me lleva a una pura especulación, siguiendo la filosofía analítica de Wittgenstein, si muestra primer contacto con la mente no es el contacto con pseudo problemas internalizados, originarios de no comprender a la madre. Disueltos ellos aparecen los verdaderos conflictos neuróticos.

Los esquizofrénicos y sus familias.

Orientaciones y hallazgos de investigaciones recientes

LYMAN C. WYNNE *

En todos los estudios amplios del origen, el desarrollo y la perpetuación de los desórdenes esquizofrénicos se encuentran consideraciones relativas al papel y la importancia de la familia. Esta proposición clave se aplica tanto a las hipótesis genéticas como a las psicodinámicas. Aunque los estudios de la familia con estos distintos puntos de partida fueron a veces origen de considerables controversias, tanto como de dogmatismo e incompreensión, ahora comienza a manifestarse una amplia área de acuerdo aún no reconocida. Este consenso emergente, aunque todavía parcial, abre un nuevo marco de referencia para futuras investigaciones. Afortunadamente, varios métodos nuevos de investigación pueden introducirse ahora en los estudios familiares. Este trabajo puede ser especialmente importante por sus posibles consecuencias para una revisión de la conceptualización de la naturaleza de los desórdenes esquizofrénicos, y tal vez también de otras formas de desviación del comportamiento.

Estudios intensivos de la dinámica familiar. Hace algo más de una década, una cantidad de investigadores (v. g.: Bateson, Jackson, y Haley y Weakland, 1956; Lidz, Cornelison, Fleck y Terry, 1957; y Wynne, Rickoff, Day e Hirsch, 1958) que previamente se habían interesado en los enfoques psicológicos y psicoterapéuticos de individuos esquizofrénicos, volvieron su atención hacia los estudios intensivos de las familias de esquizofrénicos. Estas investigaciones representaban una desviación respecto de los estudios familiares más tradicionales que se ocupaban sobre todo de la herencia. En las investigaciones sobre la genética de las esquizofrenia se hizo hincapié en la concordancia entre los diagnósticos de los miembros de la familia. Por lo general, los datos consistían en registros de hospitalización y averiguaciones sobre la sintomatología principal de los miembros de la familia. En contraste,

* Chief, Adult Psychiatry Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda Md., U.S.A.

los estudios familiares intensivos por lo común establecieron relaciones psicoterapéuticas y de investigación con todos los miembros de la familia, los que a menudo eran vistos individualmente y en conjunto, a veces en el curso de tratamientos terapéuticos que duraban años. Los miembros de la familia eran observados directamente mientras interactuaban entre sí y con los investigadores y terapeutas. Posteriormente, nuestro programa del Instituto Nacional de Salud Mental, así como otros programas, han introducido una variedad de procedimientos de tests familiares, individuales y conjuntos, a fin de obtener bases para las comparaciones sistemáticas y "ciegas" entre familias.

Gran parte de este trabajo tenía como finalidad comprender las pautas familiares dentro de una perspectiva terapéutica, estudiando en especial las complicaciones familiares *presentes* que parecían sostener la sintomatología. Estas pautas de interacción familiares, que no podían deducirse directamente de los síntomas individuales, parecían extraordinariamente estables. Se observaron familias que tenían las mismas propiedades de un "sistema" con autoequilibrio y la sintomatología individual fue vista como un ingrediente integral de este funcionamiento familiar general. De modo comprensible, surgieron especulaciones respecto de los posibles aportes de estos factores familiares al origen y el desarrollo, a la etiología y la patogénesis, de la sintomatología. No obstante, cabe señalar que estos investigadores nunca realizaron sus estudios con la finalidad de probar directamente hipótesis etiológicas, sino más bien como una etapa *preparatoria* para investigaciones posteriores en las que esta perspectiva más amplia pudiera esclarecer los detalles de los pasos evolutivos y los procesos conducentes a la aparición del cuadro sintomático.

A pesar de los objetivos especializados de estos estudios familiares, surgieron varias conclusiones básicas que resultaron semejantes a conclusiones recientes de los investigadores genéticos. Primero, pareció que los estudios previos habían subestimado la frecuencia de las perturbaciones psicológicas en los miembros-pacientes de las familias de esquizofrénicos. Aunque las entrevistas iniciales y los contactos convencionales a menudo no revelaron nada que debiera incluirse en los registros hospitalarios comunes, los estudios familiares intensivos por lo común hallaron perturbaciones graves, a menudo flagrantes, en los miembros de la familia sobre los que no se había hecho diagnóstico. Tanto Lidz como yo, realizamos esfuerzos para obtener datos de familias "normales" que tuvieran un adolescente o joven esquizofrénico, pero siempre hallamos que la primera apariencia de normalidad era una fachada que la experiencia y el comportamiento dentro de la familia la contradecían manifiestamente. Ernst (1957) hizo en Suiza una observación semejante con familias donde, según se especificaba en las historias clínicas, no se presentaban dificultades en los padres. En segundo lugar, la calidad de las perturbaciones psiquiátricas de los familiares de esquizofrénicos no se prestaba a la clasificación conven-

cional. Muchos de dichos familiares mostraban lo que se dio en llamar un síndrome "fronterizo" (*bordeline*) (cf. Grinker, Werble y Drye, 1968). Algunos clínicos calificaron a estos familiares como "caracteres esquizofrénicos", suponiendo que un proceso esquizofrénico subyacente era mantenido sintomáticamente en estado latente por la forma articular de la estructura del carácter.

En tercer lugar, estas observaciones plantearon el problema de si el concepto de esquizofrenia debía ser limitado (para excluir a estos familiares "fronterizos"), ampliado (para incluirlos) o, más fundamentalmente, reformulado en términos por completo diferentes. A pesar de tener diferentes concepciones teóricas, una cantidad de investigadores sintieron que los datos recientes sobre las familias de esquizofrénicos requerían una reformulación del concepto de esquizofrenia y una nueva consideración de los métodos de estudio (Wynne, 1968; Rosenthal y Kety, 1968).

Investigaciones genéticas con las familias de esquizofrénicos. Toda la historia de las investigaciones sobre la genética de la esquizofrenia está plagada por una controversia relativa al modo de la transmisión genética. Aunque los investigadores no han coincidido respecto de cómo ajustar los datos familiares con modelos mendelianos particulares, el aporte del factor genético resultó difícil de discutir, sobre todo después del impresionante informe de Kallmann, que encontró una tasa de concordancia del 86 % para los gemelos monozigotas, en contraste con sólo el 15 % para los gemelos dizigotas (Kallmann, 1946). Más recientemente, se ampliaron y revisaron los datos sobre gemelos y otras informaciones, sobre todo a partir de las publicaciones de Slater con la colaboración de Shields (1953) y Böök (1953). Posteriormente, las críticas metodológicas a los estudios de gemelos y otros estudios genéticos realizada por Alanen (1958), Jackson (1960) y Rosenthal (1959, 1960, 1961 y 1962a y 1962b) alentaron una revaluación de los datos familiares, en especial los de Kallmann, y se realizó una cantidad de estudios con controles metodológicos más cuidadosos (v.g., Gottesman y Shields, 1966; Kringler, 1967 y Tienari, 1963), Carlsson (1966) también llevó a cabo una amplia investigación genealógica. Heston (1966) y Rosenthal, Kety y colaboradores (1968) introdujeron un enfoque nuevo e importante al estudiar a descendientes biológicos de esquizofrénicos, a los que se había criado en casas adoptivas.

No pretendo reseñar aquí en detalle todos estos complejos estudios. A pesar de varias incertidumbres metodológicas, la investigación genética reciente confirmó el supuesto tradicional de que, de hecho, algo es transmitido genéticamente, por lo menos en el caso de *algunas* personas diagnosticadas como esquizofrénicas. No obstante, también es verdad que el factor genético parece ser menos importante de lo que antes se afirmaba. Por ejemplo, los bien controlados estudios recientes de gemelos hallan tasas de concordancia de sólo el 25 al

38 % en gemelos monozigotas (Kringlen, 1967), en contraste con el 86 % de concordancia hallado por Kallman (1946), que era la cifra citada tradicionalmente. Sobre todo a causa de que los familiares de esquizofrénicos a menudo tienen rasgos de diagnóstico marginales ("fronterizos"), se necesita urgentemente perfeccionar los métodos estandarizados para hacer evaluaciones sintomáticas y de diagnóstico a fin de usarlos en estudios familiares. No obstante, apoyarse sólo o principalmente en la concordancia entre el diagnóstico de familiares es un enfoque conceptualmente restrictivo y metodológicamente engañoso.

La preocupación tradicional por la concordancia de los diagnósticos no me satisface por varias razones:

1) Si se usa un concepto *estrecho* para el diagnóstico de la esquizofrenia, la gran mayoría de las familias no muestra pruebas de concordancia. El investigador queda entonces con especulaciones, pero sin datos empíricos acerca de estas familias. Es forzado a recurrir a hipótesis genéticas *ad hoc* sobre penetración incompleta, diagnósticos inadecuados o modificaciones debidas a factores genéticos o no genéticos. Por ejemplo, si se usa un concepto estrecho de la esquizofrenia, los estudios daneses de adopción (Rosenthal y Kety, 1968) proporcionan muy pocos datos para una hipótesis genética.

2) Los hallazgos de estos estudios recientes de gemelos o hijos adoptivos son más compatibles con un concepto amplio de la esquizofrenia. Al emplear un "espectro de la esquizofrenia" de criterios amplios, que incluyera trastornos maníaco-depresivos, "estados marginales" y "personalidades inadecuadas" se halló que un exceso pequeño pero significativo de familiares biológicos versus adoptivos era "concordante". Sin embargo, aun con este concepto amplio, en la mayoría de las familias no se encontraron datos de diagnósticos que ayudaran a esclarecer la naturaleza de los aportes genéticos o no genéticos a la enfermedad.

Además, si se amplía la variedad de condiciones clínicas que se aceptan como prueba de concordancia, forzosamente aumentan los problemas metodológicos que supone definir confiablemente los límites del concepto de esquizofrenia. Por otra parte, si el investigador adopta la hipótesis de que sólo uno o unos pocos "genotipos esquizofrénicos" determinan la extraordinaria diversidad de fenómenos clínicos incluidos en el concepto de espectro, a menos que examine los detalles de las transformaciones evolutivas que llevan a las variaciones clínicas, se encontrará con enormes lagunas en su comprensión del fenómeno.

3) Partiendo de estas y otras consideraciones, recientemente varios investigadores optaron por una hipótesis poligénica (Gottesman y Shields, 1967; Kringlen, 1967; Rosenthal y Kety, 1968). Esta posibilidad parece sumamente plausible a la luz de los datos conocidos en la actualidad, pero al evaluar una teoría poligénica, es preciso adoptar un concepto diferente de la esquizofrenia que permita suponer un conti-

núo, o continuo, de variaciones *cuantitativas* que vayan desde los casos más graves hasta la "normalidad". En una versión de un concepto cuantitativo, se toma como hipótesis un espectro de *desórdenes* o enfermedades. Como formulación alternativa, he sugerido la posibilidad de examinar las variaciones cuantitativas en una serie de *dimensiones* o continuos subyacentes específicos, con variables que son *intermedias* entre los genes y las manifestaciones sintomáticas (Wynne, 1967, 1968, 1969, 1970). Con este punto de vista, podría esperarse que el ordenamiento sistemático de los datos genéticos se produzca al nivel de las variables intermedias, no de las enfermedades clínicamente reconocidas.

En la actualidad no hay datos suficientes como para decidir entre el concepto de un espectro de enfermedades y un concepto de *dimensiones* o procesos subyacentes. Cada punto de vista es compatible con las teorías poligénicas y con los datos sobre las familias publicados hasta ahora. No obstante, ningún concepto de las variaciones cuantitativas puede ser evaluado muy adecuadamente con los actuales métodos de diagnóstico que subrayan las distinciones cualitativas de "todo o nada" tanto para los síntomas específicos como para las categorizaciones del diagnóstico.

Además de otros trabajos sobre los procedimientos del diagnóstico individual, debemos considerar un tipo radicalmente diferente de "diagnóstico" o evaluación clasificatoria. Me refiero a las evaluaciones de familias y otros grupos como *unidades*, con propiedades de sistema social. Esas estimaciones pueden correlacionarse con diagnósticos individuales, pero sólo parcialmente. Lidz *et al* (1957), Wynne (1961), Alanen (1966) y Reiss (1970) han propuesto tipologías de trastornos familiares. El concepto experimentalmente desarrollado por Reiss de familias "preocupadas por el consenso", las que a menudo tienen un miembro esquizofrénico, es un ejemplo excelente de concepto de trastorno al nivel de la familia en contraste con los conceptos usuales de trastorno a nivel de los individuos. Sería insensato suponer que los enfoques tradicionales del diagnóstico individual constituyen el único modo significativo de considerar los desórdenes del comportamiento. Por el momento, el punto importante para la investigación es que los criterios y la metodología de la evaluación deben ser cuidadosamente especificados, y que deben tomarse medidas para considerar seriamente estos conceptos alternativos.

Semejanzas y diferencias ambientales. Otro problema al que deberá prestarse más atención en la investigación familiar futura es la necesidad de especificar las condiciones ambientales para evaluar los factores genéticos y viceversa. Muy a menudo, los investigadores han supuesto que el hecho de crecer en la misma casa de familia es una prueba de que los gemelos por ejemplo, han compartido el mismo ambiente.

Concretamente, un ambiente "compartido" puede producir dife-

rencias individuales, discrepancias, con fundamentos tanto psicológicos como biológicos. El supuesto común de que un ambiente familiar compartido siempre favorece las semejanzas psicológicas carece de fundamento. Personas no criadas en la misma familia, pero sí en la misma clase social, en ciertos sentidos pueden compartir la misma experiencia en una medida mayor que los hermanos y hermanas de la misma familia. Por ejemplo, en muchas culturas los primogénitos de diferentes familias de la misma clase social indudablemente tienen más experiencias en común entre sí que con sus hermanos pequeños. Además, es bien sabido que los gemelos, como otros miembros de la misma familia, desarrollan roles complementarios característicos, por ejemplo, en lo que respecta a dominio-sumisión.

La teoría psicosocial del rol, así como todos los estudios familiares intensivos, subrayan decididamente que las diversas expectativas y roles en el interior de la familia promueven *diferencias* entre los miembros de la misma familia. Al mismo tiempo, sin duda, surgen semejanzas a lo largo de determinadas dimensiones por los factores genéticos y los procesos psicológicos de identificación. Extraer conclusiones acerca de la experiencia psicológica compartida y las semejanzas "ambientales" para los miembros de una familia particular es una tarea azarosa aun cuando se disponga de abundantes datos derivados del estudio intensivo dinámico de las relaciones dentro de la familia; sin tal estudio, las conclusiones erróneas acerca del "ambiente" son casi inevitables.

En este sentido es relevante el discutido problema de cómo interpretar la influencia de los factores extrafamiliares del ambiente social más amplio y la cultura. La reseña de Kohn (1968), muestra claramente que la frecuencia mucho mayor de los casos de esquizofrenia en las clases sociales más bajas no puede ser dejado de lado y merece un estudio de variables múltiples. Una interpretación plausible, aunque todavía no demostrada por datos, parte de la hipótesis de que la vulnerabilidad a la esquizofrenia genéticamente determinada es, en todos los niveles de la población en general, mucho más común de lo que se ha supuesto; no obstante, las pautas de comunicación, aprendizaje y experiencia que pueden dar lugar a las dificultades sintomáticas quizás sean más comunes en las condiciones de vida dentro y fuera de la familia de los niveles más bajos de las clases sociales.

Investigación de las variables intermedias entre la genética y los síntomas. Mi disconformidad con el carácter de estas formulaciones me ha llevado a proponer que la investigación con las familias de esquizofrénicos se oriente hacia variables intermedias entre la dotación genética y la aparición del cuadro sintomático. Dos clases de esas variables son: (1) las "disposiciones para responder a estímulos", que son aspectos experimentalmente definidos del "temperamento" y (2) los procesos transaccionales, en especial la comunicación intrafamiliar (cf. Fig. 1).

CUADRO I

I. PROBLEMAS DE CIERRE		260	Rechazo negativista, temporario, de una tarjeta, seguido por una respuesta
110	Fragmentos de discurso		
120	Observaciones ininteligibles	270	
130	Preceptos inestables	280	Referencias a "ellos" y al intento de otros
140	Falta de definición y tentatividad		
150	Respuestas en forma negativa		
160	Respuestas subjuntivas "a"		
170	Respuestas "Pregunta"		
181	Interferencias contradictorias		
182	Referencias incoherentes y ambiguas		
183	Alternativas incompatibles		
Descalificaciones			
191	Observaciones derogatorias, desdeñosas, críticas		
192	Observaciones nihilistas		
193	Incapacidad para comprobar las propias respuestas		
194	Retracciones y negaciones		
195	Olvido de respuestas		
196	Descalificaciones parciales		
II. COMPORTAMIENTO PERTURBADOR			
211	Interrupciones al Examinador		
212	Preguntas y observaciones extrañas		
213	Observaciones extrañas, tangenciales inapropiadas		
220	Comportamiento no-verbal, perturbador		
230	Humor		
240	Juramentos		
250	Saltar de una respuesta a otra		
III. LENGUAJE Y LÓGICA PECULIARES			
A. Usos de palabras, construcciones y pronunciaciones peculiares			
310	Palabras o expresiones comunes usadas extrañamente o fuera de contexto		
311	Construcción extraña de oraciones		
312	Términos de expresiones peculiares o extravagantes, privadas		
313	Eufemismos		
314	Lapsus linguae		
315	Palabras mal pronunciadas		
316	Palabras extranjeras usadas sin razones particulares z z z		
317	Observaciones críticas		
318	Asociaciones por sonoridad, frases rimadas y juegos de palabras		
319	Términos abstractos, globales		
320	Reiteración		
C. Lógica peculiar			
330	Combinaciones ilógicas de perceptos y categorías		
331	Razonamiento con conclusiones falsas		
332	Asignación ilógica de significados sobre la base de atributos no esenciales de las tarjetas		
333	Contaminaciones		

Disposiciones para responder a estímulos. Derivadas de mediciones de laboratorio, las disposiciones a la respuesta consisten en una serie de dimensiones que caracterizan el modo en que un individuo recibe, regula y modifica los estímulos ambientales o internos. Estas dimensiones también pueden conceptualizarse en términos de estilos de concentrar la atención, de la capacidad para retirar la atención selectivamente de los estímulos irrelevantes para la tarea, y de la capacidad para pasar flexiblemente de un foco de atención a otro. La relación

de las disposiciones a la respuesta con otros aspectos del temperamento, especial la introversión-extraversión sociales, necesita ser investigada.

Aunque las pautas de respuesta de atención probablemente se constroyan a partir de tendencias innatas, he sostenido que son elaboradas y modificadas ampliamente a través del desarrollo en el curso de los procesos de aprendizaje que tienen lugar especialmente en el seno de la familia. Sobre la base del compartir comunicado de los focos de atención, el niño en crecimiento aprende cómo manejar el problema de atender selectivamente a determinados preceptos y sentimientos, ideas y significados antes que a otros. Su capacidad innata para mantener "conjuntos mayores" deliberadamente frente a emociones conflictivas y otros estímulos es reforzada o modificada por factores no genéticos. En esta formulación evolutiva, que he desarrollado más completamente en otra parte, traté de especificar cómo los determinantes genéticos y biológicos se entretajan con procesos transaccionales y de comunicación.

Procesos "transaccionales". Los procesos de identificación psicológica pueden contribuir a las semejanzas entre los miembros de la familia. Con todo, tal cual he señalado, los procesos psicológicos y sociales también producen diferencias *predecibles* entre miembro de la familia. Aquí debe utilizarse el concepto de que los grupos duraderos, incluidas las familias, funcionan como pequeños *sistemas* sociales. Como es de esperar, los roles, el comportamiento y la experiencia de los miembros de cualquier sistema social serán *diferentes*; en sentidos importantes, ellos son recíprocos o complementarios, no iguales. Esto quiere decir que pueden hacerse predicciones respecto de las características de un miembro de la familia a partir del conocimiento de los demás, pero que esas predicciones no se harán forzosamente en términos de semejanzas o concordancia del diagnóstico, sino en términos del "ajuste" recíproco de los miembros.

Usando la concepción de la familia como sistema social, la doctora Margaret Singer y yo habíamos demostrado previamente que las características de un miembro de la familia, incluido el descendiente esquizofrénico, de hecho pueden predecirse con precisión a partir de las características psicológicas de los demás miembros de la familia (Singer y Wynne, 1965 b; Singer, 1967; Wynne, 1967). Los criterios usados en esta temprana investigación fueron luego especificados en una serie de sistemas de adjudicación de puntajes aplicados a muestras de comunicación de miembros de la familia estudiados tanto individual como conjuntamente (Loveland, 1967; Singer y Wynne, 1966; Wild *et al.*, 1965).

Hemos utilizado un enfoque heterodoxo de las respuestas del Rorschach individual. En particular merece subrayarse que no utilizamos los protocolos de Rorschach de la manera habitual con el objeto de observar los contenidos de las proyecciones intrapsíquicas sino que los consideramos más bien como *muestras de comunicación*, como ejem-

plos de cómo se relaciona el sujeto con el entrevistador, cómo organiza su atención en la tarea del test y cómo comparte o no comparte su comprensión con el entrevistador. Seguimos la hipótesis de que los padres aportarán a esa situación algunas de las modalidades típicas y persistentes de comunicación que también aparecen en sus transacciones interpretativas con los hijos, cuyas experiencias interpretativas, tanto por identificación como por impacto directo, se verían influidas predeciblemente (Singer, 1967; Wynne, 1967, 1968).

En los principios transaccionales que guiaban la selección de estas categorías de puntaje subrayamos la importancia de establecer y mantener conjuntos de tareas compartidas y concentrar la atención en una transacción; en este estudio entre el sujeto y el examinador (Singer y Wynne, 1966). No tratábamos de evaluar el "desorden del pensamiento" en los padres *mismos*, sino, más bien, la gravitación que podrían tener formas hipotéticamente importantes de comunicación sobre un oyente, y en particular sobre un niño en crecimiento. Sin duda, podría esperarse alguna correlación entre estos puntajes de desorden de la comunicación y las medidas de "desorden del pensamiento", pero no se hizo hincapié en los índices tradicionales de Rorschach.

Sistema de puntaje del Rorschach: En el Cuadro 1 los encabezamientos están enumerados en relación con las 41 categorías de nuestro actual sistema de puntajes para ser aplicado a protocolos individuales del Rorschach. (Ver Singer y Wynne, 1966, para los detalles y ejemplos de cada categoría.) Las categorías son agrupadas en tres clases principales:

1) *Problemas para completar una comunicación* (o sea para lograr el "cierre" de un significado): a) El cierre puede ser prematuro, aunque las afirmaciones y el comportamiento impliquen falsamente que ya se ha alcanzado una comprensión compartida o b) el cierre puede ser postergado, ya sea porque no se ha ofrecido un percepto visualizable, que habitualmente proporciona un punto de partida para el desarrollo del significado *compartido*, o porque una idea, inicialmente clara, es en un segundo momento descalificada.

2) *Conducta perturbadora:* El que habla perturba la atención prestada a la tarea, cambia precipitadamente prestando en un momento atención a la *tarea* y en otro a la *relación* con el oyente, impide que se comparta la atención y corta la orientación compartida hacia la tarea, aún cuando ésta fue previamente establecida y aparentemente acordada.

3) *Lenguaje y lógica peculiares:* Los puntajes asignados al lenguaje en este grupo de categorías no son "peculiares" en un sentido absoluto: en estas categorías de puntaje se toman en cuenta las características educacionales, culturales y regionales del sujeto. Se otorgan puntajes a las palabras, las oraciones y la lógica cuando se las usa de

modos idiosincrásicos que habitualmente interferirían con la capacidad del oyente para prestar atención o para adscribir significado a las ideas o perceptos que tiene en mente quien habla. No se les otorga un peso especial a las peculiaridades grotescas y característicamente psicóticas del lenguaje.

Tarjeta 1

Visión inicial (siguiendo instrucciones estándar de quien hace el test)

1. Un puntaje de desviación en esta transacción. Bueno, usted puede leer (310 - uso extraño de la palabra) en una cantidad de modos diferentes. Parece un... murciélago o... alguna clase de insecto...

INTERROGACIÓN

1. Cinco puntajes de desviación de esta transacción.

Examinador: (Dígame algo más acerca del murciélago, por favor) ¿Perdón? (Muéstreme el murciélago, por favor) Bueno, eh, fue en ésta en la que yo salí con el murciélago?

(195 - *óvula respuesta*: 310 - uso extraño) Bueno, muy bien, déjeme ver... aquí está, oh, si usted sabe que.

(110 - *cierre no consensual después de un fragmento del discurso*) Aquí está él eh... ésta sería la cabeza y el rostro mirándolo a uno, y él, eh... alas como ésta... aquí... con el cuerpo bajando de esta manera y los pies en esta zona... algo desproporcionado.

Oh... yo... yo pienso que también empecé trabajando (310) el murciélago también para ver si, eh, precisamente como una... casi como una configuración general. Como el todo, como una...

Tengo una especie de bat (*batear en base-ball*) (318 - *juego de palabras*) thing = cosa)... allí (120 - *observaciones ininteligibles, aplicable al último párrafo de este discurso*).

Ejemplos: Un corto fragmento del protocolo del padre de un esquizofrénico ilustra el uso de las categorías de puntaje:

Usando este sistema de puntajes se logró un alto grado de confiabilidad entre evaluadores. A todos los protocolos se les otorgó puntajes de modo enteramente "ciego", sin ninguna información relativa al diagnóstico o las relaciones de cualquiera de los sujetos.

Recientemente, hemos analizado puntajes de comunicación obtenidos de 348 protocolos Rorschach, de los dos padres y el hijo adolescente, adulto o joven, de 116 familias. La muestra incluía, en la categoría de hijos, 63 hombres y 53 mujeres. De éstos, 21 eran sujetos normales usados como control; 25, gravemente neuróticos o delinquentes, la mayoría hospitalizados; 25 eran pacientes fronterizos, a la mayoría de los cuales convencionalmente se los hubiera clasificado como personalidades esquizoides graves o personalidades paranoides; 25 eran psicóticos remitentes, incluidos 24 esquizofrénicos reactivos agudos y 1

maníaco-depresivo, y 24 eran esquizofrénicos típicos, "de proceso", no remitentes. Las evaluaciones de diagnóstico se hicieron sobre la base de una escala de 7 puntos de gravedad y se basaron en contactos clínicos desacomodadamente amplios y continuaciones prolongadas.

Hallazgos acerca de la comunicación en Rorschach. Nuestra hipótesis central fue decididamente confirmada: en estas familias completas, la frecuencia de las desviaciones de la comunicación de los padres se relacionó significativamente con la gravedad de la enfermedad psiquiátrica del hijo. Por ejemplo, sólo una de las 45 parejas de padres con un hijo psicótico tuvo un puntaje inferior a la mediana de todas las parejas de padres; la única pareja de puntaje bajo fueron los padres del maníaco depresivo de la serie. En el otro extremo del espectro sólo 2 de las 46 parejas de padres con un hijo normal o neurótico tuvieron puntajes de comunicación por encima de la mediana común.

Las parejas de padres con un hijo fronterizo están casi divididas en mitades por la mediana común. Aún no es totalmente claro si este hallazgo indica la presencia de un verdadero continuo en el conjunto de la muestra, o si posteriores esfuerzos destinados a subdividir el grupo fronterizo revelarán una separación más discontinua dentro del grupo fronterizo.

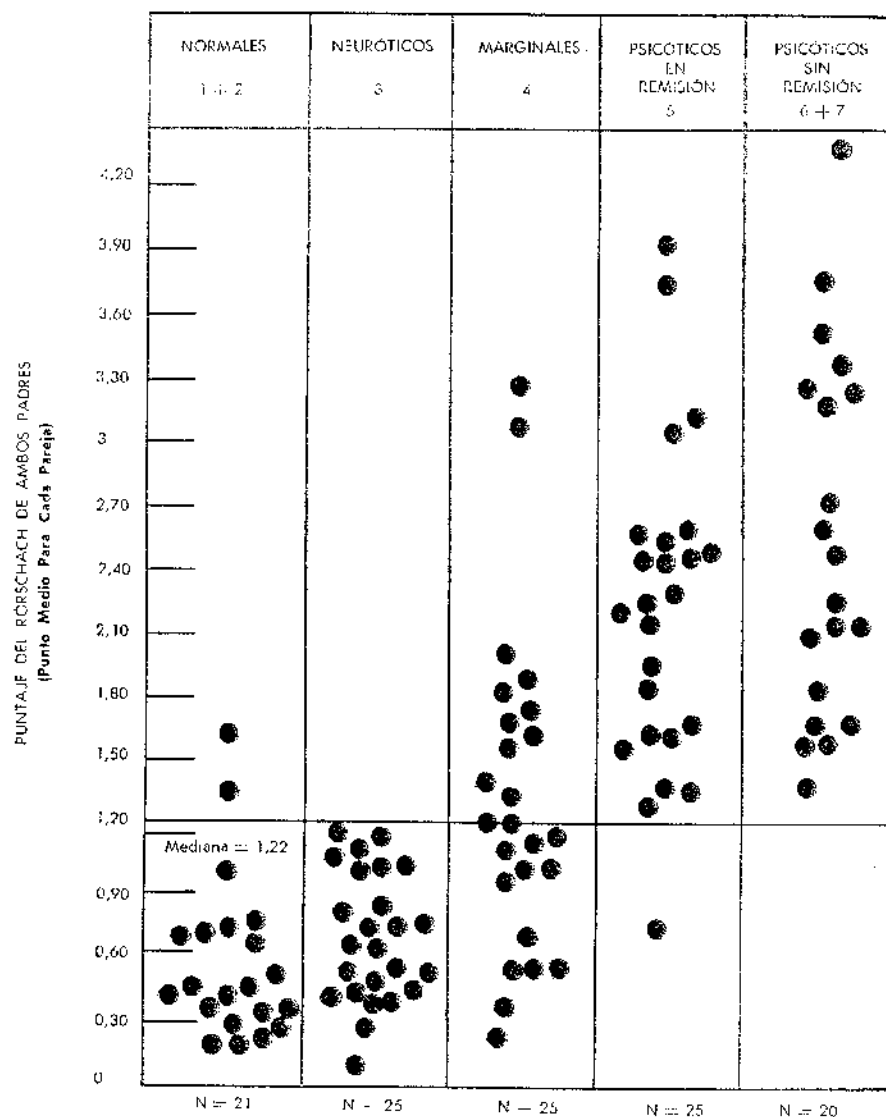
La medida de desviación en la comunicación agrupó a los padres de los neuróticos y normales. Este hallazgo fue interesante a luz del hecho de que todos los hijos neuróticos sufrían de graves perturbaciones desde un punto de vista psiquiátrico y estaban casi todos hospitalizados, como los esquizofrénicos. A pesar de la similitud de la experiencia de internación entre estos grupos de pacientes, las pautas de comunicación de los padres de los neuróticos eran semejantes a las de los normales y no a la de los padres de los esquizofrénicos.

Efectuando una medición *cuantitativa* (el número total de desviaciones comunicacionales), los puntajes de comunicación de los padres no mostraron diferencias entre los grupos de esquizofrénicos remitentes y no remitentes.

Ante un examen más detenido, se observó que los padres de esquizofrénicos no remitentes no presentaban antecedentes de episodios psicóticos, pero manifestaban dificultades muy graves para establecer y mantener relaciones interpersonales razonablemente empáticas y no centradas en la explotación del otro. Esta tendencia clínica hacia los rasgos "fronterizos" requiere una evaluación más amplia. Tenemos la impresión de que pueden obtenerse predicciones más detalladas acerca de los esquizofrénicos no remitentes evaluando no sólo la frecuencia de las desviaciones de la comunicación, sino también otros rasgos, en especial la calidad de relación (*relatedness cf. Stierlin, 1969*).

Empero, entre los familiares de primer grado de los esquizofrénicos no remitentes había muchos más con historias de enfermedad fronteriza o psicótica que entre los familiares de los esquizofrénicos remi-

DESVIACIONES EN LA COMUNICACION DE LOS PADRES
Y DIAGNOSTICO DE LA PROLE
DIAGNOSTICO DEL CASO INDICE



tentes. Este hallazgo sugiere la posibilidad de que se trate de enfermedades diferentes, lo que se vería en el diferente curso y la diferente frecuencia de historias familiares concretas. No obstante, la calidad del cuadro sintomático en los familiares de los esquizofrénicos no remiten es difícil de explicar en términos de una simple teoría de la transmisión heredada.

Los padres con historias psiquiátricas que tenían hijos esquizofrénicos también tuvieron, tal cual esperado, altos puntajes de desviación de la comunicación. Quisimos ver especialmente si los puntajes de comunicación identificaban correctamente a aquellos padres de esquizofrénicos que no tenían ellos mismos una historia psicopatológica grave. Había 24 familias en las que a ambos padres se los había diagnosticado individualmente como normales o neuróticos, antes que como fronterizos o psicóticos, pero donde el hijo era francamente esquizofrénico. Todas estas parejas de padres tenían puntajes de desviación de la comunicación que estaban muy por encima de la mediana general. De este modo y quizás sea éste el hallazgo más asombroso del estudio, nuestra técnica para estudiar las desviaciones de la comunicación de los padres diferenció adecuadamente a los padres de esquizofrénicos de los padres de neuróticos y normales, aun cuando ninguno de los padres tuvo nunca un cuadro clínico de psicopatología grave. Esto indica que la medida de comunicación no evalúa simplemente dificultades sintomáticas del tipo de las habituales en clínica psiquiátrica.

Por otra lado, esta diferencia entre síntomas y desviaciones comunicacionales fue confirmado por la presencia de una baja correlación entre la evaluación del diagnóstico de los padres y sus propios puntajes de desviación en la comunicación. Como se había predicho, se encontró una correlación significativamente más alta entre los puntajes de comunicación de los padres y las evaluaciones de diagnóstico del hijo obtenidas independientemente.

Las pautas de comunicación de los padres de esquizofrénicos difieren cualitativamente de las de sus hijos sintomáticos. Los puntajes de los padres eran significativamente más elevados que los de los hijos en categorías comunicacionales específicas que no se considerarían de sólo como manifestaciones esquizofrénicas netas: respuestas en forma negativa, respuestas en subjuntivo "si", referencias incongruentes y ambiguas, respuestas "pregunta", comentarios derogatorios, fragmentos de habla incorrecta, incapacidad de verificar las propias respuestas, e información contradictoria (cf. Tabla 1). En contraste, los hijos sintomáticos mostraron un puntaje significativamente mayor de rasgos "sintomáticos": asociaciones por consonancia, y conducta no-verbal disruptiva. Así, los padres mostraron mayor desviación comunicacional en aquellas categorías que no se consideran habitualmente como "locas" o sintomáticas pero que se supone poseen un impacto que genera perplejidad o confusión en el escucha, especialmente si éste es un niño en crecimiento que está tratando de aprender cómo comunicarse.

Un rasgo distintivo de nuestra orientación respecto de la estructura y la organización de las relaciones familiares es que subrayamos el "ajuste" adaptativo o no adaptativo entre los miembros de la familia (Wynne, 1968). Además del "ajuste" entre padres e hijo, un tema que nos interesa es el modo en que los padres de familias completas actúan juntos, o contra-actúan uno respecto del otro. Por consiguiente, la doctora Singer y yo consideramos a las parejas de padres donde uno de ellos tenía una alta desviación en la comunicación y el otro un puntaje bajo. En los pocos casos en que el padre de un normal o neurótico tenía un alto puntaje de comunicación, el otro miembro de la pareja tenía siempre un puntaje bajo. Dedujimos que un padre de puntaje alto podía tener la capacidad potencial necesaria para "corregir" o "contra-actuar" la gravitación del padre de puntaje alto. En contraste, en el caso de esquizofrénicos por lo común los dos miembros de la pareja tenían puntajes altos; ninguno daba muestras de una capacidad correctiva potencial.

Comentarios finales. Hemos formulado la hipótesis de que es probable que la contribución genética a la esquizofrenia sea indirecta, quizás no en la forma de un genotipo específicamente esquizofrénico. Además, mi hipótesis de trabajo es que el número de personas temperamentalmente vulnerables a la esquizofrenia es mucho mayor que el de los que llegan a mostrar manifestaciones clínicas, y que los factores no genéticos pueden dar cuenta del hecho de que un individuo vulnerable enfermo o no. En este artículo me he centrado en las pautas de comunicación familiar como una clase de variables de valor teórico y empírico para estudiar este problema. Desde luego, otros factores, como la mínima lesión cerebral en el nacimiento y los factores sociales extra-familiares, también pueden contribuir significativamente a la variación en los síntomas.

En este artículo he descrito dos clases amplias de variables que ahora se están tornando pasibles de estudio empírico. Los datos fueron obtenidos de una serie de familias en las que el paciente-hijo ya había enfermado. No obstante, los métodos empleados tienen aplicaciones y consecuencias más amplias: pueden y deben aplicarse a una variedad de familias diferentes: familias adoptivas, familias con gemelos, familias de los grupos de las clases sociales más bajas, familias con diversos antecedentes culturales y familias estudiadas prospectivamente en la investigación longitudinal predictiva. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de ligar las variables intermedias en una perspectiva de la investigación para comprender el origen y el desarrollo de los desórdenes esquizofrénicos. A medida que aprendamos más acerca de estas variables descartando algunos detalles y agregando otros, este conocimiento ayudará a profundizar y modificar nuestra conceptualización de la naturaleza de la esquizofrenia.

Correlato del trabajo "Los esquizofrénicos y sus familias" del doctor Lyman C. Wynne

JANINE PUGET *

El doctor Wynne acaba de leernos una síntesis de sus investigaciones sobre el esquizofrénico y su familia, dando especial valor a las perturbaciones de la comunicación intrafamiliar.

La hipótesis central de su trabajo es que *la frecuencia de las desviaciones de la comunicación de los padres pueden relacionarse significativamente con la gravedad de la enfermedad psiquiátrica del hijo*. Para demostrar esto utilizó una técnica de investigación con la que obtuvo resultados elocuentes y alentadores. Los datos obtenidos fueron tabulados e inscriptos en un gráfico cuya lectura facilita la comprensión del material y nos permite inferir directamente la relación existente entre las desviaciones de la comunicación de la pareja parental y el mayor o menor grado de enfermedad del hijo, y, lo que es más importante, establecer dos grandes grupos netamente separados entre, por un lado, familias normales y neuróticas, y, por otro lado, borderline y esquizofrénicas.

Previamente a esto, nos señala, a lo largo de una rápida revisión de los alcances y de las limitaciones de las teorías genéticas, que éstas no explican en forma satisfactoria la etiopatogenia de las enfermedades mentales, viéndose entonces motivado a buscar en los factores comunicacionales del grupo familiar una explicación más convincente.

Nos presenta, además, la metodología empleada para la que utilizó las respuestas al Test de Rorschach, cuantificó 41 variables categorizadas según un criterio personal. Estas fueron obtenidas en entrevistas a padres y madres de familia con o sin algún miembro enfermo. Este trabajo, realizado con un muestreo de 116 familias, nos permite apreciar la seriedad del estudio. El margen de error puede ser considerado mínimo, ya que es de 1 en 45 y 2 en 40.

Postula, entonces, que de la evaluación de las respuestas de los padres en términos de índices de desviación de la comunicación se podrá llegar a investigar la enfermedad del hijo y a diagnosticarla.

* Paraguay 2475, 7º, Capital Federal.

Las conclusiones tendientes a dar cada vez mayor lugar al estudio de los factores ambientales intrafamiliares parecen abrirnos grandes posibilidades, tanto diagnósticas como terapéuticas.

Mi propósito al comentar el relato del doctor Wynne es el de destacar algunas de sus hipótesis, su técnica de investigación, así como especular sobre las aperturas que se desprenden de este estudio.

Dividiré mi comentario en una primera parte en la que haré algunas consideraciones generales sobre el grupo familiar como sistema social y segundo, un comentario sobre los resultados obtenidos que confirman la hipótesis central.

Algunas consideraciones generales sobre el grupo familiar como entidad social. Queremos destacar el sentido que el concepto de *pautas compartidas* adquiere en el relato del doctor Wynne. El poder determinar cómo incide en forma diferente en cada uno de los integrantes de una familia lo compartido por todos y a qué se puede llamar núcleo familiar en función de lo compartido, nos introduce en la comprensión de las interacciones interpersonales, apoyándonos en los conocimientos que tenemos sobre las teorías de la identificación y de la adquisición de roles, ubicándolos en un campo dinámico interactivo.

En base a esto deberemos poder establecer cómo está integrado el grupo familiar, considerando a aquellos integrantes que componen la estructura interaccional. No siempre corresponde con los miembros que se presentan a la consulta, ya que hay personajes claves en términos de interacción que no han sido percibidos como tales por los demás.

Entendemos que se desprende de este trabajo que el grupo familiar es una entidad con caracteres propios y diferentes a otros pequeños grupos, que creará un sistema de interacción peculiar; por lo tanto, su estudio requerirá el empleo de una técnica específica y adecuada a ese medio y a esta postulación teórica.

La familia es un sistema social, único y primario, en permanente interacción con los demás sistemas sociales primarios y secundarios; en él encontraremos los gérmenes de los factores patógenos que podremos detectar a la luz de los conocimientos de los psicodinamismos del grupo familiar. Voy a puntualizar, entonces, algunas características que definen y diferencian el grupo familiar; la familia como grupo tiene una *historia* que hereda; esta historia está presente en todo momento y se manifiesta y repite a través de las interacciones. Como sistema social da a sus integrantes un *continente* y una *trama*, un *campo dinámico*, mediante los que éstos adquirirán el primer *sentido de pertenencia*, una *identidad individual y compartida*; además, esta institución será el depositario de un complejo interjuego de identificaciones, proyección e introyección, así como de ansiedades, determinando el aprendizaje y la adquisición de roles básicos y necesarios para su ulterior desenvolvimiento en otros medios sociales. Todo factor que incida

sobre la plasticidad de esta estructura o sobre la solidez de su forma y todo lo que distorsione los roles parentales primarios, se transformará en fuente de posibles alteraciones para uno o para todos sus miembros. El logro de una identidad madura y de un sentido de pertenencia en el transcurso del desarrollo de un individuo dependerá de cómo se establecieron sus relaciones intrafamiliares; ésta podrá ser tanto una fuente dinámica de crecimiento y madurez como transformarse en una entidad patógena que encierra a sus integrantes en roles estereotipados y paralizantes. Creemos que estos conceptos están implícitos en el relato del doctor Wynne y sirven de fundamentación a los conceptos teóricos referidos. Así comprendemos que haya jerarquizado el rol patógeno de la *pareja parental* en términos comunicacionales. A partir de los ítems que aisló para la tabulación de las desviaciones de la comunicación se puede inferir que el autor considera que conductas contradictorias, mensajes incompletos, incoherencia, cambios bruscos, fragilidad de los vínculos, repeticiones interactivas, explicaciones insuficientes, pararespuestas, frases a doble sentido, podrán perturbar la interacción del grupo familiar. La frecuencia y la intensidad de las mismas crearán el terreno disposicional para la adquisición de enfermedades mentales, a las que divide en dos grandes grupos: el primero formado por normales y neuróticos, el segundo por borderline y psicóticos. El autor dirigió el estudio de las familias de esquizofrénicos a variables intermedias entre lo genético y lo sintomático y las categorizó en dos grupos: las primeras, las disposicionales, se definen experimentalmente como aspectos del temperamento; las segundas, las transaccionales, son la comunicación intrafamiliar.

Pensamos que es factible deducir de lo anteriormente dicho que cuanto más patógena sea la estructura familiar, mayor será la necesidad de mantener un equilibrio utilizando técnicas de conducta que dificulten el crecimiento y desarrollo de sus miembros o, en otros términos, que empobrezcan la comunicación y rigidifiquen los roles.

Volviendo a la clasificación de las variables cuantificadas por el autor, sentimos que están llenas de inferencias implícitas por lo que nos interesaría conocer el criterio clínico y teórico que lo llevó a seleccionar los ítems. Suponemos que atribuye las desviaciones de la comunicación a motivaciones profundas basadas sobre una fundamentación teórica que no ha sido claramente explicitada en su relato.

Comentario sobre algunos de los resultados obtenidos que confirman la hipótesis central. En el gráfico expuesto al final del trabajo se establece una relación entre las desviaciones de comunicación y el estado de salud mental de las familias investigadas. Del estudio de la curva se puede inferir de inmediato el *alto valor* predictivo y de diagnóstico precoz que el método empleado nos facilita para detectar esquizofrenias y otras perturbaciones mentales. La progresión del índice de desviación desde la familia normal hasta la familia de psicóticos no

remitentes, nos lleva a suponer que todo intento de mejorar las técnicas de investigación de las pautas de comunicación del o de los padres de familia estudiados en su carácter de integrantes del grupo familiar, traerán aparejados nuevos enfoques técnicos, nuevas posibilidades para encarar una intensificación de la medicina preventiva en salud mental en base al estudio del grupo familiar. Sabemos que el futuro de la medicina preventiva se basa sobre el logro de medios eficaces y adecuados para descubrir enfermedades latentes antes de que se produzca la explosión sintomática. Asimismo, y como segundo paso, deben estudiarse las técnicas para efectuar los cambios. Aquí cabe señalar que, si bien el doctor Wynne no nos habló de las conductas terapéuticas en medicina preventiva, nos gustaría conocer su opinión. Pensamos que la primer dificultad consistirá en poder modificar pautas de comunicación en familias que se sienten normales, ya que representaremos, por nuestra sola presencia, una amenaza al precario equilibrio logrado.

Otro mérito de este trabajo es el de poner el acento sobre un problema, por cierto obvio, pero muchas veces olvidado, al hablar de patología y psicopatología. Me refiero al hecho de que *no existe "un enfermo"* del que se pueda hablar aisladamente, sino que existen *relaciones interpersonales que enferman, patrones de comunicación que enferman*, pudiendo adquirir la enfermedad cualquiera de los componentes de la interacción o del campo en el que interactúan. Es así como una pareja dinámicamente enferma pero interactivamente compensada que, en términos comunicacionales, podría llamarse normal, podrá enfermar a uno de los hijos, llegando éste a determinar con su enfermedad en evolución una ruptura del equilibrio familiar o de la llamada comunicación normal. Hasta un determinado momento la enfermedad del hijo puede ser un factor de equilibrio para el mantenimiento de la pareja o de la estructura familiar; luego, el mayor deterioro del hijo enfermo se transformará en un factor de perturbación en términos adaptativos; este será el momento en el que algunos de los miembros del grupo familiar llagará a la consulta.

El enfocar la enfermedad a la luz de los problemas de comunicación de la pareja parental en el grupo familiar permite considerar como fuentes patógenas a los factores adquiridos y ambientales; pensamos que parte de lo que hasta ahora fue atribuido a factores hereditarios por las teorías genéticas, corresponde a factores heredados ambientales; en la medida en que la familia hereda una historia que se perpetúa y es, a su vez, transmitida, ciertos caracteres dominantes de conducta se perpetuarán también, determinando que se encuentren concordancias de personalidad que no dependerán sólo de factores genéticos sino que podrán explicarse a la luz de los conceptos de identificación y transmisión histórica.

Mucho se podría especular en función de lo que surge al observar que pese al grado de enfermedad de los neuróticos, el tipo de comunicación de los padres parece acercarse más al que se obtiene con

familias normales y diferenciarse mucho de las familias de esquizofrénicos y borderline. Estas conclusiones, podrían sumarse a aquellos que adscriben a la esquizofrenia diferencias cuantitativas y cualitativas? Probablemente sí.

Estamos de acuerdo con el autor en que el hallazgo más importante de este estudio reside en este último, o sea en la posibilidad de diferenciar padres de neuróticos o normales de padres de esquizofrénicos mediante técnicas que permitan investigar desviaciones de la comunicación, aun cuando ninguno de los padres haya padecido nunca ningún cuadro psicopatológico grave. De esto, y en síntesis, creemos que, además del valor predictivo y preventivo ya mencionado de las hipótesis, debe destacarse la posibilidad de dar un paso más en la comprensión de la etiopatogenia de las enfermedades mentales.

Aquí nos parece necesario puntualizar que los patrones de comunicación parental clínicamente normales, siguiendo un criterio adaptativo, encubren siempre cuadros psicopatológicos dinámicamente enfermos, aunque momentáneamente compensados. De ahí que tendríamos conductas comunicacionales adaptadas o normales que pueden ser altamente patógenas, siendo ésta su única manifestación clínica patológica. Se entendería así que se produzcan irrupciones bruscas de enfermedad hasta allí latente cuando un factor desencadenante quiebra el nivel de adaptación logrado. Esto último podría explicar un fenómeno que observamos durante el transcurso de un tratamiento cuando, al mejorar el paciente diagnosticado como "el enfermo", se produce un período caótico, una crisis de pánico, se acentúan las dificultades de comunicación y el grupo intenta recuperar el equilibrio perdido restableciendo pautas de comunicación conocidas. Al desaparecer momentáneamente el receptor —el enfermo con rol fijo—, los efectores —la pareja parental—, sienten su propia dificultad de comunicación y la inadecuación de las pautas empleadas hasta ese momento. Desde el punto de vista terapéutico, este es uno de los momentos claves en el que la toma de conciencia de esta situación puede ayudar a sus integrantes a modificar conductas perturbadoras gracias a la intervención del terapeuta que verbalizará el proceso en marcha.

En cuanto a la técnica de investigación utilizada por el autor, vemos que posibilita la cuantificación de variables en las que es evaluado el efecto que sobre el observador tienen las respuestas, pudiendo entonces inferir la reacción que éstas pueden producir en el hijo. Entendemos que el incluir al observador como participante de la interacción orienta el test directamente a la situación conflictiva.

Por último, nos pareció interesante el hecho que, si bien el doctor Wynne correlaciona perturbaciones en la comunicación con enfermedad, insiste sobre todo en correlacionar perturbaciones en la comunicación con factor patógeno sobre algún miembro de la familia.

Para terminar, nos interesaría saber si el doctor Wynne ha establecido alguna correlación entre este tipo de técnicas utilizadas por él

para la investigación de las desviaciones de comunicación y otras técnicas. En ese sentido, deseamos mencionar que acá, entre nosotros, el doctor Usandivaras y colaboradores han creado un test llamado "test de las bolitas" que permite el diagnóstico grupal de los problemas interaccionales basándose en la hipótesis que cuanto más patológica sea la estructura de un grupo más estereotipadas serán sus conductas interaccionales. El test permite el registro de las conductas diferentes.

Sólo nos queda por felicitar al doctor Wynne por las investigaciones realizadas.

Conferencias
especiales

Psicoterapia familiar de impacto múltiple

HAROLD A. GOOLISHIAN *

Desde hace varios años un grupo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras de la rama médica de la Universidad de Texas ha estado utilizando, para el tratamiento de la familia, un enfoque de psicoterapia intentiva, breve y centrada en crisis. Este procedimiento, denominado Psicoterapia de Impacto Múltiple, fue desarrollado inicialmente como un enfoque terapéutico dirigido a familias que presentaban un adolescente con conflictos, pero desde entonces se ha probado su utilidad en muchas otras áreas de conflicto. Esta técnica fue diseñada con el objeto de aprovechar los cambios rápidos de personalidad que suelen aparecer en épocas de crisis. El objetivo principal de este método terapéutico es, más que suprimir la patología, promover la salud mental, e intentar lograr que en el curso de la terapia la familia se percata de su propia dinámica interaccional, en una atmósfera que promueve el cambio y la auto-rehabilitación.

Para lograrlo se tienen en cuenta tres ideas básicas y procedimientos standard. Primero, se considera que ciertas modalidades sintomáticas se mantienen en "equilibrio dinámico" mediante ciertas formas de interacción familiar. Segundo, se intenta que el equipo terapéutico asuma un "rol de modelo" en su interacción entre sí y con la familia, con la expectativa de que la familia aprenda por "ejemplo ampliado" el intercambio y la claridad de la comunicación interpersonal. En cierto sentido, el equipo terapéutico se esfuerza por interactuar de una manera: la opuesta a la modalidad de interacción de la familia. Y, finalmente, el equipo debe disponerse a mostrar su respeto por las dificultades familiares —en el curso de las entrevistas individuales y conjuntas— así como señalarles aquellos logros y potenciales poco utilizados de que disponen en el proceso de la rehabilitación familiar.

La técnica terapéutica mencionada consiste en una serie de encuentros del equipo terapéutico con el grupo familiar durante un período de dos o tres días completos.

* University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, EE.UU.

El procedimiento de entrevistas utilizado es bastante flexible y consiste esencialmente en una reunión inicial de equipo y familia seguida de una serie de entrevistas individuales, entrevistas conjuntas (dos pacientes con uno o más terapeutas, o un terapeuta con dos o más pacientes), y entrevistas superpuestas (en que el terapeuta que está finalizando una entrevista se superpone a otro terapeuta). Estos procedimientos son interrumpidos por frecuentes reuniones informales o formales del equipo. Se recomienda asimismo a la familia que converse entre sí durante esos dos días, o que tenga sus propias reuniones de equipo. Durante la primera tarde se aplican tests psicológicos standard a quienes así lo requieren, y sus resultados son compartidos en términos generales con la familia, habitualmente a comienzos del segundo día.

El contacto terapéutico con la familia termina al segundo o tercer día con una reunión final entre equipo y familia. Durante esta reunión final se discuten los problemas del hogar en términos de recomendaciones específicas, y la comprensión lograda en el curso de toda la tarea se aplica a las conductas y situaciones que pueden anticiparse.

Antes de iniciar la Psicoterapia de Impacto Múltiple con una familia, el equipo clínico se reúne para revisar toda la información disponible. Este material puede haber sido enviado por la institución que solicitó el tratamiento, o bien mediante breves entrevistas explicatorias con la familia, estas últimas a cargo de otro equipo. En esta reunión preliminar se discuten posibles dinámicas de la crisis familiar y la fortaleza potencial de la familia en función de la profundidad del material a que tiene acceso el equipo terapéutico.

Entretanto, se solicitó a la familia que concurra a la clínica a las 9 horas, momento en que se los invita a reunirse con el equipo para la conferencia inicial. Por lo general, la "familia" incluye todos los miembros significativos del grupo familiar tal cual ha sido establecido sobre la base de los datos preliminares. El grupo mínimo incluye a la madre y al padre, pero puede, y con frecuencia lo hace, incorporar a hermanos abuelos, otros parientes, y, cuando es necesario, representantes de la comunidad, tales como representantes del Juez de menores, o trabajadores sociales específicos.

La reunión inicial tiene una duración aproximada de una hora, y en ella, previas instrucciones generales, se invita a los miembros de la familia a delinear con sus propias palabras la naturaleza de la crisis inmediata y los problemas que ellos definen como la clave de sus dificultades. Casi invariablemente una persona actúa como portavoz del grupo familiar, y se estimula y apoya la participación de otros.

En estas reuniones iniciales resaltan rápidamente las pautas más importantes de la interacción familiar así como las pautas establecidas de comunicación. A medida que los miembros de la familia intentan establecer y explorar los problemas que los aquejan, los miembros del equipo clínico pueden observar directamente las áreas silenciosas de

considerable significado emocional, de no fácil acceso a través de descripciones introspectivas.

Con frecuencia, durante el curso de esas reuniones entre los miembros de la familia, se da mayor comunicación emocional significativa que en su experiencia pasada más o menos inmediata. En la mayoría de las familias se produce un aumento rápido de la tensión y la incomodidad, en razón de su falta de costumbre de efectuar este tipo novedoso de intercambio, cosa que es aliviada cuando se sugiere las entrevistas individuales. Los detalles de la programación de estas entrevistas son discutidos abiertamente con la familia, y en todo momento se provee a cada participante de la Psicoterapia de Impacto Múltiple tanta información como el equipo considere que puede tolerar y utilizar constructivamente.

Resulta particularmente importante que durante la primera entrevista grupal tanto el equipo terapéutico como la ambientación del lugar reflejen una actitud cálida y de apoyo. De no ser así, se produce un rápido deterioro del proceso que acaba instaurando una atmósfera tensa de tipo corte judicial, en el cual el equipo terapéutico asume el rol de juez, en lugar de un encuadre que estimule las esperanzas y establezca un ambiente de comprensión y buena voluntad.

Durante este contacto inicial el equipo terapéutico debe intentar detectar qué espera y desea la familia de la terapia familiar. Debe obtenerse esta información de todos los miembros de la familia, y no sólo de uno u otro padre o del portavoz de la familia. Se pide a cada uno, de diferentes maneras, que se exprese; que explique cómo está ahí, qué prevee o qué espera que pueda pasar.

La actitud y respuesta del equipo terapéutico durante este tiempo deberá dar a la familia una definición inicial de la terapia familiar e iniciar una inquisición acerca del verdadero significado del síntoma, relacionado con el contexto más amplio de las tensiones, fricciones y problemas vinculares de la familia.

Las entrevistas individuales iniciales suelen ser utilizadas por los miembros de la familia para ventilar agravios, presentar defensas, y racionalizar su conducta y las actitudes que muestran entre sí. En este proceso se obtiene una historia del desarrollo familiar razonablemente completa y se establecen formulaciones diagnósticas operativas. Al principio es obvio que las familias típicamente respondan en términos del paciente aparente, que es el problema, y esto debe ser explorado en función de la historia real del caso y cómo la familia intenta tratarlo. Estas exploraciones proporcionan mucha información en áreas muy significativas y resulta muy claro comprender quién habla por quién en la familia, cómo esta familia maneja las crisis y quién es culpado por el problema.

De estas inquisiciones comienzan a emerger alianzas familiares, modos destructivos de relacionarse y la corriente de pautas de relación.

En este momento un principal problema técnico es evitar una implicancia inconsciente en alianzas familiares competitivas y coaliciones, o uniéndose a un miembro de la familia para atacar, culpar o excluir a otro.

Las familias ejercen mucha presión sobre los miembros del equipo terapéutico para comprometerse en tales manejos y el uso de terapeutas múltiples es una estrategia vital contra lo destructivo en potencia que envuelve la patología familiar.

La finalización de las entrevistas individuales coincide con el almuerzo, y la familia es informada que durante el período de almuerzo el equipo se va a reunir para revisar la tarea de la mañana. Se recomienda a los miembros de la familia que compartan con tanta libertad como les sea posible las ideas y reacciones que tuvieron durante la mañana, y se les informa que el equipo clínico desea enterarse después del almuerzo de lo que conversaron en el interín. Durante el encuentro del mediodía, el equipo clínico se reúne con consultores, y se revisa y discute todo el material obtenido hasta entonces, así como la reacción del equipo a la familia total y a los diferentes individuos. Se establecen formulaciones operacionales respecto de los diversos roles existentes en la familia y el significado potencial de la crisis actual en términos de dichos roles. Se formula asimismo un plan provisorio de tratamiento basado en la fortaleza potencial —aun cuando todavía no activada— en la familia.

Además, en este momento el equipo terapéutico habrá obtenido —a través de las sesiones grupales, individuales y superpuestas— una historia familiar prácticamente completa. En esta forma se alcanza otra meta principal, el énfasis habrá variado de la persona "enferma" en la familia (a menudo evaluada por los demás como mala) a un énfasis en la comprensión de las principales vinculaciones dentro de la familia y en particular las relaciones parentales y parento-filiales.

Cuando digo historia familiar me refiero a una cronología completa de la familia, comenzando con los primeros contactos entre los padres antes que la familia existiera realmente. Estas tempranas implicancias en los períodos iniciales de cortejo y luna de miel, ayudan a comprender la disfunción marital que es la clave para ulteriores problemas de relaciones familiares. Es asombroso cómo los niños pequeños conocen su historia familiar y cómo necesitan desesperadamente esta información para resolver adecuadamente sus propios problemas de identidad y diferenciación.

En este proceso hay mucha oportunidad para intercambiar material de referencia y para explicitar las influencias significativas en la vida de esta familia. De qué manera la familia organiza sus problemas de la vida cotidiana, quién pasa cuánto tiempo con quién, cómo descansa la familia, cómo se pelean —todas éstas y otras importantes pautas de vida íntima emergen.

Durante las sesiones individuales y grupales —a través de las cuales se obtiene esta información— debe prestarse cuidadosa atención a cada miembro de la familia, lo que implica estimulación activa y apoyo por parte de los terapeutas. Las familias tienen poderosas maneras de mantener secretos y mitos familiares, y esta información revela la mayor parte de ellos.

Quizás lo he hecho aparecer como si reunir esta información fuese un proceso fácil y automático. No lo es. El doctor Wynne se refirió el otro día a un cerco de goma (o elástico) que rodea a todas las familias, y a esto hay que agregar un concepto adicional: cuanto más enfermas las relaciones familiares, más resistentes para introducirse desde el exterior. Las familias sanas pueden integrar libremente información nueva desde fuera de la familia, y es por lo tanto más susceptible al cambio y al crecimiento. En las familias no sanas esto está invertido y hay una rígida exclusión de la interferencia externa, que vuelve muy difícil la tarea del terapeuta familiar y requiere de él un rol terapéutico mucho más activo.

Durante la tarde del primer día se suele aplicar una batería standard de tests al paciente identificado. Se ve también a los padres en entrevistas individuales cruzadas, en las que el miembro del equipo que ha visto al padre por la mañana entrevista ahora a la madre, y viceversa. Para este entonces, cada miembro del equipo ha desarrollado impresiones nítidas acerca de las fortalezas y debilidades de cada participante, así como de las modalidades predominantes de interrelación que caracterizan a la familia. Las discrepancias y distorsiones que no han sido detectadas en el curso de las entrevistas individuales de la mañana, se esclarecen tanto durante las conferencias del equipo efectuadas durante y después del almuerzo, como en el curso de las subsiguientes sesiones cruzadas.

Las entrevistas superpuestas pasan entonces a adquirir importancia como técnica terapéutica. En el curso de cualquier entrevista individual un miembro del equipo puede telefonar a otro y solicitar su autorización para incorporarse a la sesión. El primer terapeuta resume al recién incluido tanto el contenido fáctico como afectivo de la entrevista. Para ello efectúa interpretaciones, clarifica y reformula temas y extrae conclusiones durante este resumen. Se invita al paciente a participar en esta recapitulación y a efectuar las correcciones necesarias. El segundo terapeuta responde durante este resumen y agrega información que pueda haber detectado en el curso de su propio trabajo con otros miembros de la familia. En el curso de estas entrevistas superpuestas suelen desaparecer con notable rapidez dificultades comunicacionales de larga data así como resistencias al insight.

A partir de la tarde del primer día se hacen frecuentes las entrevistas superpuestas y múltiples. Dentro de este procedimiento general existe un campo considerable de variaciones, adecuadas a la diná-

mica de la familia en estudio y a la intensidad de la patología de cada miembro.

En el curso de la tarde del primer día, la familia ha comenzado a desarrollar una comprensión acerca de los motivos de la crisis actual, se han identificado áreas de problemas y se han detectado áreas desconocidas hasta entonces de potenciales para el crecimiento emocional. En la medida en que sea practicable y razonable desde el punto de vista terapéutico se relaciona continuamente la discusión con la dinámica familiar pertinente, cosa que es, por supuesto, un rasgo clave de la terapia familiar. Se considera que la persona sintomática de la familia expresa la patología del sistema familiar total, por lo que el diagnóstico y el tratamiento se refiere al sistema y no al individuo. Por lo tanto, el cambio se dirige a las pautas de relación de la familia dado que se entiende a la sintomatología individual como un crecimiento distorsionado necesario para la familia, una manera de reducir el dolor y el sufrimiento dentro de la misma familia y no meramente como una expresión de conflicto intrapsíquico.

El segundo día (y de ser necesario el tercero) es una versión acelerada de la tarea previa. Habitualmente el segundo día comienza con una breve reunión entre equipo y familia seguida de sesiones individuales y conjuntas. A todo esto, el grupo familiar ha pernoctado en un lugar adecuado provisto por la institución, y con frecuencia utiliza esos momentos para conversar.

Los resultados de estas discusiones, o en pocos casos la falta de éstos, son habitualmente el contenido inmediato de la primera conferencia entre equipo y familia del segundo día. La familia provee entonces sugerencias de planes futuros, así como material histórico olvidado.

Esta nueva información se amplía y su relevancia se explora en sesiones de terapia individual y múltiple. Durante la tarde del día final, el contenido de las diversas entrevistas, aun cuando todavía centrado en la estructura familiar, comienza a apuntar hacia planes y posibilidades familiares para la solución de problemas inmediatos y pre-visibles. Se estimula a cada miembro de la familia para que critique y reformule, desde su propio punto de vista, estos planes emergentes. Se descubren posibles dificultades y se consideran alternativas.

Las sesiones de la tarde finalizan con una conferencia entre equipo y familia que resume toda la tarea terapéutica precedente y temas aún no resueltos. Se le asegura a la familia el interés y el apoyo continuo del equipo, y se efectúan planes para estudios de seguimiento a los seis meses y al año.

Aunque es difícil delinear etapas en algo tan complejo como una psicoterapia, hay un movimiento decidido durante este proceso total desde la fase inicial de obtención de información sobre el estilo de vida de la familia hasta la resolución de conflictos clave en las relaciones significativas maritales y parentales. En tan breve trabajo cen-

trado en las crisis es imposible explorar completamente todos los problemas vinculares y de hecho esto puede no ser necesario. Un prejuicio en nuestro grupo es que la relación clave es la marital y que éste es el eje principal en la familia. Si yo llegara a elaborar una teoría de la psicopatología familiar, empezaría con la disfunción inicial en la relación marital primaria, y si esta proposición es verdadera entonces se la enfoca como la cuestión fundamental en terapia familiar, y luego en cuanto a la ramificación que esta disfunción tiene para otras relaciones significativas.

En otras palabras, la calidad de la relación marital es la variable decisiva en las subsecuentes relaciones parento-filiales y es el determinante primario de la calidad y cantidad de estas relaciones. En nuestro trabajo se lo considera como el motor principal del desarrollo sintomático en el niño y por consiguiente recibe una mayor manifestación de atención terapéutica.

Con el cierre de esta reunión final entre equipo y familia, se completa la tarea terapéutica inmediata de la clínica. La familia, con una nueva comprensión, con esperanzas y con libertad para comunicarse, se encuentra en una posición mejor para comenzar la tarea de auto-rehabilitación. No se piensa por supuesto que las orientaciones interpersonales neuróticas y distorsionadas van a desaparecer del día a la noche, sino más bien que la familia, habrá cambiado en su equilibrio dinámico. A través de una percepción cambiante de sus roles mutuos sus modalidades típicas de respuesta comenzarán lentamente a reflejar un nuevo equilibrio familiar.

Nuestro grupo de trabajo sostiene, como ocurre con otros actualmente interesados en psicoterapia de familia, que los síntomas presentados por un miembro de la familia pueden ser entendidos como indicadores de una interacción familiar patológica de larga data, que deriva en un equilibrio estable u homeostático de fuerzas psicológicas dentro de la familia. Por lo tanto, el tratamiento debe tener en cuenta el encuadre familiar total y las pautas típicas de interacción familiar.

El trabajo con este método nos ha indicado con claridad que la psicopatología de un individuo puede ser entendida en términos de procesos familiares y que el cambio y crecimiento en un individuo pueden estimularse mediante el enfoque terapéutico de todo el grupo familiar. Dicho en otras palabras nuestro trabajo, así como el trabajo de otros, nos convence que la familia puede ser concebida como una unidad de tratamiento y que la conducta interaccional de la familia tal cual ocurre en el hogar o en la clínica, es el punto estratégico para actuar en contra de las fuerzas emocionales y sociales que determinan la desadaptación.

Es imposible resumir en un lapso tan corto la base teórica de toda mi experiencia. Intentaré sólo delinear algunas diferencias particularmente significativas entre terapia familiar y terapia individual.

La principal diferencia, es, por cierto, la comprensión teórica de la psicopatología. Desde el punto de vista familiar el desarrollo sintomatológico en un individuo es una expresión dinámica particular de las pautas de relación en la familia o un rol social requerido al servicio de la homeostasis. Es como si el individuo sintomático estuviera en realidad enviando un S.O.S. informando que algo anda mal, y todo cambio en ese individuo exige un cambio dentro del sistema familiar. En el contexto de este enfoque en el sistema familiar, el terapeuta familiar subraya en distintos momentos sub-sistemas importantes dentro de la familia tales como la relación interparental, la relación parento-filial, la relación de los hijos con sus padres, y otras. Tal enfoque indica con claridad el decurso emocional y comunicacional en la familia así como los impedimentos de tal proceso, los que son los objetivos principales para movilizar cambios terapéuticos.

Como lo mencioné anteriormente, la experiencia nos indica que la relación primaria a ser tratada en la Psicoterapia de Impacto Múltiple es la relación marital, y a mí me gustaría elaborar algo en este sentido en relación al desarrollo psicopatológico en niños.

Como pensamos que la principal disfunción surge de la relación marital, ésta se manifiesta en uno o ambos padres recurriendo al chico para la gratificación de necesidades emocionales más de acuerdo con la relación adulta. Es como si la relación parental estuviera sobrecargada con las necesidades y frustraciones de los adultos. Es en este contexto que las alianzas competitivas, coaliciones y exclusiones que conducen a la patología se transforman en una modalidad fija de vida familiar.

En la comprensión más tradicional del desarrollo individual, hemos visto esto como un proceso existente sólo en el niño y sólo como una expresión de impulsos y deseos que emanan del desarrollo individual del niño. Desde el punto de vista familiar vemos esto como un proceso psicosocial en el cual el niño tiene la carga adicional de proveer para la satisfacción de sus padres lo que ellos son neuróticamente incapaces de alcanzar entre sí.

A esta altura el niño se transforma en objeto de la vida familiar, más que producto de la misma. Es de alguna manera el cuento bien conocido del triángulo edípico pero dentro del contexto de un proceso vincular.

Desde el comienzo de nuestra práctica, hemos utilizado dos o más terapeutas según el tamaño de la familia. Debe reconocerse el hecho de que algunos terapeutas familiares funcionan o actúan solos y con bastante éxito en su tarea familiar. Nuestra experiencia nos indica con todo que los terapeutas múltiples o coterapeutas proporcionan muchas ventajas que merecen subrayarse. La terapia familiar intensiva puede resultar una experiencia muy insólita, a veces perturbadoramente irracional. Los sistemas familiares poseen estilos de vida mucho más

poterosos y hábiles que cualquier otro grupo terapéutico. Cuando tratan con grupos familiares completos, los terapeutas corren el riesgo de verse sobrepasados por la intensa transferencia de la unidad familiar, o, como dice Bower, de ser literalmente "tragados" por el sistema familiar. En este sentido, los coterapeutas proveen un componente de seguridad del que carece el terapeuta único.

Además, el equipo psicoterapéutico en acción puede proveer de una manera positiva un nuevo modelo para que sea observado por la familia. A otro nivel de profundidad, las diferentes maneras en que cada uno de los terapeutas interactúa con los estilos de vida de la familia puede conducir a una comprensión crucial de la patología familiar. Hemos aprendido, por ejemplo, que cuando la terapia familiar se estanca o pierde dirección, el primer esfuerzo para diagnosticar la dificultad debe dirigirse hacia la interrelación del equipo. Finalmente, la interrelación del equipo en sí puede crear en la familia la esperanza de que algo bueno puede surgir a partir de sus dificultades.

El uso de los coterapeutas en terapia familiar tiene otras ventajas específicas. La combinación de la experiencia y la habilidad de cada uno de los terapeutas provee una flexibilidad y una sensibilidad imposible de lograr en cualquier otra situación. En nuestro encuadre particular, se ha aprovechado esta ventaja para incluir como parte del equipo terapéutico o estudiantes de esta especialidad, lo que permite una experiencia de entrenamiento notoriamente diferente a la sección habitual en la que el estudiante se limita a informar reconstruyendo su experiencia. Con este encuadre la experiencia terapéutica es compartida.

Quienes trabajan en terapia individual suelen plantear interrogantes referidos a problemas de transferencia y contratransferencia. En la terapia familiar estos fenómenos no ocurren de la misma manera que en las terapias más convencionales. En primer lugar, son considerablemente más complejos e intrincados. Las distorsiones transferenciales se proyectan no sólo en los terapeutas múltiples sino también en otros miembros de la familia. Existe aún un tipo prácticamente nuevo de transferencia, la del sistema familiar como un todo, cosa que resulta más clara en las familias más perturbadas. De acuerdo con nuestra experiencia terapéutica con familias, estos problemas requieren la utilización de muchas técnicas de observación, por ejemplo la observación directa de la terapia por otro equipo, el uso de grabaciones y de video tape. Resulta absolutamente esencial la discusión continua de dinámica, objetivos, técnicas, fenómenos de transferencia y contratransferencia entre coterapeutas en el lapso entre sesiones de entrevistas.

Ocasionalmente nos fue necesaria la ayuda temporaria de otro terapeuta como consultor, cuando el equipo terapéutico activo corría el riesgo de naufragar totalmente en el sistema familiar. Todo esto concurre, por supuesto, a la necesidad del uso de coterapeutas con el objeto de asegurar un trabajo efectivo de terapia familiar intensiva.

Probablemente una de las preguntas más difíciles que nos hemos formulado a nosotros mismos es: ¿de qué manera es efectiva la terapia familiar? Se nos suele preguntar con toda razón cómo podemos esperar producir un cambio real en una situación tan poco manejable como es la de ver a cuatro o cinco personas con dos o tres terapeutas en un período de pocos días. A pesar de la validez de tal pregunta existe entre quienes realizamos esta tarea la convicción de que sirve. Los cambios intrapsíquicos conducen a cambios interpersonales. Asimismo los cambios interpersonales a su vez conducen a cambios intrapsíquicos, especialmente cuando los cambios son compartidos dentro del grupo más básico, la familia. Cuando se reduce la interacción y la comunicación familiar patológica, se da una nueva oportunidad para la individualización de los miembros de la familia. A medida que se reduce la intensidad del ego patológicamente compartido por la familia, cada individuo adquiere mayor libertad para desarrollar una nueva definición individual del self. A medida que la familia descubre que puede relacionarse de manera diferente sus miembros no sólo se descubren a sí mismos sino que se mantienen como familia, y estos son cambios que continúan ocurriendo mucho después que la familia abandonó la clínica. Los cambios terapéuticos de la familia no se detienen luego de la consulta: de hecho, de acuerdo con nuestra experiencia, recién comienzan en ese momento.

Es típico que en estos casos con un resultado favorable el cambio más significativo se dé primero entre los padres. En la medida en que ellos estén más libres para relacionarse entre sí con un mínimo de daño y destrucción y para encontrar dentro de su relación el calor que ambos habían deseado, están entonces más libres para reestructurar la conducta con sus niños de tal forma que el niño pueda continuar con su crecimiento individual y posterior desenvolvimiento fuera de la familia.

Se ha sugerido que la familia es en realidad un grupo destinado a disolverse. Si esto es verdad puede ocurrir sólo dentro del contexto de un sistema vincular que permita crecimiento individual y diferenciación. Si los niños son chivos emisarios de la disfunción vincular parental, esta diferenciación no puede ocurrir y a pesar de que la gente envejecerá a medida que pase el tiempo, los conflictos no resueltos del desarrollo familiar pasan inflexiblemente a través de la elección de pareja y matrimonio a las generaciones sucesoras. En este sentido la familia es más que un agente socializador para la sociedad, pero tiene predisposiciones psicológicas peculiares.

En resumen, nuestra tarea inicial en el desarrollo de métodos para el tratamiento intensivo de la familia nos condujo a diseñar un método breve para familias con un adolescente con problemas que ha resultado útil para una amplia gama de trastornos. Esta técnica utiliza un equipo terapéutico que trabaja con una familia por un período de dos a tres días y se ha probado de particular utilidad para la intervención en

situaciones de crisis. El trabajo con familias que sigue esta técnica parece exigir la utilización de coterapeutas con el objeto de proveer a la familia un modelo de roles sano, así como para asegurar un manejo adecuado de las complejidades de la transferencia y la contratransferencia peculiares del tratamiento familiar. Los cambios que se inician en las sesiones intensivas de familia continúan mucho después. Un elemento básico de la noción de tratamiento familiar es el principio de que la psicopatología individual puede ser considerada como una patología compartida representativa de un sistema familiar total, y que la intervención en este sistema familiar es el enfoque terapéutico adecuado.

Una teoría del abordaje de la prevención en el grupo familiar

ENRIQUE J. PICHON-RIVIERE *

A partir de una visión integradora del "hombre en situación", y desde un enfoque interdisciplinario, no podemos referirnos al problema de la prevención sin tratar de ubicar a éste en su contexto apropiado. La salud mental, cuya definición es previa y se halla implícita en este tipo de planteo, no es para nosotros un valor absoluto y resulta evaluable en términos de calidad de comportamiento social. Este comportamiento, su operatividad o su deterioro, está íntimamente ligado a factores de orden socio-económico y familiar, que intervienen o determinan, en forma positiva o negativa, una adaptación activa a la realidad, en la que el sujeto se compromete con el medio en una relación creativa y modificadora.

El problema central, desde esta vertiente, no es el de una metodología de la prevención, sino el de las estrategias de cambio de la estructura socio-económica, de la cual en enfermo mental es emergente. El enfermo es portavoz de los conflictos y tensiones de su grupo inmediato: la familia. Pero es también por ello el símbolo y el depositario de los aspectos alienados de su estructura social, portavoz de su inseguridad y su clima de incertidumbre. Curarlo es adjudicarle un rol nuevo; el de agente de cambio y transformarnos nosotros también en elementos del cambio.

Resulta importante señalar, ya desde un enfoque centrado en las técnicas de *prevención*, la naturaleza *instrumental y operativa* del grupo familiar como sostén de la organización social, unidad primaria de interacción, a la que se establece sobre la base de un interjuego de roles diferenciados.

Su carácter de estructura surge de la necesaria interdependencia de los roles correspondientes a la situación triangular básica: padre, madre e hijo, emergentes de las relaciones y diferencias funcionales y biológicas. Esta situación triangular básica y universal, con sus posi-

bles variables culturales, determina el modelo que seguirán las interrelaciones familiares.

El mencionado carácter estructural del grupo familiar nos permite abordarlo como unidad de análisis, en el sentido de que podemos aproximarnos a él, encarándolo como unidad diagnóstica, pronóstica, terapéutica y de profilaxis.

Como unidad básica de interacción la familia aparece como el instrumento socializador, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad, su posición individual dentro de la red interaccional. La *funcionalidad y movilidad* de dicha posición señalará el grado y naturaleza de adaptación en ese contexto grupal, del que cada sujeto resulta *portavoz*.

Cuando en esta estructura, que actúa como vehículo de las pautas culturales, mediadora entre el sujeto y la realidad a través de las relaciones vinculares, emerge la enfermedad como una *cualidad nueva* en el proceso de interacción, entendemos esta conducta desviada como una anomalía que afecta a la estructura total en su proceso de interrelación intrasistémica o intersistémica.

La enfermedad es la *cualidad emergente*, cualidad nueva que nos remite, como signo, a una situación implícita, subyacente, configurada por una particular modalidad de la interacción grupal, la que en ese momento resulta alienizante. El enfermo es el *portavoz* por intermedio del cual se manifiesta la situación patológica, que afecta a toda la estructura. Es decir, que el *portavoz* (enfermo) es el vehículo por el que comienza a manifestarse el proceso implícito causante de la enfermedad.

Podemos afirmar que todo proceso implícito llega a manifestarse, por la aparición, dentro del campo de observación, de una *cualidad nueva* en ese campo, a la que denominamos *emergente*, y que nos refiere, como indagadores, a un acontecer implícito, o dicho de otra manera, a un orden de hechos subyacentes, sometido a un permanente proceso de estructuración y desestructuración.

En un trabajo anterior (Empleo de Tofrauil y Terapia Familiar), hemos dicho que la locura es la expresión de nuestra incapacidad para soportar y elaborar un cierto monto de sufrimiento. Cuando emerge una neurosis o una psicosis en el ámbito del grupo familiar, descubrimos que previamente un grado determinado de inseguridad se ha instalado en el seno de ese grupo, impotenciándolo. Esto significa, dinámicamente, que un miembro del grupo familiar asume un rol nuevo, se transforma en el portavoz y depositario de la ansiedad del grupo. Se hace cargo de los aspectos patológicos de la situación en un proceso interaccional de adjudicación y asunción de roles, que compromete tanto al sujeto *depositario* como a los *depositantes*. El estereotipo se configura cuando la proyección de aspectos patológicos surgidos en esa situación de inseguridad es masiva. El sujeto queda paralizado, fracasa en su intento de elaborar una ansiedad tan intensa y enferma

* Primera Escuela Privada de Psicología Social, Buenos Aires.

(produciéndose en ese momento un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo). A partir de ese momento se completa el ciclo de elaboración de un mecanismo de seguridad patológica, que desencadenado por un incremento de las tensiones, consiste en la depositación masiva, con la posterior segregación del depositario, por la peligrosidad de los contenidos depositados.

El interjuego de roles se caracteriza en esa situación por su rigidez o inmovilidad, siendo regidos ya no por una ley de complementariedad sino por un principio de suplementariedad. Es decir, que una vez que el proceso interaccional ha configurado una pauta estereotipada y repetitiva, todo un sistema de realimentación se pone al servicio de esa pauta.

Como estrategia de prevención de la emergencia de situaciones patológicas en el ámbito del grupo familiar propondremos algunas técnicas de esclarecimiento destinadas a reforzar los aspectos de movilidad y operatividad dentro del grupo. Nos proponemos así la creación de un dispositivo de seguridad adaptativo y creador que permita al grupo el enfrentamiento de las situaciones de cambio generadoras de inseguridad.

Como líneas de abordaje seguiremos las propuestas de nuestro esquema del *cono invertido* en el que categorizamos en los vectores de pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y telé, las modalidades de interacción que se observan en todo grupo de tarea.

Grupo operativo y grupo familiar son susceptibles para nosotros de una misma definición: conjunto de personas reunidas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna que se proponen implícita o explícitamente una tarea, la que constituye su finalidad. En este caso, en el grupo familiar, a las constantes de tiempo y espacio agregaremos los vínculos de parentesco. La tarea del grupo familiar es, como lo hemos dicho antes, la de la socialización del sujeto proveyéndolo de un marco y basamento adecuado para lograr una adaptación activa a la realidad en la que se modifica él y modifica al medio en un permanente interjuego dialéctico.

Este modelo puede configurar un esquema de referencia para el operador ya sea que éste trabaje en el campo de lo que se entiende generalmente como prevención primaria, secundaria o terciaria.

El esclarecimiento y manejo operativo de los vectores de pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y telé, permitirán a la unidad grupal el abordaje de las ansiedades desencadenadas por las situaciones de cambio, por las que necesariamente atraviesa todo grupo familiar. De esas situaciones nos interesa señalar particularmente dos de características realmente críticas: la adolescencia, marcada por el pasaje del rol de niño al rol de adulto y la entrada

en la vejez, caracterizada en nuestra estructura familiar por la pérdida de roles operativos. Vemos que en ambos casos se trata de alteraciones significativas en el proceso de adjudicación y asunción de roles en el ámbito del grupo familiar.

Entendemos por pertenencia el sentimiento de integrar un grupo, el identificarse con los acontecimientos y vicisitudes de ese grupo. Por la pertenencia los integrantes de un grupo se visualizan como tales, sienten a los demás miembros incluidos en su mundo interno, los internalizan. Por esa pertenencia cuentan con ellos y pueden planificar la tarea grupal incluyéndolos. La pertenencia permite establecer la identidad del grupo y establecer la propia identidad como integrante de ese grupo. Para Sartre todo grupo que no revierta, como acto, sobre sí mismo corre el peligro de caer en lo que él llama "serialidad". El sujeto que se ve a sí mismo como miembro de un grupo, como *perteneciente*, adquiere una identidad, una referencia básica, que le permite ubicarse situacionalmente y elaborar estrategias para el cambio. Pero la pertenencia óptima lo mismo que los otros vectores del abordaje, no es lo "dado", como podrían serlo los lazos cosanguíneos, sino lo adquirido, algo logrado por el grupo como tal.

El grupo, por la pertenencia, por la cooperación y fundamentalmente por la pertinencia en la que juegan la comunicación, el aprendizaje y la telé, llega a una *totalización* en el sentido de un hacerse en su marcha, en su tarea, en su trabajar como grupo.

Siguiendo a Sartre al hablar de grupo como acto, como un constituirse permanentemente como grupo, tenemos que tener en cuenta el papel fundamental que en el establecimiento de sus relaciones constitutivas del grupo juega la dialéctica interna. Por eso hemos subrayado en esta definición el hecho de que el grupo es un *conjunto de personas articuladas por su mutua representación interna*. Representación ésta que sigue las características del modelo dramático.

La dialéctica interna es la dialéctica del grupo interno cuya crónica —siempre siguiendo el mencionado modelo— es la fantasía inconsciente. Por dicha dialéctica cada integrante alcanza una *totalización*, una síntesis, que hace al grupo como grupo, que lo constituye. Dicho esto en términos sartreanos, esta dialéctica interna y externa lo lleva a trascender la serialidad, entendida ésta como dispersión.

La tarea, sentido del grupo y la mutua representación interna hecha en relación con la tarea, constituye al grupo como grupo. La tarea es la marcha del grupo hacia su objetivo, es un hacerse y un hacer dialéctico hacia una finalidad, es una praxis y una trayectoria.

La cooperación, en un grupo familiar, se establece sobre la base de roles diferenciales. Ponemos el acento en la heterogeneidad que deben mostrar los roles dentro del ámbito familiar. Esta heterogeneidad está sustentada en las diferencias biológicas y funcionales sobre las que ha de configurarse una estructura familiar. La familia, ya lo

hemos dicho, se convierte así en el ámbito del aprendizaje de roles biológicos y funciones sociales. Sólo a través de una heterogeneidad podemos alcanzar la complementariedad necesitada en un grupo operativo, es decir, en un grupo capaz de logros instrumentales y situacionales.

Una clarificación de las redes de comunicación grupal, con el abordaje de los misterios familiares, y el análisis de las ideologías, permitirá, junto con el ajuste entre imágenes internas y realidad exterior, la dilucidación de los malosentendidos, creándose el clima apropiado para la tarea familiar.

**Técnicas
terapéuticas**

Diagnóstico situacional-histórico
para la planificación terapéutica con encuadre familiar
(Versión abreviada)

VALENTÍN ARROYO *
OSVALDO DEVRIES
LILIAN FISHER
NORMA SCHWARTZ

Este trabajo intenta mostrar un aspecto de la llamada Psicoterapia Planificada que habiendo partido de psicoanálisis se diferencia de éste fundamentalmente en dos aspectos:

- El criterio del tratamiento
- El criterio diagnóstico con enfoque familiar.

Se convalidan los conceptos del doctor E. Pichon Rivière acerca del paciente como portavoz y a la enfermedad como emergente del grupo familiar. Se aclara que aun cuando se brinde asistencia a un solo sujeto, a través de éste se "mira" constantemente a su grupo convivencial, familiar.

Se muestra posteriormente la visión antropológica del grupo familiar como *grupo social especializada para la producción de personas*. Dentro del contexto histórico social que integra y por el cual es determinado constantemente. Se describen y analizan las funciones que cumple este grupo.

Al fracaso en la satisfacción de alguna de estas funciones se la denomina *fracaso básico familiar*. Este es uno de los aspectos fundamentales a investigar en la operación diagnóstica.

Con respecto a la construcción del diagnóstico se opera básicamente con dos unidades de análisis:

1) *Institucional*: Se refiere a la concepción de la familia como grupo-institución.

2) *Histórico*: Se considera la historia del grupo familiar como la unidad de análisis que permite comprender significativamente su estruc-

* Cascón 697, 15-°61°, Buenos Aires.

tura, su dinámica, sus fracturas, y como la vía más adecuada para la explicación etiológica de la enfermedad actual, aun cuando ésta esté expresada en un miembro aislado.

Estas dos unidades de análisis se operativizan en lo que denominamos "*diagnóstico de la situación consulta*" que consiste en identificar aquello que transformó la intolerancia al sufrimiento en necesidad de ayuda psicológica (como decisión concreta), así como la forma en que se espera resolver a partir de esta ayuda solicitada.

Se consideran como esenciales para la comprensión de la historia:

a) La detección de los modelos básicos históricos que generan conflictos presentes, y su grado de corrección histórica. Así como las causas del fracaso actual de dichos modelos, que pudieron haber sido eficaces en otro momento.

b) El momento histórico de la consulta actual y prehistoria de la consulta en relación a la situación básica conflictiva.

c) Es necesario discriminar en estos modelos históricos el monto de *corrección* y de *repetición patológica* que brindan, y las posibilidades de recuperación en el presente, para su aplicación en el futuro.

Aspectos terapéuticos del proceso diagnóstico. El relevamiento de la historia familiar, es importante no sólo para el terapeuta, sino fundamentalmente para el paciente que se ve llevado a reflexionar, seleccionar y jerarquizar datos de su propia historia.

La modalidad de vincularse el paciente con su propia historia, permite pronosticar el vínculo terapéutico, ya que el futuro es parte de la historia.

Se dan algunos modelos indagatorios para el relevamiento de la historia. Por ejemplo: *evolutivo grupal*: Se trata de indagar la historia de la macro familia, el proyecto de pareja —la construcción de la pareja— el proyecto de los hijos, etc.

Situaciones de crisis y cambio. Pueden permanecer no resueltas como núcleos enquistados de la situación familiar por ej.: muertes, abortos, mudanzas, nacimientos no elaborados, separaciones, etc.

Todos estos modelos pueden ser indagados tanto en relación al adentro del grupo, como en relación al contexto (trabajo, escuela, diversiones, etc.).

Estos modelos indagatorios son utilizados sucesiva, simultánea o alternativamente desde las hipótesis guías elaboradas a partir del diagnóstico de la situación consulta.

Estas hipótesis se irán comprobando modificando o desechando a lo largo de la tarea diagnóstica. Esto nos llevará a aproximaciones comprensivas de la situación de fracaso básico familiar y devolver esta comprensión al paciente en una propuesta terapéutica adecuada a las necesidades y posibilidades del paciente y su grupo.

"Encuadre familiar"

(Versión abreviada)

VALENTÍN ARROYO *
LILIAN FISHER
MARÍA ROSA MORE
VIRGINIA SCHEJTER
SILVIA WEINGIERMAN
SILVIA ZEIGNER

En nuestra tarea diagnóstica y terapéutica, trabajamos con *encuadre familiar*. En el trabajo, para desarrollarlo, primeramente explicitamos qué entendemos por *encuadre* y qué por *grupo familiar*.

Encuadre. El encuadre, en la tarea psicológica es un recurso técnico que permite operativizar un conjunto de supuestos teóricos. A su vez encuadrar un fenómeno implica una categorización. El encuadre es un recurso que sirve de continente tanto al terapeuta como al paciente y regla el vínculo para la tarea compartida. Todo encuadre connota muchas más cosas de las que explicita. Toda expresión verbal conlleva un monto de actuación, por lo tanto el encuadre no sólo se define por lo verbalizado, sino también por lo actuado tanto por parte del terapeuta como del paciente.

El encuadre operando es la síntesis de los aspectos explícitos e implícitos que resumen el marco referencial de trabajo y el estilo personal del terapeuta.

En nuestro trabajo intentamos legalizar las modalidades personales de los terapeutas y las necesidades de cada paciente creando un *encuadre peculiar para cada relación terapéutica*. Por lo tanto, el contrato y el mantenimiento de éste es una responsabilidad compartida.

Grupo familiar. La familia es el modelo natural de interacción grupal. Es la unidad básica mínima de la estructura social. Siguiendo a Pichon Riviére, pensamos que: "provee el marco adecuado para la

* Casa de la familia", José Hernández 2576, Buenos Aires.

definición y conservación de las diferencias humanas, dando forma objetiva a los roles distintos pero mutuamente vinculados del padre, de la madre y del hijo, que constituyen los roles básicos de todas las culturas. Es por lo tanto, un grupo social especializado en la producción de personas con una biografía peculiar.

Consideramos a la familia como: unidad psicopatológica y psicopatogénica, de análisis, de operación, de supervivencia y de trabajo, de deuteroprendizaje.

Considerar como unidad psicopatológica y psicopatogénica, implica tomar la enfermedad como emergente del grupo familiar y al enfermo como portavoz y considerar a la familia como un mediador de la patología entre el individuo y el contexto histórico social.

Considerar al grupo familiar como unidad de operación significa incluirlo dentro de los límites de nuestra acción posible, *aún cuando la tarea en el consultorio se desarrolle solo con un miembro del grupo familiar.*

La familia como unidad de deuteroprendizaje es el ámbito en el que el individuo aprende a aprender, esto hace que la familia sea también el marco en el que se corrija el modelo aprendido.

Encuadre familiar. Esta concepción del grupo familiar nos llevó a la búsqueda de un encuadre adecuado para operar. Trabajamos con encuadre familiar, con pacientes individuales (niños o adultos), parejas y familias.

Nuestra unidad de análisis es el grupo familiar, por lo tanto pensamos la tarea a encarar con el paciente en función de él mismo pero también en función de su grupo. Esto puede llevar a trabajar sucesiva o simultáneamente con diferentes miembros de la familia en una tarea común, tarea encarada por un terapeuta o varios trabajando con un plan único.

Este encuadre da normas que prevén las situaciones de crisis de crecimiento. Incorporamos en la técnica modelos interpretativos tradicionales y modelos de interpretación pedagógica que jerarquizan la acción.

Controlamos las variables al mantener el pedido de ayuda dentro de condiciones de seguridad que permitan la productividad del vínculo.

El encuadre que se propone al grupo no debe forzar la situación más allá del horizonte de sus cambios posibles en el momento de la consulta. Si en la terapia, al cabo de un plazo determinado el horizonte familiar se amplía se hace necesario el *reencuadre* y el *recontrato* que significan una modificación de las normas, un cambio de tarea.

Se trabaja con la relación del paciente con su familia, tanto sea en la preparación de tareas a realizar fuera del ámbito del consultorio por parte del paciente, con la inclusión hipotética de la familia en el marco del tratamiento, o con su inclusión real.

El encuadre familiar tiende a transformar en datos, todas las acciones e interacciones que se dan dentro del grupo.

No consideramos que la familia deba acceder a un ideal de salud, sino que la situación alcanzada en cada momento es considerada como el máximo de salud posible para ese grupo, en esta situación histórica y con ese terapeuta.

Notas sobre técnica en psicoterapia de grupo familiar

(Versión abreviada)

SARA P. DE BERENSTEIN *
ALBERTO G. MARTICORENA
NORBERTO C. MARUCCO

En este trabajo se especifican las normas técnicas que definen nuestra tarea en psicoterapia de grupo familiar, y los fundamentos teóricos de las mismas.

Las proposiciones básicas del modelo que utilizamos en el intento de comprender la dinámica del grupo familiar en tratamiento, son: a) La familia muestra una *organización manifiesta*, que es aquella reconocida, comunicada y percibida por sus integrantes y por el terapeuta, y que habitualmente presenta una división entre los miembros del grupo (sanos-enfermos) b) La organización manifiesta es *expresión sintomática e intento de resolución* de un conflicto grupal; c) La observación de los acuerdos, contradicciones e incongruencias que presenta la organización manifiesta, permite inferir la existencia de otra organización grupal, que regula la conducta de los integrantes y que es desconocida para ellos: es la *organización latente*, que incluye personajes, vínculos e impulsos distintos de los de la organización manifiesta; d) Los integrantes del grupo ponen en juego especialmente mecanismos de *identificación proyectiva e introyectiva*, en el intento de evitar el conocimiento de la organización latente y de mantener la organización manifiesta; y e) *Diferentes configuraciones* de las organizaciones manifiesta y latente se observan en el curso del tratamiento, en la medida en que pueden ir adquiriendo significado cada vez más amplio los sucesos familiares.

El tratamiento se efectúa con la *presencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes* que se hubieren comprometido a concurrir a las sesiones, y dentro del marco preferencial antes mencionado, el

objetivo terapéutico es el de *lograr cambios en la estructura familiar* más que cambios individuales en las personas sancionadas como enfermas.

La *consigna* que define cuál ha de ser y cómo ha de desarrollarse la tarea en el grupo, explicita que: a) Los integrantes de la familia tienen que comunicar aquello que les preocupa; b) Que todos deben opinar acerca de los temas que surgen en el grupo; c) Que es conveniente que las decisiones que piense tomar la familia sean discutidas previamente en sesión; y d) Que el terapeuta señalará la manera que tienen de relacionarse e *interpretará los motivos inconscientes que provocan y regulan la interacción familiar*.

En el ejemplo clínico que presentamos, se observa la existencia de las organizaciones manifiesta y latente; las divisiones defensivas del grupo familiar; el modo como el terapeuta va entendiendo la dinámica del grupo familiar en la sesión y construyendo la interpretación; y el *interjuego de identificaciones proyectivas e introyectivas*. Sobre la *interpretación* referida en el ejemplo destacamos que *trata de no validar la división que la familia trae* (entre sanos y enfermos), así como otras que aparecen en el curso del tratamiento, ya que tales divisiones manifiestas son *expresiones defensivas frente al conflicto*. Por el contrario, se interpretan los motivos inconscientes de las conductas de los integrantes en la situación grupal, y se *posibilita*, de esta manera, *la reintroyección de lo que aparece proyectado e identificado en alguno de los familiares*.

La *interpretación no es lo único, pero sí el medio más jerarquizado* de que dispone el terapeuta para *promover cambios* en la organización grupal. Estimamos conveniente que otros recursos (preguntas, comentarios, observaciones, señalamientos) sean utilizados para lograr el establecimiento de una interacción grupal operativa. Nuestra actitud antes de formular una interpretación, es la de esperar la participación de la mayor cantidad de integrantes de la familia. Tenemos en cuenta tanto la información verbal como las *conductas no verbales*, e interpretamos cuando comprendemos la situación familiar, aunque sea parcialmente. No nos limitamos por no poder incluir a la totalidad de los integrantes, ni por desconocer la conexión histórica del acontecimiento actual. En este sentido, podemos realizar interpretaciones incompletas, ya que la *descripción de la interacción y el hacerla consciente para el grupo es, de por sí, terapéutica*.

* Departamento de Familia del Instituto Médico de Acta, Santa Fe 3651, tel. 71-5427, Buenos Aires.

definición y conservación de las diferencias humanas, dando forma objetiva a los roles distintos pero mutuamente vinculados del padre, de la madre y del hijo, que constituyen los roles básicos de todas las culturas". Es por lo tanto, un grupo social especializado en la producción de personas con una biografía peculiar.

Consideramos a la familia como: unidad psicopatológica y psicopatogénica, de análisis, de operación, de supervivencia y de trabajo, de deuterioaprendizaje.

Considerar como unidad psicopatológica y psicopatogénica, implica tomar la enfermedad como emergente del grupo familiar y al enfermo como portavoz y considerar a la familia como un mediador de la patología entre el individuo y el contexto histórico social.

Considerar al grupo familiar como unidad de operación significa incluirlo dentro de los límites de nuestra acción posible, *aún cuando la tarea en el consultorio se desarrolle solo con un miembro del grupo familiar.*

La familia como unidad de deuterioaprendizaje es el ámbito en el que el individuo aprende a aprender, esto hace que la familia sea también el marco en el que se corrija el modelo aprendido.

Encuadre familiar. Esta concepción del grupo familiar nos llevó a la búsqueda de un encuadre adecuado para operar. Trabajamos con encuadre familiar, con pacientes individuales (niños o adultos), parejas y familias.

Nuestra unidad de análisis es el grupo familiar, por lo tanto pensamos la tarea a encarar con el paciente en función de él mismo pero también en función de su grupo. Esto puede llevar a trabajar sucesiva o simultáneamente con diferentes miembros de la familia en una tarea común, tarea encarada por un terapeuta o varios trabajando con un plan único.

Este encuadre da normas que prevén las situaciones de crisis de crecimiento. Incorporamos en la técnica modelos interpretativos tradicionales y modelos de interpretación pedagógica que jerarquizan la acción.

Controlamos las variables al mantener el pedido de ayuda dentro de condiciones de seguridad que permitan la productividad del vínculo.

El encuadre que se propone al grupo no debe forzar la situación más allá del horizonte de sus cambios posibles en el momento de la consulta. Si en la terapia, al cabo de un plazo determinado el horizonte familiar se amplía se hace necesario el *reencuadre* y el *recontrato* que significan una modificación de las normas, un cambio de tarea.

Se trabaja con la relación del paciente con su familia, tanto sea en la preparación de tareas a realizar fuera del ámbito del consultorio por parte del paciente, con la inclusión hipotética de la familia en el marco del tratamiento, o con su inclusión real.

El encuadre familiar tiende a transformar en datos, todas las acciones e interacciones que se dan dentro del grupo.

No consideramos que la familia deba acceder a un ideal de salud, sino que la situación alcanzada en cada momento es considerada como el máximo de salud posible para ese grupo, en esta situación histórica y con ese terapeuta.

Notas sobre técnica en psicoterapia de grupo familiar

(Versión abreviada)

SARA P. DE BERENSTEIN *
ALBERTO G. MARTICORENA
NORBERTO C. MARUCCO

En este trabajo se especifican las normas técnicas que definen nuestra tarea en psicoterapia de grupo familiar, y los fundamentos teóricos de las mismas.

Las proposiciones básicas del modelo que utilizamos en el intento de comprender la dinámica del grupo familiar en tratamiento, son: a) La familia muestra una *organización manifiesta*, que es aquella reconocida, comunicada y percibida por sus integrantes y por el terapeuta, y que habitualmente presenta una división entre los miembros del grupo (sanos-enfermos) b) La organización manifiesta es *expresión sintomática e intento de resolución* de un conflicto grupal; c) La observación de los acuerdos, contradicciones e incongruencias que presenta la organización manifiesta, permite inferir la existencia de otra organización grupal, que regula la conducta de los integrantes y que es desconocida para ellos: es la *organización latente*, que incluye personajes, vínculos e impulsos distintos de los de la organización manifiesta; d) Los integrantes del grupo ponen en juego especialmente mecanismos de *identificación proyectiva e introyectiva*, en el intento de evitar el conocimiento de la organización latente y de mantener la organización manifiesta; y e) *Diferentes configuraciones* de las organizaciones manifiesta y latente se observan en el curso del tratamiento, en la medida en que pueden ir adquiriendo significado cada vez más amplio los sucesos familiares.

El tratamiento se efectúa con la *presencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes* que se hubieren comprometido a concurrir a las sesiones, y dentro del marco preferencial antes mencionado, el

objetivo terapéutico es el de *lograr cambios en la estructura familiar* más que cambios individuales en las personas sancionadas como enfermas.

La *consigna* que define cuál ha de ser y cómo ha de desarrollarse la tarea en el grupo, explicita que: a) Los integrantes de la familia tienen que comunicar aquello que les preocupa; b) Que todos deben opinar acerca de los temas que surgen en el grupo; c) Que es conveniente que las decisiones que piense tomar la familia sean discutidas previamente en sesión; y d) Que el terapeuta señalará la manera que tienen de relacionarse e *interpretará los motivos inconscientes que provocan y regulan la interacción familiar*.

En el ejemplo clínico que presentamos, se observa la existencia de las organizaciones manifiesta y latente; las divisiones defensivas del grupo familiar; el modo como el terapeuta va entendiendo la dinámica del grupo familiar en la sesión y construyendo la interpretación; y el *interjuego de identificaciones proyectivas e introyectivas*. Sobre la *interpretación* referida en el ejemplo destacamos que *trata de no validar la división que la familia trae* (entre sanos y enfermos), así como otras que aparecen en el curso del tratamiento, ya que tales divisiones manifiestas son *expresiones defensivas frente al conflicto*. Por el contrario, se interpretan los motivos inconscientes de las conductas de los integrantes en la situación grupal, y se *posibilita*, de esta manera, la *reintroyección de lo que aparece proyectado e identificado en alguno de los familiares*.

La *interpretación no es lo único, pero sí el medio más jerarquizado* de que dispone el terapeuta para *promover cambios* en la organización grupal. Estimamos conveniente que otros recursos (preguntas, comentarios, observaciones, señalamientos) sean utilizados para lograr el establecimiento de una interacción grupal operativa. Nuestra actitud antes de formular una interpretación, es la de esperar la participación de la mayor cantidad de integrantes de la familia. Tenemos en cuenta tanto la información verbal como las *conductas no verbales*, e interpretamos cuando comprendemos la situación familiar, aunque sea parcialmente. No nos limitamos por no poder incluir a la totalidad de los integrantes, ni por desconocer la conexión histórica del acontecimiento actual. En este sentido, podemos realizar interpretaciones incompletas, ya que la *descripción de la interacción y el hacerla consciente para el grupo es, de por sí, terapéutica*.

* Departamento de Familia del Instituto Médico de Acta, Santa Fe 3651, tel. 71-5427, Buenos Aires.

Terapia familiar en comunidad terapéutica (grupo familiar múltiple y grupo familiar nuclear)

* J. E. GARCÍA BADARACCO
N. PROVERBIO
A. A. CANEVARO

Este trabajo tiene la intención de traer nuestra experiencia en el tratamiento de familias de pacientes psicóticos dentro de un contexto de comunidad terapéutica orientada psicoanalíticamente.

Muchos autores han señalado que el tratamiento psicoanalítico de psicóticos se detiene, se estanca, se interrumpe, o se ve interferido muchas veces por la influencia directa de los familiares más próximos, lo que llevó a la necesidad de tener que incluir de maneras diversas a la familia en el tratamiento (participación en el contrato, entrevistas esclarecedoras, grupo familiar con o sin participación del paciente, etcétera).

Otros autores han señalado igualmente la influencia del medio familiar en la génesis y estructuración de procesos psicóticos, como la expresión de una seria perturbación de las relaciones interpersonales, y han encontrado en la terapia familiar un instrumento terapéutico valioso.

Para hacer más comprensible nuestra tarea, debemos decir brevemente que para nosotros el concepto de Comunidad Terapéutica implica un contexto total dentro del cual están integradas las diferentes modalidades terapéuticas que constituyen otras tantas estructuras del campo psicológico que dan la oportunidad para el trabajo de elaboración de los aspectos más psicóticos de la personalidad.

El proceso terapéutico en este contexto es el que realiza el paciente integrando estas distintas experiencias terapéuticas.

En el momento actual nosotros tenemos cuatro estructuras terapéuticas básicas dentro del funcionamiento de la comunidad, que ayudan a esta tarea integradora: terapia individual psicoanalítica, terapia

grupal comunitaria, terapia del grupo familiar nuclear y grupo familiar múltiple instrumentado terapéuticamente.

Ahora bien, para comprender adecuadamente nuestra manera de incluir a la familia en el proceso terapéutico del paciente, consideramos que la terapia familiar debe ser pensada en referencia a este contexto total.

Lo que llamamos grupo familiar múltiple está constituido por el conjunto de pacientes en tratamiento y sus familiares.

Funciona como grupo abierto al cual se van incorporando las distintas familias de los pacientes que van ingresando a la Comunidad.

El ingreso de un nuevo paciente a la Comunidad se constituye en un momento particular de la situación individual y familiar a través del cual podemos darnos una idea del estado psicopatológico, pues es en ese momento que pueden verse ya los abigarrados mecanismos defensivos de los pacientes y sus familiares proyectados en la institución que se convierte en un objeto muy especial que toma por momentos una significación simbólica variada en cada uno de esos grupos.

Nos enfrentamos habitualmente con una serie de actitudes del paciente y sus familiares que van desde un pesimismo fatalista respecto de la curación hasta una idealización exagerada de la Institución, pasando por actitudes paranoides, racionalizaciones, negaciones maníacas, ignorancia, etcétera.

Estas defensas frente a la angustia que moviliza el paciente con su enfermedad, se constituyen en una dificultad para el mejor desarrollo del proceso terapéutico.

El grupo familiar múltiple permite en estos primeros momentos que cada familia se ubique mucho más rápidamente frente a su tarea de participación en el proceso terapéutico y al esclarecer la índole de su actitud inicial, la coloca en una situación de compromiso con el mismo.

El grupo familiar múltiple actúa en estas situaciones movido por la necesidad de eliminar las resistencias de la nueva familia y lo logra porque a lo largo de su historia propia ya ha elaborado situaciones similares. En este sentido el grupo familiar múltiple es un buen "continente" para angustias y defensas de sus miembros. Cuando entra una familia nueva, entra, por así decir, a un organismo viviente al cual tiene que adaptarse. Las distintas familias que lo componen se encuentran en distinto grado de evolución de su proceso terapéutico; algunas ya hace meses que están y después de muchas vicisitudes han recorrido un camino; las angustias y los síntomas con que vinieron a la Institución se han ido transformando poco a poco.

El conjunto de los fenómenos descriptos crea un clima terapéutico que posibilita su integración con las distintas estructuras terapéuticas de la Comunidad (terapia individual, terapia familiar nuclear, grupo comunitario, etc.).

* Clínica Psiquiátrica. O'Higgins 2328, Capital Federal.

Así, el miembro de una familia puede, en el grupo familiar múltiple, señalar a otra familia, situaciones que ya ha elaborado en su grupo familiar nuclear; un paciente puede detectar a través de lo que se explicita en el grupo familiar múltiple, conflictos propios a esclarecer en su terapia individual o en el grupo familiar nuclear.

De igual manera un paciente psicótico puede permitirse expresar situaciones conflictivas intensas a su familia en el grupo familiar nuclear, sabiendo que la misma tiene posibilidad de respaldo y apoyo en el grupo familiar múltiple.

Así también puede expresar indirectamente conflictos con su familia al actuarlos psicóticamente o señalarlos en un nivel más maduro con la familia de otro paciente. De igual forma, la conducta de un paciente en el grupo comunitario al dramatizar con otros pacientes o con los miembros del Staff a través de situaciones transferenciales sus conflictos familiares, da posibilidad para que éstos puedan ser examinados en el grupo familiar nuclear o múltiple.

La terapia del grupo familiar nuclear no dista mucho de los modelos habituales de terapia familiar de psicóticos, pero eso sí, se encuentra enriquecida por la posibilidad de poder interpretar no sólo el "aquí y ahora" de la sesión, sino también por incluir las distintas situaciones que se presentan en las estructuras terapéuticas antes señaladas.

Este funcionar, que puede aparecer a primera vista como un complicado mecanismo difícil de armonizar, en la medida en que los miembros del Staff en permanente comunicación logren dar una adecuada coherencia, se convierte en un instrumento terapéutico de inusitada riqueza que permite al paciente vencer las disociaciones patológicas, integrando las distintas experiencias en un proceso terapéutico único.

Este proceso terapéutico lo entendemos según el modelo de proceso psicoanalítico pero con mayores posibilidades de trabajar en una permanente confrontación entre mundo interno-mundo externo, objetos internos objetos externos, lo que en nuestra experiencia se ha mostrado sumamente importante para la terapia psicoanalítica de psicóticos.

Dramatización de afectos en situaciones límites. Una técnica de laboratorio para la resolución de crisis familiares

FLORINDA S. DE GLOECER *

En este trabajo se describe una técnica de laboratorio aplicada al tratamiento de una crisis familiar, basada en la dramatización de situaciones vivenciales límites. En él se desarrollarán los siguientes puntos: 1) Objetivo de la técnica. 2) Supuesto básico. 3) Definiciones operacionales. 4) Función de las tres primeras reuniones: a) Estructurantes; b) Diagnósticas; c) Terapéuticas. 5) El microlaboratorio: planificación de los ejercicios y descripción de dos de ellos. 6) Técnica de la interpretación. 7) Función de las dos últimas entrevistas: análisis y evaluación.

Esta técnica apunta a la ruptura de los estereotipos verbales y afectivos, que imposibilitan el aprendizaje de nuevas conductas, amenazando conducir a una resolución patológica de la crisis. El supuesto básico que este método sugiere, es que si se logra conducir progresivamente a la familia hacia situaciones productoras de conductas emocionales primarias se produce una movilización dinámica profunda que permite la revitalización de los vínculos. Tales vivencias ponen en juego el potencial latente de comprensión afectiva que cada uno de los miembros del grupo posee.

Se define a la crisis como un estado de desorganización transicional de un sistema, que se produce por la irrupción de un estímulo fuerte, que altera su estabilidad emocional, produciendo una elevación de la tensión, que puede llegar a bloquear o por el contrario a movilizar a sus miembros para solucionarlos. (Gerald Caplan.)

La definición operacional de situaciones límites se refiere a las opciones que enfrenta el grupo: conservación o ruptura del sistema; unión o separación de sus miembros. Se trató de provocar esas opciones experimentalmente, mediante ejercicios no verbales de sensibilización,

* Av. de los Incas 3129, 4º "B", Capital Federal.

alternantes y contrastantes, capaces de evocar experiencias y fantasías básicas de encuentro y separación, a través de la dramatización de argumentos, conectados con las disyuntivas que enfrentaba el grupo.

Para los fines de este trabajo se considera al microlaboratorio como la culminación de un proceso que se desarrolla en seis reuniones. A saber: tres preliminares, el laboratorio propiamente dicho y dos posteriores al mismo.

Las tres primeras cumplen funciones diagnósticas, estructurantes y terapéuticas.

La función estructurante se relaciona con garantías de confianza y de seguridad que es imprescindible crear para lograr la cooperación de los sujetos en la tarea. Esto va unido al grado de interés que se logre despertar en el grupo, lo cual tiene que ver tanto con la personalidad del coordinador como con el dominio de la técnica. El encuadre en el que se explicita el plan en su desarrollo formal y el contrato en el que se estipula la frecuencia, duración y lugar de las reuniones, contribuyen a estructurar la situación, obviamente necesario para quienes están pasando por un momento de desestructuración.

La función diagnóstica implica: a) El diagnóstico de la estructura de la crisis; b) El diagnóstico relacional: estereotipos comunicacionales intragrupales y estructura de las alianzas; c) Diagnóstico individual de la plasticidad y de las posibilidades con que cuenta cada uno de los miembros del grupo.

La función terapéutica, en realidad, está presente desde la primera hasta la última reunión. Por la libre expresión de los afectos que alivia la tensión en una atmósfera permisiva y por otra parte por el influjo terapéutico, por el cual las conductas adquieren un nuevo significado.

En las dos reuniones posteriores se analizan y evalúan las vivencias intralaboratorio. Este trabajo se centra en la descripción de la técnica, por lo cual se tomarán en cuenta solamente aquellos aspectos clínicos que se consideran necesarios para su comprensión.

La estructura del grupo familiar en nuestro ejemplo es la siguiente: Padre, 52 años, profesional. Madre, 48, quehaceres domésticos, ex actriz. Hija A, 27, casada, un hijo, estudiante universitaria. Hija B, 20, soltera, actriz, ex estudiante universitaria.

Estructura de la crisis. Factor desencadenante: B, la hija menor está a punto de abandonar el hogar, ante la imposibilidad de tolerar las tensiones con su familia y no soportar más el rechazo del que se siente objeto. La familia no acepta que haya abandonado sus estudios universitarios para dedicarse *full-time* al teatro. Considera que el grupo teatral al que pertenece está constituido por gente muy enferma. Tienen la certeza que la hija los odia. En el momento de la consulta la crisis estaba a punto de solucionarse patológicamente.

El padre había decidido aceptar la separación de la hija, en forma absoluta, pero dicha resolución había creado un clima de angustia y depresión.

Estructura de las alianzas. El sistema estaba fragmentado. Funcionaba con subgrupos de alianzas alternantes: padre-madre; padre-madre-hija A (modelo), hija B ("problema")-hija A. Según el momento, cada uno de los miembros de la familia podía aliarse a la hija modelo, por lo cual había momentos en que la hija "problema" sentía la alianza de todos contra ella.

Diagnóstico de los estereotipos. a) Intragrupales: Los estereotipos comunes a todos los miembros del grupo contenían: acusaciones mutuas, recepción y emisión parcializadas de los mensajes, y dificultad para dar, pedir, recibir y compartir; b) Individuales: En cada uno de los miembros de la familia podían distinguirse los siguientes modelos: Madre: culpar a la hija B de su enfermedad; despreciaba lo que hacía contraponiendo el ejemplo de la hija A; buscaba la alianza del marido y de la hija A contra la hija B y finalmente se quejaba de la pasividad de su marido.

La hija B, por su parte, rechazaba violentamente la acusación de la madre de ser causante de su enfermedad. Sus metamensajes pedían a la familia aceptación y comprensión, contradiciendo su decisión de irse. El padre no aceptaba que B hubiese abandonado sus estudios. La hija A decía que estaba cansada de ser usada por la familia, puesto que era el paño de lágrimas de cada uno de ellos.

Diagnóstico individual de las posibilidades para el cambio. Se obtuvo mediante la aplicación de un test proyectivo cuya interpretación responde a un diseño que permite obtener un índice de la proporción que existe entre las conductas constructivas y las conductas conflictivas.

Planificación de los ejercicios. Los ejercicios fueron pensados en función de los estereotipos interaccionales típicos de la familia, dramatizados en situaciones límites, que como ya definimos giraban en torno a situaciones en las que se jugaban la conservación o la ruptura del sistema. Tres de ellos algunos con ciertas modificaciones) pertenecen a los doctores Leslie Phillips y Alan Katcher, de los Estados Unidos, que los pusieron en práctica en una experiencia de laboratorio de la que fui miembro participante, programada por el Centro de Investigaciones y Asesoramiento Psicológico, cuya dirección ejercen las Licenciadas Isabel Calvo y M. T. Calvo de Spolansky. Otra modificación sustancial introducida por mí, se refiere al enfoque del microlaboratorio ya no como realizado en una reunión, sino como un proceso que se desarrolla con tres reuniones preliminares (cuya función ya fue

mencionada) y dos posteriores al microlaboratorio, de análisis y evaluación.

Los argumentos dramatizados fueron los siguientes:

1. *Encuentro y cercanía física.* Consignas: permanecer muy juntos, sentados en el suelo, sin hablar y con los ojos cerrados.

2. *Soledad.* Se aisló a cada uno de los miembros en ámbitos distintos diciéndoles que permanezcan con los ojos cerrados.

3. *Dramatización de las alianzas tipo de la familia.* Primero caminando solos; luego de tres tomados de la mano, excluyendo a un miembro. Los roles fueron intercambiados, de manera que cada uno de ellos pasó por la experiencia de exclusión y soledad y por la experiencia de compartir. El miembro que estaba solo no debía hablar ni intervenir, mientras que los demás podían hacerlo. Finalmente se les dijo que caminaran todos juntos, tomados de la mano, sin hablar.

4. *El grupo camina con los ojos vendados.* (Este ejercicio será descripto más adelante).

5. *Rol playing.* Argumento: estar solo y enfermo en un país extraño. Volver a encontrarse con la familia. Se evocaba así una situación vivida muy ansiógena y no elaborada. Durante la realización de este ejercicio se produjo una microcrisis en la que emergieron modelos de agresión y de descubrimiento de cosas nunca dichas.

6. *Reconocimiento de partes buenas de los demás.* Consigna: Se les pidió que se reunieran en grupos de dos que serían intercambiables, y que cada uno dijera las virtudes del otro.

7. *Ponerse en lugar del otro.* En este rol playing la hija B debía culpar a la madre de su enfermedad.

Previendo la posibilidad del desencadenamiento de una microcrisis afectiva, dentro de la macrocrisis que estaba viviendo el grupo, el programa fue rigurosamente dosificado, graduando la calidad y la intensidad de los ejercicios. Esto se hizo en base al diagnóstico individual y relacional, efectuado en las tres reuniones previas.

La regla para su planificación fue: alternancia de ejercicios ansiógenos con ejercicios atenuadores de tensión y establecimiento de un corte para tomar un refrigerio en un clima totalmente informal.

Vamos a comunicar sólo dos de los ejercicios realizados. El primero tuvo por objeto evocar una situación de encuentro y cercanía física, o sea, de dar la oportunidad al grupo de redescubrir algo que hacía mucho se había perdido: estar juntos, sintiendo el yo corporal de la familia en una situación muy arcaica, previa a la aparición de la palabra hiriente. Les indiqué que se sentaran en el suelo. Lo hicieron menos el padre que permaneció sentado en su silla. Les pedí que se pusieran más juntos y al padre que se reuniera con su familia. Éste se arrimó al grupo sin levantarse y arrastrando la silla dijo: "Yo estoy

bien acá. Yo no puedo estar muy de cerca" (Risas). Les pedí que no hablaran y que trataran de concentrarse en lo que estaban haciendo. "Cierren los ojos y permanezcan en silencio." Insistí: "más juntos. Más". Enseguida comenzó a respirarse un clima altamente emotivo. El padre en su silla. A sus pies la familia en íntimo contacto físico. B. hacía esfuerzos por contener el llanto. Al levantarse, la madre y B tenían lágrimas en los ojos; A. estaba impasible y al padre le temblaban los labios.

A continuación y en franco contraste con el anterior, se realizó un ejercicio que sugería aislamiento total. La consigna fue caminar con los ojos vendados, sin hablar. Todos menos el padre que se había quedado en el mismo lugar, caminaban chocando a veces entre sí y seguían de largo. De pronto dejaron de caminar y quedaron parados. Era como si hubieran obedecido a una orden. Les fui indicando que trataran de encontrarse. El padre no se movió del lugar. La madre activamente buscaba a los demás. Encontró a las hijas y las abrazó y besó efusivamente. Mostraban regocijo. Sonreían. Quedaron unos instantes paradas sin saber qué hacer. De pronto la madre notó la ausencia del marido y empezó a buscarlo. Lo encontró y lo guió hacia donde estaban sus hijas. Él a su vez trató de encontrar a sus hijas. Estiró los brazos y tocó a B. Sonrió y le tironeó el pelo llamándola por su nombre.

Al finalizar la experiencia, para atenuar la ansiedad que había despertado en el grupo, se hicieron algunos señalamientos de las alternativas vividas, limitando las respuestas a las preguntas que sus miembros formulaban, aclarando que se dedicarían las reuniones siguientes para su análisis.

Técnica de la interpretación: La interpretación no sólo se centró en los aspectos patológicos de la interacción, que imposibilitaban el cambio, sino que concedió la misma importancia a sus aspectos sanos, en especial, al potencial latente de conductas afectivas constructivas que se detectaban en el sistema, que posibilitarían dicho cambio. Esta dualidad se vio reflejada en la discordancia que había entre lo que el grupo había expresado verbalmente en las entrevistas previas y lo que, por otra parte, transmitía con su rostro y con su cuerpo, en los ejercicios no verbales dramatizados. Las verbalizaciones eran utilizadas con fines de ataque y delegación de culpas, descalificando así a las conductas no verbales que en ciertos momentos expresaban acercamiento y comprensión. Las primeras movilizaron más intensamente la tendencia a la ruptura del grupo y las segundas su calidad reparatoria. La familia fue enfrentada con estos mecanismos, a través de la reproducción de fragmentos grabados de sesiones, en los que se manifestaban claramente sus estereotipias. Una semana después se pidió al grupo que escribiera lo que había sentido en cada uno de los ejercicios.

Los comentarios del padre mostraron su dificultad para exteriorizar

sus afectos. Los de A. evidenciaban una necesidad de poner distancia en la experiencia, como si no le hubiera afectado íntimamente. En cambio en la madre y en B. parece haber habido un reconocimiento más directo de la movilización de afectos. Sobre la experiencia de acercamiento la madre expresó: "Hubiese querido que durara mucho más, hasta convertirse en una realidad que hace rato que la añoro", y la hija: "me sentí primero algo incómoda, tratando de aparentar una relativa seguridad en lo que iba a hacer. Cuando usted decía que nos apretáramos, nos reíamos los cuatro muy nerviosamente, y al que más incómodo sentí fue a mi papá, sobre todo sentí que era la primera vez que se daba cuenta realmente de la separación que existía, separación que en ese momento se dio sólo a nivel físico, entre él y nosotros. Más aún cuando usted se lo hizo notar. Yo me sentí algo incómoda, por un momento pensé que usted nos iba a decir que nos tomáramos de las manos. Y luego pensé, ¿por qué miércoles no nos damos las manos nosotros? ¿Por qué miércoles hace tantos años, que no nos damos las manos?"

Sobre la experiencia de separación la hija B. expresó: "Ese creo que fue el momento más embromado de todos. Cuando me paré frente a mi mamá, cuando no pudimos ni siquiera tocarnos. Por un instante estuvimos mi hermana, mi mamá y yo juntas. Fue igual. Cuando caminaba sentí todas las cosas que siento siempre, pero en un solo instante. Sentí pasar imágenes de momentos que pasaron hace muy poco; de pronto aparecían años muy lejanos. Y quise llorar fuerte. Pero me contuve y ahí me tuve mucha bronca. Porque no podía comunicarles que yo estaba mal. Porque no entendían que los estaba buscando ahora *realmente*. Con mi papá fue muy extraño; en un momento yo me paré y él muy despacito me llamó por mi nombre. Ahí quise tocarlo yo y que se refugiara él en mí, porque su voz evidenciaba que estaba muy mal. Sentí como si me dijera: "B. estoy aquí, estoy con vos, no estás sola." Y ahí fue cuando se cortó el ejercicio.

Evaluación de la experiencia Se tomaron en cuenta para la evaluación del microlaboratorio los siguientes criterios: 1) Las observaciones directas del comportamiento del grupo, en tres momentos del desarrollo temporal del proceso: durante, al terminar, y una semana después de realizado. 2) Las manifestaciones espontáneas del grupo en la reunión de despedida. En especial del padre quien dijo que al principio había venido con escepticismo porque pensaba que el problema no tenía solución y porque no creía en la psicología. Ahora sentía que esta experiencia les había permitido decir cosas que nunca se habían dicho y estas cosas habían sido precisamente las que lo estimularon y enriquecieron para encarar el problema en forma constructiva.

Se han considerado como indicadores de cambio:

1) La redifinición de la crisis. El grupo descubrió que el factor desencadenante de la crisis "B. nos odia, B. abandona el hogar", era

un derivado de un conflicto negado y reprimido que afectaba a la relación de los padres entre sí.

2) La emergencia de conductas nuevas que ponían en descubierto el potencial afectivo de cada uno de ellos y nuevas maneras de vivirlo.

3) El proceso correctivo de la autoimagen y la de los demás a través de un acercamiento íntimo que permitía descubrir y comprender aspectos desconocidos del propio yo y del yo de los otros miembros del grupo.

4) El pasaje del dar, pedir, y recibir egocéntricos, al descubrimiento del compartir, sintiendo que cada uno puede no sólo ser receptor, sino dador de afecto y comprensión.

Algunos aspectos de la psicoterapia de familia según Bowen

JAVIER HORACIO GURVICH *

Trataré de exponer las teorías del doctor Bowen en forma sucinta y sin apartarme de cómo fueron enunciadas. Quiero aclarar que en los años 1963 y 1964, trabajé junto al doctor Bowen en la Universidad de Georgetown, en Washington y en 1965 participé en el Primer Seminario sobre Psicoterapia de Familia organizado en la misma Universidad.

El trabajo con familias en psicoterapia comenzó, quizá, con Freud cuando en 1909 éste da a conocer su tratamiento del "pequeño Juan". En este caso, Freud analiza a un niño pero con la ayuda del padre. En 1921 Flugel publica un libro titulado *El estudio psicoanalítico de la familia*. En 1934, Clarence Obendorf comienza a publicar algunos trabajos sobre tratamientos psicoanalíticos de parejas. En 1950, Mittleman publica sobre el tratamiento simultáneo de padres y niños. En 1962, Alexander Gralnik publica su artículo *Psicoterapia de familia*.

Estamos en una etapa dentro de la Psicoterapia de Familia en la cual nombres como los de Don Jackson, Wynne, Ackerman, Bell; todos ellos psicoterapeutas de familias, son ya bien conocidos.

Bowen parte de ciertas premisas importantes; considera al hombre en relación directa con todo lo que lo rodea. Lo considera diferente de los otros animales por el tamaño de su cerebro y por su capacidad de pensar y razonar. Cree que lo que el hombre piensa y habla de sí mismo es diferente de lo que en realidad es. Señala que las leyes que gobiernan el funcionamiento emocional del hombre son tan ordenadas como las otras leyes de la naturaleza, y que la dificultad que se tiene en conocerlas se debe más a la misma facultad de razonar, que a veces niega la existencia del sistema, que a la complejidad de éste.

Considerando a la familia como un sistema funcional en movimiento constante, pasaremos a las formulaciones teóricas.

El primer concepto básico es el de la "Masa yoica familiar indiferenciada". Se la podría definir como un conglomerado de emociones

presentes en los diferentes niveles de una familia y cuya intensidad varía de familia en familia. Las relaciones simbióticas, o el fenómeno de la "folié a deux", son ejemplos donde la intensidad de la fusión en la masa yoica es muy alta. Este proceso emocional puede envolver a toda la familia o a algunos miembros dentro del grupo familiar (padre, madre o hijos). En periodos de dificultades la "masa yoica" puede ampliar su núcleo y comprometer a personas fuera del grupo familiar, como médicos, maestros y otros. En periodos de calma el proceso está contenido en número menor de personas. El accreamiento emocional puede ser tan grande que los miembros de una familia llegan a conocer las fantasías, pensamientos y sueños de los otros componentes; incorporando el "sí mismo" (self) de otros al de ellos. O pueden, en otra fase dentro del ciclo que los envuelve, rechazarse hostilmente. Dentro del sistema emocional familiar, las tensiones cambian en una serie ordenada de alianzas y rechazos. La estructura emocional básica dentro del sistema sería el triángulo. En los periodos de calma, dos miembros del triángulo tienen una alianza emocional confortable, y el tercero funciona como "de afuera" se mueve hacia uno y otro de los miembros alternativamente. Cuando la tensión aumenta, el tercer miembro se ve envuelto en el conflicto, que si continúa, incluye a otros miembros que hasta el momento no estaban comprometidos, formando una cadena de triángulos que se entrelazan por turnos.

Dentro de la "Masa yoica familiar" los esposos tienen tres mecanismos de control de la intensidad de la "fusión yoica".

1) A través del conflicto marital (cada esposo trata de obtener una porción del "sí mismo común a ambos").

2) Por el mal funcionamiento de uno de los esposos, quien se vuelve candidato a enfermarse física, emocional o socialmente.

3) Transmisión del problema a uno o más de los hijos. Éste es uno de los mecanismos más comunes, y cuyo análisis es importante para los que trabajan con niños y adolescentes.

Hay familias que manifiestan sus problemas en las tres áreas mencionadas, o en dos, o en una sola. El problema puede medirse en términos de "inmadurez". Cuando un esposo se hace cargo de una gran cantidad de "inmadurez", esto puede causarle un mal funcionamiento. Pero al mismo tiempo puede ser una protección para que los hijos no se deterioren.

El segundo concepto es el de la "Escala de diferenciación del sí mismo". Se basa en el funcionamiento del individuo en las áreas más importantes de su realidad sexual, familiar, de trabajo y social. La escala no incluye un concepto de "normalidad", es si se quiere una forma de conceptualizar todo el funcionamiento humano en una sola continuidad. Sus valores van del 0 al 100. En el extremo superior se incluye la completa madurez emocional que equivaldría a "una com-

* Director del Instituto de Psicología y Psiquiatría del Niño y Adolescente, Córdoba. Jefe del Servicio de Psiquiatría Infantil, Casa Cuna, Córdoba.

pleta diferenciación del sí mismo" y en el inferior estaría la "falta de sí mismo" como representante del más alto nivel de "indiferenciación".

Las personas en el cuarto inferior de la escala, de 0 a 25, son aquellas con el más alto grado de "fusión del yo". Viven en un mundo de "sentimientos", si no son tan miserables que han perdido la capacidad de "sentir". Ellos dependen de los "sentimientos" de los que los rodean. Viven con la angustia de si son o no amados o aceptados. No pueden diferenciar entre lo que "sienten" de lo que "piensan" sobre algo. Les cuesta decir "yo pienso", "yo creo", "yo haré". El yo que utilizan es muy narcisista, "yo quiero", "yo me siento herido", "yo siento". Cuando niños crecieron como apéndices de la "masa yoica parental" y en el curso de su vida buscan de quién poder depender; si lo encuentran, logran una adaptación marginal. Los que no encuentran fuentes de dependencia hacen adaptaciones muy frágiles y son aptos para desequilibrios emocionales. Por último están los que no pueden vivir sino bajo la protección de instituciones mentales. Cuando logran sentirse libres de síntomas no aspiran a más.

Aquellos dentro de la escala que van de 25 a 50, tienen mayor "fusión del yo" con otros. Los que están en este grupo se preocupan de "querer" y que "los quieran". Cuando expresan opiniones lo hacen basados en apreciaciones dogmáticas. Sus convicciones están tan mezcladas con "sentimientos" que se hacen "causas". Necesitan del apoyo de una autoridad en sus acciones u opiniones. En vez del "yo creo" dicen "fulano ha dicho", "la ciencia ha demostrado". Las familias de este grupo tienen más posibilidad de lograr una mayor diferenciación con ayuda especializada que las del grupo anterior.

Las personas que corresponden al grupo de 50 a 75, sin aquellas con opiniones más definidas. Por otra parte tienen más energía para utilizar en actividades positivas, que en buscar apoyo. Bajo suficiente presión pueden llegar a presentar síntomas físicos o emocionales, pero se recobran con mayor facilidad que las de los grupos ya mencionados.

Las personas que pertenecen al grupo de la escala de 75 a 100, son aquellas que difícilmente encontraremos en la práctica clínica. En general, son personas de principios; Bowen las llama "dirigidas desde dentro". Son personas seguras, cuyo funcionamiento no está afectado por las críticas; pero al mismo tiempo son capaces de aceptar opiniones ajenas y modificar las propias. Son totalmente responsables ante sus familias y ante la sociedad. Debido a la habilidad de manejar su sistema emocional dentro de las fronteras del "sí mismo", pueden entrar en relaciones intensas sin "la necesidad" de que el otro pueda deteriorar su funcionamiento. "El otro", en la relación, no se siente "usado". Pueden de este modo respetar el "sí mismo" y la identidad del "otro". Son libres de relajar los límites de su "yo" por el placer de compartir con el "sí mismo" de otros en sexualidad, u otras experiencias emocionales, con la seguridad de poder separarse y luego dirigirse en un curso determinado por ellos mismos.

Los grupos más bajos de la escala suelen tener serias dificultades y variaciones de funcionamiento en las diferentes áreas donde actúan: familia, trabajo, relaciones sexuales; en cambio los grupos superiores no sufren tantas fluctuaciones. Cuanto más bajo en la escala más hacen responsables a los otros de su funcionamiento y tienen menos posibilidades de comunicarse con sentido.

El tercer concepto es el que Bowen denomina "Proceso de Transmisión a través de múltiples generaciones".

De este sistema teórico surge que los padres transmiten diferentes grados de madurez a sus hijos. En la mayoría de las familias los padres transmiten parte de su inmadurez a uno o más de sus hijos. El patrón que se da en cada familia es diferente. Mientras ciertos hijos reciben la inmadurez de los dos padres, otros se desarrollan fuera de las demandas emocionales de aquellos, y adquieren un nivel de madurez más elevado.

Bowen utiliza también los conceptos de Toman, tal cual figuran en el libro de éste: "Constelación familiar". Toman presenta la tesis de que las características de la personalidad están determinadas por la posición que los hermanos tienen en cuanto a la edad, y por la constelación del grupo en cuanto al sexo se refiere. El lugar que ocupa la hija mayor de una familia numerosa le dará características diferentes a las que tendrá una hija única.

Al iniciar el trabajo con una familia es importante conseguir el mayor número de datos sobre nacimientos, enfermedades, separaciones, muertes, etc., con las respectivas fechas; para lograr pautas sobre los cambios que ha habido en continuidad de la "masa yoica familiar", de por lo menos dos generaciones. Esta información se puede obtener en una sesión con los padres. La observación de toda la familia puede darnos datos de los subsistemas y "modus operandi".

Si la familia consulta por un problema de un hijo, un estudio cronológico de la aparición de los síntomas puede indicarnos posibles causas de malestar familiar. Sentimientos y fantasías de otros miembros en el día en que los síntomas aparecieron pueden ser de utilidad.

El último concepto es el del funcionamiento de la "masa yoica parental". Esta unidad tiene su propia dinámica y se la puede comparar a un campo magnético de dos polos. Cambios en la "masa yoica parental" ocurren con el advenimiento de los hijos. Conviene, para conocer sobre el sistema de "proyección familiar", averiguar sobre las fantasías de la madre antes y después del nacimiento de un hijo. Una proyección intensa y crónica puede provocar problemas serios en un hijo. En un caso de relación simbiótica intensa entre una madre y un hijo varón con serios síntomas (encopresis, pica, falta de desarrollo del lenguaje), encontré que la madre durante el embarazo tuvo la seguridad plena que el hijo nacería con serios problemas. No había antecedentes al respecto, pues un embarazo anterior había sido normal, y el fruto

una niña que no presentaba problema alguno. Un sistema de proyección de este tipo influye seriamente en toda la familia.

La investigación continúa con el estudio de la "extensión familiar" en ambos esposos; datos, fechas, enfermedades, muertes, son importantes. De esta forma uno adquiere una idea de la "masa yoica familiar", que luego nos dará el estilo de trabajo de una familia y nos ayudará en el proceso psicoterapéutico. Es importante no señalar nuestros descubrimientos de coincidencias entre síntomas y circunstancias en las primeras entrevistas, pues puede ser suficiente para que cierta familias abandonen la consulta.

La idea básica de esta terapia es lograr que individuos de una familia consigan un más alto nivel de diferenciación del "sí mismo". Hay que tener en cuenta que el sistema familiar obstaculizará el crecimiento de un miembro, porque de alguna forma se rompe el equilibrio adquirido. "Destriangulizar" los triángulos es parte del proceso de diferenciación. Muchas veces el terapeuta tiene que elegir aquel miembro con más posibilidades de cambio y trabajar con él. Si se trabaja con la pareja, el terapeuta, que debe permanecer emocionalmente "fuera" del sistema, permite la separación del "sí mismo" de un esposo de la "masa yoica común". Bowen considera que la separación emocional del terapeuta es la "llave mágica" de los resultados positivos de esta terapia.

Trabajando con los padres, en la mayoría de los casos no hay necesidad de trabajar con los hijos, pues éstos se beneficiarán con los cambios que los padres logren.

Es tarea del terapeuta ayudar a diferenciar entre sistemas de fantasías y de realidad. Es importante que los miembros comiencen a conocer el "sí mismo" de otros en la familia. Si los dos esposos pueden hacer cambios en la relación, podrán llevar estos cambios al resto de la familia y a los otros sistemas en donde actúan.

El terapeuta puede ayudar en el proceso de diferenciación haciendo conocer su "sí mismo" a la familia. Bowen cree que un terapeuta no puede pedir que una familia haga cambios que él no ha hecho.

Es importante poder lograr que los esposos rompan ciertos círculos viciosos de acusaciones o demandas mutuas. Conviene hacerles invertir energías para que mejoren los límites del "sí mismo" (hacerle pensar en términos de "yo creo", "yo pienso", "yo opino", desterrando el hacer o el decir cosas que realmente no creen), antes que permitir que usen esa misma energía en tratar de cambiar a otros. Se trata de que sean observadores de su propio "sí mismo", y que no reaccionen a los ataques verbales de los otros miembros. Si logran esto, el "otro" posiblemente cambie y opere en un nivel más alto. Cuando el paciente entiende cómo tiene que usar su energía, no lo hará en forma de reacciones transferenciales que prolongarán el curso del tratamiento, sino que utilizará la energía para su propio análisis.

Motivo de indicación de grupo psicoterapéutico familiar

(Versión abreviada)

MARTHA FRYDMAN DE LERMAN *

En este trabajo se trata de explicitar a través de un ejemplo clínico el motivo de indicación y finalidades del tratamiento del grupo familiar con niños, al mismo tiempo que su operatividad.

Se recomienda el grupo familiar teniendo en cuenta que la patología del grupo influye esencialmente en la patología del niño y que un cambio en éste quitará una carga de ansiedad en el niño, al mismo tiempo que lo liberará para que pueda resolver su propia patología, sin el agregado de la patología parental.

En todo momento tenemos en cuenta y tratamos de descubrir cuáles son las fallas en el aprendizaje psicológico de los padres; qué cosas no han podido aprender e internalizar en su momento evolutivo apropiado y que por lo tanto no podrán transmitir a sus hijos. Por ejemplo: el juego.

Otro de los aspectos importantes es la delegación por parte de los padres en los hijos del rol de chivo emisario.

Si bien estos criterios no son los únicos factibles, son sí los más necesarios y los que más se adecúan a la patología de este grupo familiar.

Ejemplo clínico y evolución del tratamiento. Alejandro tiene 5 años de edad. Es el miembro del grupo llevado a consulta. Sus padres muestran la problemática que presenta como "un montón de trastornos afectivos con respecto a su hermana (Mónica: tres años y medio) y a nosotros". Sus síntomas son: enuresis; encopresis; se guarda cosas; imposibilidad de aceptar relaciones, ni propias ni parentales; "rabietas". La mamá tiene 32 años. El padre 48 años, es viudo y tiene dos hijos de su matrimonio anterior que no viven con ellos. Su hija tiene 22 años, es casada y tiene un hijo. El varón tiene 20 años. No los ve, y no los ayuda económicamente, a partir de un reciente quebranto comercial."

* Beruti 3489, 3º "A", tel. 85-3758, Capital Federal.

Dada la abultada sintomatología que Alejandro presenta, la terapeuta establece primero un contrato de terapia individual; la única sesión se caracteriza por el temor a un mundo persecutorio, tanto fantaseado como real por parte de Alejandro, así como de la depositación masiva del niño en la persona del terapeuta.

Alejandro es acompañado por su padre, quien luego de prometerle que se iba a quedar abandona la sala de espera. A *posteriori* de esta primera y única sesión se impone como única forma de prosecución del tratamiento la terapia de grupo familiar. Se comprueba en esa hora que los padres no pueden asumir el compromiso de un tratamiento individual. Dejar solo a Alejandro era delegar la patología familiar; dejarlo solo sabiendo que se lo daña, al mismo tiempo que dejar a un tercero (el terapeuta) que se lo arregle.

En esta familia se utiliza el rol de chivo emisario (Alejandro), para poder mantener un equilibrio inestable. Lo sienten diferente, el que trae problemas y los hace quedar mal delante de la familia extensa y de la gente que los rodea, pero no es más que el que puede mostrar la problemática familiar.

El tratamiento del grupo familiar tiene dos períodos bien delimitados:

En el primer período (2 meses): se trabaja tratando de aliviar las tensiones del intragrupo.

Alejandro consigue reducir sus propias ansiedades y agresividad, lo mismo que sus intentos de microsuicidio, al lograr resolver, aunque no totalmente, el problema del chivoemisarismo, es aceptado al igual que su hermana Mónica como hijos y no como hijos-nietos. Ya no es el que roba, como lo define el papá. Al ser aceptado como hijo ya no está robando el cariño de sus otros hijos.

El segundo período del tratamiento, que se da luego de una entrevista con los padres pedida por la terapeuta por problemas en el endo y exogrupo, es de una evolución más favorable y más rápida.

Alejandro y Mónica se han adaptado bien en el colegio; Alejandro acepta muy bien sus propias relaciones interpersonales, así como las de sus padres, la encópresis declina, lo mismo que su enuresis. El papá pudo conseguir trabajo estable y la mamá es una madre contenta y cómoda (también en las sesiones) que puede internarse en el mundo de los niños como expectadora y que puede rescatar de ese mundo lo que no comprende del mundo de los adultos.

Alejandro toma insight de las interpretaciones y logra modificar sus pautas patológicas.

En este trabajo podemos apreciar cómo con el cambio de un "error" de la terapeuta, de terapia individual a grupo familiar, este tratamiento tuvo por efecto modificar tanto la sintomatología del paciente como la del grupo familiar.

El análisis de las relaciones de dinero como técnica de abordaje para el tratamiento psicológico del grupo familiar

(Versión abreviada)

HORACIO G. MAC DOUGALL*

Se parte, en este trabajo, de una concepción antropológica, finalista, de la familia, a la cual se concibe como la matriz humana básica que debería poder entregar a la sociedad individuos integrados, capaces de amar y trabajar creativamente.

Se conceptualiza a la familia como un "sistema abierto bio-psico-social" cuyo medio ambiente es la sociedad. Se destaca la importancia del dinero, como el "bien de cambio" que rige todas las transacciones de la familia con su medio ambiente.

Se señala que el dinero ingresa al núcleo familiar investido socioculturalmente de las características simbólicas que lo hacen apropiado para constituirse como "fetiche", en el sentido dado por Freud a este término. Se destaca entonces, la importancia de que la familia pueda "metabolizar", a nivel psicológico, la carga simbólica enajenante del dinero, para poder usarlo "instrumentalmente", al servicio de fines humanos. Si esta "metabolización" no es posible, el dinero es usado "transaccionalmente" dentro del seno familiar: funciona como "encubridor" del sentido real de los conflictos del grupo, realimentándolos y ocultando por completo sus significaciones psicodinámicas originales.

El análisis de las relaciones de dinero es un recurso técnico que permite el "descongelamiento" de dichos conflictos. A tal efecto, dentro del marco referencial dado por las teorías kleinianas, que orientan el curso del tratamiento, se introducen en el mismo consignas directivas tendientes a cambiar determinados manejos de dinero dentro del grupo familiar, en aquellos lugares, en donde el mismo está encubriendo transacciones afectivas. Al efectuarse la modificación, el conflicto subyacente emerge a niveles mentales, corporales, o del mundo externo de

* Talcahuano 1038, depto. 206, Capital Federal.

las personas implicadas en la transacción, lo cual facilita su resolución con los medios terapéuticos tradicionales.

Se considera que el manejo técnico de las transacciones monetarias dentro de la familia, es un recurso terapéutico de singular importancia. Se cree que esta importancia no le ha sido concedida, debido a las dificultades de los terapeutas para encarar críticamente su manejo del dinero dentro de su propia familia y dentro del marco social en donde se inserta su práctica profesional.

Tratamiento de las crisis familiares (Versión abreviada)

BEATRIZ A. F. MORENO *

PEDRO KUSMIN **

Una familia puede funcionar de manera satisfactoria para sus miembros, hasta que un cambio o una situación crítica inhabilita sus recursos habituales. Estos recursos pueden variar desde una relación sana —que según Caplan es aquella en la que una persona significativa percibe, respeta y trata de satisfacer las necesidades del otro, en forma tal que está de acuerdo con sus respectivos roles y los valores de su cultura— a distintos grados de complementariedad neurótica, con intenso tráfico de identificaciones proyectivas masivas, predominio de conductas no verbales sobre actividades simbólicas, comunicación en ciertas áreas con exclusión de otras, etc.

En cualquier caso, una situación crítica puede funcionar tanto como una experiencia positiva de la que el grupo salga fortalecido y sus miembros hayan ganado en madurez, como un acontecimiento que lo haga más vulnerable, manteniendo su integridad mediante recursos negativos. En tal momento, la asistencia del grupo familiar es decisiva para promover una modificación saludable de sus relaciones. Nuestra búsqueda de técnicas adecuadas para realizar esta tarea nos llevó a repetir una serie de prácticas que resultaron eficaces y fueron modelando una forma constante de operar en ciertos aspectos. Resumiremos a continuación algunas ideas estrechamente relacionadas entre sí:

a) El encuadre: es importante comenzar por el profesional que tomará contacto con el grupo familiar quien tiene que estar dispuesto a brindarle un marco de seguridad, no sólo por la ausencia de críticas, sino transmitiéndole con su actitud comprensión y respeto frente al alto costo emocional que significa para tal grupo afrontar una experiencia de este tipo. Proveer el "holding" adecuado ayuda a crear el clima

* Güemes 3520, 2º "7", Capital Federal.

** Cabildo 559, P. B. "7", Capital Federal.

propicio en el que puedan ensayar la expresión de sentimientos hostiles y amorosos en una nueva forma de relación más satisfactoria. Este tipo de consulta se puede realizar en uno o varios encuentros semanales, programados y estimulados en tanto se sienta que han quedado puntos de interés, propuestos por la misma familia, sin clarificar.

La familia puede venir completa o no, los ausentes de manera permanente o transitoria son aceptados y señalados de acuerdo con el papel que jueguen. Consideramos útil ofrecer a los integrantes la posibilidad de obtener entrevistas individuales. Esto favorece y acelera notablemente la elaboración de la problemática que se realiza armónica y simultáneamente en las dimensiones individual y grupal.

b) El señalamiento, o sea la forma en que comunicamos al grupo aquello que consideramos puede serle útil, es de capital importancia ya que de él depende, en gran parte, el resultado de la consulta. Al hacer cada señalamiento es primordial tener en cuenta que nos dirigimos a un grupo muy particular, con una imbricación emocional intensa y de convivencia permanente, en el que los elementos que introducimos tendrán un efecto reverberativo y se amplificarán en una proporción cuyo cálculo está fuera de nuestras posibilidades. Por lo tanto, hemos elegido un tipo de formulación que tiene en este momento para nosotros, tres puntos de interés: qué se trasmite, cómo hacerlo, y con qué fin.

Qué se trasmite: estamos de acuerdo con Wynne en que "el foco está más en lo desconocido pero observable que en lo desconocido pero inferible".

Cómo hacerlo: destacando en primer término lo positivo de las pautas de relación y sólo después la situación dolorosa que se desea evitar con esas mismas conductas.

Con qué fin: renovar los vínculos emocionales y el restablecimiento de la comunicación al verbalizarse los sentimientos hostiles y amorosos, explicitación y comprensión de los roles que juega cada uno, con la consecuente recuperación de lo depositado en el otro y esclarecimiento de las relaciones de autoridad-dependencia.

Con respecto al fenómeno transferencial, no creemos que en este caso se justifique su explicitación. Nos interesa remarcar al respecto las diferencias que tiene el grupo familiar con otros grupos. En este caso, al estar presentes los actores cotidianos y frecuentemente históricos de la situación conflictiva, están dadas las condiciones para que el entrevistador quede libre, en gran parte, de las proyecciones del grupo y pueda funcionar como un líder democrático que apoya a cada uno de los miembros en su rol, sin restarles autonomía crítica. Además, el grupo familiar llega con un líder natural, o por lo menos culturalmente determinado —el padre— para quien la consulta de por sí, significa admitir su inadecuación. Alentar la relación transferencial favorece actitudes regresivas y consecuente dependencia del terapeuta

quien se transforma en sustituto competidor del padre. Esta situación difícilmente es tolerada por el grupo y es una de las causas más frecuentes de abandono.

Preferimos, entonces, controlar la relación transferencial y contener la reproducción dramática del conflicto, actuando como moderadores de la misma. Esto facilita la liberación gradual y posterior elaboración de la situación que interesa agudamente la relación grupal.

Según nuestro criterio la meta en el tratamiento de las crisis familiares consiste en proporcionar a la familia la oportunidad de convivir en un clima de trabajo positivo que les permita remover y aclarar los obstáculos que la han incapacitado para resolver una situación conflictiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERENSTEIN I., KALINA E., SLUZKI C. E. y BLEICHMAN H. — Psicoterapia de la pareja. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, 1968, 14, 4.
- BLEJER J. — *Psicohigiene y psicología institucional*. Buenos Aires, Paidós, 1966.
- BOSZORMENYI-NAGY y FRAMO J. L. — *Intensive Family Therapy*. Harper & Row, 1965.
- CAPLAN G. — *Principios de psiquiatría preventiva*. Buenos Aires, Paidós, 1966.
- GRIMBERG L., LANGER M. y RODRIGUÉ E. — *Psicoterapia de grupo. Su enfoque psicoanalítico*. Buenos Aires, Paidós, 1957.
- OSBERG J. W. — *Initial Impressions of the Use of Short-Term Family Group Conferences, Family Process*. 1962, 1, 2.
- RACKER H. — *Estudios sobre técnica psicoanalítica*. Buenos Aires, Paidós, 1960.
- ULLOA F. — *La entrevista operativa*. Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Buenos Aires.
- WYNNE L. C. — Some Indications and Contraindications for Exploratory Family Therapy, en *Intensive Family Therapy*, BASZORMENYI-NAGY y FRAMO J. L., Harper & Row, 1965.

**Grupo familiar
con niños**

La psicopatología del grupo familiar y el hijo adoptivo (Versión abreviada)

SUSANA M. E. BLANCO *

La adopción debe ser estudiada dentro de un esquema referencial, ubicándonos en tiempo y espacio dentro de nuestra sociedad. Al hablar del grupo familiar básico, además de sus roles o funciones específicas, en la adopción, agregamos la *proteccional*, ya que significa o pretende significar protección para un niño abandonado, y la *gratificante*, pues posibilita a los adoptantes el poder ejercer su paternidad, en la mayoría de los casos frustrada biológicamente.

Los conflictos dentro de un grupo familiar adoptivo, están íntimamente relacionados con el ejercicio de los roles y los prejuicios. En nuestro país, hasta hace pocos años, la adopción era vista como un "estigma", insistiéndose en el secreto, que no es otra cosa, que el rechazo por la esterilidad no elaborada y no solo el temor de que el niño sea reclamado por sus progenitores como se aduce.

El esclarecimiento de su real situación, en el hijo adoptivo, es fundamental para su integración plena al grupo familiar. Generalmente, hay mucha resistencia por parte de los padres adoptivos, argumentando que la "criatura es muy pequeña", que "aún no entiende", etcétera. Existe una percepción innata en el niño, por la cual tiene un conocimiento parcializado de su situación real, esto le produce un sentimiento de inestabilidad, tensión que afloja cuando conoce su realidad, por intermedio de sus padres adoptivos y no por terceros.

La motivación de los adultos hacia la adopción, obedece a varias causas: esterilidad de la pareja; padres que han perdido un hijo propio por fallecimiento; parejas con conflictos personales, en la búsqueda de una solución; los que desean un heredero a quien dejar sus bienes o una compañía para la vejez.

El niño por su parte, no elige, su tarea consiste en poder llegar a comportarse según las expectativas del grupo familiar que lo recibe. Cuando toma plena conciencia de su real situación, elaborará su duelo

* Dirección General de la Minoridad y la Familia.

(pérdida de sus padres biológicos), recibiendo así a sus verdaderos padres, aquellos que lo ampararon.

Nuestra experiencia, dentro del organismo estatal, de carácter social-psicológica-médica y legal, de tres años y medio, nos indica que los grupos familiares adoptivos, donde precozmente se ha encarado con criterio técnico, las limitaciones y conocimiento de cada caso, se ha podido equiparar el vínculo adoptivo al biológico. No se buscan padres adoptivos perfectos, sino aquellos con flexibilidad suficiente para adaptarse a la nueva situación.

También hay otros casos, con una patología muy definida y que se encuentran bajo control y en terapia, para poder ayudarles a elaborar su problemática, por ejemplo: conflictos generacionales, pautas culturales ajenas a nuestra realidad, sobreprotección, resistencia a encarar el esclarecimiento al niño, tenencias de hecho de varios años y que recién llegan a nuestro conocimiento, etc.

Conclusiones.

- 1) Encarar en forma preventiva, los posibles conflictos que surgen en la adopción, esclareciendo los trámites, a través de los medios de comunicación social.
- 2) Perfeccionamiento del estudio integral de los adoptantes, para obtener hogares adoptivos adecuados a las necesidades de cada criatura.
- 3) Organizar grupos de futuros adoptantes, para que puedan elaborar operativamente, aquellos conflictos, que les impiden aceptar al hijo adoptivo, libremente, sin engaños.
- 4) Realizar una verdadera terapia, del grupo familiar adoptivo, con la participación de todos sus miembros, cuando se plantean conflictos y hay desajustes.
- 5) Probar nuestra hipótesis: de que el hijo adoptivo, puede equipararse al biológico, dándose las condiciones de: esclarecimiento precoz de su situación real, pérdida de prejuicios y aceptación de la realidad.

La psicoterapia del binomio madre-hijo en la simbiosis patológica

EMILCE DIO DE BLEICHMAR *

1. Un hecho de observación. En psicoanálisis y en psicoterapia individual de niños es frecuente encontramos ante casos que presentan una doble dificultad. Por un lado el padre de la criatura no acuerda a la consulta y todo el tratamiento se encara, decide y resuelve sólo con la madre; y por otro lado el niño no quiere entrar al consultorio y solamente lo hace si la madre lo acompaña. Mi orientación en estas situaciones siempre había sido tratar de analizar las ansiedades del niño hasta que tolerase que su madre lo esperara afuera, pero para mi disgusto en muchos casos me encontré con una franca resistencia en la madre para abandonar el cuarto de juegos y en aquellos en que forcé la salida, se produjo la interrupción precoz del tratamiento.

Esta situación, varias veces repetida, me mostró que me hallaba frente a un pattern familiar muy estructurado: una estrecha "ligazón" entre madre e hijo, ausencia del padre y una dificultad extrema para la inclusión de un tercero. Por lo tanto, parecía que el único camino posible para poder actuar terapéuticamente para abordar ese vínculo patológico que impedía la inclusión de cualquier ajeno a la pareja simbiótica. Es decir tomar la simbiosis patológica que se presentaba como el obstáculo para la terapia, en el nuevo objetivo de la misma. Con la denominación de —simbiosis patológica— me voy a referir a todos aquellos cuadros en los cuales se presenta una dificultad de separación entre el niño y su madre, como conducta francamente observable. Es una denominación de carácter descriptivo, que no aspira a crear una nueva categoría nosológica, sino que pone de manifiesto el vínculo estrecho entre madre e hijo, el cual puede estar presente en entidades de diferente grado de patología **.

* Av. Santa Fe 3282, p. 2º, depto. B, Capital Federal.

** J. Bleger considera la "simbiosis patológica" como una alteración cualitativa de la simbiosis normal e incluye dentro de esta categoría los cuadros de autismo.

El planteo de tratar el binomio madre-hijo supone no sólo aceptar la determinación de la patología como un hecho ocurrido en el pasado e internalizado por el niño, sino como una actual y continua interacción tendiente a mantener la relación materno-filial como exclusiva.

Simbiosis normal. La exclusividad de la relación madre-hijo es propia de los primeros meses de vida del niño. En el campo psicoanalítico Margaret Malher introdujo en 1950, el concepto de simbiosis para describir "esta condición de total interdependencia del niño y su madre, quien actúa como protectora o buffer, ya que el niño carece de la capacidad para autopreservarse".³ Esta etapa constituye la fase de simbiosis normal durante la cual para el niño no habría diferenciación entre el self y el objeto, sino por el contrario una completa fusión entre él y su madre.

Pero pareciera que no es sólo el niño quien necesita y depende de su madre, sino que se trata de una real *interdependencia*, aspecto clave de la noción de simbiosis, que se encuentra tanto en la definición de M. Malher,⁶ como en la de J. Bleger.² Y esto es lo que quiero destacar, que aún en condiciones normales también la madre se halla fuertemente ligada a su hijo en un vínculo muy estrecho y que separarse del bebé y admitir un tercero es un proceso que le demanda un alto grado de elaboración psicológica.

Para avalar esta afirmación me voy a referir a los acontecimientos de la sexta semana de vida descriptos por Matilde y Arnaldo Rascovsky. Estos autores han observado que con la terminación del período puerperal se produce una crisis transitoria de la lactancia que habitualmente dura dos o tres días y que se manifiesta por una discreta hipogalaxia en la madre, con las consiguientes repercusiones sobre la lactante quien experimenta hambre, insomnio, inquietud y un evidente incremento de la ansiedad y el llanto. A su vez la sexta semana o sea alrededor de los cuarenta días posteriores al parto es el momento en que se reinician las relaciones sexuales de la pareja, interrumpidas durante el período que comprende el final del embarazo, el parto y el puerperio. Es decir que en ese momento se suspende la relación exclusiva madre-hijo, estableciéndose la organización triangular con la reinstalación de la genitalidad de la pareja.

Ahora bien, según vemos por las observaciones clínicas este momento de reorganización de la relación familiar no pasa desapercibido, ni para el niño (quien sufre las consecuencias de la disminución de la leche), ni para la madre y aquí cabría agregar tampoco para el padre.

Comencemos por la madre: el fin del puerperio implica la culminación de una serie de modificaciones hormonales que la colocan en condiciones de concebir nuevamente otro hijo y de sentirse otra vez estimulada a la búsqueda de su compañero sexual. A su vez, en aquellas mujeres que trabajan, generalmente también coincide con la reiniciación de su labor. Todo esto implica que la relación diádica

materno-filial, se rompe. Y vemos que aún en condiciones de máxima armonía conyugal y tranquilidad psicológica este cambio provoca en la mujer un alto grado de tensión que se traduce por un lado, en la hipogalaxia transitoria y por otro en dificultades en retomar tanto el ritmo sexual, como las actividades habituales. La madre siente que "abandona" a su hijo y son comunes las fantasías o los sueños filicidas. Es decir que la mujer que hasta ese momento funcionaba exclusivamente como madre, satisfecha en su relación amorosa con el bebé, siente sus impulsos genitales y la presencia de su esposo como una amenaza a la relación simbiótica y reacciona en consecuencia. En condiciones normales si sus ansiedades orales se hallan resueltas, toda esta crisis no dura más que un corto período que podríamos llamar de pasaje o ajuste de la relación diádica a la triádica. Pero creo que para que esta evolución tenga lugar de una manera adecuada, no sólo es necesario una buena elaboración previa por parte de la madre, sino que el rol jugado por el padre también es sustancial.

Es común que el esposo postergado en sus necesidades afectivas por la presencia del bebé, obligado a la abstinencia sexual del puerperio y con un papel muy secundario en el cuidado y relación con su hijo durante los primeros tiempos, reaccione a esta forzada exclusión, a su vez con un mayor distanciamiento de su mujer y del bebé (son frecuentes las relaciones extramatrimoniales iniciadas por el hombre, en estas circunstancias que rodean al embarazo y parto). Si logra superar sus sentimientos de exclusión y establecer un contacto afectivo con madre y el bebé, al actuar de esta forma se incluye como tercero convirtiéndose así en agente activo del pasaje de la relación exclusiva materno-filial a la triangular. Con ello contribuye a impedir el desarrollo de la simbiosis patológica, sentando las bases para el proceso de diferenciación-individuación. Por lo tanto, si aún en condiciones normales este ajuste o reorganización familiar es problemática, podemos pensar que si no se cumplen las condiciones anteriormente mencionadas la evolución del vínculo madre-hijo puede quedar seriamente perturbada.

O sea que la simbiosis patológica es el resultado de varios factores en juego: dificultad de la madre para elaborar la ansiedad de separación, dificultad del padre para incluirse, sin dejar obviamente de lado las dificultades que puede aportar el bebé. El peso relativo que pueden tener cada uno de estos factores variará en cada caso en particular y cuando se presentan simultáneamente en conjunción, estarán dadas las condiciones óptimas para el establecimiento de los cuadros más serios de simbiosis patológica.

Planteo terapéutico. Cuando estos casos llegan a la consulta pueden aparecer bajo dos fachadas. Puede venir la madre quejándose del "pegoteo" del niño, sufriendo por la enorme demanda que exige de ella, pero ignorando por completo su activa intervención en la deter-

minación del problema. O puede consultar una madre, por cualquier otro tipo de sintomatología infantil, como enuresis, problemas de conducta, etc., sin notar el apegamiento del niño, pues éste es totalmente sintónico con su sentir, de manera que no lo categoriza como queja. Estos son los casos que podríamos denominar de simbiosis muda, pues es detectada por el terapeuta, ya sea al levantar la historia clínica o más tarde en el consultorio cuando se intenta el diagnóstico o el tratamiento individual, sin conseguir que la madre y el niño se separen.

Pienso que en estos casos se debe tomar el binomio como objeto de la terapia y esclarecer en todo momento la estrecha *interdependencia* y la ansiedad de separación existente en ambos frente a la inclusión entre ellos de un tercero, en este caso el terapeuta, así también como todas las técnicas defensivas a que recurren ambos para mantenerlo aparte. Al actuar de esta forma el terapeuta, asume el rol diferenciador que debería haber cumplido el padre y que no pudo hacerlo ya sea por dificultad propia o porque le fue impedido por la diada madre-hijo.

Ahora bien, si he sostenido que el padre juega un rol diferenciador tan importante, ¿por qué no incluirlo en la terapia? Fundamentalmente por una razón de hecho, ya sea que el padre haya sido radiado por el par simbiótico o se haya él mismo autoexcluido, lo cierto es que está ausente, no acudiendo al tratamiento. En el caso que la ausencia del padre se deba prevalentemente a la segregación promovida por el par simbiótico, la terapia de este último puede ser una primer etapa que al romper la ligazón patológica modifique la dinámica de tal modo que en un segundo paso el padre pueda intervenir.

Por otra parte, ¿cuáles son las ventajas de la psicoterapia conjunta del binomio madre-hijo con respecto a la terapia individual? En primer lugar como he señalado al comienzo a veces se puede iniciar el tratamiento individual del niño recurriendo al método drástico de forzar la separación por cualquier medio. Pero aun cuando esta actuación terapéutica * tuviese éxito, se presenta el inconveniente de que la madre fuera del control y de la posibilidad terapéutica suspenda precozmente el tratamiento al no tolerar ella el rompimiento brusco de la simbiosis, o que sabotee la terapia a través de un reforzamiento de las conductas que mantienen el apegamiento. A su vez, el inconveniente que se presenta en los casos en que la madre acepta también ella un tratamiento individual, es decir que ambos miembros lo hagan por separado, es que el análisis de la interdependencia se hace difícil en su acceso. Y justamente, creo que ésta es la mayor ventaja de la terapia conjunta, una posibilidad de acceso muy directo a las conductas de apegamiento, a todo lo que se entiende por código gestual entre ambos miembros, que aparece muy claramente desde las primeras entrevistas

* Al decir "actuación terapéutica" no lo hago obviamente en forma peyorativa, sino que me refiero al hecho de utilizar la acción en lugar de la palabra como agente terapéutico.

y que es muy fácil tanto de observar, como de señalar e interpretar. A su vez, generalmente el vínculo simbiótico se mantiene a niveles corporales (caricias, higiene, cuidado del cuerpo) y como bien sabemos en el contexto terapéutico, todo contacto corporal está prohibido, de manera que su reproducción en la transferencia es muy difícil que se produzca, favoreciendo esto que se mantenga a nivel del objeto original.

Conclusiones.

1. Tanto en la simbiosis normal, como en la patológica, la dependencia no es sólo del niño hacia su madre, sino que se trata de una real y verdadera *interdependencia*. Cada momento de la evolución del vínculo que implique una separación es sufrido en mayor o menor grado por ambos miembros del par simbiótico.

2. El padre cumple un papel diferenciador al incluirse como el tercero en la relación diádica.

3. Los dos puntos anteriores me han llevado a la proposición de un nuevo planteo del desarrollo de la simbiosis, ya no en términos del niño o aun del niño y su madre, como fuera formulado hasta ahora, sino como producto de una determinada constelación familiar.

4. Al efectuarse el tratamiento del binomio simbiótico, el terapeuta asume el rol diferenciador que le hubiera correspondido al padre. Su acción terapéutica la ejerce creando una estructura relacional triádica que posibilita el esclarecimiento del déficit de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BLEGER J. — Simbiosis, psicopatía y manía, en A. RASCOVSKY y D. LIBERMAN: *Psicoanálisis de la manía y psicopatía*. Buenos Aires, Paidós, 1966.
2. BLEGER J. — *Simbiosis y ambigüedad*. Buenos Aires, Paidós, 1967.
3. BURNES E. MAUD y BERNARD D. F. — A Glossary of Psychoanalytic Terms and Concepts. *The Amer. Psychoan. Assoc.*, 1968.
4. BOWLBY JOHN. — Separation Anxiety. *Int. J. Psychoanal.*, 1960, 41, 2-3.
5. MALKER M. — On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation. *Int. Univ. Press*, New York, 1968, 1.
6. RASCOVSKY A. y M. — Acontecimientos de la sexta semana de vida y el comienzo de la posición depresiva. *Rev. de psicoanal.*, 1969, 24, 1.
7. WINNICOTT D. W. — The Theory of the Parent-Infant Relationship. *Int. J. Psychoanal.*, 1960, 41, 6.

La orientación psicológica de padres
como factor de cambio en las relaciones familiares
(Versión abreviada)

FANNY LEVINTON DE BARANCHUK *

La orientación para padres es un instrumento importante en psicología preventiva pero la experiencia nos muestra que los padres recurren a la orientación, sólo cuando las dificultades de sus hijos se hacen demasiado evidentes. En lugar de escuela para padres tendríamos que pensar en un re-formatorio para padres. La educación de padres es una tarea muy gratificante pero también muy difícil.

Es muy gratificante porque los resultados son evidentes a corto plazo. Es muy difícil porque aunque son muchos los padres que acuden a la escuela para padres son pocos los que tienen la valentía y la humildad necesarias para aceptar ser enseñados a ser padres.

Aspectos teóricos de la técnica. La técnica de aprendizaje adecuada para el trabajo con padres es no-directiva.

No empleamos la interpretación porque no se trata de resolver problemas profundos de personalidad sino de modificar vínculos inadecuados en las relaciones familiares provocados por el desconocimiento que tienen los padres sobre su rol de tales; sobre la influencia de los padres en el desarrollo de los hijos y sobre las necesidades del niño.

Tampoco empleamos el consejo porque el objetivo es que los padres aprendan a pensar, se estimula la participación activa de los miembros desde el principio, aclarando las expectativas, lo que favorece al mismo tiempo, el establecimiento de un vínculo de cooperación e igualdad y no de dependencia entre coordinador y miembros y de miembros entre sí, demostrando que las soluciones no son privilegio del coordinador sino que las tienen todos.

Los que los padres obtienen en los grupos de orientación no es la solución inmediata de sus problemas, sino, en primer lugar, el conocimiento de muchas cosas simples sobre sus hijos que ellos ignoraban,

en segundo que existen soluciones diversas para una misma situación y en tercero que ellos pueden intentar modificar (con las técnicas logradas) las relaciones perturbadas con sus hijos.

Los padres no aprenden solamente información sino que incorporan una modalidad, un código, un modelo de *cómo* resolver situaciones o problemas, aprenden a pensar y también piensan cuando se van a su casa, de modo que pueden resolver situaciones nuevas, de manera creativa, no estereotipada.

Aprender, de alguna manera significa un cambio de actitudes de los padres, que se logra dentro del grupo a través de la interrelación con el resto de los miembros y con el coordinador.

El cambio de actitud tiene varias dimensiones, no es solamente en cuanto a conocimiento, sino que la actitud tiene una base emocional, la experiencia tiene una connotación afectiva y es importante apelar a ella para lograr cualquier modificación.

Los padres obtienen también: a) Una perspectiva de causalidad (el discernimiento de los factores motivantes de la conducta del chico); b) Poder utilizar una conducta racional y no impulsiva; c) El conocimiento adecuado de las necesidades del niño y su respuesta a ellas; d) La aceptación de que el hijo es una persona distinta, que puede no cumplir sus propias expectativas; e) Además, la reducción de la culpa, ésta es compartida con los otros padres (todos tienen equivocaciones y errores) y porque a través del grupo los padres advierten la posibilidad de modificar su conducta, la posibilidad de reparación.

* Escuela para Padres y Educadores de Buenos Aires.

Un enfoque para el diagnóstico del grupo familiar con niños

MABEL MALDAVSKY DE BURIN *
DORA VILAR DE SARACHAGA
CAROL DUGGAN DE HOSNE

Este trabajo surge de la experiencia obtenida en el Instituto Bené Berith de Orientación Familiar, de la necesidad de proceder al diagnóstico del grupo familiar. Entre las prescripciones para abocarnos a dicha tarea, tomamos las indicaciones generales citadas por distintos autores, que son las referidas a la situación económica, lugar de residencia apartado, contradicción de los datos obtenidos, situaciones psicopatológicas específicas de la familia, etc. A ellas debemos agregar que, de acuerdo con nuestra experiencia, es de fundamental importancia la prescripción del diagnóstico del grupo familiar cuando se consulta simultáneamente por dos o más hijos, o por uno o ambos padres y uno o varios de los niños. (Si se consulta sólo por los padres procedemos a realizar entrevistas de pareja.)

El miembro enfermo es el emergente de una enfermedad familiar. Generalmente el depositario es uno solo. Si se consulta por varios miembros, sospechamos que la difusión de la enfermedad en esa familia es tal, que les resulta necesario encontrar más de un depositario de ella. Por eso señalamos la necesidad de realizar el diagnóstico familiar, no sólo para comprender mejor a los miembros que consultan, sino también para evaluar si lo indicado es la terapia de la familia como grupo.

Cuando se consulta por dos o más miembros de una familia, las posibilidades son que traigan a los miembros más sanos considerados como los más enfermos, o a los miembros que se han hecho cargo de la patología familiar. Aún suponiendo que los miembros por los cuales se consulta fueran los representantes más sanos de la familia, resulta imprescindible la entrevista familiar, que permite dar atención también a los miembros supuestamente más enfermos, y no aumentar la disociación enfermos-sanos. En síntesis, si una familia produce dos o más

miembros enfermos es necesario reunirlos para observar su funcionamiento y ver quién es quién dentro del grupo familiar.

De acuerdo con la ideología de terapia breve de objetivos limitados, que es la que se aplica en la institución a la que pertenecemos, tomamos en consideración, a los fines del diagnóstico y la orientación terapéutica, no sólo las ansiedades básicas y los mecanismos de defensa patológicos predominantes de la familia, sino también y muy especialmente, los aspectos más sanos y los mecanismos exitosos de adaptación.

Nos preguntamos qué *fantasía de enfermedad* tiene la familia al consultar, qué ayuda pretende de nosotros (*fantasía de curación*) y qué teme que le ocurra en el caso de que no mediara nuestra intervención. La fantasía de enfermedad es la idea que tiene la familia de lo que la perturba, y, es a menudo depositada la perturbación en un agente enfermante, que puede ser humano, o no humano (cambios en la situación económica, migraciones, etc.). La fantasía de curación de la familia es el anhelo de cambio y el deseo de modificar su compulsión a repetir las experiencias enfermantes. Distinguimos las fantasías de curación realistas y patológicas. Además analizamos el vínculo intrafamiliar, los roles que desempeña cada uno de los miembros, el nivel de comunicación, y la modalidad del conflicto de la familia.

A los efectos de ejemplificar nuestra modalidad de trabajo, presentamos, a continuación, la descripción y síntesis de elaboración de un caso.

La familia A está compuesta por el padre, de 42 años, ingeniero; la madre, de 40 años, comerciante; Jaime, de 15 años; Raquel, de 11; Elsa, de 9, y Mario, de 7 años, todos estudiantes. Su nivel socioeconómico es actualmente muy bueno. La madre solicitó atención para sí y para sus cuatro hijos. Los motivos de consulta fueron los siguientes: la madre se exaspera ante las peleas y rivalidades de sus hijos y piensa que para aliviarse de esa dificultad ella tendría que salir a trabajar fuera de su casa, pero también la idea de trabajar la perturba. Jaime, de 15 años, desea consultar por dificultades sexuales. Raquel, de 11 años: la madre no sabe si está enferma o sana; sospecha que puede tener perturbaciones emocionales, dado que ella siente que la abandonó cuando niña dejándola en manos de una nifera con la cual su hija tuvo co-lecho hasta los 4 años. La describe como discutiadora, rebelde, y que, en apariencia, no le tiene miedo a nada. Elsa, de 9 años, consulta porque le tiene miedo a la oscuridad y debe dormir con la luz encendida. Mario, de 7 años, es inhibido, no tiene amigos, tiene bronquitis asintomática. La madre piensa que es el que debe estar peor dado que ella sintió rechazo hacia él desde antes de nacer el niño.

Síntesis de la historia familiar. El matrimonio A está casado desde hace 20 años. Tuvieron un hijo al año y medio de haberse casado, el que falleció a los dos meses, según refieren los padres, por espina bífida. Un año después la madre embarazó de Jaime y durante ese embarazo la aquejó una fobia que le impidió salir sola a la calle durante varios años. Después del nacimiento del último hijo

* Instituto Bené Berith de Orientación Familiar, Buenos Aires.

inició tratamiento psicoanalítico individual que se prolongó durante tres años y medio, lapso en el cual desapareció su fobia. Durante esos años la familia estaba en una condición económica precaria, dado que el padre no asumía su profesión y ambos trabajaban como comerciantes. Poco después el padre comenzó a trabajar bien como ingeniero y la situación económica mejoró notablemente. Durante todo ese tiempo los padres tenían gran dificultad en aceptar a sus hijos y comunicarse con ellos. Esta situación se evidenció más dramáticamente durante el embarazo de Mario, el hijo menor, a quien quisieron abortar, ignorándolo luego como nuevo miembro de la familia. Coincidentemente con el nacimiento de Mario, Jaime, el mayor, empezó a evidenciar ataques de asma. Dos años después Jaime mejoró de su asma y Mario inició una bronquitis asmática.

Procedimientos utilizados. Procedimos a hacer el diagnóstico de cada uno de los miembros de la familia y una *entrevista familiar diagnóstica*, cuyo resumen exponemos a continuación. Esta se realizó con una entrevistadora y dos observadoras silenciosas. Sobre una mesa del consultorio había juguetes para los niños. Una de las observadoras tenía como tarea registrar el juego de los niños y la otra el diálogo verbal. La familia A se distribuye en los asientos en semicírculo y se produce un silencio inicial, con sonrisas ansiosas por parte de los niños, sonrisa "sobradora" por parte del padre y levemente en la madre, y gesto semiserio y semisonriente en Jaime. La entrevistadora da la consigna y la madre inicia el diálogo diciendo que ella fue la de la idea de que consulten todos; que nota que cuando los chicos pelean por algo ella no los aguanta, no les tiene paciencia. Dice que antes trabajaba y volvía a su casa agotada, lo cual justificaba su malhumor hacia los hijos, pero que ahora no trabaja e igual está mal. Jaime interviene diciendo que cree que es positivo que sus hermanos peleen, "es un aprendizaje para la vida", según él, y agrega que su madre, comparada con otras madres, tiene bastante paciencia. La madre admite entonces que Jaime y Elsa son más comprensivos con ella, en tanto que Raquel y Mario piensan primero en ellos mismos (hay miradas de complicidad entre Raquel y Mario). Aquí interviene el padre diciendo que, "como valor comparativo, el nuestro es un hogar bien encuadrado; mi falla está en que yo me acoplo a la falta de serenidad de mi señora; si ella tuviera más paciencia, yo también tendría más paciencia. La falla la veo en mi señora". La madre repite que también ve en ella la falla del hogar, y se produce un silencio. La madre pregunta a Elsa si no quiere decir algo, especialmente referido al padre. Elsa dice: "Con papá bien, porque nunca está en casa, y los domingos, cuando está, se lo pasa diciendo '¡qué domingo podrido!'". Todos ríen ansiosos. El padre se encoge de hombros, trata también de reír. Parece haber acusado el impacto de la observación de Elsa. Nuevo silencio que se quiebra con un muy confuso diálogo entre Raquel, Mario y Elsa, en el cual se acusan mutuamente de quitarse juguetes; Raquel alega que ella defiende siempre a Mario porque su madre protege siempre a Elsa, y Elsa acusa a Raquel y a Mario de que siempre están juntos y se dicen secretos; todo esto en un clima de diálogos cruzados, en que lo que se dice es prácticamente ininteligible. La entrevistadora trata de intervenir, señalando lo que está pasando como clima de gran confusión, con rivalidades y acusaciones, pero es interrumpida por el padre, que dice, sonriendo, que todos esos problemas son normales. La madre trata de hacerlo callar, pidiendo que no interrumpa a la entrevistadora porque le interesa lo

que ésta dice, pero el padre insiste en que la única falla es la de su mujer. La madre dice que cuando se refieren a los chicos separan siempre a Jaime, el mayor, porque tiene vida aparte con sus propios amigos y es muy maduro y reflexivo. Jaime interviene entonces diciendo que sus padres gastan mucha plata y nunca están satisfechos; dice: "Por ejemplo, Elsa tiene un reloj de diez mil pesos y ni sabe leer la hora". Nuevo clima de desorganización y confusión en la familia, que se expresa mediante voces airadas y comentarios. Elsa amaga defenderse y nuevamente lo que se dice no es claramente distinguible. La madre trata de apoyar lo que dijo Jaime, pero el padre dice que su hijo no tiene razón. En este momento Elsa pone una mano sobre la rodilla del padre, y la madre pone una mano sobre la pierna de Elsa. Aquí el padre señala que él se siente joven y exitoso, no como su mujer, aunque refiere que él tiene "un problema íntimo" con el teléfono, porque lo insulta cuando espera un llamado importante y éste no se produce. Dice que por este motivo consultó a un psicoanalista e iniciará la semana siguiente terapia de grupo, pues piensa que ésta "subirá su energía potencial de rendimiento". Se cierra aquí la entrevista familiar con la indicación de que se hará el estudio de cada uno de los miembros por lo que consultaron y la evaluación de esta entrevista, y se los volvería a ver para ver con ellos qué orientación se les daría.

La posibilidad de la terapia de la familia como grupo quedaba descartada inicialmente por la inminente iniciación de terapia grupal por parte del padre. Pensamos en realizar terapia del grupo familiar parcial (madre e hijos), pero al poco tiempo de esta entrevista inicial familiar ambos padres requirieron entrevistas como pareja por dificultades sexuales, habiendo abandonado el padre su terapia grupal. Indicamos terapia de pareja para los padres, terapia grupal para las niñas y Jaime, y terapia individual para Mario. No descartamos la posibilidad de recomendar terapia familiar, quizá después de finalizada la terapia de la pareja parental.

Conclusiones. Esta familia se presenta como un grupo fóbico en el que cada uno de sus miembros se alternan y complementan en los roles fóbicos-contrafóbicos. La depositación mayor de la fobia está hecha en la madre, y de la contrafobia, con características maníacas, en el padre. Hay un substractum básico de ansiedades confusionales en la familia, que se instrumentan como ansiedades persecutorias frente al exogrupo, configurado aquí por el equipo terapéutico. Desde ese ángulo, toda la fachada fóbica encubre un grupo relativamente aglutinado, con marcadas pulsiones incestuosas. Esta familia hace maniobras de desconcierto frente al exogrupo como mecanismos de defensa; dichas maniobras evitativas se revelan en el contexto de la entrevista en dos momentos cruciales: uno, después que Elsa pone en descubierto a su padre al contar que él dice "¡qué domingo podrido!" cuando está la familia remida, y el otro, después que Jaime muestra críticamente la actitud de sus padres que hacen gastos excesivos que igual no los dejan satisfechos.

Si tenemos en cuenta que en toda familia siempre hay identificaciones proyectivas masivas, cruzadas y múltiples, comprenderemos que hay acá un miembro de la familia, la madre, que introyectó todos los conflictos familiares y se autorreprocha de los mismos. El padre establece una complementariedad de roles con su mujer acusándola de ser la enferma de la familia, en un vínculo sado-masoquista. Jaime hace pareja con su madre mediante el rol de quitaculpas, defendiéndola de sus

autorreproches y de las acusaciones del padre. Los chicos se alternan en los roles de víctimas y victimarios.

Jaime no se ve como hijo, y por consenso familiar, parecería que junto con sus padres formarían un triángulo parental. Jaime tiene el rol psicológico de la familia; es quizá la persona más sana del grupo. El padre es el líder económico y, junto con Mario, creemos que es uno de los miembros más enfermos de la familia.

El temor de esta familia es el aumento de las pulsiones incestuosas que se evidencian en las parejas formadas por la madre y Jaime, Raquel y Mario, y Elsa y el padre.

La fantasía de enfermedad de la familia encuentra su vocero en el padre, que halla como agentes enfermantos de la familia a Mario y a la madre, pero sostiene que de todos modos es una familia normal. La fantasía de enfermedad que trae Jaime es más realista, y se manifiesta como la dificultad que tiene esta familia en obtener satisfacciones con aquello que codician, y que una vez poseído es desvalorizado y denigrado. Por ejemplo, en el contexto de la entrevista familiar esto se vio cuando los niños pelecaban acerbadamente acerca de los juguetes que se disputaban en la casa, y no podían utilizar los juguetes que tenían a su disposición en el consultorio.

La fantasía patológica de curación está expresada por el padre en términos de modificar a los agentes enfermantos de la familia (madre y Mario); la fantasía de curación más realista está expresada por la madre en el anhelo de redistribución de los roles entre los miembros de la familia y de elaboración de la disociación enfermos-sanos.

Estudio comparativo del dibujo "Mi familia" en 20 preescolares con presencia o ausencia de trastornos de conducta

B. GARCÍA CASAL
F. E. MOISIN
E. H. PONTORIERO *

Dado que el presente aporte libre no está centrado en la observación directa del grupo familiar sino en la observación mediatizada de su representación gráfica en los niños guarda escasa relación con la mayoría de los aportes a este congreso. Los autores consideran, no obstante, que junto al progreso que representa la observación del grupo familiar como el legítimo punto de partida no debe descuidarse la continuación de investigaciones que parten de la observación de un miembro en particular a través de una prueba psicológica determinada.

El dibujo de la familia, desde hace casi cuatro décadas, es incluido en las baterías diagnósticas infantiles formando parte de una consigna compuesta o única. Así, Appell¹ en 1931 proponía que el niño dibujara una casa, una familia, animales; Minkowska² en 1947 y 1952 pide "yo, mi familia, mi casa"; Porot³ en 1952 solicita "Dibuja a tu familia" y Corman⁴ en 1961 indica "Dibújame una familia". Le corresponde a Porot, sin embargo, el mérito de haber señalado por primera vez cuáles son las condiciones necesarias para que una técnica proyectiva pueda formar parte de un plan de investigación: "Una buena técnica proyectiva es la que permite al sujeto proyectar su personalidad global, consciente e inconsciente a la vez, sobre un material poco estructurado, para no deformar ni limitar la proyección, pero que, al mismo tiempo, permita más tarde, a través de este material, el análisis de la personalidad y su comparación con los resultados experimentales proporcionados por otros sujetos sobre el mismo material. El dibujo de la familia nos parece más adecuado que la mayoría de las demás pruebas estudiadas, por responder a estas dos exigencias bastante contradictorias"⁵.

* Investigadores miembros del Centro de Neurología y Psicología Aplicada, Lezica 3902, Buenos Aires.

Respecto de las señales sensorio-motrices-gráficas que deben tenerse en cuenta para el estudio de los resultados es necesario destacar los aportes que iniciados por Porot fueron continuados por Corman en 1961. El primero "para extender el análisis la síntesis de los resultados obtenidos más lejos de lo que suele hacerse"¹ describe, entre otras, las omisiones, la ubicación izquierda-derecha, la estatura proporcional, el orden de prioridad y los diversos grados de imperfección en la representación como aspectos que tomados en su conjunto permiten arribar a la "valorización y minimización de los diversos personajes"². El segundo, al retomar y profundizar los mismos objetivos —valorización y desvalorización del personaje principal— agrega, entre otras, las adiciones de animales, la distancia entre personajes, la posición central.

Deseamos detenernos, por último, en un aspecto que interesa a Corman de manera especial en relación con el personaje más valorizado y lo lleva a decir "el dibujo de ese personaje es ejecutado con mayor esmero. Sus rasgos son más acabados, no falta ningún detalle y por ello, si se lo considera aisladamente, según la escala de Goodenough, se le asignará un número de puntos superior al que obtengan los otros monigotes del dibujo"² y "a veces la escotomización se produce con respecto a una parte del personaje, omitiéndose, como ocurre por lo común, los brazos o detalles del rostro"². Resulta lamentable, sin embargo, que tal observación no haya sido aplicada de manera sistemática a los 67 casos estudiados en su libro. En un trabajo anterior³ estudiamos la incidencia de los aspectos emocionales sobre los puntajes totales obtenidos por los niños cuando se utiliza la escala de Goodenough⁴ para evaluar los dibujos de la figura humana en respuesta a la consigna verbal de Machover⁵.

La presente comunicación tiene por objeto el estudio de las posibles vinculaciones entre los trastornos de conducta manifestados por un grupo de 10 niños en su jardín de infantes —grupo secundario— y los dibujos de sus familias respectivas —representación gráfica del grupo primario.

Material y método. La observación de la conducta de los niños en el ámbito escolar por parte de los maestros y el registro de los resultados mediante cuestionarios confeccionados especialmente para seleccionar grupos diversos respecto de una determinada variable, constituye un método tradicional en la investigación psicológica. Siguiendo idéntico criterio se aplicó a los maestros un cuestionario que indaga algunos aspectos de la conducta en el jardín de infantes de los niños estudiados. En el mismo se requirió la opción entre las respuestas A o B de cada uno de los ítems que se señalan a continuación.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Actitud frente al trabajo | A. Muy buena disposición. Encara entusiasmada la tarea. |
| | B. Trabaja obligado y debe ser estimulado constantemente. |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. Grado de responsabilidad | A. Muy responsable. Capta inmediatamente la importancia y sentido de la tarea. |
| | B. No tiene sentido de responsabilidad. Acepta o rechaza la tarea arbitrariamente. |
| 3. Confianza en sí mismo | A. Muy seguro de sí y toma decisiones en consonancia con ello. |
| | B. Muy inseguro. Nunca toma una decisión por sí mismo. |
| 4. Estabilidad emocional | A. Reacciona siempre adecuadamente. Puede expresar sus sentimientos. Muy equilibrado. |
| | B. Sus reacciones no son adecuadas. No puede expresar sus sentimientos. Inestable. |
| 5. Relación con el maestro | A. Muy colaborador. Siempre dispuesto a intervenir en distintas actividades. |
| | B. Se resiste a colaborar. |
| 6. Relación con los compañeros | A. Se integra muy fácilmente. Es apreciado en su grupo. |
| | B. Prefiere estar solo. |

De la tabulación de las respuestas B —indicadores de desajuste emocional— y distribución de las frecuencias de las mismas para cada niño fue posible establecer tres grupos diferentes: el grupo I que incluye a 11 niños que a través del cuestionario de los maestros fueron caracterizados por la ausencia de trastornos de conducta (ausencia de respuestas B); el grupo II que incluye a 46 niños que fueron caracterizados por la presencia en grado leve de trastornos de conducta (de 1 a 3 respuestas B); el grupo III que incluye a 14 niños que a través del cuestionario de los maestros fueron caracterizados por la presencia en grado acentuado de trastornos de conducta (de 4 a 6 respuestas B). Simultáneamente los 71 niños fueron examinados por una batería de pruebas y de la misma fueron seleccionados, para el presente estudio, los registros gráficos del test "Mi familia" de 10 niños correspondientes al grupo III y de 10 niños correspondientes al grupo I (grupo control).

Finalmente se administró a los padres de los niños de ambos grupos otro cuestionario que requiere, entre otras, la opción entre las respuestas A o B de cada uno de los ítems mencionados más arriba (en el ítem 5 "relación con el maestro" se substituyó por "relación con los padres" y el ítem 6 "relación con los compañeros" quedó substituido por "relación con los amigos").

Resultados. De los registros gráficos del test "Mi familia" de los 10 niños del grupo III y de los 10 niños del grupo I (control) fueron estudiados los siguientes aspectos: 1. la respuesta inmediata a la consigna "Dibuja a tu familia"; 2. la correspondencia entre la familia real y la familia dibujada y sus respectivas omisiones y adiciones; 3. el

conjunto padre-madre-hijo mediante las siguientes señales sensorio-motrices-gráficas: *a.* distancia gráfica entre los padres y el sujeto, *b.* ubicación izquierda-centro-derecha y, *c.* las relacionadas con la representación de los rasgos humanos aplicando la escala de Goodenough a los dibujos del padre, madre y sujeto.

CUADRO 1
Respuesta inmediata a la consigna

	Grupo I	Grupo III
Niños que dibujaron inmediatamente a su familia	10	6
Niños que no dibujaron inmediatamente a su familia	—	4
	N = 10	N = 10

En primer lugar (cuadro 1) se observa que todos los niños pertenecientes al grupo I dibujaron inmediatamente a su familia en comparación con sólo 6 niños del grupo III. Aplicando la prueba de probabilidades exactas de Fisher la diferencia entre ambos grupos (10 y 6) es estadísticamente significativa ($P = 0.04$ menor que 0.05) a un nivel del 5 % trabajando con una hipótesis unidireccional.

CUADRO 2
Correspondencia entre familia real y familia dibujada

	Grupo I	Grupo III
Dibujaron a todos los miembros	8	2
No dibujaron a todos	7	8
	N = 10	N = 10

En segundo lugar (cuadro 2) se observa que muy pocos niños de ambos grupos dibujaron a su familia completa y la diferencia entre ambos grupos (3 y 2) no es estadísticamente significativa ($P = 0.4$ mayor que 0.05) aplicando la mencionada prueba de Fisher.

CUADRO 3.1
Distancia gráfica entre los padres y el sujeto

	GRUPO I		GRUPO III	
	Padre-Sujeto	Madre-Sujeto	Padre-Sujeto	Madre-Sujeto
Más cerca	4	6	1	9
Más lejos	6	4	9	1
	N = 10	N = 10	N = 10	N = 10

En tercer lugar (cuadro 3.1) se observa que tanto los niños del grupo I como los niños del grupo III se dibujaron más cerca de sus madres (6 y 9) que de sus padres (4 y 1), aunque tal diferencia no resultó estadísticamente significativa ($P = 0.14$ mayor que 0.05). Sin embargo, dentro de cada grupo en particular, las distancias difieren entre sí: en el grupo I la diferencia de distancia entre Padre-Sujeto y Madre-Sujeto (4 y 6) no es estadísticamente significativa (P mayor que 0.05), mientras que en el grupo III 9 niños se dibujaron más cerca de su madre que de su padre y dicha diferencia es estadísticamente significativa ($P = 0.0007$ menor que 0.05) aplicando la misma prueba de Fisher.

CUADRO 3.2
Posición izquierda centro-derecha

POSICIÓN IZQUIERDA

	GRUPO I			GRUPO III		
	Padre	Madre	Sujeto	Padre	Madre	Sujeto
sí	6	1	—	5	2	1
no	4	9	10	5	8	9
	N = 10	10	10	10	10	10

POSICIÓN CENTRAL

	GRUPO I			GRUPO III		
	Padre	Madre	Sujeto	Padre	Madre	Sujeto
sí	1	4	4	1	8	—
no	9	6	6	9	2	10
	N = 10	10	10	10	10	10

POSICIÓN DERECHA

	GRUPO I			GRUPO III		
	Padre	Madre	Sujeto	Padre	Madre	Sujeto
sí	2	3	1	2	1	4
no	8	7	9	8	9	6
	N = 10	10	10	10	10	10

En cuarto lugar (cuadro 3.2) las diferencias observadas entre el grupo I y grupo III para las diversas posiciones en que fueron dibujados los personajes no son estadísticamente significativas con excepción de la diferencia en la *Posición central* entre Madre-Sujeto (4 y 4) del grupo I y Madre-Sujeto (8 y 0) del grupo III que es estadísticamente

significativa ($P = 0.03$ menor que 0.05). En cuanto a cada grupo en sí solamente son estadísticamente significativas la diferencia en la *Posición izquierda* entre el padre y la madre (6 y 1) del grupo I ($P = 0.02$ menor que 0.05) y la diferencia en la *Posición central* entre el padre y la madre (1 y 8) del grupo III ($P = 0.002$ menor que 0.05).

CUADRO 3.3

Resultados totales en el test "Mi familia" correspondientes a las representaciones gráficas de padre, madre y sujeto

	PADRE		MADRE		SUJETO	
	Grupo I	Grupo III	Grupo I	Grupo III	Grupo I	Grupo III
Puntaje total promedio según escala Goodenough $N_I = 10$ y $N_{III} = 10$	14	8.6	14.8	9.2	12.7	6.7

En quinto lugar (cuadro 3.3) se observa que en la representación gráfica del *Padre* la diferencia entre las medias aritméticas de los grupos I y III (14 y 8.6) es estadísticamente significativa (el cociente t obtenido = 3.67 es mayor que la t crítica = 2.88 a un nivel de significación 0.01 para 18 g.l.). Además, en la representación gráfica de *Madre* la diferencia entre las medias de los grupos I y III (14.8 y 9.2) es estadísticamente significativa (el cociente t obtenido = 2.94 es mayor que la t crítica = 2.88 a un nivel de significación 0.01 para 18 g.l.). En cuanto a la representación gráfica del *Sujeto* también la diferencia entre las medias de los grupos I y III (12.7 y 6.7) es estadísticamente significativa (el cociente t obtenido = 5.6 es mayor que la t crítica = 2.88 a un nivel de significación 0.01 para 18 g.l.).

Comentario. Mediante el cuestionario a los maestros fue posible seleccionar dos grupos de niños que difieren entre sí en lo que concierne a algunos aspectos de su conducta diaria en el grupo secundario —jardín de infantes—. Así, el grupo I presenta buena disposición frente a sus tareas, son responsables, seguros de sí, equilibrados, colaboradores con el maestro y se integran fácilmente con los otros niños (ausencia de respuestas B). El grupo III, en cambio, trabaja obligado, no tiene sentido de responsabilidad, inseguro, inestable, no colabora con el maestro y preferentemente está solo (4 a 6 respuestas B).

No obstante, ambos grupos en su conjunto presentaron las siguientes características comunes: 1. edad cronológica promedio 5 años 7 meses; nivel de madurez promedio *Normal* en el Test Metropolitan Madurez (con una media aritmética promedio de 68.20); una edad mental promedio de 7 años de acuerdo al baremo de Goodenough para el dibujo de la figura humana.

Ahora bien, dado que nos interesó estudiar las posibles vinculaciones entre tales trastornos de conducta observados en los niños del grupo III y las representaciones gráficas de sus familias respectivas, pasamos a continuación a comentar las diferencias observadas en los aspectos estudiados.

1. *Respuesta a la consigna:* ante ésta los niños del grupo III no pudieron ofrecer de inmediato una representación gráfica adecuada a sus familias respectivas en comparación con la totalidad de los niños del grupo I. Los dibujos sustitutivos —"Familia de Vibora"—, "Una cama", "Familia de Cowboys" y "Familia Telerín"— constituyen representaciones simbólicas del concepto "Mi familia" en los cuatro casos que determinan la significación estadística de las diferencias entre ambos grupos. Dado que las respuestas de los mismos niños ante una repetición de la consigna mostraron representaciones gráficas adecuadas de sus familias respectivas, la dificultad puede considerarse temporaria y expresa la incidencia de un proceso inhibitorio que determina el pasaje de un estadio representativo gráfico a otro anterior en respuesta al significado de la consigna "Mi familia".

2. *Correspondencia entre la familia real y dibujada:* muy pocos niños de ambos grupos pudieron dibujar a todos los miembros de su familia y las omisiones en la mayoría de los casos es la correspondiente a los hermanos. En cuanto a las adiciones es necesario destacar que mientras en el grupo I son personajes completos y humano desde el punto de vista representativo gráfico y verbal ("Tía", "Abuelo", "Primo", "Muchacha") en el grupo III adoptan formas diversas y contradictorias (la mamá "perro", la hija "cartera de la mamá", el hermano "un huevo de Pascua... crecen... va a crecer una planta") correspondientes a un estadio representativo simbólico anterior.

3. *El conjunto padre-madre-hijo:* el estudio fue realizado mediante las siguientes señales sensorio-motrices-gráficas: *a.* distancia gráfica entre los padres y el sujeto, *b.* la ubicación izquierda-centro-derecha y, *c.* las relacionadas con la representación de los rasgos humanos aplicando la escala de Goodenough. Tanto Porot como Corman coinciden en que son señales que tomadas en su conjunto permiten llegar a la valorización del personaje principal (signo positivo: menor distancia, posición izquierda y central, mayor "esmero" en su dibujo; signo negativo: mayor distancia respecto del sujeto, posición derecha, menor "esmero" o menor puntaje). De la comparación de los resultados apoyándonos en la dirección que determinan las diferencias estadísticamente significativas llegamos a la siguiente descripción:

En el grupo III el personaje más importante es la madre: se encuentra a menor distancia del sujeto, siempre en posición central y su representación gráfica es más completa (X 9.2 según Goodenough). Le sigue en orden de valor el padre —aunque significativamente desva-

lorizado respecto de la madre— dadas las relaciones inversas observadas: se encuentra a mayor distancia del sujeto, nunca en posición central y su representación gráfica es levemente menos completa (X 8,6 según Goodenough). No obstante es dibujado en posición izquierda. A pesar de ello el personaje más desvalorizado es el que surge de las representaciones gráficas que los niños hacen de sí mismos. El sujeto nunca aparece en posición izquierda ni central y sí predominantemente a la derecha.

En el grupo I aunque la madre es también el personaje más importante la situación es completamente distinta: no surge de los resultados observados una diferencia tan brusca en el grado de valorización para los 3 personajes. Así, casi no se observan diferencias respecto a la distancia menor entre los padres y el sujeto, el padre está significativamente en posición izquierda y la posición central es igualmente partida por la madre y el sujeto. Los puntajes obtenidos de acuerdo a la escala de Goodenough para la figura de padre, madre y sujeto guardan la misma proporción entre sí (14, 14,8 y 12,7). En ambos grupos de niños la proporción de sexos es idéntica (7 varones y 3 mujeres).

Conclusiones. Del estudio realizado se comprueba una estrecha vinculación entre los trastornos de conducta manifestados por un grupo de 10 niños en su jardín de infantes —grupo secundario— y los dibujos de sus familias respectivas —representación gráfica del grupo primario—. En éstos cuya conducta es siempre una respuesta opuesta a la esperable (ausencia de interés, irresponsables, inseguros, inestables y prefieren estar solos) tal vinculación adopta, en comparación con el grupo control, las características siguientes:

a) Un predominio de representaciones simbólicas en respuesta al significado parcial o total de la consigna. Ello se observa en las representaciones sustitutivas descritas en los puntos 1 y 2 del comentario.

b) La manifestación de un estadio inferior en la representación gráfica del concepto de padre, madre y sujeto tal como surge de los puntajes obtenidos mediante la escala de Goodenough (cuadro 3.3). Los rasgos humanos ausentes de estos dibujos y determinantes del descenso son los que se refieren preferentemente a los ítems de ojos, nariz, boca y brazos. Según un trabajo anterior² todos los niños de los dos grupos habían dibujado estos cuatro rasgos en el test de Machover.

c) El predominio anómalo en la valorización de la madre como el personaje principal y la correlativa desvalorización atribuida a las representaciones gráficas del padre y del niño mismo tal como surge del estudio del punto 3. del comentario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APPELL N. — Drawings of Children as Aid to Personality Study. *Am. J. Orthopsych.*, 1961, 129-4.
- CORMAN L. — *El test del dibujo de la familia*. Buenos Aires, Kapelutsky, 1967.
- GARCÍA CASAL B. y PONTORIERO E. — Evaluación cuantitativa de los aspectos emocionales en el dibujo de la figura humana. *Actas del III Congr. Intern. Med. Psicósom.*, Buenos Aires, 1970.
- GOODENOUGH F. — *Test de inteligencia infantil por medio del dibujo de la figura humana*. Buenos Aires, Paidós, 1965.
- MACHOVER K. — Dibujo de la figura humana: un método de investigar la personalidad, en ANDERSON y ANDERSON: *Técnicas proyectivas del diagnóstico psicológico*. Madrid, Rialp, 1963, 393.
- MINKOWSKA F. y MIKOWSKI E. — La Psychopathologie Infantile et le Test de Rorschach. *Evol. psych.*, 1947, 65-133.
- MINKOWSKA F. — La Typologie Constitutionnelle vue a Travers le Rorschach et le Dessins d'Enfants. *Rev. de Morpho-phys. hum.*, 1952.
- POROT M. — Le Dessin de la Famille. Exploration par le Dessin de la Situation Affective de l'Enfant dans sa Famille. *Pédiatrie*, 1952, 3.
- POROT M. — *La familia y el niño*. Barcelona, Mirale, 1969.

madre es ansiosa y su unión con el padre se basa en su rol complementario "tranquilo" (éste niega omnipotentemente la realidad). A partir del tratamiento de ambos padres se logra la derivación de J. a una institución asistencial y la internación de la abuela en una institución adecuada.

El significado común de los distintos datos acá expuestos lo da el hecho de tener la familia —en cada uno de sus miembros y expresándolo en su totalidad— la imago interna de un continente madre dañado y culpógeno. Esto se ve dramatizado claramente en el tipo de vivienda elegidas y en la dificultad de sacar a la abuela psicótica de la casa (en un intento reparatorio maniaco). Esta imago materna no permite la diferenciación y autonomía genital.

Lo antedicho se manifiesta en la cohabitación de toda la familia hasta hace año y medio, y es dramatizado por J. en su criptorquidia, así como en los conflictos en las relaciones sexuales de los padres.

La defensa predominante es la identificación proyectiva masiva y consecuente control en los miembros de la familia que aparecen como los más enfermos. La evacuación de uno de los depositarios, la anciana, y la depositación de J. en un servicio psiquiátrico, son temidos por significar la pérdida de control sobre los objetos internos sádicos enloquecedores. De modo paralelo aparece en J. el empeoramiento cuando no puede en su fantasía controlar a la pareja parental afuera. Durante la cohabitación J. proyectaba y controlaba omnipotentemente en sus padres la pareja interna en coito sádico atacante. Al interrumpirse la cohabitación proyecta esta misma pareja sobre objetos inanimados (bultos que se mueven de noche, tijeras que se le clavan en la espalda, etc.) configurándose así su sintomatología delirante; el control obsesivo omnipotente de esta pareja proyectada se exterioriza clínicamente en los rituales. Vemos entonces cómo el aglutinamiento cumple una función de defensa para evitar una mayor irrupción de los vínculos arcaicos con el núcleo aglutinado y objetos destruidos, persecutorios y culpógenos que cada miembro deposita en otros.

La sintomatología del niño no es tomada en cuenta mientras permite el funcionamiento de estos mecanismos. Solicitan su atención sólo cuando el cuadro que presenta es de tal magnitud que impide la operatividad grupal de las defensas maníacas.

Las instituciones y el vínculo terapéutico funcionaron como continentes logrando muy parcialmente una dosificación de la ansiedad y consecuentemente una reorganización de la dinámica grupal en un nivel que puede permitir una mejor integración: a partir de la terapia a los padres, la derivación de J. a una institución asistencial y la internación de la abuela, mutan gradualmente los roles familiares estableciéndose un nuevo equilibrio dinámico en el cual los otros hijos comienzan a ser objeto de preocupación.

Funcionalidad del niño psicótico en la familia

(Versión abreviada)

JUANA B. DE GUITER
BEATRIZ BLANCK DE BERGER

(Sobre un caso clínico atendido en la Primera Cátedra de Pediatría,
Sala VI, Hospital Clínicas, jefe profesor doctor Elizalde,
Departamento de Psicoprofilaxis
a cargo de la doctora Martha Beker.)

Numerosos aportes demuestran que el enfermo mental es un emergente del grupo familiar y cumple en él una función semejante a la del síntoma en el individuo, logrando la preservación del equilibrio dinámico. La estereotipia y consecuente enfermedad depositada en uno o más miembros surge cuando la familia no cumple adecuadamente la función de contener y ayudar a elaborar las ansiedades psicóticas de sus integrantes. Desde un punto de vista grupal familiar, el rol de cada uno y pautas de conducta tales como la introducción forzada de nuevos miembros, elección del habitat, interacciones con otros grupos, son aspectos dinámicamente vinculados a la fantasía inconsciente común en actividad.

En el caso presentado para ilustrar estos conceptos la consulta es motivada por la enfermedad de J., de 11 años, quien manifiesta ilusiones psiquiátricas de contenido persecutorio, excitación, insomnio, rituales y además padece de criptorquidia. En la familia hay también una niña de 14 años y un varón de 8. Vive con ellos la abuela paterna, enferma de arteriosclerosis cerebral, que presenta un cuadro demencial. El comienzo de la convivencia con ésta coincide con el empeoramiento de los síntomas de J. (hace un año y medio). Es interesante destacar que esta familia se ha obligado a sucesivas mudanzas, compartiendo viviendas antiguas y deterioradas con familiares enfermos y ancianos, ante la imposibilidad de vivir solos. En el momento de la consulta, la abuela y J. aparecen como los "locos" de la familia, y se atribuye a la presencia de la primera en la casa, la enfermedad del segundo. La

**Comentario de entrevistas realizadas a dos familias
con niños mellizos
(Versión abreviada)**

LIDIA KORNBLIHT DE RAVASCHINO *
RAQUEL SOIFER **

Tuvimos oportunidad de realizar entrevistas diagnósticas a dos familias distintas, ambos con niños mellizos del mismo sexo y distinta apariencia. Ambos grupos fueron coordinados por la doctora Soifer y observados por la doctora Ravaschino.

La familia B, compuesta por padre, madre, dos mellizos varones de 7 años —J y L— y otro, C, de 4 años, consultó por trastornos de conducta y aprendizaje. Los mellizos concurren al mismo grado, el menor a jardín de infantes; todos al mismo colegio.

Al llegar los mayorcitos se ubican, el padre acomoda a C, la madre dirige la actividad, da indicaciones, habla de continuo, invade. El padre permanece callado. L amasa plastilina moviendo la mesa y perturbando el juego de todos. La coordinadora señala la sensación que tienen de que alguien les mueve el piso, se ve a los padres trabados para ayudarlos. Posiblemente están todos asustados por la entrevista. C dice que hizo una selva, pero que los animales no hacen nada. L vuelve a perturbar; la terapeuta señala nuevamente la no intervención de los padres. Estos intervienen y brindan a L un lugar aparte para amasar plastilina y hace una canastita con huevitos. La madre vuelve a asumir el rol de directora, tras lo cual se produce una gran confusión, los chicos tiran los juguetes sobre la mesa y los mezclan. J se defiende poniendo límites, hace un cerco y coloca animales adentro. C juega solo en un rincón de la mesa. L con los pies apoyados sobre el travesaño de la mesa la mueve imperceptiblemente hasta que hace caer todos los juguetes de la misma. Sus hermanos reaccionan con gritos de fastidio y actitud de desesperanza. La terapeuta señala que el mover el piso a los demás es un método especial para buscarse una ubicación. Los padres confirman que no se habían dado cuenta de lo

qué pasaba, que es muy semejante a como se aman los líos en casa, así, en forma solapada. Mientras, C se ha ido a dibujar al lado de la mamá que lo sobreprotege.

Al finalizar la sesión, la coordinadora explicita lo observado en cada niño, los padres muestran gran dificultad en escucharla; los chicos vuelven a pelearse y finalmente deshacen lo modelado en plastilina. Una vez que se fueron, la terapeuta comprueba que se llevaron una pequeña fosforera que estaba en la sala de espera. Posteriormente, los padres la reintegraron, diciendo que no pudieron saber cuál de los niños se la había llevado, aunque tenían la impresión que fueron los mellizos complotados entre sí.

La técnica de grupo familiar, facilitó en este caso la secuencia especial de la movida de piso solapada, como expresión de la situación de máxima ansiedad. También permitió observar y ayudar a entender los mecanismos de defensa de los padres, básicamente, la negación ante la potenciación de la ansiedad de sus hijos mellizos.

Estudiaremos ahora la entrevista con la familia K, integrada por padre, madre y dos varoncitos mellizos de cuatro años, D. y P. Consultaron por bronquitis reiteradas y terrores nocturnos.

Cuando la coordinadora los hace pasar D. dice: "¿Vos sos la doctora?" "¿me das agua?". El pedido es satisfecho. Juegan un rato, D se va al lado de la madre, juega con ella quien se presta de buen grado en tanto P. juega solo. La coordinadora muestra esto y P. se acerca a la madre tendiéndole un trozo de plastilina. Los padres confirman lo observado admitiendo que la madre tiende a concentrarse en D. quien se está quejando de no poder amasar la plastilina, mientras P. lo hace tranquilamente. Señalado esto la madre empieza a hacerles pulseritas, con lo cual el padre queda aparte. Se menciona y el padre se integra al juego.

De este material se puede observar cómo la tendencia de ambos niños, expresada por D., es buscar una mamá propia para sí. Primero lo hace con la coordinadora, negando para ello el temor a lo desconocido y luego con la mamá que se muestra muy dispuesta a favorecerlo en esa fantasía, evidenciando como lo sintió la coordinadora frente al pedido de agua, la enorme dificultad de dividirse entre dos niños pequeños, coincidentes en el mismo momento evolutivo y con ansiedades y necesidades idénticas. De este modo, al concentrarse en D. establecía una división que le servía de defensa frente a esta ansiedad. Consideramos que esta conducta tiene relación con la asumida por la señora B. que dirigía a todos. El mecanismo en común es la división y la negación. Al controlar a un niño —señora K.— o a toda la familia —señora B.—, dejaban de lado, negándola, una parte de la realidad, nada menos que la necesidad de individuación de cada niño y su libre expresión. Pensamos que esta negación se vincula a su vez con la imagen persecutoria, solapada, especular, dramatizada por L.

También pudo observarse en ambas familias, la tendencia del pa-

* Centro de Salud nº 1, OSE.

** Asociación Psicoanalítica Argentina. Centro de Salud de San Isidro.

dre a mantenerse aparte, que atribuimos a un mecanismo de defensa, resultante de la ansiedad resultante de la duplicación.

Se nos planteó entonces, el drama de los progenitores de niños mellizos: cómo hacer para responder en forma adecuada a las demandas y necesidades de dos niños en iguales condiciones y situación. La tendencia de las madres en el estudio de estos dos casos era refugiarse en el aspecto narcisista infantil de la personalidad; la mamá B. con sus directivas como una nena jugando a la maestra, tratando a sus hijos como nenitos que le iban a hacer caso. La señora K. en forma mucho más dramática —entendemos que la edad de los niños se prestaba para ello—, jugando con D., confeccionando pulseras como si fueran dos nenas, para él y para P. Cada mellizo vive al otro como un rival especular, como alguien igual a él mismo, pero que en lugar de ser amigo es un enemigo constante en cada una de las situaciones vitales.

Entendemos que la posibilidad dada por los juguetes, al vehiculizar la expresión de los contenidos preverbales y la observación directa de la interacción familiar, constituyen los elementos que facilitan el acceso a la investigación de situaciones especiales, como así también permiten brindar ayuda a los padres, cumpliéndose así una tarea psicosocial valiosa.

Elección de la psicoterapia de grupo familiar con niños. Posibilidades que ofrece en la práctica clínica

(Versión abreviada)

GRACIELA F. DE RESNICOFF *

Al enfrentarnos con el problema de la salud mental, se hace cada día más evidente la necesidad de tomar como unidad de estudio, no ya al individuo aislado sino al grupo al que pertenece y del cual es emergente. En el caso de ser el paciente un niño, la importancia de toda esta dinámica se acrecienta notablemente: su yo inmaduro se hace más fácilmente cargo de las proyecciones, existe una dependencia real con respecto a su ambiente y, además, habiendo sido traído a la consulta por sus padres, depende enteramente de ellos para la prosecución del tratamiento.

Hay circunstancias en que esta problemática, común a todos los tratamientos psicológicos infantiles, se agudiza: niños en cuya historia vital advertimos severas interferencias externas que nos plantean una urgente necesidad de modificación. En estos casos, comenzar una psicoterapia a nivel individual resulta inoperante; cada vez que el niño reingresa al medio familiar se cierra el circuito patológico, entrando en un proceso de realimentación de la enfermedad.

Frente a estas dificultades hemos encontrado de especial utilidad recurrir a una modificación del encuadre y tomar en tratamiento no ya al niño aislado sino al grupo familiar, y cuando esto no nos resultó posible a la pareja madre-hijo.

Trataré de ejemplificar esto mediante la presentación de material clínico.

Fui consultada por una niña de 7 años, la llamaremos Marcela, cuyos padres, de alrededor de 40 años, se quejaban de su excesiva dependencia. Comprendí que se trataba de una pareja con buen nivel de información, quienes no obstante bloqueaban, coartaban la autonomía de la niña. Los otros dos hijos del matrimonio eran adolescentes y las posibilidades derivadas de su edad amenazaban la cohesión

* Consejo Argentino de Mujeres Israelitas, Buenos Aires.

de la familia. Esta problemática era depositada en la más pequeña, quien asumía el rol de bebita de la familia para mantenerla unida. Teniendo en cuenta esta especial constelación grupal pensé que resultaría infructuoso el tratamiento individual de Marcela e indiqué en consecuencia psicoterapia de grupo familiar.

Durante el período del tratamiento en que estábamos viendo este tema, Marcela llegó a una de las entrevistas tremendamente resfriada, quejándose de tener la nariz tapada. Traía consigo una linda carterita nueva que mostró complacida, entreteniéndose en sacar, contar y guardar lo que llevaba dentro, habiendo entre otros objetos, un pañuelo. Trataba a su cartera como a un interesante juguete (no utilizó durante este período de la hora su material) y la investigaba con diversión, como un bebito que ve por primera vez un objeto llamativo. Los padres, por su parte, volvieron a traer el problema de la inmodificada dependencia de la niña y cuánto esto los molestaba. Mientras la madre hablaba, el padre, atento al resfío de Marcela, le avisaba cuando ésta estornudaba: "Mirá, mirá, la nena"; al escucharlo, la madre le hacía sonar la nariz con su pañuelo casi automáticamente, mientras continuaba quejándose a gran velocidad. Pude así mostrarles la discrepancia entre la queja y lo que ocurría en la realidad: Marcela tenía su propia cartera y en ella un pañuelo que me había estado mostrando, pero que no podía usar ya que la madre se le adelantaba con el suyo. La niña, frente a esta actitud de los padres, se sentía frenada, pasaba a ubicarse en el rol de "bebita" y transformaba su cartera y su pañuelo —sus posibilidades de crecer— en simples juguetes. Así la dependencia de Marcela pasó a ser problema de toda la familia que necesitaba mantenerla chiquita y sin movilidad. ¿Por qué surgía esta necesidad?, la niña se encargó de aclararlo con su juego. Mientras los padres, impactados por el señalamiento, replantaban sucesos similares que solían interpretar de manera muy diferente, Marcela, que había dejado la cartera para acercarse a la mesa, anunció que iba a trabajar en composición y descomposición de números. Tomó el número 23.145 y lo descompuso en 5 unidades, 4 decenas, etcétera. Estando el número descompuesto, trató, por el camino inverso, de recomponerlo, pero por más que se esforzaba no logró hacerlo, poniéndose muy ansiosa. Sus padres trataron de ayudarla, pero, no lográndose hacer entender, recriminaban a Marcela, notándose también bastante nerviosos a ellos. Ligando el juego de la niña a lo que anteriormente habían dicho sus padres, señalé la fantasía del grupo familiar que los obligaba a permanecer juntos hasta tal punto de originar dificultades. Señalé que el número 23.145 representaba a la familia como totalidad. Ellos "eran" 23.145, pero esta familia estaba compuesta por el padre, la madre y los cinco hijos, así como el número estaba compuesto por cinco cifras diferentes. Lograr la independencia e individualidad era vivenciado como descomponer la familia y la ansiedad era no poder juntarse nuevamente. Una vez separados esa armonía interna que los englobaba en una única organización amenazaba romperse definitivamente. De allí surgió un línea de investigación muy interesante; se hizo muy evidente la ideología familiar "estar todos juntos" correspondiendo a ansiedades de muerte y se vio cómo la entrada en la adolescencia de los dos mayores obligaba a afianzar las defensas utilizando a la pequeña como depositaria. Podemos apreciar cómo, el trabajar con todo el grupo familiar, ayudó a lograr una adecuada comprensión de los problemas. Hubiera resultado infructuoso, al menos así lo entiende la autora, abordar la situa-

ción tratando sólo a Marcela, quien presentaba desde ya características especiales para ser la depositaria ideal, pero no era la única responsable de la situación. Sin una adecuada modificación del medio familiar Marcela hubiera sido una de las tantas niñas que abandonan el tratamiento por la ansiedad de padres que no pueden enfrentar la mejora de sus hijos.

Así como señalé las ventajas que este encuadre brinda, cabe también señalar sus limitaciones. En esos casos puede utilizarse el método de entrevistas familiares simultáneamente o precediendo a una terapia individual. Hemos realizado interesantes experiencias en esta línea que serán participadas en futuras publicaciones.

Fundamentos de la psicoterapia familiar con niños y juguetes

RAQUEL SOIFER *

Muchas veces, al presentar la evolución de un tratamiento familiar realizado con inclusión de los niños y de juguetes para éstos, se nos ha preguntado cuáles eran las causas de una mejoría así, tan neta y rápida. Este interrogante nos lo hemos planteado nosotros mismos a lo largo del tiempo. El objetivo del presente trabajo es exponer las conceptualizaciones a las que llegamos en pos de respuestas a tales indagaciones.

Ya en una primera publicación sobre la utilización de este método terapéutico como auxiliar en el diagnóstico psiquiátrico infantil (1964)⁵, señalábamos que habíamos "alcanzado a determinar en todos los casos la incidencia que la modalidad de comunicación familiar tiene en la enfermedad del niño". En nuestra segunda presentación, sobre "Mecanismos y evaluación de la dinámica de un caso de psicoterapia de grupo familiar con niños" (1965)⁶, postulábamos que esta modalidad "en algunos casos, puede resolver conflictos en un período bastante breve y con un número reducido de entrevistas". Aclarábamos además que tal posibilidad se debía "a la dramatización que se produce al interactuar al juego de los niños con los padres, es decir, por la unión de lo verbal con lo preverbal visualizado".

Sintetizando ambos conceptos, podríamos decir que los fundamentos de la terapia son: la incidencia de la familia en la enfermedad del niño y el impacto dramático, visible, de la coincidencia de lo verbal con lo preverbal como promotor de la autoobservación y de la reflexión.

Comenzaremos por buscar apoyo teórico en un concepto del doctor José Bleger³: "la función institucional de la familia es la de servir de reservorio, control y seguridad para la satisfacción de la parte más inmadura o primitiva, narcisística de la personalidad". La parte inmadura o primitiva de la personalidad es, a nuestro criterio, lo infantil, con sus características narcisistas, incestuosas, hostiles, autoeróticas, etcétera, seguimos en esto la descripción freudiana sobre el tema y los unimos con el concepto sobre las ansiedades emergentes del conflicto

edípico y de la lucha por sobrevivir. Aclaremos que cuando hablamos de la lucha por sobrevivir, estamos utilizando un esquema que procura integrar la postulación acerca del proceso biológico de maduración en un nivel psicológico y utiliza a tal fin la fusión defusión de los instintos de vida y muerte.

Ese niño, tan necesitado de su grupo familiar y tan dependiente de él, en el cual el proceso de maduración constituye una exigencia vital, procura, como consecuencia de ese mismo proceso y a los fines del mismo, adquirir las distintas habilidades motoras de las que carece —y que su familia tiene—. También se ve urgido, por ello mismo, a desarrollar las nociones psíquicas relativas a esas habilidades. Surge entonces en él, en contraposición a la situación narcisista, el así llamado imperativo a crecer, término metafórico que expresa el apremio y la exigencia interna por desarrollar su vida mental y ampliar su mundo objetal, interno y externo.

La observación clínica y la observación empírica indican que todos estos procesos madurativos van acompañados de grandes ansiedades. Melanie Klein abrió el camino hacia la descripción y comprensión de esas ansiedades y de los mecanismos de defensa que van promoviendo y guiando las conductas infantiles.

El análisis de niños y la observación de lactantes permitieron entender, a través del concepto de contratransferencia, cómo la ansiedad del niño y sus conductas pueden reactivar en sus familiares, al igual que en el terapeuta, las propias vivencias del momento evolutivo por el cual está atravesando él. Las entrevistas con los padres nos han permitido comprobar cómo la reactivación de esas ansiedades promueve en ellos las defensas que establecieron contra las mismas. O sea, si las defensas instauradas tuvieron por finalidad poner en marcha y ampliar el aprendizaje de determinada función psíquica, esos progenitores podrán ayudar a su niño en la misma dirección. Pero si, en cambio, centraron sus defensas en la represión de la ansiedad y las estereotiparon, no estarán en condiciones de brindar esa ayuda; por otra parte, muy posiblemente, a esa función que deben ayudar a desarrollar en el hijo, la habrán adquirido en una forma parcial o quizá fallida o defectuosa.

Ilustraremos esto con un ejemplo extraído de la observación directa de infantes. Una niña de un año de edad se encuentra dentro del corralito. Su actividad principal consiste en caminar en derredor, sosteniéndose por la baranda con una mano. En un momento dado, se lleva la mano a la boca y con el dedo índice se oprime la encía, y sus dos dientes inferiores, en tanto va dando lentamente algunos pasos. El padre le dice severamente: "¡No, eso no se hace!", con lo cual acude la madre. La niña sigue en la misma actitud, a pesar de la admonición de ambos, que en el caso de la madre va acompañada de un gesto amenazando una palmada. Finalmente, la madre le da la palmada. Consideramos que estos progenitores, que por otra parte tienen una conducta muy tierna y comprensiva en general hacia su hija, actúan así por sentir en

* Asociación Psicoanalítica Argentina. Centro de Salud de San Isidro.

ellos la reactivación de las ansiedades propias del momento evolutivo de su niña —la marcha y la dentición—. Siguiendo este esquema, podríamos decir que la beba está tratando de discriminar entre una sensación penosa en su encía y el placer de caminar, posiblemente confundido aún con el placer de morder. Para el logro de esa discriminación acude a una actividad autoerótica, ponerse el dedo en la boca, en tanto continúa su aprendizaje de la marcha. Los padres, al contemplar todo eso, sienten que se reactivan en ellos las ansiedades que experimentaron en su oportunidad frente a la misma situación y despliegan la defensa que consideraron útil en ese momento: pegar, como probablemente les pegaron a ellos (identificación con el perseguidor).

Vayamos ahora al estudio del proceso terapéutico en un grupo familiar con niños y con juguetes. Tomaremos para ello la definición que el doctor Isidoro Berenstein ha hecho del mismo y que consideramos de gran utilidad para la delimitación del campo operacional: "Es un grupo de personas que tienen una relación previa de larga duración, que conforma una institución 'familia', incluyéndose en otra institución 'grupo terapéutico', según normas y reglas determinadas por el terapeuta y aceptadas en principio por el resto" (1968)².

Esta inclusión de la familia dentro de la institución "grupo terapéutico" despierta en todos los integrantes de la misma las ansiedades y defensas que les son características ante las situaciones de cambio, configurándose así como denominador común grupal la vivencia que todos tienen frente al equipo terapéutico. A partir de este punto se va desarrollando el proceso, en el que, como explicaremos, se producirá el impacto dramático de la coincidencia de lo verbal con lo preverbal.

Ilustraremos esto con una primera sesión. La familia, compuesta por padre, madre, un hijo de 15 años, una hija de 13 y una nena de 4, consultó por sus dificultades en relación con la pequeña, que sufría de asma. En esta primera sesión, al entrar, los padres y la hija mayor, Olga, se ubican en los asientos preparados para los adultos. El varón, Raúl, en cambio se queda de pie, titubeando y, ante una indicación del padre, toma el banquito que se encontraba junto a la mesa de los juguetes y se sienta en él, junto a éste. La nena, Valeria, se apoya en la madre y comienza a jugar con un cinturón de ésta. Todos permanecen en silencio.

Se les señaló la vivencia de extrañeza en la situación nueva y la fantasía de que no se esperaba que la nena jugase con los juguetes, y sí que lo hiciera con el cinturón materno. También que habían querido destacar otro problema, algo así como si Raúl no pudiera ubicarse y lo mandaran permanecer en el lugar de los niños.

Esta apertura permitió que los progenitores se explayaran acerca de las características de ellos y de sus hijos, entre otras cosas señalaron que los varones de esa familia eran muy apocados. A continuación, se produjeron dos secuencias de "Secreto": primero de la madre con Valeria, luego de ésta con Olga. Se interpreta el temor a exteriorizarse en la situación terapéutica y la necesidad de mantener una

relación íntima, secreta, Valeria pidió ir al baño, adonde fue acompañada por la terapeuta. Allí decidió que no "le salía el pis" y regresó tosiendo al consultorio. Surge entonces el tema de la dificultad que tienen todos para hablarse y compartir cosas. La madre y Olga lloran en tanto Valeria se trepa a las rodillas del padre y juega con él. Destacóse en ese momento la dificultad de todos para hablar entre sí, jugar con Valeria o llorar. Valeria intenta salir del consultorio y la terapeuta no se lo permite explicándole por qué. El padre se queja de la poca disposición y tiempo que les queda para estar en familia tras la jornada agobiadora de trabajo. Olga le habla en voz baja al padre, quien se ríe y comenta que ésta le recordó el problema que existe con su ida a un campamento, dado que él no quiere que ella vaya, aunque se lo permite a Raúl.

Súbitamente, Valeria se baja de las rodillas del padre, va a la mesita e inicia en un juego con la plastilina y la tijera, que culmina en la separación de ésta en cuatro pedazos. Es el fin de la hora.

Entendimos esta sesión como el despliegue de una vivencia según la cual todos sentían el comienzo de la terapia como una reactivación de intensas ansiedades frente a la separación y a la individuación: tratarse era desmembrarse en pedazos como la plastilina, según había explicado Valeria con su juego, producido en el vértice del "cono invertido" (una postulación del doctor Enrique Pichon Rivière³ que asemeja una sesión de grupo familiar a esa figura geométrica, cuya base está constituida por observaciones más numerosas en cantidad pero más indefinidas, que se van transformando en emergentes más o menos delimitados, pero cada vez menores en número hasta llegar al vértice en donde aparece el conflicto básico).

Pero había algo más: los pedazos eran solamente 4, o sea que existía un integrante de la familia que no tenía cabida en ella. Se trataba de Valeria misma, que no había podido lograr aún una estabilidad tal en su individuación que le permitiera el manejo libre de su propio cuerpo en una situación conflictual y por lo tanto, no pudo orinar ni hablar ni jugar, en inclusive le falló la respiración (la tos). Recién en ese momento, el fin de la hora, podía integrarse, ante la necesidad de sentir que entraba en relación con la terapia, que la aceptaba y englobaba de alguna manera en su mundo interno.

Detengámonos un poco en los distintos momentos dramáticos de la entrevista. El primero, el episodio del banquito. Vemos allí cómo la ansiedad del padre, reactivada indudablemente por el titubeo del hijo y de Valeria, lo lleva a éste a indicar a Raúl que tome el banco, clara reminiscencia del castigo infantil: sentarse en un rincón y no poder jugar. Por su parte, Valeria expresa en el juego con el cinturón materno su vivencia frente a ese emergente: no se le permite la aproximación exógena y la única posibilidad lúdica está en el cuerpo de su madre. Es el cinturón que, en su vivencia, los tiene atados, trabados, y que por eso callan. O sea que es la nena la que, con su juego, da el indicio que permite esclarecer la situación.

El "secreteo", seguido de la ida al baño y luego transformado en la permanencia de Valeria en las rodillas del padre y su juego con éste, señalan la necesidad de una relación íntima, cuerpo a cuerpo, que sería el modo en que esta familia vive el juego infantil. Podríamos decir, siguiendo el esquema trazado por Arminda Aberastury⁴ que Valeria nos explica que ella tiene aún confundido el juego con el cuerpo, el propio y el materno, con el juego con juguetes y que aún no pudo delimitar

lo suficientemente bien el manejo de sus funciones excretorias —proyectivas en el plano psíquico— como para poder manejar los juguetes. Sus padres y sus hermanos mayores, al enfrentarse con esta ansiedad de la pequeña, lo único que pueden hacer es acompañarla en su juego con el cuerpo, y no logran ayudarla para ampliar su desarrollo.

El señalamiento de la dificultad para hablar entre sí, existente en la familia, equivalente al jugar con Valeria, o a la comprensión del llanto, promueve en ésta la urgencia de irse. O sea que ha apuntado, al parecer, a lo que ella siente como más doloroso: que nadie comparte sus cosas con ella.

Finalmente, la puesta de límites, permite emerger el tema latente, con el reconocimiento de la dificultad para relacionarse entre sí, lo cual lleva al temor a la separación: los adolescentes que se van.

En este momento, Valeria, una vez más, da forma espacial a la vivencia colectiva: compartir lleva a la individuación y a la separación. O sea que nadie quiere jugar con Valeria, porque jugar hace crecer y si uno crece, deja a la familia y se va.

Creemos haber expuesto con claridad este interjuego muy particular que se produce en los grupos familiares con niños y con juguetes, en el que resulta evidente la descripción de D. Winnicott⁷ acerca de cómo los niños en su juego asocian con el hablar de los adultos, y cómo estas asociaciones lúdicas permiten la comprensión de la ansiedad experimentada por la familia. Queda también claro cómo esa ansiedad es justamente la responsable de la falla en la comunicación con el niño, y la causa del síntoma de éste.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABERASTURY ARMANDA. — La importancia de la organización genital en la iniciación del complejo de Edipo temprano. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1970, 27, 1.
2. BERENSTEIN ISIDORO. — El grupo familiar, proceso psicoterapéutico y encuadre. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, Buenos Aires, 1968, 14, 3.
3. BLEGER JOSÉ. — *Psicohigiene y psicología institucional*. Buenos Aires, Paidós, 1966.
4. PICHON RIVIÈRE ENRIQUE *et al.* — Comunicación sobre entrevistas de grupo familiar, con psicóticos internados en el hospicio. Presentado a la Asociación Médica Argentina, Buenos Aires, 1948.
5. SOIFER RAQUEL y col. — El grupo familiar como método auxiliar de diagnóstico y orientación terapéutica en el niño. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, Buenos Aires, 1964, 10, 2.
6. SOIFER RAQUEL y col. — Mecanismos y evolución de un caso en psicoterapia de grupo familiar con niños. *Rev. psicol. psicot. de grupo*, Buenos Aires, 1965, 3, 3.
7. WINNICOTT DONALD. — Playing: its Theoretical Status in the Clinical Situation. *Int. J. psycho-anal.*, Londres, 1968, 49, 4.

Posibilidades del grupo familiar con niños como colaborador para una tarea de psicohigiene: el problema de la desprotección de la familia contemporánea

(Versión abreviada)

RAQUEL SOIFER *
GRACIELA F. DE RESNICOFF **

El trabajo de grupo familiar con niños permite, según lo pudimos comprobar, el abordaje de diversos problemas sociales. De uno de ellos nos hemos ocupado en un escrito: el tema de la muerte brusca del padre. Hoy queremos referirnos a la desprotección de la familia contemporánea, tal como la hemos observado en la práctica terapéutica.

Cuando hablamos de familia contemporánea estamos definiendo una situación en oposición a otra: la familia de antes. Efectivamente, la familia de antes, aclaramos que nos referimos a la clase media urbana, estaba constituida por un gran núcleo en el que convivían, ya sea en la misma casa o en casas vecinas, tres o más generaciones. La transmisión de la experiencia vital era entonces una práctica cotidiana, que se hacía insensiblemente. Del mismo modo, el intercambio de información entre los miembros de una misma generación era diaria.

Pero además de la adquisición del conocimiento empírico, existía otro factor imponderable, que era la posibilidad de recibir ayuda inmediata y en cualquier momento, ya que siempre había abuelos, tíos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos, etc., dispuestos a colaborar. Por último y quizá lo más importante, se vivía en casas, que eran amplias y que por lo general tenían patio o jardín. En cambio, la familia contemporánea, hablamos siempre de la clase media urbana, se limita la gran mayoría de las veces, al núcleo restringido de padres e hijos y vive en un departamento. Además, en muchos casos, la esposa trabaja en tareas fuera del hogar. O sea que estos progenitores se ven abocados a la crianza y educación de los hijos carentes de todos los elementos que enunciábamos antes como comunes: la transmisión de la experiencia, el aprendizaje empírico, el intercambio de información, la

* Centro de Salud de San Isidro, Asociación Psicoanalítica Argentina.

** Consejo Argentino de Mujeres Israelitas.

ayuda física inmediata. El departamento, como resulta bien claro, no tiene espacio para la expansión y la descarga motriz de los niños. Nos encontramos entonces con que los padres, prácticamente carentes de enseñanza y ayuda, tienen que enfrentar a los niños con tensiones aumentadas por la imposibilidad de la descarga. Debemos también tener en cuenta que estas tensiones se ven incrementadas además por otros factores: la educación más libre, el aumento y diversificación de las fuentes de estimulación inherentes a nuestro mundo de perfeccionamiento técnico y un mayor abandono, ya que no hay parientes que sustituyan a la madre que está ausente. Por supuesto que la práctica es reemplazar todo esto por una mucama, que hace las veces de niñera, casi siempre sin tener calificaciones para ello. Por otra parte, una moda última ha decretado que las abuelas y abuelos malcrian a los niños y por ello deben permanecer alejados.

Si tenemos en cuenta que para poder estar con un niño hay que asumir una cierta disposición, que en psicoanálisis llamamos regresión controlada (ponerse en el papel del niño), podemos trazarnos un panorama de cómo se sienten los padres cuando regresan a su casa, abrumados por la lucha por la existencia en un mundo tan difícil como el actual y se encuentran con sus niños en tensión, insatisfechos, agresivos, caprichosos, etcétera.

Se ejemplifica esto mediante la presentación de una sesión de terapia de grupo familiar. Pasaremos a dar brevísimas síntesis de ella.

Se trata de una familia en su tercer año de tratamiento, compuesta por una joven pareja con sus 4 hijos de 10, 9, 7 y 5 años de edad. A esta altura del tratamiento los grandes trastornos de conducta han desaparecido: enuresis, problemas escolares, destrozos, etcétera.

En la sesión a la que nos referimos expresan, dentro del marco terapéutico, la problemática que viven en ese momento: entre los niños intensas vivencias de celos referidas a la dificultad en compartir al padre y a la madre, que se traducen en interferencias cada vez que éstos tratan de hablar acerca de la situación particular de alguno de ellos. Esto hacía que el clima de la entrevista resultara ruidoso y expectante: los pequeños "armaban" frecuentes peleas que debían ser frenadas, además de por los padres que no daban "a basto", por la terapeuta y la observadora. La madre comenta en determinado momento que en su casa, frente a situaciones como ésta, pierde el control y comienza a gritar. Esto es señalado por la terapeuta en el dibujo de la más pequeña (una especie de trapecio abierto hacia abajo) como el deseo de los niños de explicar cómo consiguen que la madre se transforme en un trasero abierto que desparrama excrementos. Los padres también cuentan que la noche anterior, en que festejaban un cumpleaños y frente a un cuadro parecido, sintiéndose agobiados e impotentes "desparramaron" a los chicos en casas de parientes.

Podemos ver acá la profunda desolación de estos padres, que se sienten sin derecho a expresiones mínimas de intimidad o expansión

y el drama de los niños en su vivencia de ser abandonados y desechados. Vinieron a la entrevista a expresar estos sentimientos y el temor al desborde de odio o desesperanza, representado por el trasero abierto del dibujo. La necesidad de una adecuada contención resulta lo más relevante: alguien que contenga y delimite los sentimientos hostiles y les devuelva la comunicación y el cariño. Para ellos la terapia es el lugar donde pueden abrir el trasero sin peligro de encontrar otro trasero hostil que los ataque y confían en que allí hay alguien, que en un rol muy similar al de una abuela, los ayude a sentirse una persona otra vez. Por lo tanto, la terapia, mientras colabora con los padres en la comprensión de los hijos, permite a éstos conocer y temer menos sus pulsiones y se convierte, a lo largo del proceso, en una imagen familiar cercana, pero distante, con la que todos se pueden identificar y que toma los contornos de lo humano.

Claro está, una terapia no es una familia, pero ayuda a resolver, como lo demostramos en este caso, los problemas que suscita la carencia de ésta. En el caso expuesto, los padres están tratando de encontrar en el exogrupo y en sus familias originarias, el apoyo que antes no podían pedir. Por ahora lo hacen en forma quizá no tan adecuada, o por lo menos ellos y los niños lo viven así, pero se trata de un lento camino que los va acercando a una relación más laxa y menos terrorífica con sus parientes, a los que, por otra parte, necesitan tanto. Todo esto sucede mientras en el núcleo primario, el de ellos, se van flexibilizando las pautas de comunicación.

Algunas consideraciones sobre la psicoterapia del vínculo madre-hijo

ANA LIA KORNBILIT *
JAIME S. SZWARSTEIN
ISABEL BARREIRO
SUSANA MARTA BENDERSKY

El objetivo de esta presentación es referir una experiencia que desde hace un año estamos realizando en el equipo de niños del Centro de Salud Mental N° 1, de la Municipalidad de Buenos Aires. Dicha experiencia consiste en la psicoterapia breve conjunta de la pareja madre-hijo, centrada en el vínculo entre ambos.

En nuestra labor en el servicio habíamos observado que en determinados casos era necesaria la inclusión de la pareja madre-hijo en el proceso diagnóstico y terapéutico. Vimos que esta modalidad de trabajo permitía a la madre tomar cierto insight acerca de la problemática de su hijo y de su implicancia en ella. Posteriormente nos dimos cuenta del significado que podía tener para el niño la posibilidad de dramatizar el vínculo con su madre real frente al terapeuta, como medio de objetivarlo y de intentar una apertura. De este modo, el tratamiento mismo se convierte en el continente del vínculo patológico madre-hijo y a la vez en la posibilidad de incorporar nuevos modelos de relación. Si bien puede decirse que esto en esencia se cumple en todo tratamiento, en estos casos el tipo de vínculo impide una adecuada simbolización y requiere la dramatización del conflicto para poder objetivarlo y reelaborarlo.

Se trata de parejas madre-hijo en las que se da un tipo de relación simbiótica. Destacamos que esta simbiosis abarca ciertas áreas de la personalidad, quedando otros aspectos no comprometidos. Por lo tanto esta situación no reviste los caracteres de la simbiosis descripta por M. Mahler como una de las dos formas fundamentales de la psicosis infantil.

Realizamos esta experiencia con niños que consultaron por síntomas que expresaban dificultades en el proceso evolutivo en situaciones que exigen una mayor autonomía y que implican separación

de la figura materna (verbigracia, dificultades para quedarse solos en el colegio, para dormir en cuartos separados, etc.). Trabajamos también por ejemplo con un niño diabético de 11 años que no podía asumir su enfermedad: no controlaba su glucosuria ni reconocía los síntomas de hipoglucemia, tarea que era realizada por la madre, quien por otra parte le había hecho interrumpir ya dos tratamientos psicológicos anteriores.

Todos los niños que consideramos presentaban perturbaciones especialmente después del primer año de vida, en la etapa que Stone y Church han denominado como la del "deambulador" que se caracteriza por una adquisición gradual de mayor autonomía, por parte del niño, basada en el incremento de sus potencialidades corporales, especialmente el lenguaje y la marcha. Esto coincide con la apreciación de M. Mahler acerca de la existencia de un segundo período evolutivo, que abarca de los 10 a los 18 meses, y que "trac como resultado el dominio de las habilidades locomotoras, las capacidades cognitivas y otras funciones y/oicas autónomas parciales". En los niños con los que trabajamos en esta experiencia existía una falla especialmente en el momento, si bien pueden ya encontrarse evoluciones parcialmente patológicas en el primer período de desarrollo.

La dificultad en la posibilidad de alcanzar una "independencia emocional relativa con respecto al objeto amoroso", correspondiente al segundo momento evolutivo de que hablamos, implica un déficit de ciertas realizaciones que siguen a cargo de la madre que no permite que el niño las lleve a cabo.

El niño se convierte entonces para la madre en un apéndice permanente "necesitante", evitándole a ella hacerse cargo de su propia condición de "necesitante". El funcionar de esta manera significa para la madre, en cierto sentido, perpetuar su capacidad creadora que siente amenazada por una figura interna castradora, que configura su propio modelo de relación madre-hijo. Casi todos los niños considerados son hijos únicos o menores, y en todas las madres se pusieron de manifiesto dudas y conflictos relacionados con la posibilidad de tener otros bebés en el futuro. Esta situación proporciona cierta seguridad, pero con el incremento de estímulos del mundo externo, correspondientes al desarrollo evolutivo, sobreviene el temor a la pérdida de ese vínculo necesitado. El temor por parte del niño o la pérdida de una figura materna "gratificadora", encuentra su correlato en la madre, en la dificultad para desprenderse del niño bebé, sin sentir que lo pierde. Este juego de identificaciones proyectivas que tiene como base en la madre, la ansiedad de sentirse vaciada abruptamente, y en el niño de perder su continente, se expresa a un nivel fóbico. La fobia surgiría como defensa frente al sentimiento de soledad, vivido como desintegración y muerte. En uno de los casos con los que trabajamos, la fobia se expresaba a través del síntoma insomnio, sufrido por la madre y el niño, como intento de defensa frente a la ansiedad de muerte.

* Centro de Salud Mental n° 1, Buenos Aires.

Es sobre el nivel fóbico sobre el que trabajamos en la psicoterapia breve conjunta de la pareja madre-hijo. Vimos que en todos los casos se trataba de configuraciones familiares en las que existían conflictos en la pareja paterna, vividos por la madre como abandono por parte del padre, que aparecía como ausente, real o virtualmente.

Esta situación de abandono reactiva en la madre antiguas situaciones de pérdida, y reagudiza especialmente su mala elaboración del conflicto edípico, todo lo cual culmina en un intento de realizar en la pareja madre-hijo, la fantasía de unión idealizada. Esta pareja adquiere las características de ideal en tanto no se plantean situaciones de separación, en un intento de fantasía de detención del tiempo, en la que la madre identificada con el hijo, realiza fantásticamente la unión idealizada con su propia madre.

El proceso evolutivo del niño viene a romper esta fantasía, por lo que es vivido como un ataque a la identidad fusionada madre-hijo, ya que implica una exigencia de individuación para los dos, lo que desencadena en ambos reacciones fóbicas.

Vimos también que en todos los casos la mala elaboración del duelo por la separación hacía que éste se expresara en una de las dos partes de la pareja, o en las dos, a nivel del cuerpo. Esto se puso de manifiesto de un modo dramático en un niño de 9 años al cual la madre debía dar de comer en la boca y realizar toda su higiene personal, a pesar de que no se trataba, como podría pensarse, de un desarrollo psicótico. En una oportunidad en que la madre debió ser hospitalizada por un problema de columna vertebral, el niño enfermó a los dos días de peritonitis.

En la situación transferencial el terapeuta es vivido como el ejecutante de la pérdida. Si este conflicto es elaborado en la situación terapéutica conjunta hay más posibilidades de que la madre no saque al niño del tratamiento.

Indicaciones de la terapia breve conjunta madre-hijo.

1. Niños que no entran solos al consultorio por sus vivencias fóbicas.
2. Niños que consultan por problemas de dependencia (problemas para dormir solos, comer solos o quedarse en la escuela).
3. Niños que presentan una enfermedad, que sin serlo, es vivida como invalidante, lo que crea dependencia.
4. Madres que consultan por sus hijos, pero que en realidad necesitan tratamiento ellas mismas, presentando su pedido de ayuda a través de los niños.

Técnica de trabajo. Por lo general realizamos un contrato de tres a cuatro meses a razón de una sesión semanal, de 50 minutos de duración. En algunos casos hemos trabajado en coterapia, por la dificultad

que sentíamos de hacernos cargo de ansiedades vividas a un nivel muy regresivo y dramatizadas vividamente en sesión.

Trabajamos de acuerdo con los lineamientos generales de la psicoterapia breve, en cuanto a focalización del tratamiento, manejo de la transferencia poniendo el acento sobre lo institucional y desalentando la emergencia de lo regresivo. Centramos la tarea en el mundo habitual de la pareja, incluyendo además información en caso de considerarlo necesario.

En una parte de los pacientes el objetivo de la técnica que describimos fue la curación del síntoma motivo de consulta. En otros casos el objetivo fue posibilitar en un segundo momento el tratamiento individual de la madre y el hijo por separado, o el tratamiento familiar. Pensamos que forzar la presencia del padre o del resto de la familia en el momento de la consulta, sería convertir a la institución en un continente para el mensaje traído por estos pacientes, que es específicamente la simbiosis parcial madre-hijo.

En las sesiones incluimos una caja de juegos, e interpretamos sobre todo, el vínculo entre la madre y el hijo, es decir lo que el niño "hace" a la madre y lo que ella le "hace" a él, usando como vehículo de simbolización los juguetes.

Resultados de la experiencia. Si bien la situación simbiótica de fondo no puede resolverse bajo ningún concepto, en una psicoterapia breve, pensamos que esta técnica es útil en cuanto permite:

1. Un mayor grado de insight por parte de la madre en cuanto a su implicancia en los conflictos del niño.
2. Un alivio relativo del sentimiento de culpa persecutoria por parte de la madre frente al hijo.
3. Una apertura para la inclusión del padre.
4. El alivio de síntomas paralizantes como el insomnio pertinaz, no poder quedarse en la escuela, etcétera.
5. Esta técnica disminuye el número de deserciones al permitir una mayor elaboración del temor a la pérdida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABERASTURY A., DE GARMA E. G., LANGER M. y RASCOVSKY A. — Psicología de la mujer. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1966, 23.
- Coloquio Acta 1967. — Psicoterapia breve. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. Lat.*, Buenos Aires, 1967, 14, 2.
- BELLAK y SMALL. — *Psicoterapia breve y de emergencia*. México, Ed. Pax México, 1969.
- GELEER E. R. — La fase de separación-individuación. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1970, 27, 1.
- MAHLER M. — *On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation*. New York, Int. Univ. Press, Inc., 1968, 1.
- MOM JORGE. — *Aspectos teóricos y técnicos en las fobias y en las modalidades fóbicas*. Buenos Aires, 1956.
- STONE L. J. y CHURCH J. — *Niñez y adolescencia*. Buenos Aires, Hormé, 1965.

**Grupo familiar
con miembros psicóticos**

La reacción terapéutica negativa y la influencia familiar

* J. E. GARCIA BADARACCO
A. A. CANEVARO

En esta comunicación trataremos de desarrollar una hipótesis de trabajo, articulada a través de la experiencia clínica con pacientes psicóticos y sus grupos familiares, con el propósito de investigar más profundamente en las causas de serias dificultades que caracterizan estos tratamientos.

Con este fin, y tomando aquí una de esas dificultades, la llamada reacción terapéutica negativa, esbozaremos primero su desarrollo histórico, y trataremos luego de fundamentar el uso de uno de los más importantes recursos técnicos con que hemos contado en nuestra práctica clínica para su disolución, a saber, la terapia del grupo familiar, con el paciente incluido.

En "*El Yo y el Ello*", Freud, en 1923, describe la Reacción Terapéutica Negativa de la siguiente manera:

"Hay personas que se conducen muy singularmente en el tratamiento psicoanalítico. Cuando les damos esperanzas y nos mostramos satisfechos de la marcha del tratamiento se muestran descontentos y empeoran marcadamente. Al principio atribuimos este fenómeno a una rebeldía contra el médico y el deseo de testimoniarle su superioridad, pero luego llegamos a darle una interpretación más justa. Descubrimos en efecto que tales personas reaccionan en un sentido inverso a los progresos de la cura. Cada una de las soluciones parciales que habría de traer consigo un alivio o una desaparición temporal de los síntomas, provoca, por el contrario, en estos sujetos, una intensificación momentánea de la enfermedad y durante el tratamiento empeoran en lugar de mejorar. Muestran, pues, la llamada reacción terapéutica negativa.

"Es indudable que en estos enfermos hay algo que se opone a la curación, la cual es considerada por ellos como un peligro. Decimos, pues, que predomina en ellos la necesidad de la enfermedad y no la voluntad de curación...

"La reacción terapéutica negativa tiene intensidad suficiente para constituir el mayor obstáculo contra la curación, obstáculo más fuerte aún que la inaccesibilidad narcisista, la conducta negativa con el médico y la adherencia a la enfermedad."

* Clínica Psiquiátrica. O'Higgins 2328, Capital Federal.

El lo atribuye a un poderoso sentimiento inconsciente de culpabilidad, contra el cual nada se puede hacer directamente, y que indirectamente, en el mejor de los casos, la tarea se ve facilitada cuando este sentimiento es el resultado de una identificación del sujeto con otra persona, que fue en su día, objeto de una carga erótica. Este proceso sería similar al que vemos en la melancolía.

Con los aportes de la teoría kleiniana en su concepción de los objetos internos y su relación con el yo, así como la enfatización en los mecanismos de proyección, se fue enriqueciendo la visión de este proceso, y en especial la contribución de J. Rivière nos ayuda más claramente, cuando en 1936, equiparando al narcisismo secundario con el yo más sus objetos internalizados, se dedica más aún al estudio del mundo interno de estos pacientes. Así entonces, pone el acento en que para estos pacientes curarse significa un acto egoísta por el cual dejarían abandonados a los objetos internos, a los que desean reparar.

Sólo pueden progresar en el análisis pensando que curarse significa curar a sus objetos internos, de los que a su vez ellos dependen. Pero emprenden la tarea de reparar a sus objetos, los exponen a dar todo de sí por ellos, con el consiguiente peligro para su yo.

Esto nos sitúa de lleno en la problemática de la psicoterapia de los psicóticos, quienes constituyen el paradigma más claro de los pacientes con una reacción terapéutica negativa difícil de solucionar, dado el intenso grado de su narcisismo, y la excesiva dependencia con objetos internos de los cuales no pueden desprenderse, bajo pena de un empobrecimiento masivo del yo y sus funciones.

El grado de adherencia de aspectos o partes del yo de estos pacientes a los objetos proyectados en el mecanismo de la identificación proyectiva, y las características de dureza o labilidad de sus objetos internos, constituyen uno de los puntos de mayor interés terapéutico y científico de esta problemática.

Ahora bien, la práctica clínica con psicóticos y sus familiares nos permite ver mucho más claramente la génesis y estructuración de estos procesos internos del paciente, en tanto podemos ver su funcionamiento con los objetos internos "encarnados" afuera, dentro de la dinámica del proceso terapéutico.

Al arribar a la conclusión de que la mejoría o curación de los pacientes psicóticos es muy difícil sin la participación de sus familiares directos en el proceso terapéutico, el estudio de los mecanismos antes descriptos se ha visto paulatinamente enriquecido con la ampliación del campo psicológico en un encuadre de terapia familiar conjunta, a nuestro juicio más pertinente con este tipo de problemas.

Así hemos podido comprobar a título de hipótesis permanentemente confrontada con la experiencia clínica, cómo la influencia familiar se convierte en algo casi decisivo para la estructuración, desarrollo y eventual disolución de la reacción terapéutica negativa.

Por momentos, la calidad de los objetos internos del paciente era similar a la de los objetos externos, de manera tal que nos permitía trabajar en forma complementaria con la terapia individual, a fin de poder asegurar las condiciones de ésta, en momentos en los cuales, de no ser así, el tratamiento corría graves riesgos de interrupción.

Así, el psicótico lleva al tratamiento a sus familiares, dada la imposibilidad de contar con una fortaleza suficiente de su yo, para enfrentar no sólo las vicisitudes del proceso terapéutico, sino también los "peligros" que la curación llevaría implicados.

Este peligro, si bien se manifiesta por un intenso sentimiento de culpabilidad frente al abandono de objetos internos primarios y fundamentales del mundo interno del paciente, lleva implícitas intensas ansiedades persecutorias provenientes de esos objetos, que en la terapia familiar hemos visto concordantes con actitudes reales de los objetos externos y no solamente provenientes de las fantasías de los pacientes.

Así pues, actitudes de franco sabotaje al tratamiento, en momentos de mejoría del paciente, los hemos visto provenir alternativamente de parientes próximos que no podían ni reintroyectar sus propias identificaciones proyectivas puestas en las pacientes, ni hacerse cargo como buen continente de las identificaciones proyectivas de estos mismos.

La estereotipia de los mecanismos psicológicos y afectivos que rigen la comunicación interpersonal en el grupo familiar del psicótico nos muestran que no sólo el paciente, sino sus propios familiares próximos viven de una forma extremadamente ambivalente el curso de una psicoterapia, y la paulatina disolución de ese círculo vicioso va configurando un cambio en muchas oportunidades francamente resistido.

La posibilidad de trabajar simultáneamente con todos los miembros de esa constelación familiar pone de manifiesto a veces la profunda complicidad existente entre los distintos subgrupos formados, que viendo peligrar el status quo adquirido, sabotean claramente los logros terapéuticos, dirigiendo sus ataques directamente al terapeuta, o a través del mismo paciente, explotando esa relación de dependencia inmadura con los objetos externos, en actitudes que oscilan desde el ataque envidioso a la relación terapeuta-paciente hasta la creación de un clima desfavorable para la consolidación de los logros terapéuticos.

Antes de citar algún ejemplo clínico de esta situación, queremos retomar conceptos teóricos formulados por Cesio, autor que se ha ocupado ampliamente sobre el tema de la reacción terapéutica negativa.

En 1962, en su trabajo sobre "*La disociación y el letargo en la reacción terapéutica negativa*", vuelve a insistir sobre la disociación básica en estos pacientes, poniendo el acento sobre el estado letárgico en que está una de las partes del yo, correspondiente a los aspectos más profundos.

Siguiendo la idea de la identificación primaria de Freud, Cesio

considera que hay que diferenciar en el aparato psíquico formaciones yóicas primarias, productos de la identificación directa, anterior a toda carga de objeto, es decir, con los contenidos del ello, con los padres de la prehistoria y formaciones yóicas secundarias, productos de la identificación con los objetos del mundo externo. Piensa que cuando el desarrollo es adecuado podemos suponer que las identificaciones primarias y las secundarias se fusionan con el consiguiente desarrollo unitario del yo y que cuando hay trastornos en el desarrollo se produce una disociación entre dos yos. Además, postula que en los casos de reacción terapéutica negativa se encuentran disociaciones muy notables, en donde el yo primario aparece como un perseguidor terrorífico, monstruoso y poseedor de una tremenda energía, y que en estas condiciones el yo secundario recurre a la defensa de transformar al yo primario en un objeto "muerto", es decir, alcatargado.

Siguiendo este esquema de Cesio, sin entrar a considerar en este momento algunos posibles aspectos de discusión y con el objeto de considerar solamente lo que nos preocupa en el presente trabajo, podemos decir que las figuras reales significativas en la vida de estos pacientes (es decir, los padres o sustitutos), se han comportado como objetos externos castradores, que de alguna manera han impedido una verdadera integración del yo primario en los aspectos más evolucionados del yo secundario.

Mientras Cesio señala que el yo secundario recurre a la defensa de transformar al yo primario en un objeto alcatargado, nosotros podemos decir complementariamente que el yo secundario ha incorporado pautas rígidas de los padres y se comporta tanáticamente con respecto al yo primario como los padres se comportaron con los aspectos vitales del hijo.

Cesio dice: En estos casos, el yo primario, heredero directo del ello, es atacado por los instintos de muerte al servicio del yo secundario y es alcatargado, con la consiguiente paralización del mundo interno.

En la práctica de la psicoterapia de familias con pacientes psicóticos podemos observar estos fenómenos y esta dinámica en el campo psicológico de la relación interpersonal y vemos cómo uno o varios familiares pueden llegar a tener actitudes sumamente paralizantes para el paciente justamente cuando éste comienza a movilizar los aspectos más paralizados en un intento de salir del encierro y recuperar la salud.

Parecería repetirse "aquí y ahora" en la dramática familiar lo que seguramente se dio reiteradamente en la infancia del paciente con sus padres. En estos casos la rigidez es un patrimonio compartido por toda la familia y cualquiera de los miembros que pretende salir de ésta es severamente criticado, agredido o expulsado. "Más vale verlo muerto" es una secreta consigna que juega inconscientemente y muchas veces como un mandato superyóico para el paciente que hace un intento de suicidio. "La familia es sagrada", es otra expresión típica en

algunos pacientes con reacción terapéutica negativa que significa un respeto reverencial a los objetos internos representantes de la familia tanática superyóica introyectada. (En la presentación al Congreso se incluyó un ejemplo clínico.)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARANGER WILLY. — Aspectos problemáticos de la teoría de los objetos en la obra de Melanie Klein. *Rev. de psicoanál.*, 1962, 1-2, 14-19.
- CESIO F. — La reacción terapéutica negativa. Actualización. *Rev. de psicoanál.*, 1958, 3, 293-299.
- CESIO F. — El letargo. Una contribución al estudio de la reacción terapéutica negativa. *Rev. de psicoanál.*, 1960, 1, 10-24.
- CESIO F. — Contribución al estudio de la reacción terapéutica negativa. *Rev. de psicoanál.*, 1960, 3, 289-295.
- CESIO, F. — La disociación y el letargo en la reacción terapéutica negativa. *Rev. de psicoanál.*, 1962, 1-2, 20-25.
- CESIO F. — El letargo, la melancolía y el duelo en la reacción terapéutica negativa. *Rev. de psicoanál.*, 1962, 4, 317-321.
- CESIO F. — El letargo, una reacción a la pérdida de objeto. *Rev. de psicoanál.*, 1964, 1, 19-26.
- FREUD S. — *El yo y el ello*. Obras Completas, t. I. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1948.
- RIVIÈRE J. — Contribución al análisis de la reacción terapéutica negativa. *Rev. de psicoanál.*, 1949, 1, 121-142.

La coterapia y el grupo familiar

J. E. GARCÍA BADARACCO
A. A. CANEVARO
O. CZERTOK *

Siguiendo la línea de lo expuesto en un trabajo anterior ** y pasando un año más de permanente confrontación de estas hipótesis con la realidad clínica, queremos desarrollar algunos conceptos más sobre esta técnica, aplicada al tratamiento grupal familiar de pacientes psicóticos.

Definíamos la coterapia como "el trabajo simultáneo de más de un terapeuta cuando actúan conjuntamente en igual nivel formal de liderazgo", y tratábamos de señalar algunas de las ventajas técnicas de este encuadre, frente al del terapeuta único.

Frente a la mayor exigencia emocional e intelectual a la que se ve sometido el terapeuta grupal especialmente en grupos de psicóticos, la coterapia se convierte para nosotros en uno de los recursos de mayor eficacia para la resolución de difíciles problemas que surgen de esta clase de tratamientos.

Este nivel de exigencias es tan grande que a veces es muy difícil superar momentos de desesperanza y desaliento que si bien podríamos comprender como una contratransferencia concordante con el paciente, se constituyen en uno de los obstáculos más grandes durante el proceso terapéutico.

En estas condiciones, la necesidad y el deseo de intercambio para mejor comprensión y elaboración de estos problemas pueden satisfacerse en parte en el diálogo con el observador grupal y luego en la supervisión técnica. Pero dado que este intercambio no siempre es posible o que solo puede realizarse a posteriori, las más de las veces el terapeuta se ve obligado a dialogar consigo mismo o pensar por sí solo, pues siendo el único que asume el rol de terapeuta, tiene que hacerse cargo de las transferencias masivas de los pacientes.

* Clínica Psiquiátrica, O'Higgins 2326, Capital Federal.

** *La coterapia como modificación integradora en el encuadre de la terapia grupal.* Presentado en el IV Congreso Internacional de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo. Buenos Aires, julio de 1969.

Por el contrario, cuando su tarea es compartida con otro terapeuta en igual nivel de liderazgo, pensamos que la labor se enriquece y disminuye su insalubridad.

Así pues, en la coterapia, cuando el terapeuta está interpretando interviene activamente en el grupo y es otro miembro más de él, pues podríamos decir que se ha "sumergido" en el grupo, "desapareciendo" como observador, pero da lugar a que el otro terapeuta se transforme entonces en el observador y el coordinador.

Luego, al revertir éste en forma de interpretación, lo observado, permitirá al grupo y al coterapeuta realimentarse instantáneamente, lográndose así una integración témporo-espacial más adecuada. Los roles de los terapeutas oscilarán alternativamente en un proceso dialéctico, constituyendo entre sí una "microunidad gestáltica" que interactúa permanentemente con el grupo.

De este modo pensamos que queda incorporada la actividad de la supervisión y de la observación, como una cosa del grupo, respetando así esa realidad que constituye el grupo en sí mismo, y las interpretaciones, como se ve, interactúan además entre los coterapeutas conformando lo que Pichon Rivière llamaría una espiral dialéctica frente a los emergentes grupales.

Esto facilita mucho el trabajo de los terapeutas, y creemos que lo hace más efectivo, pero en función directa de la complementariedad, a la cual se ciñen como un elemento importante del esquema referencial de cada interpretación, de cada observación, de cada sentimiento que aparezca durante la tarea, al margen de las diferentes líneas interpretativas que pudieran seguir.

Se requiere interacción estrecha entre los coterapeutas y comprensión de los roles que ambos están asumiendo a cada momento frente al grupo y entre sí. En esta actitud complementaria no se produce una sumación, sino un fenómeno de gestalt.

Así entonces, esta regla básica de la complementariedad deviene por momentos en verdadera guía para la actitud coterapéutica. Cuando ella se ve obstaculizada, algo está sucediendo en el grupo: procesos de destrucción que pugnan desde él, intentan dividir a los terapeutas como un fenómeno resistencial grupal o individual.

Frente al grupo familiar, por sus especiales características, esta técnica puede convertirse en valiosa ayuda por momentos, no sólo para el esclarecimiento de intensas resistencias, sino para evitar también actuaciones que puedan ser nocivas para la prosecución del tratamiento.

Nuestra experiencia con grupos familiares de psicóticos, nos hace enfrentarnos habitualmente con panoramas muy caóticos, donde las intensidades de los conflictos se reducen a veces en "quién enloquece a quién" o en "quién se queda con la locura de todos".

Como el correcto desarrollo del proceso terapéutico llevará todo esto al nivel transferencial y contratransferencial para que estas fantasías inconscientes puedan ser aclaradas, suceden momentos muy espe-

ciales en los que el terapeuta pasa a ser desde el ser omnipotente que va a vencer la enfermedad, hasta el loco quijote que lucha contra los molinos de viento, o el diabólico ser que intenta enloquecer a los sanos pasando entonces por situaciones de dramática intensidad, donde se hace mucho más clara y necesaria la intervención de alguien no "Contaminado" que ayude a aclarar la situación.

Eso plantea una variante interesante de la técnica, en el sentido de poder utilizarla como "recurso móvil" o "momentos coterapéuticos" en crisis que de por sí sobrepasarían las posibilidades de un solo terapeuta.

Así hemos tenido oportunidad de ensayarla en situaciones tales como la internación de pacientes, donde momentáneamente uno de los coterapeutas hablaba con los familiares y otro con el paciente, superando el primer momento caótico y reuniéndose luego todos, en un momento de mayor integración. Asimismo en crisis que atentaban la prosecución de un tratamiento, ya sea por intervención directa de familiares, ya por actitudes del paciente mismo.

Igualmente hemos tenido oportunidad de beneficiarnos con esta técnica, en el establecimiento de psicoterapia individual del psicótico, reuniéndose el paciente y sus familiares con el terapeuta familiar y el futuro terapeuta individual del paciente, para interpretar y aclarar en el momento todos los emergentes, dificultades y resistencias que se suscitaren.

Como ejemplo clínico, vamos a relatar un momento de coterapia en una reunión familiar de un paciente psicótico internado.

Bruno, de 30 años, se interna con un cuadro melancólico, fantasías suicidas e ideas delirantes de referencia. A lo largo de reuniones con él y su grupo familiar se va viendo claramente que toda la familia está impregnada de ideas de muerte, especialmente desde hace 20 años en que en un accidente de caza, Bruno ve morir a su hermano, 2 años mayor, cuando éste cruza un alambrado y se le dispara su propia arma, ocasionándole la muerte.

La familia se refugia entonces en un duelo patológico que los va segregando del mundo y convirtiendo la casa en un santuario o bóveda, donde además de las culpas asumidas y proyectadas masivamente entre ellos se va creando un clima que convierte a la muerte en tema central de comunicación, y donde la maniobra defensiva grupal es amplia gama de recursos obsesivos ante toda posibilidad de cambio, que es vivida potencialmente como peligro de muerte. Especialmente la madre y la hermana menor se aíslan en la casa, guardándose bien de hacer cambios en muebles y ropas, pues cualquier intento en ese sentido, presagia algo funesto.

Así, por ejemplo, desde hace muchos años no se ponen nuevas cortinas en la casa para evitar malos augurios. El padre y Bruno son los encargados de mantener la casa y el contacto con la realidad, a través de un trabajo compartido de administración de sus propiedades. Toda esta actitud grupal se ve claramente en el "aquí y ahora" de una reunión conjunta con el terapeuta familiar (B) que vuelve de sus vacaciones y el terapeuta (A) que trató a la familia durante ese lapso, y que sinte-

tiza lo ocurrido, dando además su propia idea del panorama familiar. En estos momentos, Bruno sirve café de una bandeja sobre el escritorio, y al verterlo sobre la taza de A, vuelca parte sobre los dedos del terapeuta. La madre le dice entonces: "Bruno, no le vayas a quemar los dedos del doctor", cosa que es respondida por A con una sonrisa, diciendo: "Con tal que no me queme las ideas..."

Esta situación es registrada por B, en ese momento de observador, quien la utilizará para una interpretación posterior a lo que vamos a relatar.

A lo largo de esos primeros minutos, A hacía gala de una actitud vital y de pensamiento, que contrastaba cada vez más, a los ojos del observador B, con la actitud de la familia, que oía al terapeuta, con escasas intervenciones. Luego del episodio del café, comienza paulatinamente todo el grupo a hablar, con una permanente crítica de lo dicho anteriormente por A, negando los logros mencionados por éste sobre el progreso terapéutico, y abrumándolo con menciones de síntomas y situaciones patológicas, que "destruyen" todo el panorama optimista delineado por A.

Éste comienza a callarse y a hundirse poco a poco en un sillón, con una expresión de paralización en su rostro y en su tarea. Para B queda claro el mecanismo defensivo grupal contra la actitud vital y optimista de A, y lo integra en una interpretación que muestra cómo toda la familia se defiende frente a cualquier fenómeno vital, con una actitud envidiosa y destructiva, evidenciada en el "aquí y ahora" por una paralización de A, "muerto" por ellos en la sesión, a través de "quemarle sus ideas" y anularle su trabajo terapéutico. Esta interpretación permitió tomar *insight* al terapeuta A y a la familia de lo que estaba pasando, modificando el campo psicológico con la inclusión participante de B, que transformándose en coordinador, da lugar a que A elabore rápidamente la situación y salga de su paralización, y a la familia que tome conciencia de una actitud defensiva importante. Esto permitió aclarar algunos conflictos latentes y se pudo hablar en la reunión de la muerte del hermano, que era vital y alegre, de la envidia destructiva de los familiares, y llegar a un esclarecimiento mayor de la culpa frente a ese episodio.

Este ejemplo de un "momento coterapéutico" nos permite comprender mejor y hacer frente a situaciones en las cuales la intensidad de los fenómenos proyectivos puede llegar a paralizar momentáneamente la capacidad de pensamiento del terapeuta, que no consigue elaborar operativamente la situación y que puede llevar a un estancamiento en la tarea. Asimismo, la actitud de B, muestra a la familia un modelo reparador de la comunicación bipersonal, con el cual se permiten modificar situaciones de envidia y rivalidad familiares, pues B (como Bruno) pasivo y silencioso hasta entonces, no acepta la "muerte" de su colega, que representaba aquí al hermano de Bruno, sino que le permite salir de esa "muerte" enriquecido y nuevamente fecundo, pudiéndose entonces crear un clima más apto para la reparación de ese duelo no elaborado.

Así, la coterapia, puede, a nivel familiar, restablecer modelos más saludables de convivencia, que haga que la familia, a través de experiencias correctoras de la comunicación, se mueva con una soltura mayor de roles, y alterne más plásticamente los liderazgos.

Las alianzas familiares en las terapias de familias de psicóticos

J. E. GARCÍA BADARACCO
A. CANEVARO
O. CZERTOK *

Así como los miembros de una familia sana pueden formar subgrupos (alianzas) que tienden a resolver conflictos que se originan en diferencias, necesidades e intereses contrarios, así también se forman alianzas enfermas para defenderse de conflictos vividos como amenazantes e insolubles.

En las alianzas afectivas sanas hay coherencia y movilidad para una adaptación a la realidad que favorece el crecimiento y madurez del grupo y de sus integrantes. Por el contrario las alianzas enfermas se revelan generalmente estereotipadas, fijas en los objetivos patológicos de negar la realidad y de mantener la omnipotencia, aunque puedan cambiar los personajes que intervienen.

En la práctica de la terapia familiar, sobre todo con pacientes psicóticos, nos encontramos frecuentemente con la formación de alianzas enfermas que funcionan fuertemente cohesionadas en actitudes básicas de ataque o fuga respecto del resto. En dichas familias el paciente es no sólo el depositario de la enfermedad del grupo sino que a su vez es utilizado habitualmente con distintos significados por los subgrupos (alianzas) para hacer prevalecer su dominio.

Así, el paciente al hacerse cargo de las ansiedades psicóticas del familiar es rechazado por todo el grupo por temor a lo proyectado en él, pero a su vez puede ser utilizado por un subgrupo formando una alianza a través de la cual se revelan contra el otro utilizando la defensa, la seducción o el ataque al paciente. De esta forma el paciente pasa de ser el perseguidor del grupo familiar a funcionar alternativamente como perseguidor-perseguido, amado-odiado, idealizado-denigrado, etc., de las distintas alianzas.

El señalamiento e interpretación de estos fenómenos favorecen, evidentemente, cuando las alianzas no se han hecho estereotipadas y

rígidas, la marcha del proceso terapéutico familiar. Pero en las familias de psicóticos, es frecuente que los intentos del terapeuta se estrelen contra patrones rígidos y estereotipados. En estos casos muchas veces los señalamientos no hacen sino aumentar exageradamente las defensas del grupo.

Al optar por la exclusión temporaria de uno o varios miembros hemos visto que se produce una nueva distribución de roles que favorece la elaboración de los conflictos permitiendo la posterior inclusión del o los excluidos en un clima distinto.

Como ejemplo aportamos en forma esquemática la terapia del grupo familiar de Juan, paciente esquizofrénico de 32 años, el menor de cinco hermanos, hijos de una mujer viuda desde hace 15 años. A poco de comenzar la terapia los hijos acusaron a la madre de que no les había dado el afecto suficiente. Lo hacían reprochándole la actitud que tenía con respecto al hijo enfermo, pero en realidad la acusaban indirectamente a través de él. La madre se deprimió cargándose con resentimiento y paralizó la situación mostrando a su vez su soledad y carencia haciendo reproches a los hijos por esto mismo.

Si bien esto era más o menos cierto, era utilizado, sin embargo, en forma de contraataque, lo que imposibilitaba la elaboración de la situación, con lo que conseguía mantener la simbiosis más evidente con el hijo enfermo. Éste en ese momento se plegaba a la madre por temor a hacerle daño o destruirla y teniendo, entonces, que reprimir, disociar y negar su propia hostilidad por la dependencia, estereotipándose en su rol de enfermo.

En ese momento el grupo funcionaba con dos alianzas: una, la de los hermanos de Juan y Juan y otra, la de Juan y la madre. Juan aparecía así "tironeando y confundido". Por otro lado los conflictos entre los hermanos quedaban así, enmascarados.

Se decidió la exclusión temporaria de la madre del grupo; esto permitió la exteriorización de la depresión en los hermanos de Juan y demostró que en realidad la dependencia existía en todos. La aparente independencia de cada uno de los hijos había sido depositada en el paciente, lo que lo obligaba a mantener su rol fijo.

Los reproches ya no estuvieron más dirigidos hacia la madre y se vio cómo ellos habían utilizado en su relación interpersonal mecanismos parecidos a los utilizados por la madre para con ellos.

Apareció muy claro que Juan era utilizado indistintamente como depositario de las frustraciones tempranas de sus hermanos constituyéndose así en un objeto temido por lo proyectado en él a la vez que un objeto muy valorizado porque era el único que se había podido permitir protestar, aunque psicóticamente, frente al régimen impuesto. Cada uno de los hermanos tuvo que responder ante el otro y ante Juan del rol que había sucesivamente jugado en la historia familiar.

Se reincorporó a la madre a la terapia familiar. Los hijos le pudieron ofrecer en ese momento un continente adecuado para sus necesidades de afecto, que perdieron rápidamente el carácter de queja y reproche y se estructuró una nueva alianza entre éstos y la madre para iniciar un proceso de reparación en la figura de Juan.

* Clínica Psiquiátrica, O'Higgins 2328, Capital Federal.

Comentarios sobre una experiencia clínica
con un grupo plurifamiliar de familias con miembros psicóticos
(Versión abreviada)

EDUARDO MANDELBAUM *
BEATRIZ ALAZRAQUI
SILVIA KOZIOL

El presente informe tiene como objeto comunicar algunas reflexiones sobre las vicisitudes de un grupo de familias de pacientes psicóticos que durante dos años, aproximadamente, se reunió en el Sector Hospital de Día y luego en el Servicio N° 3 del Hospital Nacional José T. Borda, cuya jefatura ejerce el doctor García Badaracco.

Encuadre de la tarea. Habíamos comenzado un grupo terapéutico de pacientes psicóticos cuya tarea y encuadre se veía perturbada por las intervenciones de los familiares, quienes requerían información sobre la marcha del tratamiento, normas de conducta para con el paciente, etc. Dado que no podíamos dejar de lado el pedido de ayuda del grupo familiar afectado y tampoco podíamos ocuparnos de cada familia individualmente, decidimos reunir a las mismas en hora y lugar fijos mientras el paciente proseguía su tratamiento individual.

Los objetivos estaban dirigidos fundamentalmente a mantener el contacto permanente con los familiares para asegurar, así, la cooperación para la continuidad del tratamiento, así como adecuar el clima familiar al que el paciente se reintegraba en sus altas parciales o facilitar la convivencia en las horas del día o la noche para los pacientes con régimen de Hospital de Día. Para alcanzar tales fines pensamos que debíamos provocar la interacción profunda y "forzada" entre núcleos que tienden a mantener una estructura cerrada y poco permeable a estímulos que pudieran modificar configuraciones grupales patológicas. Asimismo, consideramos que la interacción familiar múltiple promovería más fácilmente la remoción de estereotipos psicóticos en la percepción y conducta de las familias con respecto a sus miembros enfermos y secundariamente, en su relación con la realidad. Se combinó con las seis

familias una reunión de una hora y media una vez por mes. Nuestra tarea, tanto con el grupo de pacientes como con el grupo de familias, se desarrollaba dentro de la Comunidad Terapéutica, marco habitual en el que nos desenvolvíamos, teniendo ambos grupos la posibilidad de interactuar por lo menos tres veces por semana con otros pacientes del servicio.

El equipo terapéutico se componía de asistente social, terapeuta ocupacional, psiquiatra, enfermera psiquiátrica y psicólogo; en las reuniones participaban todos los profesionales mencionados y la técnica empleada fue la del grupo operativo, funcionando psicólogo y psiquiatra como coordinadores.

Desarrollo de la experiencia. Al iniciarse las reuniones observamos lo siguiente:

1) El contacto entre miembros de las diferentes familias interesándose mutuamente por el miembro enfermo del otro grupo fue una pauta común a gran número de sesiones.

2) Comenzó a romperse el estereotipo del "loco de la familia" que alude a la penosa sensación que el grupo familiar tiene de sentirse discriminado dentro del contexto social sintiéndose culpables y acusados de la locura del paciente. Cada grupo familiar se sintió aliviado de no ser el único con un "loco en casa".

Las situaciones de corte resistencial fueron de dos tipos, por un lado una comparación de normas en el sentido de ver qué hacían las otras familias con el miembro enfermo; esta comparación se fue convirtiendo en un exponer temeroso de las conductas que se habían tenido para con el paciente, viviendo en la fantasía al equipo terapéutico como un juez inapelable de lo que se hacía con el mismo. Esto fue cambiando con el tiempo, haciéndose el clima menos tenso y persecutorio; por otro lado, dicha resistencia se manifestaba en el intento de monopolizar al equipo terapéutico. El señalamiento adecuado respetando los *timings* individuales fue probado recurso operativo tendiendo a cambiar patrones equivocados.

Queremos destacar la importancia de lo que denominamos "eslabón intermedio" entendiendo como tal al familiar que, ambivalentemente aparece haciéndose cargo del aspecto del paciente que quiere curarse y por otra parte acercándose al terapeuta para controlar un agente de cambio vivido persecutoriamente; cuando ambos interrumpían su asistencia nuestra percepción era que la simbiosis se veía excesivamente amenazada y la huida se presentaba como el recurso para preservarla.

Manejo de la contratransferencia. La participación en coterapia de la totalidad del equipo asistencial nos permitió registrar reacciones con-

* Hospital Nacional José T. Borda, Capital Federal.

tránsferenciales variadas y de diferente intensidad. Se registraron intensas reacciones emocionales, sobre todo en miembros del equipo que no tenían tratamiento personal psicoanalítico; la elaboración posterior a las sesiones permitió eludir las consecuencias de contraindificaciones excesivas y el desglose adecuado de transferencia-contratransferencia nos permitió la continuidad adecuada de la tarea.

Pudimos hacer consciente que el hecho de trabajar simultáneamente el mismo equipo terapéutico en tres contextos diferentes: a) grupo de pacientes, b) grupo de familias, c) equipo terapéutico elaborando, nos podía inducir a repetir configuraciones triangulares inconscientes proyectadas por el grupo de pacientes o el de familias.

Evaluación. Tratando de evaluar los resultados desde el punto de vista clínico creemos que algunos de nuestros objetivos se vieron alcanzados. En algunos períodos en que los pacientes dejaban de concurrir, los familiares funcionaban como nexo entre aquéllos y el equipo terapéutico; en otros casos cambiaron actitudes y depositarios, consiguiéndose que algunos familiares se hicieran cargo de sus núcleos enfermos cambiando su actitud de rechazo hacia el paciente o solicitando tratamiento para ellos mismos.

De lo que no pudimos modificar se destaca el hecho de que en las familias en que la madre concurría, el padre estuvo permanentemente ausente. Dado lo exiguo de la muestra no podemos decir si este dato es significativo, si bien en el paciente esa ausencia era claramente detectable.

Por último, creemos que este tipo de manejo técnico es posible gracias al contexto que la Comunidad Terapéutica brinda a paciente y terapeutas.

Patología familiar y esquizofrenia. Un caso clínico

EDMUNDO ZIMMERMAN *
JOSÉ KUTEN

Este trabajo narra la historia y vicisitudes del tratamiento de la primera familia que atendimos. Una discusión diagnóstica acerca de Paula —una paciente de 23 años, internada por un brote esquizofrénico—, en la que se enfatizó cómo se ensombrecía el pronóstico por la patología del grupo familiar, nos llevó a encarar el tratamiento de la familia como complemento de la terapia individual. Haremos a continuación una breve descripción del delirio y de la familia, veremos luego algunas secuencias de las sesiones para referirnos por último a la evolución y conclusiones.

El delirio. Un día en que Paula estaba tomando café en la oficina donde trabajaba, un empleado se le acercó; ella entonces vio todo nublado, sintió frío, luego calor y pensó que él le había puesto algo en el café para seducirla. Comenzó a pensar que estaba embarazada; sentía intensa angustia y veía a la gente como desde detrás de un velo rojo. Los primeros días se sintió muy excitada, luego se aisló. Por todo esto pidió la consulta. Durante su transcurso, un tío que la acompañaba, le dijo al psiquiatra que el padre de la paciente era homosexual. En ese momento Paula comenzó a tener alucinaciones olfatorias: sentía olor a gas.

La familia. Está compuesta por cinco miembros, la pareja parental y tres hijos. Ambos padres están más ligados a sus familias de origen que entre ellos. Sus intentos de acercamiento se ven continuamente perturbados por reyertas que hablan de viejos conflictos nunca enfrentados, o por la intromisión de las hijas que no lo toleran. Se mueven en una constante red de controles de la que no pueden salir. Si un miembro de la familia toma una decisión, los demás lo sienten como una agresión tal, que el primero es atacado hasta que desiste. La división de la familia se fue acentuando hasta llegar a una separación, en la que el padre y las dos hijas menores, fueron a vivir a la casa de la hermana de aquél, y la madre y Paula a la del hermano de aquélla. Este hecho coincidió con dos situaciones: la quiebra económica y la internación de la paciente. A partir de ese momento, la negación de la separación

* Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

ción de ambos padres fue casi constante. Era un acuerdo tácito del que no se hablaba pero que existía de hecho.

Los integrantes. *Padre* (Alberto): Rígido y negador, se refugia en fantasías grandilocuentes, mientras vive de una escasa jubilación, manteniendo una apariencia de condición social alta. Acusado de homosexual, con claras expresiones de celotipia. Desvaloriza lo emocional y atribuye sus dificultades a los problemas económicos: "Ustedes no tiene por qué estar tristes, no hay nadie enfermo" —dijo una vez en plena disolución familiar—; "en casa la palabra sexo es tabú" —fue una de sus primeras frases—, "lo importante son las apariencias".

Madre (Juana): Impresiona como una parafrénica. Sus ideas persecutorias, celotípicas e interpretaciones delirantes, pusieron de manifiesto que era la enferma más grave y crónica del grupo familiar, aun cuando aparentemente su enfermedad había pasado desapercibida. Fija a los demás en los roles que ella misma les asigna. Asegura que sus hermanos son los inventores del estroboscopio y de las máquinas psicotécnicas. Refiere que su padre murió quemado después de haberse limpiado el traje con bencina, al acercarle un fósforo para disipar el olor. Habla siempre de sus enormes sacrificios instilando en sus oyentes intensos sentimientos de culpa.

Paula: 23 años. Sumisa, al principio con gran dificultad para discriminar la patología de la madre de la suya propia, y aceptando sus indicaciones e imitando su modalidad de pensamiento.

Silvia: 21 años. Inicialmente el líder sano del grupo. Hizo una coalición con los terapeutas enfrentando a la madre; fue la primera en descubrir la irrealidad en que ésta se movía. A medida que transcurrió el tratamiento, fue estereotipándose en un rol de observadora crítica.

Alicia: 18 años. Asumió una función silenciosa al principio para convertirse luego en un líder de *insight*, incluyéndose en la problemática familiar.

Algunas secuencias. En las secuencias que mostraremos, se ve cómo interactúan especialmente la madre y Paula, y cómo el cuadro psicótico de esta última se va despejando a medida que se pone de relieve el de la primera.

En una de las primeras sesiones la madre dice: "... Paula quería pedir protección al snc. Hacía el saludo nazi y todo esto tiene que ver con la amistad de Gaby, que estudia química con Richter. Por eso consideré peligrosa la amistad de Gaby. Qué raro lo que pasó en tu oficina. Todo coincide. Para lo único que soy normal es para trabajar. Yo la eché. Que Dios me perdone si calumnio. Lo cierto es que Paula se enfermó".

Lo que vemos aquí es la indiscriminación entre fantasía y realidad y la confirmación que le hace la madre a Paula de la interpretación delirante de los hechos. En esta sesión Paula está callada, sentada al lado de la madre y muy angustiada mientras el resto de los integrantes continúa el diálogo sin hacerle notar el plano irreal en el que se desarrolla.

Después de varios meses, Paula reacciona frente al discurso de la madre, rectificando el delirio. M.: "Yo le noté el desvarío a Paula cuando fue a la editorial y cada vez que tomaba café se marcaba y el tipo la seguía". Paula: "En el café no había nada". M.: "Vos me lo decís". Paula: "No había nada en el café". M.: "Es una incógnita, porque si no le pusieron nada en el café, yo no entiendo".

El próximo fragmento muestra la persistencia de las ideas delirantes de la madre y la escasa reacción del resto de la familia, pasando del plano racional al irracional sin discriminarlos. M.: "Cuando están los dos doctores, el doctor Kuten escribe y éste es un cuaderno nuevo, ya van varios". P.: "Van a formar una enciclopedia". P.: "Cuando está el doctor Zimmerman nada más escucha. El doctor Kuten a veces pone un grabador". M.: "El grabador está siempre". P.: "Mamá cree que siempre se graba. Cree que hay cables ocultos". M.: "No, a mí no me molesta". Silvia: "Sí, engañate a vos misma, que si no hay grabador hay taquigrafía". M.: "Si yo reviso, encuentro".

A medida que la psicosis de la madre se fue manifestando con mayor claridad a lo largo de las sesiones, nos planteamos la posibilidad de hallarnos frente a un cuadro de *folie a deux*. Noyes describe los rasgos clínicos de la *folie a deux* como de naturaleza paranoide en que la identificación suele ser un importante mecanismo de producción. Las falsas percepciones paranoides que sufre una de las personas íntimamente asociadas a otra, son comunicadas y aceptadas por ésta. La descripción clínica de la madre y de Paula confirmarían este diagnóstico, pero sólo un enfoque psicodinámico aclarará su patogenia.

Lo que fenomenológicamente aparece como *folie a deux*, puede verse desde un punto de vista dinámico como una consecuencia de la imposibilidad familiar para elaborar los duelos. La familia niega su separación, y a pesar de que ésta lleva ya dos años —el único lugar de reunión que tienen es el hospital— aluden a ella como "provisoria"; frente a la muerte de un familiar cercano continúan hablando de él en presente, como si estuviera vivo, y cuando el terapeuta se los señala explican que se trata de una costumbre familiar ante las muertes. La situación básica de duelo que la familia no ha podido elaborar es la psicosis de la madre. Necesitan mantener una ficción de madre, así como mantienen una ficción de familia; Paula carga con la enfermedad porque eso es menos doloroso que reconocer que tienen una madre loca.

En tercer lugar observamos como factor de importancia patógena, la intensa ligazón de la pareja parental a sus propias familias de origen. También aquí nos encontramos con una dificultad para elaborar duelos. Cuando Paula fue externada, cada uno de los padres se fue a vivir con sus hermanos, y en situaciones extremas confunden a los hijos con los padres.

Una línea de pensamiento separada de la anterior, apunta a la relación entre el contenido del delirio y la patología familiar. El delirio encubre y devela otra fuente de conflictos de la familia, su problemática sexual. Por un lado, el padre dice que en la casa, la palabra sexo es tabú; por otro, la madre les ha hablado a las hijas desde chicas de la supuesta homosexualidad del padre; éste ha ejercido siempre un severo control sobre las hijas, vigilando sus relaciones y mostrándose celoso, tanto frente a las hijas como frente a la madre. El cuadro colgado por él en el comedor de la casa es el de Otelio estrangulando a Desdémona. Una secuencia ilustra este aspecto: Silvia: "Siempre en casa la palabra sexo, fue pintada con el peor color". M.: "No por mí, pero hay tantas cosas lindas de que hablar. Te acordás de cuando sacabas tazas finas para tomar (alude a un episodio de neurosis obsesiva en el cual Silvia no podía tomar café en las tazas de diario. También la taza de café jugó un

papel importante en el delirio de Paula). A los chicos, por qué hablarles de lo sexual". S.: "Nos hablabas de la deformación de lo sexual".

Evolución. La familia lleva dos años de tratamiento. Se dividieron en dos fracciones, situación que aún persiste. Los roles en las sesiones se fueron haciendo cada vez más plásticos, desapareció "la enferma sancionada" —Paula— para hacerse cada vez más notoria la necesidad de tratamiento de la pareja parental hasta ser verbalizada por ellos. Las tres hijas se encuentran en tratamiento individual.

El padre: Comenzó a expresar emociones, se mostró apenado al finalizar el año de tratamiento, así como también por no hallar solución a los problemas familiares. Reconoció finalmente que asistía al tratamiento familiar por él, más que por su hija.

La madre: Es la que menos se modificó. Durante un período estuvo en tratamiento medicamentoso que abandonó. Pensamos que su pronóstico es reservado.

Paula: Hace ya más de un año que está sin medicación. No hubo recidiva del brote en los dos años transcurridos. Aprendió a discriminar, a competir con las hermanas y a compartir algunas actividades con ellas, así como también realizó algunos intentos de trabajos independientes.

Silvia: Fue la primera que pidió tratamiento individual. Hizo un intento de separarse del grupo, que no prosperó. Su actitud se tornó más cooperativa, incluyéndose en su compromiso con la familia.

Alicia: Fue participando cada vez más activamente en el grupo familiar. También pidió terapia individual, y en el transcurso de estos dos años pudo terminar sus estudios secundarios.

Conclusiones.

- a) *Clínicas:* El trabajo muestra las posibilidades de evolución de un grupo familiar, como resultado del cual pudimos observar:
 - 1) Remisión del cuadro esquizofrénico, con reintegración a sus tareas habituales, sin aparición de nuevos brotes en el transcurso de estos dos años.
 - 2) Apertura de una terapia psicológica para otros miembros de la familia.
 - 3) Reconocimiento e inicios de elaboración de la patología de la pareja parental.
- b) *Conclusiones teóricas:*
 - 1) Planteamos como dato a comprobar en otras familias, que la falta de elaboración de duelos importantes es uno de los principales factores patógenos en el grupo familiar. Habría que comprobar en qué medida es ésta una característica de las familias con un miembro esquizofrénico y cuáles son los matices diferenciales con otros cuadros.
 - 2) La asunción por uno de los miembros del rol enfermo, como fantasía de reparación patológica.
 - 3) Creemos que el tratamiento familiar combinado con el individual, es el ideal en pacientes con un brote esquizofrénico, permitiendo una mejor evolución y disminuyendo la posibilidad de recidivas.

Test interpersonal proyectivo para parejas (TIPP)

HUGO BLEICHMAR
CARLOS E. SLUZKI
GLORIA SMOLA *

A) Introducción. La realidad depende de nuestras creencias, según Bateson. Pero a su vez nuestras creencias dependen de la realidad. Si aplicamos estas afirmaciones al estudio de las relaciones de pareja, resultará que de acuerdo a la percepción que cada uno tenga de sí mismo y del otro se derivarán conductas que actuando sobre cada integrante podrán modificarlo muchas veces en el sentido de las expectativas previas, a la manera de las profecías que se autorealizan, modificación que a su turno revertirá sobre las percepciones reestructurándolas. Nos encontramos entonces que a través de esta compleja interacción entre realidad y creencias se pondrán en operación, en cada momento determinado y para cada uno de los componentes de una pareja, múltiples imágenes de cómo se ve a sí mismo y al otro, de cómo le gustaría que fueran, cómo supone que el otro se ve a sí mismo y a él, etc. Dado que la relación de pareja se conformará en función del "engarce" entre esas percepciones o "imágenes" que aporta cada miembro, la detección de las mismas adquiere particular relevancia para comprender el proceso de interacción y por ende para el desarrollo de cualquier psicoterapia de la pareja.

Ahora bien, para poner en evidencia estas "imágenes" se podría recurrir a un cuestionario directo en que se pida opinión acerca de diversos aspectos o conductas de sí y del otro. Pero este método presenta los inconvenientes de toda encuesta de opinión: el control consciente del emergente y la tendencia a respuestas convencionales. Un test proyectivo, por el contrario, permite enfrentar en condiciones más favorables ambas dificultades.

En la presente comunicación informaremos acerca de un test proyectivo para parejas que tiene por finalidad permitir la detección y

* Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Servicio de Psicopatología, Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

correlación de las imágenes que cada miembro de la pareja tiene de sí, del otro y de la pareja como totalidad, y de cómo esas imágenes se ven influenciadas por el proceso de interacción. Dadas las características del instrumento lo hemos denominado Test Interpersonal Proyectivo para Parejas, abreviadamente TIPP.

En el desarrollo de esta exposición quedará claro que el TIPP posee una fuerte influencia de dos fuentes: El Test Desiderativo de Pigen Serra¹ en el que se inspiraron buena parte de las consignas, y el "Interpersonal Perception Test", de Laing Phillipson, y Lee², del que se siguió parte del criterio general para el análisis de ciertos datos.

B) Descripción del instrumento. El test consta de tres momentos: una apertura en que a ambos miembros de la pareja se les informa de la tarea, luego un tiempo individual en el que se interroga a cada uno por separado, y finalmente un tiempo conjunto en que las preguntas se formulan a la pareja.

1. *Apertura:* Se hace pasar a la pareja y se les dice: "Les voy a hacer una serie de preguntas, primero a cada uno de ustedes por separado y después a los dos juntos. Quisiera entonces que se quede aquí uno de ustedes y el otro espera afuera durante unos minutos". (Se registra este primer momento de Interacción.)

2. *Tiempo Individual:* "Le voy a hacer seis preguntas en total, que están divididas en dos grupos: las primeras tres se refieren a cómo usted piensa que son su esposo y usted. Las otras tres se refieren, en cambio, no a cómo *son* en realidad sino a cómo *le gustaría* que fueran. Vamos a comenzar por el primer grupo de preguntas, las que se refieren a cómo usted piensa que son realmente su esposo y usted.

1. Imagínese que su esposo/a se convirtiera en algo que no fuera una persona pero que reflejase de alguna manera el modo de ser de él/ella. En ese caso, ¿en qué se convertiría?
2. Ahora imagínese que usted se convirtiera en algo que no fuera una persona pero que reflejase de alguna manera su modo de ser. En ese caso, ¿en qué se convertiría usted?
3. Ahora imagínese que usted y su esposo/a se convirtieran en algo que no fuera una pareja de personas pero que reflejase de alguna manera, cómo son ustedes como pareja. En ese caso, ¿en qué se convertirían?

Una vez contestadas estas preguntas se le dice:

"Ahora vamos a pasar al segundo grupo de preguntas. Las que se refieren a cómo le gustaría que ustedes fueran".

4. Imagínese que su esposo/a se convirtiera en algo que no fuera una persona. En ese caso, ¿qué le gustaría a usted que él/ella fuera?
5. Ahora imagínese que usted se convirtiera en algo que no fuera una persona. En ese caso, ¿qué le gustaría ser a usted?
6. Ahora imagínese que usted y su esposo/a se convirtieran en algo que no fuera una pareja de personas. En ese caso, ¿qué le gustaría que fueran ustedes dos?

Decodificación de las respuestas. Una vez que el entrevistado contestó las seis preguntas anteriores se trata de determinar qué connotación particular tiene para él cada una de las respuestas. Para ello se utiliza el siguiente método de asociación verbal:

"En qué le hace pensar un..." (y se le propone la respuesta que dio para cada una de las preguntas. Así por ejemplo, si a la primera pregunta contestó "un molino", se le interroga: "¿En qué le hace pensar un molino?").

3. *Tiempo conjunto.* (A ambos miembros de la pareja en conjunto.) "A cada uno de ustedes le he hecho las mismas preguntas. Ahora quisiera que contestaran las preguntas que voy a hacerles *trayendo de llegar a una respuesta única en que los dos estén de acuerdo:*

- 1— Imagínense que ustedes se convirtieran en algo que no fuera una pareja de personas pero que reflejase de alguna manera cómo son como pareja. En ese caso, ¿en qué se convertirían?
- 2— Imagínense que ustedes se convirtieran en algo que no fuera una pareja de personas, ¿en qué les gustaría convertirse?"

Decodificación. (Igual al tiempo individual.)

C) Comentarios. El TIPP no constituye un test de personalidad de cada uno de los individuos que forman una pareja, aun cuando sus datos puedan dar indicios en ese sentido. Se trata en cambio de un test centrado en la relación interpersonal. Ello es así no solamente porque posee un tiempo conjunto, porque el análisis de las respuestas se efectúa mediante apareamiento y comparación entre respuestas individuales sino porque dado el contexto en que se toma el test —una entrevista de pareja— y el tipo de consignas, las respuestas proveen necesariamente información acerca del vínculo que existe en la pareja.

En el TIPP se piden dos tipos de respuestas: aquellas que llamaremos "imágenes reales" y las que llamaremos "imágenes ideales" o de realización de deseos. Es importante aclarar que el nombre de "reales" no implica que supongamos que reflejen las características de la persona tal cual ésta es objetivamente, sino que se refiere al hecho de que el que responde las concibe como describiendo de manera realista su

forma de ser o la de su pareja. Más aún, en algunas parejas, las respuestas que uno o los dos miembros dan como "reales" pueden ser claramente producto de la idealización y coincidir con las que dan como "ideales". Dado que son posibles todas las combinaciones, por ejemplo, que la imagen real de sí mismo coincida con la ideal de sí, que la imagen ideal de sí coincida con la considerada real para el otro miembro de la pareja, etc., el TIPP permite la construcción de una tipología observacional de parejas en base al parámetro idealización. De este modo se pueden describir por ejemplo a parejas cuyos miembros funcionen con idealización de sí y del otro, con desvalorización de ambos, y así sucesivamente, con las posibilidades combinatorias de las respuestas de ambos integrantes. Por otro lado en algunas parejas es posible interpretar la discordancia entre las imágenes reales y las ideales, como índice de deseo de cambio. Así, por ejemplo, si en la imagen real figuran atributos con valoraciones claramente negativas y en la ideal atributos especularmente opuestos, valorados como positivos, se puede inferir el deseo de cambio. Para cada miembro de la pareja es factible la confección de alguno de los siguientes perfiles:

- Que yo no cambie y el otro sí.
- Que yo sí cambie y el otro no.
- Que yo sí cambie y el otro también.
- Que yo no cambie y el otro tampoco.

Lo anterior sirve para mostrar que el TIPP, no sólo permite un análisis de contenido, es decir, de las imágenes específicas que cada pareja tiene sino además un análisis formal o de configuraciones. Así dos parejas podrán diferir en cuanto al contenido específico de sus respuestas, pero podrán tener el mismo perfil o configuración en cuanto a si ambos integrantes tienden a ubicar la valorización en sí y la desvalorización en el otro o a idealizar a ambos. Es precisamente en la posibilidad de un análisis formal y de la construcción de diferentes configuraciones para la pareja donde reside el potencial del TIPP como instrumento de investigación, ya que abre el camino para establecer correlaciones entre diferentes tipos de parejas con formas específicas de conflicto entre sus miembros o con determinada patología de los hijos, por ejemplo.

Otro aspecto del TIPP que merece ser comentado es su propiedad de estar constituido por dos tiempos: el individual y el conjunto. El conjunto permite obviamente observar la interacción que se genera alrededor de responder las preguntas, si las parejas pueden o no llegar a un acuerdo, si frente al desacuerdo hay un reconocimiento explícito del mismo, etc. Pero con todo, esto no sería algo específico del TIPP, sino que ante cualquier tarea que una pareja deba realizar en común; se pueden observar estos aspectos de la interacción. Lo interesante reside en la posibilidad de comparar las respuestas dadas en el tiempo

individual con las dadas en el conjunto. Se puede observar si en el tiempo conjunto los miembros de la pareja dan las mismas respuestas que en el individual, si aceptan la del otro aun cuando estén en contraposición con la propia dada en el tiempo individual, si proponen una respuesta de transacción entre las dadas en ambos tiempos individuales, etc. Esto posibilita operacionalizar conceptos como dominancia-sumisión, dependencia-independencia. La interacción que tiene lugar en el tiempo conjunto, puede ser además aprovechada para detectar los métodos empleados por cada miembro de la pareja para la inoculación de imágenes en el otro.

Para el análisis de las respuestas del TIPP se construyeron categorías que no derivan directamente de supuestos clínicos. Con todo se intenta relacionar estas configuraciones con diversos conceptos clínicos relevantes. En este sentido algunos, como por ejemplo, los de simbiosis, narcisismo, autismo, falta de discriminación yo-no yo, pueden ser correlacionados con los resultados del TIPP. Así si las respuestas acerca de *cómo se desea que el otro sea* coinciden con cómo el individuo se ve a sí mismo, podemos pensar que la relación es de tipo narcisista en que el otro es visto o deseado fundamentalmente como una extensión de sí mismo. Este aspecto del TIPP al mismo tiempo que prometedor es, sin embargo, uno de los que merece ser tomado con la mayor cautela, en esta fase de la investigación, hasta tanto no se hagan estudios de doble ciego entre protocolos de TIPP e historias clínicas de la pareja que permitan afirmar que tales correlaciones son válidas.

Apéndice. Grillas para el registro de respuestas

		Acerca de		
		♂	♀	♂
Responde		1	2	3
	R			X
	I			
	R			
	♀			
	I	X X		

Grilla para el registro de respuestas del tiempo individual (TI)

Notación: "1", "2", "3", indican la columna correspondiente a las respuestas acerca del varón, de la mujer y de la pareja, respectivamente. "R", "I", indican si la respuesta se refiere al nivel real o al ideal, respectivamente. "♂", "♀", indican si la respuesta es dada por el varón o por la mujer, respectivamente. Cada columna está dividida por una línea de puntos. A la izquierda se escribe el símbolo y a la derecha los atributos dados como asociaciones al símbolo.

Ejemplo: Respuesta dada por el varón en el tiempo individual acerca de la pareja, nivel real: "Una casa, cómoda, ordenada, limpia". Esta respuesta se ubicará en la parte de la grilla señalada con una cruz.

Ejemplo: Respuesta dada por la mujer en el tiempo individual acerca del varón, nivel ideal: "Las estrellas; una las mira todas las noches, son lindas"; se ubicará en la parte de la grilla señalada con dos cruces.

	TI	1 ^o resp.	2 ^o resp.	etc.	Resp. final
R	♂				
	♀				
I	♂				
	♀				

Grilla para el registro de respuestas del tiempo conjunto (TC)

En la primera columna (TI) se escribe la respuesta dada por cada uno de los miembros de la pareja en el tiempo individual. Símbolos y asociaciones se colocan tal como se indica para la grilla anterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. FIGEM SERRA J. M. — *La prueba de la expresión desiderativa*. Barcelona, Ciencias Médicas, 1949.
2. LAING R. D., PHILLIPSON H. y LEE A. R. — *Interpersonal Perception*. Londres, Tavistock Publications, 1966.

"Los inviolables": Una pareja y su mito

MARÍA LUISA L. DE SCHUGURENSKY
HELENA LYGO
SAMUEL KRYNSKI *

"... Así el mito confunde la necesidad de los fenómenos físicos con la actividad voluntaria del hombre; trata esos hechos constantes y eternos como los acontecimientos caprichosos de una historia que ha sucedido en el tiempo. En el seno de ese mundo inconsciente y de las fuerzas ciegas introduce el drama, y este drama lo cuenta con imaginación y en un lenguaje figurado cuya clave tenemos que descubrir." DECHARME.

Vamos a presentar el caso clínico de una pareja que no podía consumar el acto sexual. De acuerdo a nuestras consultas bibliográficas, sólo se encuentran como antecedentes, tratamientos individuales de fobias a la desfloración.

Aunque consultaron en forma separada, decidimos tratarlos como pareja basándonos en los siguientes ítems: la evidente complementariedad manifestada en el motivo de consulta; el grado de compromiso entre sí y con la consulta quizás más importante que el grado de plasticidad o *insight* que se percibía; una vivencia contratransferencial positiva e interés por el caso en sí.

Se trata de una pareja joven entre 25 y 30 años, Lucía y Andrés, de aspecto agradable y que impresionan como adolescentes confundidos. Él, profesional universitario; ella, ama de casa, con estudios secundarios inconclusos. Ambos proceden de familias muy católicas. El padre de Lucía, sacerdote de una orden muy estricta durante varios años, abandonó luego los hábitos, y la madre tenía hermanos ordenados con jerarquía eclesiástica. Los padres de Andrés se desempeñaban activamente en instituciones católicas y sus hijos fueron educados en colegios religiosos.

* Departamento de Familias del Centro de Salud Mental n° 1, coordinación y supervisión del doctor Ignacio Maldonado Allende.

Andrés y Lucía compartían un modelo de pareja parental caracterizado por: madres prolíficas, las figuras fuertes e idealizadas del hogar; y padres débiles y deteriorados. El de Lucía, ex catedrático, sin progreso económico y con creciente adicción alcohólica; el de Andrés, médico fracasado en el desempeño de su rol profesional.

Cuando nuestra pareja consulta a la institución en la cual trabajamos, llevan un año y tres meses de casados. Fueron asistidos por una terapeuta mujer, con un contrato de diez meses, de una hora semanal de atención. Podemos discriminar tres etapas significativas en el tratamiento: los primeros cuatro meses; el embarazo y como tercera etapa, pre-parto, parto y seguimiento.

Los primeros cuatro meses. Lucía y Andrés consideraban su problema como excepcional; el no tener relaciones sexuales los llevaba a auto-calificarse como "la mosca blanca". Mostraban una relación asimétrica entre sí: Lucía-paciente y Andrés-acompañante; Lucía-hija y Andrés-papá, intentando encubrir una pareja de hermanos que temía ser puesta en evidencia por la terapeuta-mamá. Esto fue deducido a partir del contenido de las identificaciones proyectivas que se daban entre Lucía y Andrés, basadas en el vínculo erótico que los unía a sus hermanos.

Se enfatizaban las resistencias de Lucía a ser penetrada. Las sensaciones corporales que no podían ser codificadas eran peligrosas. La ansiedad paranoide imponía conductas estereotipadas de defensa, prevaleciendo así el monólogo sobre el diálogo, la masturbación sobre la penetración y la pasividad sobre la actividad. Corolario de todo esto era un vínculo sado-masoquista caracterizado por la descalificación recíproca de pensamientos y sentimientos.

A lo largo de este período vimos cómo Lucía se hacía cargo de los aspectos enfermos y desvalorizados de la pareja, guardando Andrés para sí aquéllos relacionados con la adultez y responsabilidad. Esta concepción tácita se explicitó cuando plantearon la intervención quirúrgica del himen.

Ese proyecto pudo ser comprendido en toda su implicancia al traer Lucía un recuerdo traumático de la niñez, relatado como un intento de reducción y violación por parte de su padre. Lo interpretamos como un recuerdo-pantalla, donde la imagen de un médico-sacerdote-victimario, servía para encubrir la relación incestuosa-fraternal subyacente.

Lucía rechazaba su femineidad: fluctuaba entre el peligro de ser destruida y el sentimiento de estarlo ya. Este temor se debía a la amenaza de la reintroyección de sus sentimientos hostiles. Para Andrés, el coito era un acto denigrante, y vivía la desfloración de Lucía como pervertirla y prostituirla; temía, por lo tanto, su reacción hostil.

Queda claro que en esta pareja, las fantasías psicóticas estaban referidas al área sexual: de rotura, en el caso de ella, y de descontrol en el de él.

Las dificultades para sentir y pensar, relacionadas con su incapacidad para denominar, los lleva a actuar. Y llegamos a la segunda etapa:

El embarazo. Comenzaron a traer síntomas de embarazo pero sin poder referirse a él; el nombrar quedaba a cargo de la terapeuta, quien era entonces la mediadora entre las sensaciones y los conceptos.

Las dificultades para reconocer las relaciones sexuales implícitas en el hecho del embarazo, hizo surgir la fantasía de un embarazo psicológico: el hijo de dos chicos jugando.

Ante la certeza del embarazo disocian la vivencia de su sexualidad en dos aspectos: uno adulto (otros que miran) y uno infantil (lo que ellos guardan). En tanto el saber-memoria está en la terapeuta necesitan desvalorizarla, y esto les impide recuperar los ojos puestos en ella y mirar sus relaciones.

La relación de ambos con la terapeuta se tornaba cada vez más ambivalente, asemejándose a la que experimentaban hacia el hijo: deseado y temido. Una forma de controlar estos sentimientos era a través de la distancia, mediante sucesivos viajes que imponían discontinuidad en el tratamiento. En tanto preservaban a la terapeuta-continente, se aliaban contra la terapeuta hostil: por primera vez pueden tener relaciones sexuales, rompiendo el tabú a la desfloración.

Con el esclarecimiento de la concepción mágica del hijo, Lucía comienza a afirmarse en un equilibrio narcisístico. Andrés, por su parte, abandona el rol de padre sustituto por el de un chico abandonado que busca protección en la terapeuta-mamá.

Lucía proyectaba en el futuro hijo la agresividad que sentía hacia su propia madre, figura de identificación destructiva, y Andrés vivía a Lucía embarazada, como el superyó materno. Una manera de controlar estos efectos era apoyarse en estrategias previas: Lucía se mostraba débil e incompetente a través de un juego seductor, respondiendo Andrés con actitudes que oscilaban entre el reproche, la normatividad y una pseudo-comprensión.

Nos referiremos ahora a la *etapa del pre-parto, parto y seguimiento*.

A esta altura comenzamos a temer la posible ruptura del equilibrio narcisístico de Lucía en el momento del parto, con un cuadro psicótico ulterior. Ratificaban nuestra impresión los siguientes hechos: en el 7º mes de embarazo, Lucía tuvo caídas sobre el vientre y sintomatología que atribuía a apendicitis; se le indicó reposo absoluto. En el 9º mes surgieron ideas bizarras y de contaminación: quería comprar otra plancha porque la que usaba tenía microbios.

Sin embargo, el parto se desarrolló favorablemente, y Andrés trajo con alegría la noticia del nacimiento de su hijo varón.

Dentro de esta etapa ambos promovían un modo peculiar de re-equilibrio, tendiente a negar la relación de pareja. Lucía reproducía con el hijo la pareja omnipotente que aparecía en otros momentos,

vinculada a la terapeuta, a la partera, etc. Andrés expresaba su exclusión diciendo: "Estoy radiado" o "Me sentí padre de golpe, de un día para otro".

Se reiteraba la dificultad para nombrar al hijo como sucedió, antes, con el embarazo.

Indudablemente, persistían serias dificultades para la integración de esta pareja, pero pudimos rescatar algunos aspectos:

- Se amplió la percepción de su relación global como pareja;
- El proceso de "aprender a aprender" se desarrolló a través del hablar y pensar juntamente con la terapeuta, disminuyendo así el caudal de dramatizaciones. Un ejemplo de esto estaría dado por las posibilidades de verbalizar las relaciones con sus padres, en lugar de actuarlas.
- La inclusión del hijo promovió el aprendizaje de nuevos roles y permitió el esclarecimiento del papel que éste cumpliría en relación a la pareja.

Mito. Vamos a retomar lo relatado acerca de esta pareja, en relación al mito de la virgen María. Éste dice:

"Nuestros primeros padres vivieron en un estado de santidad; eran inmortales, estaban libres del dolor".

"Pecaron gravemente contrariando los preceptos de Dios. Todos los hombres que descienden de Adán, excepto María, vienen al mundo manchados por la culpa: pecado que les priva de la gracia santificante necesaria para ser admitidos ante Dios."

En nuestro caso, los primeros Adanes son los padres de Lucía y Andrés, fracasados en la consagración a sus sacerdocios, y por ende, pecadores. Pensamos que aquí, como dice T. Reik, no fue el deseo sexual el que motivó el sentimiento de culpa ante el pecado sino el de agresión a Dios: intentaron ser como Él, robando su sabiduría. Esta agresión se vuelve contra ellos mismos y sus consecuencias son legadas a Lucía y Andrés.

"Cometido el pecado y la expulsión del paraíso, Dios promete al género humano culpable un Redentor futuro, que nacido de Mujer, vencerá el mal a costa de su vida. Jesús, hijo de Dios, tomó naturaleza humana en el seno de una Virgen. Unido a María en legítimo matrimonio, José, padre nutricio y adoptivo, se somete al designio divino que hay que acatar."

Lucía y Andrés llegan como "*Los Inviolables*", la pareja sagrada que debe redimir el pasado familiar. Esta redención implica la necesidad de un hijo Mesías que los salve de los pecados cometidos. "... Y el nacimiento de Jesucristo fue así: Que siendo María su Madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo."

Conclusiones. Creemos, como A. Ferreira, que la enfermedad mental de uno o más miembros de la familia, es un aspecto de sus relaciones habituales. Estas relaciones se estructuran en base a expectativas recíprocas que cada uno de los miembros tiene con respecto a los demás y entre sí. De este modo, se pautan vínculos tendientes a elaborar los mitos familiares pre-existentes, como un modo de preservar el equilibrio intrafamiliar.

Nos vamos a referir, ahora, a los tres indicadores que hemos utilizado para la comprensión del mito:

Primer indicador. Concepción interna de las relaciones familiares, según la cual se estipulan conductas y se definen roles e identidades. Vimos un *modelo de pareja parental*, compartido por Lucía y Andrés, con madres omnipotentes y padres deteriorados: son los primeros Adanes, que legan el pecado original a sus hijos. Nuestra pareja se asume fraternalmente como María y José, para concretar la redención familiar.

La consulta introduce al Espíritu Santo-terapeuta. Este rol, dentro del mito, implicaba el mediador que la pareja necesitaba para concretar el vínculo de amor y hostilidad entre padres e hijos. Desde la función terapéutica, esclarecía la relación entre la pareja estéril y la pareja mesiánica.

Segundo indicador. Proyecto de acción. Incluye un conjunto de patrones y rituales programados con un valor económico para las relaciones familiares. Vimos que tiende a cumplir con el mito: un hijo concebido de virgen para salvar a la familia del pecado, concretando el filicidio.

Tercer indicador. Defensa grupal. Tendiente a preservar el equilibrio intrafamiliar. Lucía y Andrés actúan e imponen una pareja heterosexual capaz de engendrar omnipotentemente un hijo, defendiéndose así de la pareja fraternal incestuosa para quien la redención es *tabú*.

En función de estos tres indicadores, nuestra hipótesis es que: el mito configura un área de seguridad capaz de resguardar el grupo familiar de las amenazas externas e internas, que podrían suscitar la emergencia de las ansiedades psicóticas.

La validez de esta aproximación al grupo familiar, radicaría en su posibilidad diagnóstica, y pronóstica, a confirmar en nuestra labor futura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antiguo y Nuevo Testamento.* Buenos Aires, Soc. Bíblicas Unidas, 1949.
 CESARMAN F. V. — Complejo de Edipo y recuerdo oníbrido. *Cuadernos de psicoanálisis*. Asoc. Psicoanal. Mexicana, abril-junio 1965.
 FERREIRA A. — Psicosis y mito familiar. *Amer. J. psycho.*, 1967.
 FREUD S. — *El tabú de la virginidad*. Obras completas, t. 13, Rueda.

- FRAZER J. — *La rama dorada*. México, Fondo de Cultura Económica, 1951.
- GARRIGOU-LAGRANGE R. — *Las tres edades de la vida interior*. Debedec, 1957.
- GREENACRE P. — *Trauma, desarrollo y personalidad*. Buenos Aires, Paidós, 1960.
- LANGER M. — *Maternidad y sexo*. Buenos Aires, Nova, 1951.
- LOMAS P. — Passivity and Failure of Identity Development. *Int. J. psychoanal.*, 1965, 46, 4.
- MAIN T. F. — Mutual Projection in a Marriage. *Comprehensive Psychiatry*, 1966, 7, 5.
- OLIVEIRA W. I. — Psicoanálisis de una fobia a la desfloración. *Rev. de psicoanál.*, enero-marzo 1953.
- PRADÓ HUANTE H. — Un caso de fobia a la desfloración. *Rev. Mex. de psicoan.*, México, 1967.
- REIX T. — *Myth and Guilt*. New York, Braziler, 1957.
- REIDER N. — Chess, Oedipus and the Mater Dolorosa. *Int. J. psychoanal.*, 1959, 40, 5-6.
- TERUEL G. — Consideraciones para el diagnóstico en la psicoterapia familiar. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, Buenos Aires, 1968.
- VON RUDLOFF L. — *Breve teología para laicos*. Buenos Aires, Desclée, de Rowner, 1957.
- SZKELY LAJOS. — Screen Memory and Myth Formation in a Case of Apparent Pre-Cognition. *Int. J. psychoanal.*, 1958, 39, 2-4.

Tema general

Las variables tiempo-casa-identidad en algunos grupos familiares

GISELA G. DE AHLIN
JAIME S. SZWARSTEIN *

Presentaremos algunas observaciones derivadas de nuestra experiencia en tratamientos de un tipo específico de grupos familiares, realizados en el Centro de Salud Mental N° 1, de la Municipalidad de Buenos Aires.

Estos grupos pertenecen a la categoría que en un trabajo anterior denominamos "Familias aisladas", entendiendo por tales a las que interactúan sólo con grupos naturales (familiares y/o vecinos). Nos referíamos entonces concretamente a familias nucleares. Las que presentamos en esta comunicación no lo son, ya que justamente la característica fundamental que las homologa y llama en primera instancia nuestra atención es la convivencia de tres generaciones en la misma casa.

Para facilitar la exposición denominaremos S.1 al subsistema que corresponde a los abuelos, S.2 a los padres y S.3 a los hijos.

En las tres familias a las que concretamente nos referiremos, el paciente identificado estaba en S.3 y fue traído a la consulta por S.2.

Si bien los síntomas manifiestos son diferentes en los tres casos, hay una total coincidencia en el motivo de consulta latente: la dificultad de separación de padres e hijos entre sí, lo cual abarca a los tres subsistemas mencionados.

Conviene en este punto aclarar que las familias se presentaban como formadas por tres generaciones. Bajo este nivel de organización manifiesto se ocultaba otro en el cual los límites generacionales eran difusos. De las tres familias estudiadas pudimos abstraer una serie de características comunes (que se refieren tanto a aspectos observables como inferidos) que pasaremos a describir.

La casa pertenece a S.1. Nunca hubo vivienda en otra parte. Siempre hubo cohabitación de S.2 y S.3, no justificada por las posibilidades

* Centro de Salud Mental n° 1, Municipalidad de Buenos Aires, Dep. de Familias. Coord. doctor Ignacio Maldonado Allende.

reales. S.1 aparecen como líderes autoritarios que dictan las normas de circulación y de uso de determinadas habitaciones u objetos: que no se puede tocar; que no se puede construir, que no se puede cambiar.

S.2: escasa intimidad en la pareja, pasan poco tiempo juntos. Casi no salen sin los hijos. Sus roles son fijos. El marido tiene mayor contacto con el "afuera" pero a través del trabajo. En la casa es el líder de "autoridad tranquila" se entiende mejor con los hijos que la esposa que es más ansiosa y con menor eficacia. Hay similitud en la prehistoria de cada uno: carencias, padres que los abandonaron, murieron o viviendo les dieron escaso afecto.

Dan poca importancia o niegan los conflictos entre sí, acentuándolos más con sus hijos, especialmente con el paciente identificado. Con respecto a S.1 "muestran y esconden" sus sentimientos. Hay una relación de sometimiento resentido bajo un aparente deseo de independencia.

Se muestran como una pareja compuesta por dos personas diferentes pero subyacentemente conforman una estructura fraterna cuyos miembros tienen rasgos de personalidad similares.

En las sesiones aparecen por momentos como hermanos rivales o que esconden juegos sexuales compartidos frente a un tercero que mira. En general se los siente como un bloque, como una unidad poco diferenciada más que como una pareja compuesta por dos individuos diferentes. Frente a temas que impliquen cambios, alternan en su aceptación o negación en marcada rotación de roles. Se muestran impotentes frente a la educación de sus hijos, tratando de controlar los aspectos combatidos: autonomía, espontaneidad, sexualidad, agresividad y especialmente su relación con el mundo externo (amigos, lugares, etc.).

Los hijos se rebelan y someten alternativamente en forma análoga, pero con mayor intensidad a lo que ocurre entre S.2 respecto a S.1. Predomina el lenguaje de acción y doble mensaje. La vida familiar se desenvuelve en una rutina invariable, los roles son estereotipados, cada uno tiene su "lugar y su horario".

Los miembros de S.3 son los que expresan la necesidad de mayor libertad en el espacio y en el tiempo (dentro y fuera de la casa).

Dos de las familias tienen una habitación que pudiendo utilizarse para vivienda de los S.3, están llena de objetos que pertenecen al pasado familiar y no se pueden tocar. En la otra familia esta característica se muestra en parte, en una habitación que pudiendo ser utilizada no lo es bajo pretexto.

Lo que se refiere a los objetos que pertenecen al pasado, aparecen en el afán coleccionista del S.2 hombre, quien conserva cosas que pertenecen a sus abuelos, padres, infancia y la de sus hijos, a quienes desea transmitirlos cuando crezcan.

Siendo familias aisladas, sus contactos con el mundo externo son escasos. Los de "afuera" representan valores y normas rechazadas, opuestas a la ideología familiar, de carácter tradicionalista, represiva.

Se destaca la importancia del "respeto a los mayores". En S.2 subyacen temores a la muerte o deterioro de S.1.

Deseamos interpretar lo expuesto en función de dos variables: *espacio y tiempo*. Debido a la significación específica que el tiempo adquiere para estas familias, pensamos que niegan su existencia como proceso evolutivo que puede diferenciarse en un pasado, presente y futuro, y también establecer una conexión entre ellos. La utilización del espacio está en función de mantener el tiempo inmóvil.

En la casa que pertenece a S.1 donde vive S.2 desde su constitución, de la que no se pueden ir: somos hermanitos, vivimos con papá y mamá; *donde S.2 cohabita con S.3:* somos hermanitos que juegan a papá y mamá que tienen hijos; *donde las habitaciones permanecen cerradas con objetos del pasado familiar y que no se utilizan como dormitorio:* tenemos miedo de darnos cuenta que perdimos cosas, y *de donde no hay que salir:* en casa todos juntos estamos seguros, afuera está lo malo. Adentro todo sigue igual, afuera hay cambios, los roles son estereotipados. *Rutina:* a la misma hora siempre lo mismo: somos siempre los mismos, no hay cambios, el tiempo no pasa. *Se jerarquiza el respeto a los mayores:* hay que obedecer a papá y mamá, somos chicos, no somos marido y mujer, somos hermanos y jugamos a escondidas.

Estas fantasías fueron expresadas a través de S.2 sobre los cuales se centró primordialmente el tratamiento. En grupos donde la incapacidad de separación parecía ser vivida por todos los integrantes, era sin embargo posible diferenciar más claramente a S.1 y S.3. S.2 aparecía con menor discriminación, portavoces del miedo compartido a separarse, manifestado por ellos en su imposibilidad de desprenderse de S.1 y soltar a S.3.

De acuerdo con lo dicho por el doctor J. Szpilka, cada existencia individual se define y singulariza dentro de una matriz en la que tiempo y espacio adquieren una importancia primordial. La posibilidad de asumir una individualidad sin temor a la disgregación del "yo" se juega en el espacio bajo la forma de multiplicidad de intereses contradictorios y en el tiempo bajo la forma de cambios continuos (profesor W. Baranguer). En estas familias lo expuesto respecto a su vivencia y utilización del tiempo y del espacio muestra el déficit de identidad de cada miembro.

A través de esta particular vivencia del tiempo y utilización del espacio, se trata de negar la diferenciación sujeto-objeto. Separarse significa algo peligroso; la pérdida del objeto; más aún, miedo a la desintegración. "La unión hace la fuerza" dicen dos familias. Otra al referirse a la posibilidad de "ir a vivir a una casa sin la madre (S.1), y donde hijos y padres tengan cuartos separados", plantean que "eso es igual a una gangrena".

Recordando que el motivo de consulta estaba centrado en S.3, en momentos evolutivos que implican separación (adolescencia, entrada

a la escuela primaria) comprendemos la ansiedad suscitada en estas familias, particularmente en S.2. Esta situación reactivaba sus deseos frustrados de separarse de S.1, y acrecentaban los temores a su muerte. El miembro que se va al mundo exterior a la casa, implica peligro de contaminación con lo rechazado: tiempo que fluye en un espacio incontrolable. De hecho, si crece, introduce en sí mismo el tiempo. De esta manera visualizamos a este tipo de familias como una entidad cuya simbiosis va más allá de la necesaria y normal. Su vida se desarrolla en el espacio casa, la que marca con precisión los límites de lo que en última instancia se definiría como una identidad grupal. Para preservarla necesitan una rígida diferenciación entre mundo interno familiar (con sus leyes de tiempo, espacio que le son propios) y mundo externo diferente.

Lo dicho nos hace pensar a la casa como un continente cuyo abandono significaría nacimiento con peligro cierto de muerte.

Estas observaciones constituyen sólo una primera aproximación a un fenómeno complejo, que pensamos exige mayor profundización y que podría llevar a establecer una tipología del grupo familiar en base a las variables consideradas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHLIN G. DE G. y col. — Observaciones sobre grupos familiares en un servicio de psiquiatría. *Rev. de psicol. social*, 1968, 2.
- BLEGER JOSÉ. — *Simbiosis y ambigüedad y Psicohigiene y psicología institucional*.
- BOSZOMENYI-NAGI IVÁN. — *Relationships: Experience and Transactions. Intensive Family Therapy*. Harper and Row, 1965.
- LIBERMAN DAVID. — Acerca de la percepción del tiempo. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1955, 3.
- MOM JORGE M. — Aspectos teóricos y técnicos en las fobias y en las modalidades fóbicas. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1960, 2.
- MOM JORGE M. — Algunas consideraciones sobre el concepto de distancia en las fobias. *Rev. de psicoanál.*, Buenos Aires, 1956, 4.
- MOM JORGE M. y MORGAN J. JOSÉ. — Psicodinamismos de un grupo familiar. *Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo*, Buenos Aires, 1957.
- PUGET JANINE. — *Algunas consideraciones acerca del tiempo*. Buenos Aires, 1966.
- SZPILKA JAIME. — Tiempo, espacio y encuadre. *Rev. de psicol.*, Buenos Aires, 1969, 2.
- WERNER HEINZ. — *Psicología comparada del desarrollo mental*. Buenos Aires, Paidós, 1965.

Psicoterapia de grupo familiar: Una aproximación teórica

SARA P. DE BERENSTEIN *
ALBERTO G. MARTICORENA
NORBERTO C. MARUCCO

Se presenta un modelo con un marco de referencia psicoanalítico que intenta comprender la dinámica del grupo familiar en tratamiento.

La familia es una estructura con un sistema de relaciones estables y continuas, que, desde la perspectiva psicoterapéutica muestra distintas configuraciones. Dichas configuraciones son generadas por procesos dinámicos del grupo familiar. Aquellas que son conscientes constituyen la organización manifiesta y las inconscientes, la organización latente.

En la situación terapéutica, la *organización manifiesta* es aquella conocida, comunicada y percibida por sus integrantes. En ella, se reconocen acuerdos acerca de aspectos formales: quiénes componen el grupo, qué normas rigen la relación entre los individuos, qué funciones cumplen cada uno. Se observan explicaciones acerca de los acontecimientos familiares, que en lo sustancial, son compartidas por todos los integrantes, aunque existan desacuerdos y contradicciones parciales. La organización manifiesta presenta una división que habitualmente pasa por un eje que divide a los integrantes en sanos y enfermos.

Esta organización manifiesta es *expresión sintomática e intento de resolución* de un conflicto grupal. Es una manera de dar coherencia a una situación de mayor desorganización subyacente.

En el curso del tratamiento, a través de las contradicciones, actuaciones, conductas estereotipadas y de la información que surge de la revisión de la historia del grupo, se detecta lo que hemos denominado *organización latente* del grupo familiar. Esta está constituida por personajes, vínculos e impulsos de características distintas de los de la organización manifiesta. En el curso de un tratamiento van apareciendo diferentes configuraciones de las organizaciones manifiesta y latente, en la medida que el grupo puede ir dando significado a lo que aparece como incoherente o contradictorio. Esto quiere decir que la

* Instituto Médico Acta. Santa Fe 3651, Buenos Aires, Argentina.

familia va tomando conocimiento de los procesos inconscientes que condicionan las conductas de sus miembros y la desaparición del desajuste grupal, pasando a través de sucesivos momentos de integración y disociación entre los elementos de la organización manifiesta y latente.

Para la familia, el conocimiento de lo latente, es sentido como un peligro al amenazar el equilibrio grupal. Se ponen en juego entonces, mecanismos de defensa que al tiempo que evitan la emergencia de angustias intensas, tratan de mantener escindida la organización latente.

Los mecanismos de *identificación proyectiva e introyectiva* son esenciales en este proceso y es característica la estereotipia de los mismos.

A continuación, a través de un breve ejemplo, trataremos de mostrar la manera en que aparecen durante el tratamiento estos dos tipos de organización. Es una familia que se presentó, constituida por cuatro integrantes: el padre, la madre y dos hijos varones de 16 y 12 años. El motivo de la consulta fue la conducta delictiva (robo) del hijo mayor, vivida como una amenaza para la vida del padre, ya que éste había tenido un infarto y se pensaba que el hijo lo iba a "matar por los disgustos". La explicación que primero se dio el grupo fue que el adolescente, a quien llamaremos Roberto, estaba influido por "malas compañías y malos ejemplos". Esta primera configuración, manifiesta en el momento de la iniciación, fue sucedida por otras en el curso del tratamiento, que fueron acercándose a la comprensión de otra organización, inconsciente para el grupo familiar, en la que aparecían el robo a los padres y el parricidio, incluyendo *personajes, vínculos e impulsos de características distintas* de los de la organización manifiesta.

En una nueva configuración la familia informó que una tía de Roberto, hermana de la madre, acusaba al padre de Roberto de haber robado dinero en el momento de la disolución de una sociedad comercial.

Posteriormente tomó relevancia el hecho de que la abuela materna de Roberto viviera con el grupo que consultó, provocando esto un distanciamiento entre ambas hermanas. Interpretamos en estas dos configuraciones fantasías de robo; en esta última una hermana habría robado la madre a la otra hermana. Por último, el robo a los padres y las fantasías de parricidio, que era la forma manifiesta del conflicto familiar, expresada por la conducta de Roberto, apareció vinculado con un momento de la familia en que los padres del adolescente constituyeron una sociedad al poco tiempo de la muerte de un abuelo de Roberto, con dinero que habían heredado de él.

Esta familia presentó una organización manifiesta en la que existía una división (ladrones - no ladrones) a la que se daba una explicación determinada. Las sucesivas organizaciones latentes, inferidas por el terapeuta, mostraban el robo asociado a otras personas del grupo e incluían vínculos y personajes distintos de los de la organización manifiesta. El robo aparecía como expresión de impulsos destructivos dirigidos a los padres.

El conocimiento de los elementos inconscientes de la organización familiar coincidió con la aparición de dos conductas grupales: la facilitación del robo y la

idea de separarlo a Roberto del grupo familiar. La facilitación del robo se observaba en situaciones tales como en las que grandes sumas de dinero y alhajas valiosas quedaban al alcance de Roberto. La idea de separarlo a Roberto del grupo familiar se expresaba en los proyectos de enviarlo al exterior.

Estas dos conductas tendían a confirmar la división de la organización manifiesta, la negación de la historia familiar y la escisión de los aspectos más conflictivos del grupo familiar.

Destacamos especialmente el uso de la *identificación proyectiva* en las dos situaciones señaladas anteriormente.

La identificación proyectiva, que es un mecanismo habitual del grupo familiar, se intensifica durante el proceso terapéutico en situaciones en las que el grupo tiende a cambiar su configuración.

Dentro de esta perspectiva, consideramos que la tarea en el grupo familiar no está centrada en la división que muestra la organización manifiesta (por ejemplo, en el individuo sancionado como enfermo). Se trata especialmente de detectar todas las manifestaciones grupales que aparecen como incoherentes y a través de ellas llevar a la conciencia del grupo familiar los elementos de la organización latente y las técnicas defensivas que los integrantes del grupo utilizan para mantener la escisión.

La meta del terapeuta es enriquecer la comprensión del conflicto familiar, a través de la interpretación de la organización latente. De esta manera lo que aparece como un *dilema* (sano-enfermo) en la organización manifiesta, queda planteado como un *problema* familiar con lo cual se amplían las posibilidades de resolución.

Resumen. La familia muestra una *organización manifiesta*, reconocida, comunicada y percibida por sus integrantes y por el terapeuta. En ésta se observan una serie de acuerdos, contradicciones e incongruencias entre los integrantes del grupo.

La *organización manifiesta* aparece como *expresión sintomática* y como *intento de resolución* de un conflicto familiar. A través de ella, el terapeuta infiere la existencia de otro tipo de organización, que regula la conducta de los miembros del grupo, y que es desconocida para ellos. Ésta es la *organización latente*, que incluye personajes, vínculos e impulsos de características distintas de los de la organización manifiesta. Para evitar el conocimiento de la organización latente, los integrantes del grupo ponen en juego, especialmente, mecanismos de identificación proyectiva e introyectiva.

Diferentes configuraciones de las organizaciones manifiesta y latente se desarrollan en el curso del tratamiento, en la medida en que pueden ir adquiriendo significado cada vez más amplio los sucesos familiares.

Presentamos un ejemplo clínico con el que intentamos demostrar los conceptos teóricos mencionados en el trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERENSTEIN I. — El grupo familiar. Proceso psicoterapéutico y encuadre. *Acta psiquiátr. psicol. Amér. lat.*, 1968, 14, 238.
- BERENSTEIN I. — *La familia del enfermo mental: Una denominación ficticia*. Trabajo leído en la Soc. Arg. de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática (A.M.A.), 1969.
- BION W. R. — Una revisión de la dinámica de grupo, en KLEIN M., HEINMAN P. y MONEY-KIRLE R. F.: *Nuevas direcciones en psicoanálisis*. Buenos Aires, Paidós, 1965.
- BLEGER J. — *Simbiosis. Estudio de la parte psicótica de la personalidad*. A.P.A. Buenos Aires, 1964.
- GRINBERG L. — Si yo fuera usted. Contribución al estudio de la identificación proyectiva. *Rev. de psicoanál.*, 1957, 14.
- GRINBERG L. — Perturbaciones de la interpretación motivadas por la contraidentificación proyectiva. *Rev. de psicoanál.*, 1957, 14.
- GRINBERG L. — Identificación y contraidentificación proyectiva. *Rev. de psicoanál.*, 1958, 15.
- JACQUES E. — Los sistemas sociales como defensa contra las ansiedades persecutorias y depresivas, en KLEIN M., HEINMAN P. y MONEY-KIRLE R. E.: *Nuevas direcciones en psicoanálisis*. Buenos Aires, Paidós, 1965.
- KLEIN M. — Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, en: *Desarrollos en psicoanálisis*. Buenos Aires, Hormé, 1962.
- KLEIN M. — Sobre la identificación, en: *Nuevas direcciones en psicoanálisis*.

Patología del carácter y estructura familiar

MARIO FUKS *
ALBERTO GOLDIN

Describiremos un tipo de pacientes en la situación analítica, que se perfilan de la siguiente forma: El analista percibe que el clima del tratamiento se curarece, aunque le cuesta encontrar las palabras o conceptos que definan dicho clima. Son pacientes que están correctamente adaptados a los aspectos formales del tratamiento, pero es típico que digan, ir a "clase" en vez de ir a "sesión", (hasta que "aprendan a decirlo correctamente"); suelen sentir que al tratar un determinado problema, cumplen con una *obligación*, que luego de realizada, será un "deber cumplido"; cuando esta situación reaparezca, comentará: "Bueno, eso ya lo vimos", o tenderá a comentar alguna interpretación con un amigo, validándola, o quizá nos dice: "Ud. tenía razón con eso de los celos, también me lo dijo fulanito". Temen, por momentos, que se acaben las asociaciones para analizar, sobre todo si aumentamos el número de sesiones. Asimismo, hacen comentarios como "eso no se lo dije debido a que no creí que fuera importante", o, "¿no será que esto que le digo está fuera de tema?", "¿interesará al análisis esta información?". Ellos nos viven preocupados por llenar una cartilla con casilleros que se corresponden a una "persona normal", o a un "buen paciente", nos inquietan manifiestamente si es que hubo mejoras, o los percibimos intentando sacar esa conclusión de nuestras interpretaciones. A veces crean un clima que se adecúe al relato que van a hacer: "hoy quiero decirle algo, me he dado cuenta que ser honesto es... etc.; luego del clima de confesión, la confesión propiamente dicha. Es frecuente que lean lo que dicen revistas o programas televisivos sobre psicoanálisis, y luego cuentan esto en sesión, dando la impresión que se sienten "en la cosa"; otra distorsión aparece con comentarios tales como: "Yo sabía que Ud. me interpretaría eso". En este caso, la interpretación es tomada como una información, que podría haberse obtenido en cualquier otro lado, pero, el analista, que "sabe más", se lo "dice".

* Servicio de Psicopatología y Neurología. Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Son propensos a recordar aniversarios, efemérides, se emocionan la "última sesión del año", la sesión que marca dos años de terapia. O sea, se adhieren a situaciones estatuidas, en las que se sienten cómodos. Así mismo, en otros momentos, el paciente se suele sentir vacío; si no tiene nada que decir, está silencioso, despersonalizado. Nos pide que le interpretemos; parecería que lo que en la primera descripción nos sucedía a nosotros, o sea, que veíamos perplejos que no teníamos nada para decirle al paciente, ahora, es el paciente el que no tiene nada para decirnos a nosotros. Tendemos entonces a "informarle acerca de su estado", pero no damos con una interpretación adecuada, se nos superpone la interpretación con una información o si no, el paciente lo toma de esta forma. Sentimos una progresiva pérdida del sentido de la tarea analítica, pero, si lo denunciáramos, nos sentiríamos inútiles, aunque no sabemos útiles a qué. Suele suceder que toda esta situación, que va instalándose de a poco en la terapia, luego, puede ser difícil ponerla en claro, el paciente nos fuerza a seguir, ya que cumple ceremoniosamente con todas las reglas del análisis, salvo, la de analizarse. Es el momento entonces en que el paciente que describimos, considerado en la literatura analítica como caracterópata, ha caracteropatizado el tratamiento. Objetivando o desde las teorías tradicionales, podríamos afirmar que el paciente proyecta en la transferencia sobre el analista un objeto superyoico, pretérito, con características exigentes y severas, al que trata de complacer y aplacar con su conducta. Pero, desde el punto de vista del análisis del carácter, la línea de trabajo de la identificación proyectiva y algunos aportes de la psicología del yo, entendemos esto que sucede en la situación analítica como una repetición compulsiva de situaciones pasadas y presentes, acompañadas de una inversión maníaca de los roles de la situación traumática, con la identificación proyectiva de partes del "yo sufriente" y del "superyó" dentro del analista, que una vez asumidos, afectan por un lado a su tarea y por el otro, su percepción de la misma y su identidad profesional implícita. Desde un punto de vista genético, el paciente trata al análisis y al analista del mismo modo en que ha sido y es tratado por las personas de su entorno. Consideramos pues que se trata de una patología, en gran medida inducida, que afecta al "superyó" al "yo" y a la conciencia distorsionando el carácter y alterando el juicio y sentido de realidad interna y externa, la autopercepción y la vivencia de identidad autónoma. Desde el punto de vista clínico, esta patología produce cuadros en un espectro que va desde la despersonalización en un polo a lo que podríamos llamar caracteropatización en el otro.

La familia del paciente caracterópata. La familia está presente en el tratamiento desde diferentes puntos de vista, como pasado y como presente, ya que no ha cambiado a lo largo del tiempo, no ha evolucionado, sino más bien se ha hipertrofiado; el paciente llega al tratamiento con una expectativa de desprendimiento de características biza-

rras y formales, pero en el fondo con un temor profundo a esto, ya que su rol familiar da sentido a su vida. Los padres del paciente son caracterópatas. Han atravesado momentos difíciles vinculados a duelos importantes, migraciones, crisis económicas, muertes, etc., de los que se han recuperado concomitantemente con la estabilización de la familia en los años de infancia del paciente; padecieron a menudo enfermedades psiquiátricas o psicósomáticas severas, generalmente depresiones. Los niños también sufrieron perturbaciones, enuresis, fobias, problemas alimenticios serios, disturbios gastrointestinales, etc., pero éstos no fueron categorizados en términos de enfermedad psicológica. La familia se compensó de las crisis a expensas de una rigidificación de su estructura, en la cual el hijo ha jugado y juega el papel de depositario de aspectos conflictivos de los padres. Se desarrolla un tipo de interacción que creemos similar a la descrita por Wynne y col. en familias de esquizofrénicos agudos con el nombre de "seudomutualidad". Los individuos no son tratados como tales sino como alguien que tiene que jugar un rol fijo las desviaciones de rol son excluidas del reconocimiento, atacándose todo sentido de diferenciación personal. Peter Lomas agrega que la habilidad para percibirse y creerse como un organismo con estabilidad de percepción, se ve interferida por la falsificación de la atmósfera emocional que ocurre en la familia. Para distorsionar el sentido, se recurre a diversos procedimientos, se invoca el nombre del status abstracto, para afirmar o negar intenciones, por ej.: "Un padre nunca podría querer tal cosa para su hijo". "Si sos un hijo mío tendrías que sentirte agradecido de tal cosa, etc." En general, la superestructura valorativa y normativa es contradictoria o abarca un número de temas reducido, coherentes en sí mismo, pero utilizados en forma contradictoria. Existe poca o nula capacidad de pensamiento filosófico, apareciendo en su lugar, una especie de sabiduría popular consistente en un repertorio de proverbios, metáforas, anécdotas de las que se extraen moralejas que constituyen una especie de mito familiar. Ocurre a menudo también una confusión de niveles en el diálogo entre lo gnoseológico, lo ético y lo práctico. Se esperan explicaciones y se obtienen recomendaciones. Este aspecto en general ha sido bastante tratado en la literatura. La incoherencia entre lo normativo y valorativo genera un cierto tipo de problema. Se producen en el hijo dudas y confusiones, pero en última instancia se podría salir de ellas denunciando la contradicción. Padres que dicen una cosa y luego la niegan, pueden inducir a una respuesta airada del hijo. A partir de allí, éste puede ir constituyéndose en un neurótico obsesivo con sus dudas y sus explosiones. Tal vez si el manejo es a nivel de los sentimientos, será un neurótico depresivo. De esto resultarían los niveles neuróticos de los pacientes en estudio. Pero además, entre las múltiples y frecuentes maniobras de control de un miembro sobre otro, encontramos algunas que parecen tener que ver con el tipo de mensaje "doble-vincular". Uno de los pacientes, relataba el siguiente episodio, como

típico de lo que sucedía en su casa: "Cuando llego a casa, por la noche, al cerrar la puerta de calle, escucho a mi madre, que desde su habitación me dice '¿Ya llegaste? Cerrá la puerta', justo cuando yo la acabo de cerrar, al dirigirme a la cocina a comer algo (ella siempre me deja algo preparado) la oigo decir 'Andá a la cocina que te dejé comida', busco, no veo nada y pienso, debe estar en la heladera, mientras la oigo decir 'Te la dejé en la heladera', luego acostumbro ir a charlar un rato con ella, mientras me dirijo hacia su habitación, dice 'Vení, vamos a conversar un rato'".... El relato continúa. Parece ser que la madre actúa de apuntadora de la situación donde la experiencia se inscribe doblemente, en la realidad vivencial y en un subtítulo redundante, que no es precisamente una orden previa, sino más bien una simultaneidad. La madre dice "cerrá la puerta", mientras oye el "click" de la puerta cerrándose, no emite aquí la expectativa de un acto diferente, no dice "no la cierres" o "por qué la cerraste" o "abrila", agrega un mensaje verbal concordante que descalifica ciertos aspectos del acto. Esto actúa en varios niveles: a) Aunque oiga el "click" de la puerta, cuestiona la percepción de la realidad del acto; b) Forzando la verificación del mismo, niega en cierto modo el acto como originado en el interior del sujeto, como intención propia. O sea, cuestiona la concordancia entre deseo y acto, o sea la sintonía consigo mismo; c) También niega en cierto modo el acto como respuesta al deseo internalizado del otro, el acto propio como relación, es decir la sintonía de lo propio con lo de otros, dentro de él mismo. Creemos que en estos tres puntos se apoya la idea de autonomía o de falta de ella. Estas tres vertientes que constituyen lo "interno" e "implícito como voz interior muda, lo latente en cierto modo, se vuelve explícito, externo, personificando, como palabras habladas por otro". Finalmente, son estas las voces que son incorporadas en sucesivas aposiciones que no se integran sino que se superponen, como "yoes" y "superyóes" auxiliares que no auxilian sino que anulan al yo y superyé propios, concordando precisamente con ellos. Se trata de una especie de *sintonía distonizante*. Este ejemplo nos hizo pensar en los esquizofrénicos que refieren tener una voz que dice en voz alta todo lo que ellos hacen, piensan o dicen. Creemos que estos pacientes caracterópatas huyen precisamente de esta voz interna que sustituyó a la autopercepción y pensamiento reflexivo, tratando de llenar el silencio, pensar en voz alta o hacer que hable otro, para neutralizar su propio pensamiento que sienten como neutralizante y tal vez poder pensar. Podríamos agregar que tal vez en este momento, ya adulto el paciente, toda su conducta se ha convertido en una anulación concordante de la voz interna de la madre. Aquí reside quizás la vivencia de despersonalización y angustia que produce la interpretación del analista, principalmente aquellas que intentan rescatar una parte observadora del paciente mediante la descripción de las conductas del mismo. La respuesta del paciente, en general acompañada de endurecimiento de su cuerpo es: "no sé dónde me quiere llevar" o

"está diciendo lo mismo que yo digo" o "¿qué hago entonces?". En general, aspectos ritualizados del encuadre analítico y cierto tipo de formulaciones en la interpretación, generan dificultades en el tratamiento en tanto reproducen para el paciente circunstancias traumatizantes de su vida familiar. La clásica interpretación del "acting-out" como que "eso que usted hizo fuera tiene sentido en función de esto que pasó aquí dentro". Se acerca curiosamente a la modalidad familiar de referir todos los actos autónomos del paciente a la familia, como si el mundo fuera una extensión del setting familiar. Para el paciente, el analista tampoco reconoce, al igual que sus padres, que lo que él hace puede ser autónomo y tener un sentido independiente. Por otra parte, incluir en la interpretación la frase: "además esto que usted dice... tiene que ver con..." impresiona como formal, y no cambia mucho las cosas. En general parece que para el paciente puede haber un solo sentido y no concibe la "intersección" de sentidos. Los hechos se colocan uno al lado del otro; es difícil integrar aquella perspectiva formulada como que todo concreto es un entrecruzamiento de abstractos. La interpretación de la transferencia ofrece dificultades similares; la fórmula: "lo que dijo me lo está diciendo a mí" o "lo que hace me lo está haciendo a mí" es asimilada a la actitud de los padres particularmente de aquel con quien hay un más intenso vínculo simbiótico, que tiende a "transferenciar", a "autoreferir" todo lo que hace o dice el hijo: "Qué me estás haciendo". Aunque tiene razón, en parte, porque mucho de lo que hace y dice el paciente está dirigido hacia los padres, la explicitación verbal es sentida por el hijo como un procedimiento para controlarlo, y aquí en parte también tiene razón el hijo. Creemos que la caracteropatización del tratamiento psicoanalítico se ve favorecido, desde la vertiente del analista, por la tendencia a la ritualización de la técnica como respuesta al "sin sentido" presente en estos aspectos de las relaciones humanas, pero también debidas a la insuficiente comprensión de la patología del carácter por un lado y las vicisitudes de su formación teórico-técnica por el otro. Así como clásicamente se recomienda para entender a neuróticos adultos haber hecho experiencia en psicóticos y niños, nos proponemos estudiar grupos familiares porque creemos que podemos entender más a fondo los trastornos del carácter. Así como el trabajo permanentemente necesario de revisión del sentido de la tarea analítica.

Para terminar, resumiendo, hemos tratado de hacer un paralelo entre las características de interacción que se dan con el caracterópata con la relación analítica, en el funcionamiento familiar y en su relación consigo mismo. Se trata, esencialmente, de una perturbación de la percepción, juicio y sentido de realidad que produce cuadros clínicos de despersonalización en un extremo y caracteropatía en el otro, y consideramos que esta patología es inducida por un tipo de interacción particular, del estilo de la descrita con el nombre de "seudomutualidad". Planteamos la posibilidad de que exista un tipo de maniobra

específicamente descalificadora del sentido de "mismidad" de autonomía y de reciprocidad. Ilustramos el modo en que esto afecta al proceso analítico y a la percepción del mismo por el analista, señalando la posible existencia de rasgos en este último y en su tarea, que pueden favorecer esta deformación. Creemos que en última instancia esto ilustra y a la vez forma parte de un proceso más amplio, de falsificación de las relaciones humanas; el de la alienación y de cómo éste puede producir en aquellas relaciones concebidas específicamente como desalienantes.

Intento de aplicación del análisis fenomenológico al psicodiagnóstico y psicoterapia del grupo familiar

STELLA M. A. DE JIMENEZ DE ASUA *

El estudio de los distintos trastornos de conducta en los niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad mediante el análisis fenomenológico, condujo a la necesidad de enfocar estos problemas más ampliamente, tomando al niño en su núcleo familiar.

Metodología y resultados. El método descripto por Husserl fue aplicado en forma adecuada a la originalidad de cada una de las experiencias. En general, el análisis fenomenológico fue efectuado teniendo en cuenta la reducción intersubjetiva. La comunicación siguió el esquema *sujeto-verbo-sujetos* describiéndose lo experimentado como tal en forma inmediata; es decir, lo vivenciado y pensado en el vivenciar. En este esquema se consideró como sujetos al grupo familiar y como sujeto al observador o terapeuta.

Los puntos de partida para la descripción de la comunicación fueron los siguientes:

- a) *Los fenómenos espaciales:* en los cuales se incluyó el contorno físico y material en el cual se desarrolla la percepción.
- b) *Los fenómenos temporales:* comprendieron, la *sucesión* de dónde surgió y hacia dónde se proyectó la experiencia, y *el sentido de progreso* el cual está referido a muchas posibilidades de las que se toma una que conduce a la apertura de otras.
- c) *Las vivencias del observador en el momento* comprenden la *intuición; intención; proyección; trascendencia; y la identidad, unidad y continuidad del yo.*
- d) *El recuerdo* del observador de una experiencia significativa similar a la que se desarrolla permite la orientación en el mundo circundante con la posibilidad de actuar dentro de él.

* Cátedra de Psicología Fenomenológica II, Facultad de Psicología, Universidad del Salvador. Buenos Aires, Argentina. Guido 1754, 8º A, Buenos Aires.

- e) *Mundo familiar*. Comprende lo incorporado por cada uno de los sujetos presentes durante la comunicación del grupo.
- f) *Mundo compartido* comprende la relación con los objetos y seres vivientes.
- g) *Mundo comunitario* que incluyó el aprendizaje y tradición.
- h) *Interiorización* de todos los factores precedentes.

Los resultados obtenidos indican que en el caso de un niño de 15 días la descripción de la comunicación en el análisis fenomenológico se efectúa principalmente por medio de los fenómenos espaciales y temporales. En efecto, la experiencia con sus progenitores demostró que estos fenómenos son los principales medios de comunicación dentro del grupo. Así por ejemplo, un gesto de molestia del niño, fue inmediatamente correspondido por la acción comprensiva conjunta de ambos padres.

El estudio de estos hechos en distintas oportunidades, permite demostrar, al menos en este caso particular, una perfecta correlación entre ambos fenómenos ya que a lo *espacial* (molestia) correspondió lo *temporal* (la acción comprensiva de los padres). Es posible además afirmar que lo que es *presente* en el niño, es *presente* en sus padres.

Por el contrario en una niña de dos años de edad, el análisis fenomenológico de la conducta requiere tener en cuenta todos los elementos que hemos señalado anteriormente.

El caso particular estudiado presentaba una conducta caracterizada por la destrucción de los objetos y agresión hacia la madre. La interacción del padre dentro del grupo era pasiva y marginada. No obstante en su relación individual con él mismo era tranquila y afectiva.

La observación de los fenómenos espaciales demostró que las palabras y gestos de la madre se han interiorizado en la niña y se expresan en su conducta agresiva.

Los fenómenos temporales se caracterizaron por la *sucesión* de enojo de la madre por una acción de la niña, lo cual motivó la interacción opuesta, es decir, a enojo de la niña por acción de la madre.

La vivencia del observador fue la de una barrera imposible de pasar.

El recuerdo frente al grupo y en especial en el caso madre e hija fue semejante al de dos personas que se repliegan sobre sí misma ante la agresión externa. El interrogatorio de la madre reveló el sentido posesivo de ésta ante sus objetos y los de la niña "*no dejo que se meta con mis cosas*". En el diálogo el observador le mostró a la madre que por medio de ese meterse la niña, conoce, busca afecto y signos de vida. Meterse remite a la introducción de un objeto dentro de otro revelando la relación entre madre e hija que es considerado como una relación de objeto.

El mundo familiar, es decir, lo físico que ha incorporado parecería ser, destruir buscando signos de vida. Lo quieto o sin reacciones,

la *remite* a muerte, desamparo o soledad y la conducta de la niña *remite* a un rechazo hacia la madre que representa su *cosificación*. De esta manera no le otorga sentido a su mundo y no lo habita humanamente, sintiéndose inmovilizada y sin posibilidades a desarrollar. El reclamo del padre, le permite entonces abrirse al mundo incorporándolo, transformándolo, adaptándolo y asimilándolo.

La vivencia de la paliza y el encierro es de burla a su interioridad y opta por lo mismo con la madre. De esta manera aparecería una posición negativista de la madre que condiciona en la hija una manera de reaccionar desconfiada hacia los demás y hacia sí misma, temiendo asumir un papel pasivo y de objeto.

Sin embargo, en este caso no hubo intuición del ser original y particular, de cada uno de los miembros, ni tampoco interrelación de intenciones en un proyecto común.

Conclusión. Estas notas que se encuentran en la experiencia de comunicación son como el ordenamiento que rige al hombre concreto. Esto significa que dicha realidad se presenta constituida por estas dimensiones en forma tal que cuando en una experiencia una de las mismas no aparece la comunicación es defectuosa y hablamos de anormalidad.

Es como si uno de los elementos del análisis fenomenológico se *hiciese absoluto*, asumiendo todas las posibilidades.

Comunicación de una experiencia de grupo familiar en un hospital psiquiátrico

(Versión abreviada)

LUIS GIUNIPERO *
MIGUEL SOTO **

Esta comunicación refiere a una experiencia, realizada en la ciudad de Rosario, de inclusión de Terapia Familiar en el Sector C, Sala 2 del Hospital Psiquiátrico de la Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Nacional de Rosario).

Esta técnica se empleó en casos de pacientes diagnosticados (psicométrica y clínicamente) como esquizofrenias paranoides.

La inclusión de la Terapia Familiar se reconoció como necesaria a partir de estos supuestos:

- a) El monto de dependencia respecto del grupo familiar originado en la gravedad del cuadro.
- b) La posibilidad de labilización de vínculos cristalizados conformados como defensa (deposiciones masivas) ante la ansiedad (desequilibrio) que despierta la psicosis en uno de sus miembros (emergente).
- c) Aprovechamiento de los aspectos sanos del grupo.

Encuadre. Una reunión semanal de una hora, en un consultorio para terapia de grupo, coordinador y observador. Consigna: tratamiento de la situación por la que atraviesa el grupo. Tiempo: un año.

Esquema referencial. Psicoterapia grupal de base psicoanalítica. Se intenta crear una situación de laboratorio social donde privilegiar el repensado de las experiencias familiares, permitiendo al grupo descubrir significaciones a situaciones estereotipadas y posibilitar el análisis de la comunicación para la mejor comprensión del significado de los mensajes.

Realizamos entrevistas con el grupo familiar para detectar el "conflicto nuclear" y quienes lo asumen.

* Mendoza 640, tel. 63573, Rosario.

** Urquiza 2970, tel. 29154, Rosario.

"Conflicto nuclear" es aquel que se destaca en una relación figurado, conteniendo vínculos estereotipados depositarios de las fantasías más temidas del grupo.

Ante la ausencia de una nosología familiar utilizamos el concepto de "conflicto nuclear" para caracterizar, en términos de vida cotidiana, la problemática del grupo (Ej. conflictos homosexuales entre hermanos, infidelidad de la madre).

Si bien la tendencia del plan de trabajo es realizarlo con todos los integrantes del grupo, hemos apelado a la técnica de la división del grupo en función del conflicto nuclear y a quienes están, desde el punto de vista observacional, más comprometidos en el mismo. La operatividad de la terapéutica es favorecida por esta modalidad que, pensamos, permite superar situaciones inherentes al objeto de estudio: problemas generacionales, diferencias de lenguaje, capacidad de simbolización, comprensión, etc.

Interpretación. La actitud del coordinador fue predominantemente interpretativa. La interpretación de los roles fue usada preferentemente; se analizó la deposición masiva en el miembro más enfermo. A nivel de la comunicación, el coordinador asumió el rol de clarificar los niveles metacomunicativos. También se trabajó a nivel de la interpretación discriminativa. En determinados momentos, en los grupos se dramatizan los aspectos psicóticos propios de la estructura grupal y de su emergente enfermo; en estos casos recurrimos a efectuar un chequeo entre realidad y fantasía.

La interpretación de contenido o simbólica no fue usada en forma predominante por verse complicada su comprensión por el marco de ambigüedad que se da entre el "como si" y el "como real" influido por las características del contexto.

En relación al contexto hospitalario creemos necesario equilibrar dos actitudes típicas: confusión con el contexto (pérdida de iniciativa y burocratización), y marca de disociación (que termina en el abandono de la tarea que incluye un matiz descalificador de la misma).

A nivel del encuadre, en el primer caso, éste desaparece; mientras que en el segundo, aparece exacerbado (trasplante mecánico del encuadre de la práctica privada del psicoanálisis).

Al hablar de las interpretaciones de contenido, dijimos que se veían dificultadas por la confusión entre el "como si" y el "como real", es decir, la invasión del contexto hospitalario en el encuadre grupal, por falta de formalizaciones institucionales que permitan la articulación de los diferentes encuadres terapéuticos (individual, grupal, etc.).

Finalmente, y también en relación al contexto hospital, los criterios de mejoría debieron equilibrar el énfasis de la institución puesto en el "mundo externo" (rehabilitación social) y el que proviene del encuadre grupal que privilegia el "aquí y ahora".

Análisis de un grupo familiar en una obra teatral

(Versión abreviada)

SUSANA HULER *
RUTH PODETTI
MARIO WASERMAN

Resumen. En este trabajo se trata de conceptualizar cuál es el drama original presentado artísticamente por L. Pirandello en su obra *Seis personajes en busca de un autor* y qué es lo que lleva a sus personajes a la repetición compulsiva de la situación traumática. Estas cuestiones fundamentales son respondidas por el mismo Pirandello en el título y subtítulo de la obra *Comedia todavía no escrita*, donde señala la falta de la figura autorial-parental y la dificultad de escribir-objetivar el drama original, guiando con estos índices al espectador en la comprensión de los sucesos dramáticos actuales e históricos.

Descontando el conocimiento de la obra por parte del lector de este trabajo, vamos a señalar sólo los detalles más relevantes para la comprensión del drama y la repetición:

El grupo familiar se presenta declarando que son personajes, que tienen un drama y buscan un autor que los escriba y poder así ser representados.

Los seis miembros se identifican por su rol (no tienen nombre). Los actores intentan representar el encuentro en el burdel, pero los Personajes interrumpen, y vuelven a actuar las situaciones traumáticas (la ya citada más el suicidio del Muchacho y el accidente fatal de la Niña) y la representación de los actores se hace imposible porque los Personajes no aceptan ninguna divergencia entre lo que sucede en el escenario y lo que sucedió en su historia y sigue sucediendo dentro de ellos.

La queja de que no tienen autor que los asuma como personajes y les devuelva la libertad de diversificarse en otros roles, se puede traducir como el sentimiento de no tener padres, o de haber sido rechazados por los mismos. Esta carencia o déficit de la función parental provoca que en la fantasía patológica de cada uno la relación bipolar

sea vivida como la totalidad de la persona, cada uno se confunde con el Personaje que es. La imposibilidad para reconocer, dentro de cada uno, el deseo y la capacidad para desempeñar otros roles, rigidiza la dramática vida de esta familia y dificulta la individuación de los miembros y su salida al extragrupo. Carecen de un Otro que los objete como personajes, que corrija la identificación indiscriminada de su persona y su Personaje Interno: no hay Autor. El fracaso del grupo es que no pueden perpetuarse como personajes de un drama. Buscan ser personajes eternos y esto es comprensible, porque en la medida en que el personaje interno se atemporalice la persona puede seguir viviendo en el tiempo real. De lo contrario el rol se eterniza en la persona.

El intento de dramatización de los Personajes es casi equivalente al intento de pensar; la representación teatral equivale a la representación mental.

El fracaso de la representación, como fracaso del pensamiento, deja como alternativa la actuación y esto está expresado en el final de la obra, que no da la impresión de ser un final: se reconstituye el triángulo inicial para volver a empezar, para repetir incesantemente.

* Añasco 1528, PB, depto. 2, Buenos Aires.

Técnica proyectiva para el diagnóstico del grupo familiar

LUIS J. JURI *

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el funcionamiento de una técnica proyectiva destinada al diagnóstico de los pequeños grupos, y su aplicación en el caso particular de los grupos familiares.

Un hecho que sorprende, al introducirnos en el estudio de los pequeños grupos y de los grupos familiares, es la escasez de instrumentos para el diagnóstico grupal, fuera de la entrevista clínica. Son pocos los instrumentos de este tipo que podemos nombrar. Entre ellos y en nuestro país, el Test de las Bolitas, de Usandivaras y col., y en los EE.UU. la técnica elaborada por Henry y Gurtzow, en base a una modificación del T.A.T. de Murray. En realidad, la mayor parte de las técnicas proyectivas actualmente en uso están destinadas a la aplicación individual. Para subsanar esta carencia, se impone una mayor apertura de las técnicas proyectivas hacia el campo grupal. La pregunta que se nos plantea en nuestro caso es: ¿qué características debe poseer una técnica proyectiva para ser adecuada al estudio del grupo familiar? A mi criterio, solo de la definición de las características de nuestro objeto de estudio se puede desprender la respuesta. La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el rasgo principal que caracteriza a estos grupos, una variedad de los pequeños grupos, es el proceso de interacción que se produce entre sus miembros, habiéndoselos calificado como "sistemas de interacción". La interacción es el núcleo generador de todas las manifestaciones grupales. A mi entender, este es el hecho nodal del cual deben partir todas las elaboraciones técnicas. Si el grupo familiar es un sistema de interacción, el instrumento a utilizar para su diagnóstico debe ser apto para "leer" esta interacción. Esto implica que sería un error tratar de inferir la interacción grupal a través del estudio individual de los integrantes del grupo. En sentido estricto, un procedimiento de este tipo no estudia el grupo, sino el individuo. Lo que se impone metodológicamente sería estudiar

el grupo cuando éste se encuentra interaccionando, y este ha sido el criterio principal con el cual he confeccionado una Batería de Técnicas Proyectivas destinadas al diagnóstico grupal. Su denominación es Batería de Técnicas Proyectivas Grupales, y fue presentada por vez primera en el II Congreso Argentino de Psicología (San Luis, 1965). Posteriormente fue publicada como apéndice a la edición en castellano del libro de L. Abt y L. Bellak: *Psicología Proyectiva*. Paidós. Buenos Aires, 1967. Está compuesta por cuatro tests para el estudio de pequeños grupos de 2, 3, 4 y 5 miembros. Los distintos tests de la Batería utilizan el mismo procedimiento técnico, pero se los denomina, en relación con el tamaño del grupo al cual se aplican:

Test de la Pareja en Interacción (T.P.I.)

Test del Triángulo en Interacción (T.T.I.)

Test del Cuadrilátero en Interacción (T.C.I.)

Test del Pentágono en Interacción (T. PENT. I.)

Como el procedimiento técnico es el mismo para todos los tests de la Batería, el proceso de administración y las consignas que se dan a continuación se pueden considerar como patrones para todos ellos.

Administración. El examinador colocará sobre una mesa una hoja grande de cartulina blanca, de 50 x 60 cms y junto a ella un lápiz de color negro y una goma de borrar, e imparte las siguientes instrucciones:

"En esta hoja cada uno de ustedes deberá dibujar una persona de cualquier edad y sexo. Lo harán por turno, uno de ustedes dibujará primero y el otro (o los otros) lo hará después. Puede comenzar cualquiera".

Una vez concluidos los dibujos, se agrega esta otra consigna:

"Ahora cada uno de ustedes deberá colocarle un nombre cualquiera a su dibujo".

Siguiendo las normas de toda técnica proyectiva, los sujetos pueden realizar la tarea como ellos deseen, tanto en la ubicación de los dibujos como en las características de que los provean.

Terminada la tarea gráfica se entra en la segunda etapa del proceso de administración, dándoseles a los sujetos la siguiente consigna:

"Ahora ustedes harán un trabajo en conjunto. Entre los dos (o entre todos) deberán inventar una historia, una sola historia, que tenga como personajes a y (se nombran los personajes dibujados).

"Cada uno de ustedes se encargará de un solo personaje, al cual, como si fuera en una obra de teatro, deberán hacer actuar, pensar y sentir durante el desarrollo de la historia. Cada uno de ustedes hablará solamente cuando toca que le toca intervenir a su personaje. ¿Han comprendido? Bien, puede comenzar cualquiera."

La idea de utilizar una sola hoja donde todos los sujetos deben

* Entre Ríos 286, 8º piso, Rosario.

ubicar sus dibujos es el fruto de una sugerencia que me fuera efectuada por J. Bernstein, en relación al *Test de la Pareja en Interacción* y que posteriormente amplió al resto de los test de la Batería.

Presentación de material. A efectos de mostrar el tipo de material que recogen los tests de la Batería presentaré una aplicación del test del Cuadrilátero en Interacción, administrado a un grupo familiar de cuatro miembros. Este grupo concurrió al Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico "Prof. G. Aráoz Alfaro" (Lanús) habiéndose realizado con ellos previamente dos entrevistas diagnósticas, llevadas a cabo por el doctor Miguel Méndez. Con Miguel Méndez estoy en deuda y agradezco por sus valiosas indicaciones sobre la interpretación del material recogido por el test y presentado en este trabajo. El motivo inicial de consulta fue en relación a los problemas del hijo menor de la familia, un adolescente varón de 12 años. Posteriormente se citó a todo el grupo familiar. Concurrieron a las entrevistas el padre (42 años), la madrastra (23 años), la hija (14 años) y el hijo (12 años). Los problemas del chico habían comenzado en 3º y 4º grados de la escuela primaria, y eran tanto de aprendizaje como de conducta.

El padre expresa en las entrevistas que el hijo se encuentra distinto, desganaado, y que tiene enojos. Lo acusa de ser descuidado con sus cosas y de pelear en la casa; esta última acusación la efectúa con respecto a su hija. Estas peleas se dan especialmente con la madrastra, con quien el padre se casó hace poco. Ésta concurre a las entrevistas teniendo un embarazo de 7 meses. El padre expresa que se separó de su mujer anterior porque ella se fue con un hombre, y en las entrevistas la llama "esa persona", porque considera que no merece llamarse madre. Hace pocos meses, los dos hijos se fueron de la casa, a casa de la madre, yendo el padre a buscarlos y trayéndolos nuevamente. Pasemos ahora al material del test.

I. Registro gráfico. El padre dibujó a un hombre y le puso *Carlos*. El hijo dibujó a un muchacho y le puso *Néstor*. La hija dibujó a una mujer y le puso *Leonid*, y la madrastra dibujó una mujer a la que puso *Verónica*. (Ver gráfico.)

II. Registro verbal. Las intervenciones de los miembros del grupo son consignadas con el nombre de sus respectivos dibujos. A los efectos de una mejor comprensión, se menciona antes del nombre el rol familiar de cada uno.

Historia.

Padre (Carlos): Carlos se ha ido a un lugar de esparcimiento, huyendo del calor de la ciudad.

Hijo (Néstor): Carlos se zambulló y lo mojó todo a Néstor, que tuvo que mandar el traje a la tintorería y fue a buscar otro traje para ponerse. Cuando fue a la tintorería se encontró con Leonid.

Hija (Leonid): Néstor fue a buscar el traje y había perdido el número de la tintorería. Entre los dos buscaron el traje, pero no se acordaba si era verde, azul o rojo y empezó a revolver todos los trajes. Cuando se terminó de probar los trajes se dio cuenta de que se equivocó de tintorería y le pregunta a Leonid por otra tintorería, y ésta le indicó otra.

Padre (Carlos): Al entrar se da cuenta que era Carlos el que atiende y es el dueño y le quiso reclamar por el traje que había mandado al ser mojado por Carlos.

Hijo (Néstor): Entonces Néstor se enojó y se fue con un traje a su casa y cuando se cambió se fue a mirar las carreras al hipódromo.

Madrastra (Verónica): Ahí se encontró con Verónica, y le preguntó qué andaba buscando, y Verónica le dijo que estaba apostando, al igual que él, y que estaba perdiendo dinero.

Hijo (Néstor): Néstor se encontró con un amigo y jugaron hasta el último peso, pero el amigo de Néstor se quería desquitar y fueron a un garito.

Padre (Carlos): Se encuentran con Carlos en la puerta, que era amigo del amigo y le comentan la pérdida del dinero. Carlos le dice que tomen el ejemplo de él, que es más lindo pasarse el día en el río practicando ejercicios.

Hija (Leonid): Aparece Leonid que dice que Carlos va al río para salpicar a la gente porque tiene una tintorería.

Padre (Carlos): Carlos le contesta que si tiene una tintorería es porque tiene un capital que no lo ha ido a dejar en los hipódromos.

Hija (Leonid): Leonid le refuta que ese capital lo ha hecho a costillas de la pobre gente.

Hijo (Néstor): Néstor se escabulló y se metió en el garito y perdió todo y le prestan un barril. Sigue caminando y llega a la casa y ahí busca otra ropa y como estaba nervioso fue dispuesto a romperle la cabeza a Carlos y sigue caminando, y camina y camina y se le calman los ánimos y fue a comer pizza. Como la pizza no estaba bien hecha se la agarra con el pizzero, y después sale a la calle, y camina, camina.

Padre (Carlos): Se encuentra con Carlos y éste lo invita a un día lindo, salir a cazar, pescar, haciendo resaltar que siempre es preferible el aire libre, que el juego lleva a la ruina.

Hijo (Néstor): Néstor le pide a Carlos el traje que le arruinó y se pelearon. Aparece un policía, los separa y lleva a los dos a la policía. Salen de la policía y Néstor se fue a dormir, y ahí terminó la historia.

Hija (Leonid): "¿Y Verónica? ¿Quedó fundida?"

Madrastra (Verónica): "No tenía para dónde ir".

Análisis de los registros. Debido al poco tiempo disponible, no puedo extenderme sobre la interpretación y los criterios de análisis del material brindado por el test. Presento por ello solamente una somera interpretación del mismo, a título ilustrativo.

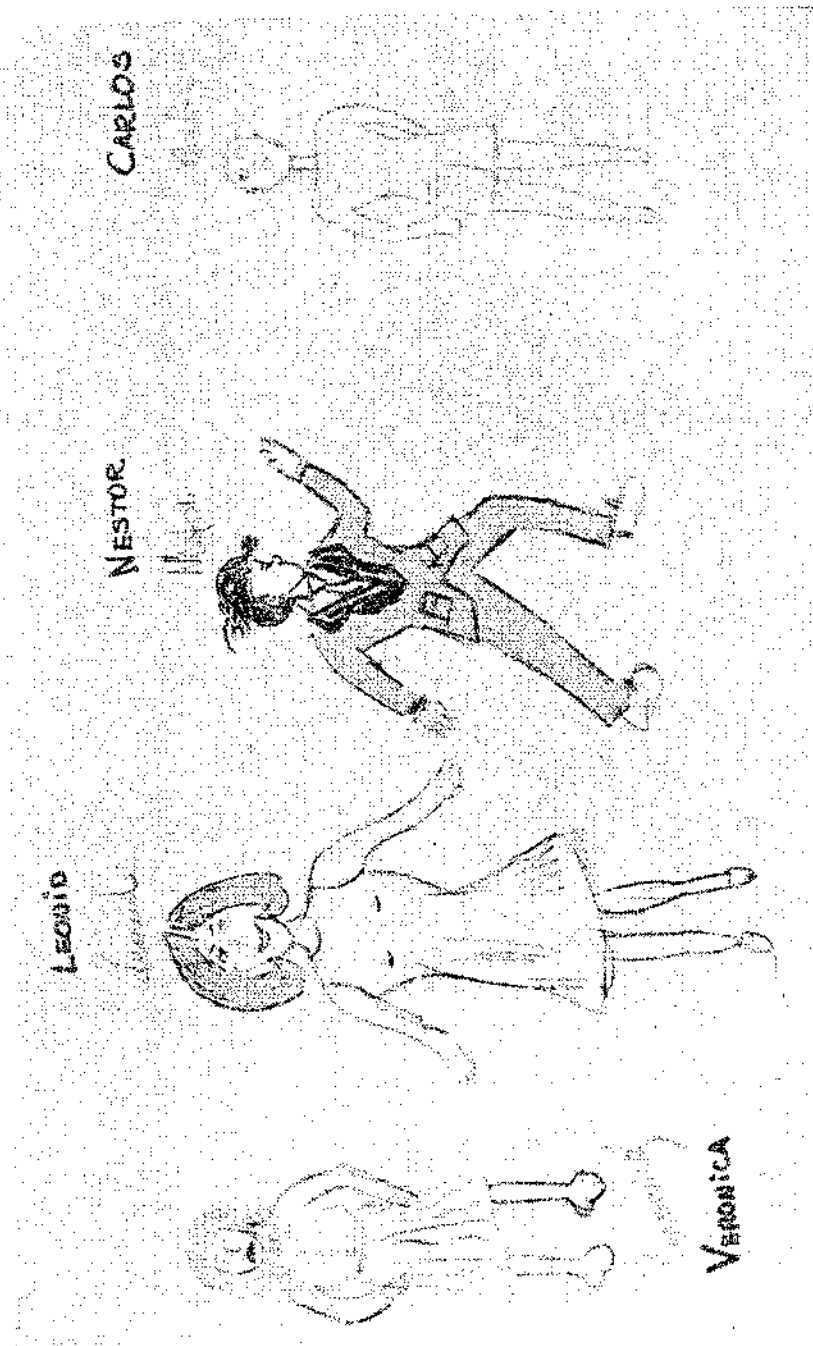
Análisis de los dibujos. El dibujo del padre, Carlos, aparece escondiendo la mano, y en una actitud de tener ser acusado, como veremos en la historia, corresponde a la culpa por la depositación realizada en su esposa primera e hijos. Néstor, el hijo, se dirige a Carlos en una actitud de ataque y recriminación. Tiene puesto un traje de características no definidas, con solapas de smoking y bolsillos de suco sport, mostrando la confusión de identidad. Leonid, la hija, realiza un dibujo grande de tamaño, representando una mujer adulta y atractiva, representando esto su deseo de ocupar el lugar materno, que había ocupado hasta la aparición de la madrastra. Verónica, la madrastra, está en situación marginada (lo cual se repite en

la historia). Es de notar cómo los dibujos de los hijos separan los del padre y la madrastra, interponiéndose entre ellos.

Análisis de la historia. El padre realiza depositaciones en el hijo (mojar-salpicar) de culpas, por lo cual queda sucio (tuvo que mandar el traje a la tintorería). El hijo aparece con problemas de identidad por estas depositaciones (confusión de trajes). El reclama al padre (dueño de la tintorería, la pérdida del traje-identidad, que también representa la pérdida de la madre. Surge en el hijo enojo por la pérdida del traje-madre y como consecuencia la adopción de una identidad de mala conducta (el hipódromo-garito) en identificación con la madre perdida, acusada por el padre de mala vida, y como recriminación y ataque al padre. Esto se relaciona con sus problemas de conducta familiar escolar.

El padre aparece asumiendo un rol virtuoso (inocente) y poniendo en los hijos un rol de mala vida (culpables). La hija, Leonid, acusa al padre, Carlos, de depositar (salpicar) para provecho propio (la tintorería) que sería la necesidad de aparecer idealizado a costa de las depositaciones de la culpa en los otros. La madrastra aparece en competencia con los hijos (apostando en el hipódromo).

El padre hace intentos de reparación (la tintorería y los consejos) pero con características maniacas, al colocar la responsabilidad y las culpas en los hijos (Néstor y Leonid).



Familia marginal y desarrollo de la identidad en adolescentes mujeres. Una experiencia grupal

DIANA LERNER
EDUARDO LUXARDO
ELISA MARINO
JUAN CARLOS NOCETTI
MARÍA ISABEL PUNTA
LEONARDO RODRIGUEZ

A través de la observación de núcleos familiares que habitan en un barrio transitorio perteneciente al Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, ubicado en el Gran Buenos Aires, se puso de manifiesto, como una de las problemáticas más relevantes de esta comunidad, la presencia de relaciones de pareja inestables, promiscuidad y *actings* sexuales. Estos hechos iban acompañados generalmente de una brusca ruptura con el núcleo familiar por parte de las adolescentes mujeres de esta población.

Esta situación nos llevó a tomar como una de las tareas psicológicas inmediatas la formación de grupos de adolescentes para la prevención de dichas conductas. Por lo tanto, la experiencia grupal que se relata en este trabajo se realizó ante la necesidad de asistir psicoprofilácticamente a un sector de la población adolescente en riesgo.

Descripción de una familia tipo. A través de las entrevistas realizadas con este sector de la comunidad y sus madres, y de la observación sistemática de sus núcleos familiares, presentamos una descripción generalizada del grupo familiar en la que se condensan las características comunes a estas familias:

En el hogar de esta muchacha adolescente, bastante aniñada, a nuestros ojos, para su edad, pero a quien se le exige hacerse cargo de roles que no le corresponderían en otra clase social, encontramos una

familia cuyos miembros provienen del interior, aunque su estructura, tal como la encontramos ahora, tiene quizá sólo cinco años de existencia.

Su madre suele trabajar como empleada doméstica, lava y plancha ropa en su casa o realiza alguna tarea manual cobrando por cantidad. Su compañero trabaja en changas en forma ocasional; no suele estar de buen humor, es más bien callado y permanece poco en casa. Si en ciertas ocasiones se emborracha se vuelve peligroso, ella sabe que sólo amenaza, pero verlo intimidando con un cuchillo a su madre, a sus hermanos o a ella, la asusta hasta el terror.

Esta adolescente-tipo es alegre y charlatana fuera de su casa; en su hogar no se siente bien, es tímida y reservada, callada y seria, está siempre trabajando, lavando, planchando, limpiando, cuidando a los hermanos; por eso, en cuanto puede sale a hacer mandados, aprovechando para encontrarse un rato con sus amigas, pocas, y comentar cosas acerca de los muchachos del barrio. No le atraen el aseo ni el arreglo personal, por el contrario, su cuerpo y su apariencia la tienen sin cuidado. La sexualidad es algo siempre presente y en acecho, pero tremendamente peligroso, por eso temida y sobre todo negada.

Esta adolescente posee figuras parentales típicas: su madre suele ser silenciosa, gritona y punitiva; a menudo la castiga físicamente. Espera que se la trate con suma consideración y se queja constantemente por no lograrlo; acusa a los demás, por otra parte, por este hecho. Generalmente el peso del hogar cae sobre sus hombros; a pesar de sus quejas, parece resignada a ello y esta idea la transmite a su hija.

Su padre es una figura desdibujada y ausente. Se fue hace mucho tiempo, cuando era chica, no sabe bien por qué, pero de pronto no estuvo más. Quizá se fue a trabajar lejos o se volvió a su provincia o se fue a vivir con otra mujer, pero en general no lo volvió a ver, quedando implícito el tema como tabú. Un día, también de pronto, apareció otro hombre, y tal vez todavía viva con ellos; es el padre de sus numerosos hermanos menores. A veces le pega, aunque no es frecuente. Por lo general es mezquino con ella; prefiere abiertamente a sus hijos varones, ignorando o castigando injustamente a sus hijastros. En ocasiones actúa provocativamente con ella; si se emborracha suele tratar de seducirla y en estos casos la madre la defiende y se enoja muchísimo con su compañero. A veces tiene ella que defender a la madre de los ataques del padrastro, y cuando éstos son muy violentos ha tenido que ir a la comisaría para que los protejan. Lo detienen un par de días, cuando regresa está mucho más calmado y sin ningún tipo de explicación las cosas siguen como antes. En otras ocasiones amenaza con irse y llevarse sus cosas.

En cuanto a la madre, tiene un ideal femenino que extrae de una pauta que no proviene de su experiencia concreta, sino que pertenece a otra clase social y es la que trata de lograr que su hija realice. Trata, por lo general inútilmente, que su hija no sea lo que ella fue y es por-que esto es desvalorizado.

* Licenciados. Psicólogos del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia. Coordinadora: Licenciada Martha Gonçalves. Supervisión técnica: Licenciado Roberto Harari.

¹ Una descripción detallada de las características de la comunidad a la que esta experiencia se refiere, se puede encontrar en el trabajo de B. Mercer *et al.*: *Familia y marginalidad en el Gran Buenos Aires*, presentado en el presente Congreso.

El ideal del yo raramente corresponde a lo que ha incorporado de las figuras más importantes del mundo de su infancia, sino a imágenes ajenas, idealizadas e inalcanzables, tal como se lo ha presentado su madre. De esta manera nuestra adolescente la siente como una madre controladora, exigente, que la obliga por un lado a respetarla y por otro a denigrarla.

Todo sigue así hasta que un día, de pronto, encuentra un muchacho que sin saber cómo se la lleva a vivir con él. Tiene un hijo. Siente que no ha cumplido con las esperanzas de su madre, vuelve a ella, le entrega el hijo sintiendo que la ha defraudado. Ahora están iguales y podrán entenderse y comprenderse, compartir la resignación y tratar de hacer de este nuevo hijo lo que de ella se esperaba.

Esto nos recuerda a Erikson cuando dice: "... generaciones dependerán de la habilidad que cada uno de los individuos procreadores tengan para enfrentar a sus hijos, mostrando que él fue capaz de salvar cierto entusiasmo vital de los conflictos de la infancia ...", "... dichos principios de educación temprana fallan desde su raíz porque exigen un esfuerzo demasiado constante de parte de los padres: la transforman más bien en educación de padres que de hijos".

Dinámica del grupo familiar*. Teniendo en cuenta las características generales de la familia tipo descripta, pasaremos ahora a analizar algunos aspectos conflictivos de esta etapa evolutiva, tal como se dan en las adolescentes de esta comunidad particular. Nos centraremos fundamentalmente en el análisis de la resolución de la situación edípica, ilustrando las hipótesis con ejemplos extraídos del material vertido en las sesiones grupales.

En las integrantes del grupo esta resolución se ve dificultada por la circunstancia real de la ausencia del padre biológico en edad temprana. El hecho actual de la presencia del padrastro hace revivir en la adolescente su primitiva fantasía de haber destruido omnipotentemente la pareja parental. Pero, a diferencia de aquella situación, en el presente el padrastro es una figura ambigua: por un lado ocupa el rol paterno, por lo que la adolescente debe renunciar a unirse sexualmente con él; por otro no es estrictamente su padre, por ello los deseos eróticos hacia él están menos inhibidos. La presencia del padrastro acorta, pues, la distancia entre fantasía y acción, intensificando el peligro de la retaliación como consecuencia del deseo incestuoso, y por consiguiente la fantasía de destrucción de la pareja.

De esta manera, las circunstancias reales de la ausencia del padre biológico en edad temprana, la presencia del padrastro —ambos hechos abruptos e inesperados— y la modalidad de los vínculos establecidos con ellos dan características distintivas al proceso de elaboración de la reedición de la situación edípica.

* La mayoría de las ideas aquí expuestas fueron elaboradas en el grupo de control coordinado por el licenciado Roberto Harari.

En la relación con la figura del padre biológico, hemos observado que el grupo familiar no hace una elaboración progresiva del duelo por su pérdida, sino que ésta es negada y la salida de esta situación se produce a través de la inclusión abrupta de un sustituto por parte de la madre.

En cuanto a la figura del padrastro, éste desempeña desde el punto de vista formal el rol del padre, pero su conducta concreta no satisface las expectativas de la adolescente en lo referente a aportes básicos vinculados a ese rol. La frustración constante de estas expectativas genera un monto de agresión hacia él, lo que por otra parte se pone al servicio de la defensa de carácter reactivo frente a la intensificación de los impulsos incestuosos:

Marta: "... pero le tenía una bronca a mi padrastro cada vez que me acordaba. Estábamos comiendo y él dijo que no quería más pizza, mi mamá le dijo que me diera y él me tiró el plato y yo se lo devolví igual y le dije: 'No quiero comer su comida...'".

La defensa reactiva se expresa a nivel manifiesto de dos maneras: por un lado como agresión directa hacia el padrastro, y por otro mediante el establecimiento de una excesiva distancia emocional para bloquear la emergencia del deseo:

Marta: "Norma ... fue y le preguntó a la madre (*si podía salir*); la dejó pero después el padrastro se enojó."

Alicia: "¿Qué tiene que ver el padrastro con ella?" ... "Yo le pido a mi mamá y si ella me deja voy igual."

Raquel: "¿Y si tu padrastro no te deja?"

Alicia: "Yo le hago caso a mi mamá."

Otra defensa utilizada con este mismo fin es la proyección en la figura del padrastro de sus propios deseos, en ella misma negados, mecanismo indudablemente favorecido por la conducta real de aquél. Por ello la vivencia a nivel consciente es la de ser víctima de la situación sin participación activa en ella.

En cuanto a la modalidad de los vínculos intrafamiliares, consideramos ahora algunos aspectos relacionados con el manejo de los impulsos incestuosos. En esta estructura familiar la adolescente posee la imagen interna de una madre que promueve la emergencia del impulso libidinoso y apoya las conductas correspondientes:

Marta: "Una vez mi hermana le dijo si la dejaba ir al baile y mi padrastro no quería ... y mi abuela dijo que cuando se durma nos íbamos a ir. Fuimos y ... cuando volvimos estaba en la puerta de la casa, y le dijo a mi mamá adónde fuimos. Mi mamá le dijo a bailar. Él le dijo: 'La llevaste con los hombres, la vas a entregar'."

El padrastro, más allá de la imagen interna de la adolescente, provoca la intensificación de las fantasías eróticas con conductas a veces encubiertas y otras manifiestas de seducción, provocación y celos en relación a figuras masculinas del exogrupo:

Marta: "...el domingo pasado mi padrastro se peleó con mi mamá. A la mañana me fui y a la tarde volví. Estaba con mi novio y mi padrastro me pegó, mi novio me defendió y mi padrastro sacó un cuchillo. Yo me fui a la casa de mi tía. Esa noche mi padrastro no me dejaba entrar."

Por otra parte, aún cuando las características de la vivienda actual facilita una distribución espacial adecuada a los miembros, tiende a persistir cierto grado de hacinamiento, como la cohabitación y el colecho, que incrementan la excitación por la cercanía de la escena primaria, lo que reactiva primitivas fantasías de esta escena como coito sádico, intensamente destructivo para los miembros de la pareja parental, viviendo así también la adolescente en su fantasía la posibilidad de la relación incestuosa:

Marta: "...se empezaron a pegar y mi hermana lo agarró del cuello, lo tiró y lo agarró de los pelos. ¡Ojalá lo hubiera muerto! Mi mamá los separó. Después mi hermana salió disparando y él sacó un cuchillo..."

Las situaciones mencionadas determinan la vivencia de un intenso peligro ligado a la convivencia con el grupo familiar, y genera ansiedades de tipo claustrofóbico, ante cuya emergencia la adolescente tiende a una fuga evitativa hacia el mundo externo. Como contrapartida el exogrupo también es vivido como peligroso (generando ansiedades de tipo agorafóbico) por ser en gran medida desconocido y no haberse realizado un adecuado entrenamiento de los roles necesarios para actuar en él. Se da pues, en este momento evolutivo, una oscilación entre la fuga hacia el mundo exterior y la permanencia (en el nivel de sometimiento infantil) en el mundo familiar:

Marta: "...mi hermana salió disparando... se escondió detrás de un ombú. Después volvió y se metió abajo de la cama hasta el otro día. Al día siguiente nos fuimos a la casa de una vecina."

En un momento evolutivo posterior (habitualmente hacia los 15 a 16 años) la resolución de esta conflictiva particular se da a través de la fuga repentina del hogar acompañada de *actings* sexuales compulsivos. Desde otra perspectiva de análisis, esta resolución indica el fracaso de la adquisición de un rol diferenciado y una identidad individual dentro de un grupo familiar de tipo aglutinado, siguiendo la caracterización de Bleger. En efecto, en las familias de estas adolescentes se observa un

alto grado de indiscriminación en cuanto a la identidad individual de sus miembros y gran estereotipia en el desempeño de los roles. Al mismo tiempo predominan las conductas concretas, siendo pobre la función de simbolización y, de este modo, la comunicación se da fundamentalmente a nivel preverbal.

El *acting* es una salida observada en núcleos familiares de tipo aglutinado independientemente del nivel sociocultural al que pertenezcan. Donde se evidencia el peso de los factores socioculturales —tal como se ha observado en esta población— es en la modalidad del *acting* —regida por normas específicas de esta comunidad— y el momento evolutivo en que se produce, ya que implica la ruptura temprana con el núcleo familiar, la unión sexual prematura —y a menudo promiscua— en vínculos no formalizados y por consiguiente la adquisición precoz de responsabilidades inherentes al rol adulto, como embarazo, tenencia de hijos, etcétera.

Conclusiones. Las peculiaridades de esta estructura familiar y la posición ocupada por la adolescente en ella otorgan características diferenciales al modo en que se presentan algunas situaciones típicas de la crisis adolescente. En forma somera describiremos algunos de sus aspectos relevantes.

En primer lugar, el fenómeno generalmente observado en los adolescentes de otros medios socioculturales de la intensificación del repliegue en la fantasía —tal como lo exponen A. Aberastury y otros— como una manera de "reconectarse con su pasado para retener muchos de sus logros infantiles y desde allí enfrentar el futuro, con el afán de alcanzar su nuevo status", no se registra en la población de la cual nos ocupamos, verificándose en cambio la tendencia a las conductas a nivel concreto. La vinculación de esta tendencia con perturbaciones en el desarrollo de la función simbólica es sin duda un punto importante a considerar, pero excede los límites de este trabajo.

En segundo término, con respecto a la elaboración de la pérdida de la bisexualidad y el pasaje a la unisexualidad, podemos comprobar que la moratoria psicosexual que otras comunidades otorgan a los adolescentes —posibilitando una progresiva elaboración de los cambios de este período— está mucho más restringida en esta población. De este modo, la relación heterosexual aparece abruptamente y se da generalmente hacia fines del período puberal en forma de *acting* sin que ello implique una real elaboración de este pasaje.

En tercer lugar —e íntimamente relacionado con el anterior— observamos que la elección de objeto sexual y por ende el coito se produce tempranamente. Correlativamente comprobamos la inhibición del culto narcisístico del cuerpo. Probablemente esto sea consecuencia de la facilitación en este medio de la consumación de la relación sexual, fomentando el desplazamiento de la energía libidinosa hacia un objeto externo heterosexual.

A través de los distintos puntos del análisis realizado sobre la estructura familiar de una comunidad específica y su relación con el desarrollo de la identidad de las adolescentes podemos observar que la situación universal de crisis en este período de la vida adquiere especiales formas de manifestación, particularidades en determinados conflictos y también específicos mecanismos de resolución, de acuerdo con variables socioculturales de la comunidad.

Mito y familia

MIGUEL MENDEZ ELIZALDE *

Esta comunicación es una generalización aproximativa al problema del mito en la familia. Desde el comienzo de mi práctica con familias, hace ya algunos años, uno de los fenómenos que más me interesó era el encontrarme frente a un cierto tipo de creencias compartidas por toda la familia, irreductibles a una comprensión lógica, ya que parecían pertenecer a una descripción objetiva de la realidad y no podían ser reconocidas en su carácter de ilusión, de modo que formaban una verdadera mitología familiar **. A diferencia del mito, que es un relato de acontecimientos fabulosos que puede a su vez ser origen y explicar una sociedad totémica, por ejemplo, acá no hay un relato explícito, sino que debe ser inferido de sus consecuencias en la práctica y de la comunicación entre los miembros, que permite al observador reconstruirlo. Muchas veces forma parte de un —llamémoslo así— pararelato, que transcurre imbricado en todas las interacciones.

Voy a comenzar con un ejemplo clínico y espero que, a partir de él, podamos definir el problema. Es un ejemplo muy simple. Se trata de una familia compuesta por padre, madre y dos hijos varones que consultó a causa de que el hijo menor de 15 años, estaba casi en estado de autismo. A los 2 años de edad había desarrollado un granuloma de paladar que fue irradiado, produciéndose a consecuencia de esto un daño hipofisario irreversible. En el momento de la consulta tenía una diabetes insípida, detención del crecimiento y falta de caracteres sexuales secundarios. Había abandonado el colegio, aunque era buen alumno, y no quería hablar con nadie. Su aspecto contrastaba con el de su hermano mayor, alto y fuerte. En el curso de la entrevista surgió la creencia compartida por todos de que si le compraban un auto *Falcon* se resolvería el problema.

* Servicio Psicopatología y Neurología. Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Pcia. de Buenos Aires.

** Frente a una situación mítica operante, la tendencia es la de enfrentar las contradicciones que se dan en el nivel manifiesto o recurrir a interpretaciones de contenido que muchas veces son prematuras.

En esta descripción general, pero incompleta, ustedes apreciarán cierto número de contradicciones que se dan en la familia. Por un lado, está la serie enfermo-dañado-chico-débil-castrado, y por el otro la serie sanos-indemnes-adultos-fuertes-viril, que aparecen como una discontinuidad en el seno de la familia. El mito del *Falcon* que los une a todos actúa como mediador entre estas dos series, como un objeto manufacturado, y esto es importante, que resuelve aunque no supera las contradicciones. Con esto quiero recalcar lo importante que es la "posición" del mito en el sistema familiar por sobre su contenido simbólico.

El mito del *Falcon* homologa naturaleza y cultura al permitir reemplazar por un objeto inanimado, aunque manufacturado, la falta de pene y virilidad, es decir de vida; y finalmente restituye ilusoriamente lo perdido a través de la imitación de una prestación funcional por parte del grupo con respecto al paciente.

Levi-Strauss en *Lo crudo y lo cocido* estudia los mitos ofahe y ge sobre el origen del fuego. En estos mitos el hombre toma el fuego del jaguar, con quien está en términos amistosos. Sin embargo es hostilizado por la pareja del jaguar, que en dos de las versiones es humana, y entonces la mata, cosa que al jaguar no le preocupa e incluso aprueba. Dice Levi-Strauss que siendo jaguar y hombre términos polares de oposición, el contraste no sólo es absoluto sino que una relación de reciprocidad entre los dos es nula. Para que todo lo que posee el hombre haya podido venirle del jaguar es preciso que aparezca una mediación en la relación y tal es el papel de la mujer humana del jaguar. Una vez efectuada la transferencia del fuego, donde la mujer es intermediaria, el hombre y el jaguar se separan y vuelven a su relación de reciprocidad nula, por lo tanto la supervivencia de la mujer es contradictoria y por esto es suprimida. Volviendo a nuestro ejemplo del mito del *Falcon*, ahora nos explicamos mejor su "posición" en el sistema familiar, semejante al de la mujer del jaguar.

Levi-Strauss, que estudió mitos de otras culturas a través del análisis estructural, nos dice que así como en lingüística se dio un paso fundamental cuando se pasó de querer relacionar los sonidos con el sentido en el seno de una lengua, a encontrar que lo significativo es cómo se relacionan los sonidos entre sí, es decir, que la relación entre el significante y el significado es arbitraria y lo que importa es la relación entre los significantes, en el estudio de los mitos el sentido debe buscarse no en los elementos aislados sino en la forma en que están combinados. Es decir que lo que importa en el mito son las relaciones entre sus elementos más que los contenidos. De esta manera el mito refleja una particular forma de pensar y organizar la experiencia, actúa como un mediador entre antítesis inconciliables tales como vida-muerte, naturaleza-cultura; une grupos previamente separados y establece relaciones de homología entre ellos tales como entre la serie natural y la serie cultural.

Carpinacci, en un trabajo muy interesante del año pasado, describió cómo el mito personal de una paciente sobre su identidad y la de su familia la defendía de la irrupción de la psicosis y el derrumbe de su personalidad. También en este caso el mito obraba como un mediador entre un mundo objetual deshecho y un yo no muy bien estructurado.

Otro trabajo del mismo autor en colaboración con Goijman, Pellegrin y Weis, mostraba cómo un grupo de adolescentes en tratamiento dramatizaban por sí mismos un mito que les permitía el pasaje a la adultez.

Ahora trataré de mostrarles a través de otro ejemplo un mito que ocupa una distinta "posición" que el del primer ejemplo.

Se trata de una pareja de edad avanzada y más de 40 años de matrimonio, con varios hijos todos ellos casados, y viviendo aparte. Consultan por peleas continuas que vienen de toda la vida. Están viviendo en un departamento, solos, frente a frente por primera vez y "esperando morirnos" como dice el marido. Del relato que hacen de las múltiples causas que tienen para disputar, se podría sintetizar lo siguiente: a) que la mujer le reprocha al marido el ser como es, y b) que el marido le reprocha a la mujer el tratarlo como lo trata. Como ustedes ven, al tratarlo ella como lo trata, por ser él como es y viceversa, cómo entonces no va a ser él como es si ella lo trata así, están asegurando el círculo vicioso. Sobre un punto en particular se dramatiza en forma más repetida el conflicto: él quiere cuidarla a ella en cosas tales como prepararle el desayuno, que según dice es lo que lo haría más feliz, y ella aborrece precisamente eso, rechazándolo en ocasiones con la frase "no quiero verte en servil".

Al mismo tiempo se definen como una pareja unida por el máximo afán de cariño, lucha, integridad, renunciamento y sacrificio. Como una unión casi perfecta, que no es pasible de ser entendida por otra persona, donde cada uno está totalmente seguro del otro. Es una unión romántica y tan sólida como la naturaleza, ya que comparten el amor a las plantas, las flores y los animales.

Otro aspecto importante es el hecho de que la madre de él, mujer dominante y despótica, que vivía con ellos y a quien la esposa atribuye algo así como el fracaso del matrimonio, murió hace 4 años con más de 90 años de edad.

Se establece la "posición" del mito ubicándolo con respecto a las condiciones objetivas en que vive la familia. Con esto me refiero al marco socio-económico que determina las contradicciones específicas de clase, el género de vida, las técnicas de comunicación, la historia y el contexto cultural. Esto permite la localización de la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción y las contradicciones específicas, lo que posibilita la comprensión del proceso.

En efecto, se ha roto la organización familiar como sistema, ya no producen, entonces imitan prestaciones funcionales tales como que el

marido cuida a la esposa, porque se han quedado sin roles de padre y madre; con la muerte de la madre de él dejaron de ser hijos y se enfrentaron con la propia muerte, cada vez están más lejos de la historia mítica que se refiere a una pareja ideal, un padre y una madre unidos y creadores. La diacronía, o sea la historia, les niega esa posibilidad en la actualidad. Están realmente enfrentados a contradicciones insolubles: la vejez, la separación de los hijos, la propia muerte. De acuerdo a nuestra sociedad, el aspecto principal de la contradicción para esta pareja es que ya deberían estar muertos, se han cumplido los plazos, lo único que sobrevive es el mito. Con respecto a la "posición" del mito, la propia pareja dio la clave al sacarlo del contexto de sus relaciones y al no admitir el cotejarlo con el resto de su vida y ubicarlo en el tiempo. El marido decía de la mujer: "es mi muchachita, la veo siempre igual, no se puede desdibujar, es mi creación". Pero esta es la clave, si el mito en las sociedades primitivas, como dice Lévi-Strauss, sirve para fundar un pensamiento al establecer una homología entre dos sistemas diferentes tales como el de la serie natural y el de la serie cultural a través de la mediación, entonces tiene esencialmente un carácter metafórico estableciendo un respeto fundamental por la independencia de las dos series, entonces el mito no es un sistema de creencias sino un método de pensamiento, basado en la lógica de las cualidades sensibles, que permite ordenar y clasificar. Los hombres del clan del oso, no son osos; ésto significa que son distintos al clan de la urraca; es una denominación, y a través de ella fundan un sistema de diferencias. No intentan explicar nada, unen discontinuidades, como veíamos en el mito del *Falcon*. La obra de teatro *Quién le teme a Virginia Woolf* trata de una pareja estéril que crea el mito de un hijo ilusorio, pero ellos no creen tener un hijo, sino que el mito del hijo les permite seguir juntos, o sea que el mito no tiene una significación intrínseca tan importante. Esto no ocurre así en esta pareja. Acá el mito ya no tiene una función de mediador, por lo tanto metafórica, sino que se ha convertido en una realidad concreta, han pasado del reino de la metáfora al reino de la metonimia, que es la religión, donde el hombre se convierte de verdad en animal o viceversa sin comprometer a toda la especie, esto es la metonimia.

Ferreira, en 1963 decía que el mito familiar funcionaba como parte integrante del sistema homeostático familiar, asignando roles y estipulando conductas, y era utilizado como una defensa grupal donde estaban prescriptas las reglas ocultas de la relación. En resumen, como la válvula de una caldera. Creo que Ferreira tomaba al mito familiar en este segundo aspecto que estamos viendo.

Continuando con la pareja, el mito sirve para coagular el tiempo, paralizar los acontecimientos, eludir el campo de las contradicciones reales, se interviene en el determinismo natural, completándolo o modificándolo. El peligro está en los nuevos acontecimientos; el mito se ha convertido en un rito histórico; podríamos decir que el mito está

mistificado ya que la realidad, los hijos, el trabajo, huye de ellos y el mito no los puede alcanzar.

La pareja no está en peligro por las peleas, ya que hace 40 años que discuten, el que está en peligro es el mito. Pero estas peleas no entran en contradicción ni afectan a la historia mítica de unión. ¿Por qué? Porque las peleas no son como un juego donde uno gana y otro pierde, uno vive y otro muere y al término del cual quedan separados, sino el campo semántico privilegiado donde ellos resuelven las contradicciones objetivas que se dan en otro nivel. Este es un juego que los une; nuevamente los términos de la discusión no poseen significado en sí mismos sino por su posición, ya que son las reglas del juego que aseguran el equilibrio del campo. No se llaman con nombres lindos cuando se insultan entre ellos, pero más que el contenido de los nombres, importa que están clasificando y controlando con el rito, lo nervioso, lo dependiente, lo celoso, lo servil. A través de las definiciones de cada uno con respecto al otro, establecen una asimetría, se dividen en dos bandos y comienza la partida. Los nombres son como las barajas de la partida, que manejan como si fueran una realidad externa, de esta manera y a través de este ritual consiguen controlarla.

En síntesis: en esta pareja el mito pasa de mediador a ocupar la "posición" de polo opuesto al aspecto principal de la contradicción.

Creo con ésto haber explicado algo del alcance y la operatividad del mito en la familia. La posibilidad es que en lugar de enfrentar el mito como un obstáculo sea por el contrario un instrumento privilegiado para la comprensión.

Grupo familiar e intentos suicidas en la adolescencia. Un modelo para el estudio de la agresión

OCTAVIO FERNANDEZ MOUJÁN *
ROBERTO ILLEYASOF
SILVIA TUBERT DE PEYROU *

En este trabajo presentamos los resultados de una investigación acerca de algunos aspectos relacionados con el manejo de los afectos dentro de determinadas estructuras familiares. Nos hemos ocupado especialmente de los afectos agresivos por dos motivos, uno empírico y otro teórico. Hemos observado en una investigación anterior¹ que había una diferencia notable en la resolución de situaciones agresivas en las familias cuyo motivo de consulta era un intento suicida calificado por nosotros como "benigno", en comparación con las que consultaban por un intento suicida "maligno", y con el grupo control (incluyen casos que presentaban otras patologías). Vimos que la agresión no recibía ningún tipo de "elaboración" en las familias de los pacientes con intentos suicidas malignos; era "mal elaborada" en los casos de intentos suicidas benignos, y "aceptablemente elaborada" en los casos control. Además, observamos que la influencia de la familia en los intentos de suicidio benignos es directa, cosa que no ocurre en los intentos de suicidio malignos. Con respecto al motivo teórico, suponemos que existe en toda familia con un hijo adolescente, una situación de inestabilidad por el aumento de la agresión dentro del grupo familiar, cuya "fuente natural" es el adolescente mismo. Pensamos que la familia atraviesa una situación de insatisfacción e inestabilidad² transitorias, que puede ser manejada de distintas maneras:

a) Los padres "responden" a esta fuente natural de hostilidad con total prescindencia o fuerte represión, consiguiendo así una "estabilidad insatisfactoria".

* Servicio Psicopatología. Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Pcia. de Buenos Aires.

** Agradecemos a la licenciada Gisela Rubarth su colaboración en la primera etapa de este trabajo.

¹ "Intentos suicidas juveniles", llevada a cabo en el Servicio de Psicopatología del Policlínico "Aráoz Alfaro", de Lanús.

² Tomamos esta terminología de Don D. Jackson.

b) Los padres responden con otra agresión de igual calidad e intensidad, y esta situación se estructura como algo permanente, tomando ellos el rol de fuente "secundaria" de la agresión. De esta manera no existe resolución de la agresión ni para el adolescente ni para la familia, a causa de la incapacidad de los padres para modificarla. (En la nomenclatura de Jackson correspondería al grupo "inestable insatisfactorio".)

c) Cuando los padres responden con modificaciones cualitativas y cuantitativas de la agresión, el adolescente se siente más protegido de su propia hostilidad, lo que le permite expresarla y elaborarla de alguna manera, sin verse obligado a dejar su rol de fuente de la agresión. En este caso encontramos una situación "satisfactoria inestable", en la cual las manifestaciones agresivas son transitorias, lo que para nosotros es un índice de que existe cierta "elaboración de la agresión".

Hablamos entonces de "deficiencias en la elaboración de la agresión" cuando el grupo familiar ha perdido transitoria o definitivamente la capacidad de simbolizar, reparar e instrumentar la agresión (capacidad de modificarla). Cuando el adolescente enfrenta a una familia que carece de estas capacidades en forma definitiva, tiene dos salidas: la actuación agresiva (delincuencia), o la transformación de la heteroagresión en autoagresión (intento de suicidio). De esta manera la familia vuelve a su estructura primitiva, al precio de la renuncia del adolescente a su identidad.

Estas familias pueden ser llamadas "aglutinadas" (según la clasificación presentada en el trabajo anterior), y entre sus características incluimos el manejo de la agresión por "anulación". Entendemos por anulación la respuesta a una agresión (expresada por alguno de los hijos) con otra agresión de las mismas características. Esto fortalece la estereotipia del grupo, que pierde su dinamismo propio, necesario para el cambio y el crecimiento del grupo familiar.

I. Hipótesis. 1. La familia con un hijo adolescente que consulta por un intento suicida, es incapaz de tolerar la expresión de la agresión porque no puede elaborarla, por la incapacidad de simbolizarla, instrumentarla y reparar, tanto dentro del grupo familiar como en el extragrupo. Estas deficiencias en la elaboración de la agresión están directamente relacionadas con la estereotipia de la estructura familiar.

2. Esto se debe a una deficiencia en el desempeño del rol paterno (discriminación e instrumentación), y a una hipertrofia en el desempeño del rol materno (unión y expresión de afectos), lo que lleva a la aglutinación del grupo familiar.

3. En este tipo de familia la agresión se maneja eligiendo un chivo emisario que asume la agresión, volviéndola contra sí mismo, lo que impide la desintegración del grupo.

II. Diseño de investigación. Selección de la muestra. Trabajamos con dos muestras tomadas de la población de familias que consultaron por pacientes adolescentes (de 12 a 21 años), entre octubre de 1967 y junio de 1969.

Grupo experimental: familias de pacientes que presentaron un intento suicida como motivo de consulta o que hubieran tenido intentos suicidas previos, siempre que no fueran antes de los 12 años.

Grupo control: familias tomadas al azar entre el conjunto de los adolescentes que concurren a la consulta por otros motivos.

Tamaño de la muestra. Las muestras incluían 30 casos cada una. Hemos tomado al azar 10 casos de cada grupo para el presente trabajo.

Estudio de la muestra. 1. Recolección de datos. Se realizó una entrevista familiar en cada uno de los casos. Se consideró necesaria la presencia del paciente que consultó y uno de los padres como mínimo.

La entrevista era conducida por un entrevistador y registrada por un observador. Su duración variaba entre una hora y dos horas, y se dividía en dos partes, para cada una de las cuales se formulaba una consigna diferente. La primera consigna solicitaba a la familia conversar acerca del motivo de consulta que los llevó al Policlínico. La segunda consigna les proponía hablar sobre el grupo familiar como tal. Exceptuando estas dos consignas, se dejaba actuar libremente a la familia.

2. Análisis de los datos. Trabajamos sobre los registros de las entrevistas, aplicando un modelo de análisis centrado en la interacción. La unidad de análisis considerada es la secuencia de agresión, entendiendo por tal una pauta de interacción iniciada por una agresión de ataque, seguida por respuestas agresivas defensivas, y que termina con una respuesta no agresiva.

Se estudiaron las siguientes variables:

a) **Fuente de agresión:** llamamos así a la persona que inicia una secuencia de agresión con mayor frecuencia durante la entrevista, en proporción al número de intervenciones.

b) **Dirección de la agresión:** llamamos así a la estructura que resulta de considerar quiénes manifiestan agresión y hacia quiénes la dirigen. Diferenciamos en esta variable las siguientes categorías:

- 1) Centrifugas: la agresión se dirige de los hijos hacia los padres.
- 2) Centrípetas: la agresión se dirige de los padres hacia los hijos.
- 3) Mixta: la agresión se dirige en ambas direcciones.
- 4) Sin dirección fija.
- 5) La agresión se dirige hacia el extragrupo.

c) **Respuesta a la agresión:** es la manera en que los miembros del grupo familiar responden a la "fuente de agresión". La categorizamos de la siguiente manera:

- 1) Responden con otra agresión de iguales características.
- 2) Responden desplazando la agresión hacia otras personas y objetos de valor simbólico (desplazamientos en tiempo y lugar).
- 3) No responden con agresión:
 - 3.1 La "rebotan" (no acusan recibo)
 - 3.2 La evitan.
 - 3.3 Se someten.
 - 3.4 Aplacan.
- 4) Responden con cierta comprensión (simbolización, instrumentación y/o reparación y esclarecimiento).

d) **Evolución de la agresión:** incluye tres aspectos:

- 1) Cantidad y extensión de las secuencias agresivas. Categorizamos la extensión de la siguiente manera:
 - secuencias largas: las de cuatro intervenciones o más.
 - secuencias cortas: las de menos de cuatro intervenciones.
- 2) Cambios cuantitativos y cualitativos de las secuencias de agresión a lo largo de la entrevista y especialmente al final.
- 3) Relación entre secuencias agresivas y no agresivas.

e) **Magnitud de la agresión:** Incluye dos aspectos:

- 1) Cantidad relativa de intervenciones agresivas y no agresivas.
- 2) Intensidad agresiva de las intervenciones. Para medirla se aplicó una escala (cuadro VII), que es una modificación de la escala de hostilidad de L. A. Gottschalk y colaboradores. Se obtuvieron así índices de intensidad de la agresión.

f) **Diagnóstico familiar:** corresponde a una evaluación de la estructura familiar. Aplicamos las siguientes categorías (usando las definiciones que figuran en el trabajo leído anteriormente):

- 1) Aglutinada
- 2) Uniformada
- 3) Aislada
- 4) Integrada

III. Análisis de los datos. 1. Fuente de agresión. a) En ambos grupos el paciente aparece como fuente de agresión en un 10 % de los casos. Suponemos que este 10 % corresponde a lo que hemos denominado "fuente natural" de la agresión en los grupos familiares con un hijo adolescente. Luego, esto apoyaría nuestro planteo teórico acer-

ca de la importancia del grupo familiar en los problemas del manejo de la agresión.

b) Comparando los datos sobre agresión "compartida" por padres e hijos, observamos una mayor tendencia a la estereotipia en el grupo I.S. (10 % en "compartida"), con respecto a la fuente de la agresión, y una mayor distribución de la misma en el grupo C. (30 %.)

c) En los casos control el padre aparece como "fuente" en un 20 % de los casos, contra un 0 % en el grupo I.S. Teniendo en cuenta que la agresión del padre está más de acuerdo con su rol de imponer orden y discriminación, pensamos que este dato apoya nuestra segunda hipótesis (deficiencia en el rol paterno más notable en el grupo I.S.). Además, en el grupo I.S. el padre está ausente en la entrevista en 6 de los 10 casos, en tanto que en un solo caso control faltó el padre.

2. *Dirección de la agresión.* a) En el grupo control encontramos una mayor flexibilidad en la dirección de la agresión, la cual carece de "dirección fija" (70 %), comparado con el grupo I.S. (10 %). La dirección fija (90 %) en el grupo I.S. apoya nuestra hipótesis sobre la estereotipia (hipótesis I).

b) Esa dirección fija es predominante "centrípeto" (60 %) en el grupo I.S., lo que apoyaría nuestra tercera hipótesis acerca de la elección de un chivo emisario.

3. *Respuesta a la agresión.* a) El porcentaje de respuestas agresivas es moderadamente mayor en el grupo I.S.

b) Consideramos más relevante la diferencia entre las respuestas comprensivas, a favor del grupo C, con predominio de los padres, lo que apoya nuestra hipótesis de una mayor posibilidad de elaborar la agresión.

4. *Evolución de la agresión.* a) Encontramos un mayor porcentaje de secuencias agresivas en el grupo I.S. (68 %) que en el grupo C (36 %). Esto apoya la hipótesis de una mayor agresividad en las familias del grupo I.S., en cuanto a *cantidad* de secuencias.

b) Considerando la extensión relativa de las secuencias agresivas y no agresivas como índice del manejo de la agresión, podemos concluir que en el grupo C hay un mejor manejo o elaboración de la agresión, pues cuando existe ésta es rápidamente elaborada (76 % de secuencias cortas contra 0 % en el grupo I.S.). Las secuencias no agresivas son toleradas y mantenidas durante más tiempo (50 % de secuencias largas contra 0 % en el grupo I.S.). Queremos destacar especialmente que en el grupo I.S. las secuencias no agresivas no son toleradas (son cortas en un 100 % de los casos).

5. *Magnitud de la agresión.* En el grupo I.S. la agresión está incrementada por aumento de la *cantidad* de intervenciones agresivas durante la entrevista (63 % contra 34 % en el grupo C), y por la mayor

intensidad agresiva de las intervenciones (el índice de intensidad promedio duplica al del grupo C).

6. *Diagnóstico familiar.* La estructura familiar del grupo I.S. corresponde a la categoría aglutinada (90 %) y la del grupo C a la categoría integrada (80 %). Estas cifras corroboran nuestra segunda hipótesis.

Conclusiones. La observación clínica de 70 familias, realizada en una investigación anterior, y el estudio sistemático de 20 de ellas, nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:

1. Entendemos por "deficiencia en la elaboración de la agresión" dentro de una familia, la incapacidad de responder a las fuentes naturales o circunstanciales de hostilidad, ya sea verbalizándola de una forma más abstracta, instrumentándola dentro o fuera de la familia, o dando respuestas reparatorias o esclarecedoras que disminuyan su intensidad y modifiquen su calidad.

2. Hemos construido un modelo para el estudio de la elaboración de la agresión y sus deficiencias. El modelo, que consiste en un conjunto de variables operacionalizadas, se centra en las secuencias de interacción agresivas y no agresivas en la entrevista familiar, e incluye una escala que mide la intensidad de la agresión.

3. Nuestras hipótesis surgieron de la observación clínica. Los resultados obtenidos aplicando el modelo (que hemos expuesto en este trabajo) coinciden con nuestra observación clínica, lo cual, además de corroborar nuestra hipótesis, valida el modelo.

4. El diagnóstico de familia aglutinada se incluye como un indicador importante de deficiencias en la elaboración de la agresión.

5. Pensamos que este modelo podría aplicarse para el estudio del manejo familiar de otros afectos, como el miedo, vergüenza, etc.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BLEGER J. y BLEGER L. — Grupo familiar, psicología y psicopatología, en L. GRUNBERG, M. LANGER y E. RODRIGUEZ: *El grupo psicológico*. Buenos Aires, Nova, 1959.
- FERNÁNDEZ MOUJÁN O. y PEYROU S. — *Aportes para una nosología del grupo familiar*. Trabajo presentado en el Primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, Buenos Aires, 1970.
- FERNÁNDEZ MOUJÁN et al. — *Intentos suicidas juveniles*, Primer Congreso Infanto-Juvenil Argentino, 1969.
- GOTTSCHALK L. A. et al. — The Measurement of Emotional Changes During a Psychiatric Interview: a Working Model Toward Quantifying the Psychoanalytic Concept of Affect, en L. A. GOTTSCHALK y A. H. AUERBACH: *Methods of Research in Psychotherapy*, New York, Appleton, Century, Crofts, 1966.
- JACKSON D. D. — Family Interaction, Family Homeostasis and some Implications for Conjoint Family Psychotherapy, en J. H. MASSERMAN: *Individual and Familial Dynamics*, New York, Grune and Stratton, 1959.

Aportes para una nosología del grupo familiar

OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN *
SILVIA TUBERT DE PEYROU

Introducción. Reflexionando sobre una investigación anterior acerca de los intentos suicidas juveniles, encontramos algunos elementos importantes con respecto a la relación entre familia y adolescencia. Comprendimos que la adolescencia es una etapa ideal para el estudio de la estructura familiar, ya que el adolescente, con sus cambios, pone a prueba la estabilidad y la identidad familiar, haciendo necesario un cambio de roles para el desarrollo del grupo. Nos referimos no sólo a una mayor flexibilidad en la asunción de los roles, sino también a un cambio cualitativo en la asignación de los mismos (paternos y filiales). Dijimos que se trata de una etapa ideal porque frente a esta situación límite se pone en evidencia la tolerancia o intolerancia familiar ante el cambio, lo que revela las defensas con que cuenta la familia. Estas defensas son instrumentales o patológicas. En el curso de la investigación mencionada, en la que tuvimos la oportunidad de estudiar 70 familias con pacientes adolescentes (40 casos con intentos de suicidio y 30 casos control), encontramos necesario establecer una primera diferenciación de los grupos familiares, ya que encontramos una relación directa entre el tipo de estructura familiar y la conducta suicida.

Otros enfoques sobre el tema. Uno de los puntos de partida de nuestra clasificación fueron los aportes de E. Pichon Rivière y J. y L. Bleger, quienes reconocen como extremos de una escala las estructuras esquizoide y epileptoide, donde los miembros se encuentran dispersos o segregados, en el primer caso, y aglutinados en el segundo.

Don D. Jackson toma como criterio para su clasificación el tipo de comunicación, más exactamente, las transacciones usadas para definir la naturaleza de una relación bipersonal. Los acuerdos logrados al respecto y la duración de los mismos determinan la *satisfacción* y *estabilidad* de la familia.

* Servicio de Psicopatología, Policlínico "Aráoz Alfaro", Río de Janeiro 1910, Lanús, Pcia. de Buenos Aires.

De la combinación de estas dos variables, resultan cuatro tipos de relaciones o familias:

1. En una relación *satisfactoria estable* ambas partes pueden alcanzar un acuerdo explícito acerca de quién controla la relación o las áreas incluidas en ella.

2. La relación *satisfactoria inestable* difiere de la anterior sólo en la duración de los períodos de inestabilidad, que son más extensos. Ocurre cuando hay una relación nueva o modificada, hasta que se alcanza una definición compartida de la relación.

3. En la relación *insatisfactoria inestable* no hay acuerdo explícito ni implícito acerca de quién controla la relación o las áreas incluidas en ella. Es necesario redefinir la relación cada vez que ésta es definida.

4. En la relación *insatisfactoria estable* nunca hubo acuerdo para considerar quién está a cargo de la relación. La relación es estable en el sentido de que se evitan los problemas que podrían hacerla inestable. Si bien se trata de una clasificación sistemática, considera un solo nivel de análisis, el de la comunicación y Jackson mismo critica el hecho de trasladar un modelo de relación bipersonal a una relación grupal.

Parámetros para una clasificación de familias. Incluimos en nuestra clasificación cuatro tipos de familias, que llamamos: aglutinada*, uniformada, aislada e integrada, y se pueden diferenciar según los parámetros que exponemos a continuación.

I. *Identidad.* Partimos de la idea de que la identidad grupal es un concepto dinámico, en tanto surge de la interacción entre las identidades personales y la identidad de la pareja como tal. Esta identidad grupal tiene una fuerza propia, que es uno de los factores principales en el desarrollo y cambio de la familia, y mantiene al mismo tiempo su continuidad y uniformidad¹. El grupo busca el equilibrio en una nueva situación en la que cada miembro reconoce el "yo soy" y en la que todos reconocen un "nosotros"².

Describiremos ahora las características de los cuatro tipos de familia según este parámetro.

1. En la familia *aglutinada* hay una falla en la identidad grupal, compensada mediante la exageración de la tendencia a la *aglutinación* (unión) propia de toda familia, lo que dificulta la individuación de sus miembros. Cuando existen intentos de individuación (más manifiestos en la adolescencia), éstos adoptan características *accesionales*. No nos referimos solamente a conductas explosivas graves, como auto agresiones o hetero agresiones sino también a ciertos índices observables en las entrevistas familiares, como crisis de llanto, conductas pre-verbales que indican descarga de tensión, expresiones de rabia aparentemente inmotivadas, risas, etc.

* Como se verá, definimos "aglutinada" de un modo diferente del de Pichon Rivière y Bleger.

2. En la familia *uniformada* encontramos una falla en la identidad grupal, compensada mediante la exageración de la tendencia a la *uniformidad* (semejanza). Se logra una mayor individuación de los miembros, pero todos deben someterse a la identidad de uno de ellos, que reemplaza a la identidad grupal. Los intentos de individuación son agresivos pero no accesionales; la agresión es más controlada y defensiva. Esto puede observarse en discusiones relacionadas con la rivalidad, enfrentamientos con el líder sometedor, preponderancia de expresiones verbales agresivas motivadas.

3. En oposición a los dos grupos anteriores, en la familia *aislada* hay un excesivo predominio de las identidades individuales, con pérdida de la identidad grupal, que no es compensada por ninguna de las dos tendencias, a la aglutinación y a la uniformidad. Hay sólo una apariencia formal de grupo familiar y los miembros se mantienen aislados y separados. En las entrevistas no se observan discusiones por motivos familiares, los miembros interactúan muy poco entre ellos, cada uno se dirige por separado al entrevistador.

4. En la familia *integrada* la identidad familiar mantiene en equilibrio los elementos de igualdad y diferencia entre sus miembros, dando al grupo un perfil propio en constante desarrollo. Hay un equilibrio entre las tendencias a la uniformidad y a la aglutinación, por la fuerza integradora de la identidad grupal, que permite la individuación de los miembros. En las entrevistas se puede observar que se discuten explícitamente problemas relativos al desarrollo de la familia, respetando los aportes de los miembros; las discusiones no tienden a la descarga sino al esclarecimiento, son breves y seguidas por interacciones no agresivas.

II. *Estabilidad*. Es un concepto estructural, referido a la posibilidad de la familia de enfrentar los conflictos, mantener la identidad a través del tiempo, y permitir su adaptación, tanto extra como intra-familiar. No se refiere a la dinámica de la interacción, como la identidad, sino a la organización del grupo familiar, que estimula el sentimiento de continuidad en un marco de confianza.

Describimos los distintos tipos de familia según su estabilidad.

1. En la familia *aglutinada* hay una excesiva rigidez o estereotipia de la estructura familiar, por la exageración del polo aglutinante, lo que impide resolver los conflictos grupales, cristaliza el desarrollo de la identidad, y lleva al fracaso en la adaptación social, marginando a la familia del grupo social más amplio. En las entrevistas se observa la estereotipia en la interacción y en la forma de enfrentar los problemas.

2. En la familia *uniformada* encontramos una excesiva rigidez o estereotipia en la estructura familiar, que impide resolver los conflictos y frena el desarrollo de la identidad; la diferencia con el grupo

anterior radica en que estas familias logran una mayor adaptación social, debido a la hegemonía de uno de sus miembros (polo uniforme). También se observa la rigidez de la interacción en la entrevistas, pero impuesta por algún tipo de criterio social.

3. En la familia *aislada*, la estereotipia no es una defensa grupal sino que resulta del aislamiento y escasa interacción entre los individuos. Existe estabilidad pero a costa de la pérdida de la identidad grupal, por lo que no lleva a ningún tipo de adaptación ni elaboración de conflictos. En las entrevistas se observa una interacción pobre y rígida; los miembros reaccionan individualmente.

4. En la familia *integrada* hay una organización estable y flexible; existe una posibilidad de cambio unida a la continuidad y desarrollo de la identidad, lo que permite enfrentar los conflictos y lograr adaptación social. En las entrevistas observamos que la interacción es flexible, no estereotipada. Se enfrentan explícitamente los conflictos y se proponen soluciones adaptadas, reconociendo las limitaciones. Dentro de este grupo pueden haber momentos de estereotipia ante situaciones de crisis, con tendencia a la aglutinación o a la uniformidad, es decir, puede fracasar la adaptación, o imponerse las soluciones de uno de los miembros.

III. *Roles y normas*. Entendemos por roles las funciones básicas (padre, madre, hijos) que desempeña cada miembro de la familia, y que son necesarias para mantener la estabilidad e identidad del grupo, sin impedir el desarrollo de las identidades personales.

Cada rol se desempeña en relación directa con ciertas normas y a su vez promueve normas para el funcionamiento de la familia.

Distinguimos tres roles básicos asignados por la estructura familiar:

Rol materno: tiende a la unión del grupo y a la regulación de los afectos.

Las *normas maternas* se refieren a los cuidados corporales, a la satisfacción de necesidades y al manejo de los sentimientos y emociones.

Rol paterno: tiende a la discriminación y a la regulación de las actividades instrumentales (pensamiento-acción). Las *normas paternas* se refieren al aprendizaje de roles sociales, a la administración de la autoridad y la justicia.

Rol filial: es un rol mesiánico, que tiende a promover la novedad y la esperanza en el grupo familiar. Las normas filiales corresponden a la regulación de la relación de dependencia-independencia.

La presencia y la ausencia de los roles se puede detectar por los siguientes indicadores:

a) el *absolutismo* de una función, indica que un rol está compensando la ausencia de otro.

b) las *normas* exageradas indican que el rol correspondiente está compensando la ausencia de otro. Veamos cómo se distribuyen los roles y normas en cada tipo de familia.

1. En la familia *aglutinada* observamos un absolutismo del rol materno y exageración de las normas maternas.

2. En la familia *uniformada* observamos absolutismo del rol paterno y exageración de las normas paternas.

3. En la familia *aislada* encontramos que los roles asignados están diferenciados, lo que dificulta la asunción de los mismos. Esta "ausencia" de todos los roles crea la necesidad de adquirir roles individuales independientes de la estructura familiar. Las normas correspondientes a cada rol no están en relación con el funcionamiento familiar, es decir que no hay normas familiares.

4. En la familia *integrada* encontramos un equilibrio entre los distintos roles asignados y asumidos, y discusión abierta de las normas filiales y parentales, sin preponderancia exagerada de ninguna de ellas.

IV. *Mensajes*. Hemos tomado en consideración dos aspectos. Uno de ellos es el grado de abstracción de los mensajes: éstos pueden referirse sólo al objeto concreto o a la abstracción y conceptualización del objeto. El otro aspecto es la carga emocional de los mensajes. No creemos que estos dos aspectos tengan la misma importancia para definir las distintas categorías.

1. En la familia *aglutinada* predominan los mensajes concretos y de intensa carga emocional.

2. En la familia *uniformada* encontramos una mayor proporción de mensajes abstractos, y con carga emocional controlada.

3. En la familia *aislada* no es relevante el grado de abstracción, pero sí la ausencia de carga emocional en los mensajes.

4. En la familia *integrada* hay un equilibrio relativo entre mensajes concretos y abstractos, y éstos tienen una carga emocional instrumentable.

Grados de patología familiar. La clasificación de Jackson implica grados de patología que van de la familia estable —satisfactoria a la estable— insatisfactoria pasando por las inestables. Nuestra clasificación también puede ordenarse según grados de patología, que irían de la familia integrada a la aislada, pasando por las aglutinadas y uniformadas que coincidirían con las inestables de Jackson. Queremos clarar que esta clasificación es esquemática y que sirve para señalar tanto estructuras predominantes en la familia, como tendencias que pueden surgir en una familia ante una situación de crisis.

Siguiendo esta correlación entre ambas clasificaciones, pensamos que un índice de patología es el pasaje de una relación satisfactoria

a una insatisfactoria. Luego, sería conveniente incluir este parámetro en nuestra clasificación, puesto que polariza nuestras categorías en normales y patológicas, del mismo modo que la variable estereotipia-flexibilidad.

El pasaje de una relación estable a una inestable, por el contrario, no indica patología sino una situación de crisis que puede ser resuelta favorablemente.

Conclusiones.

1. Creemos que una clasificación de familias tiene que cumplir los siguientes requisitos:

a) los parámetros deben extraerse de una teoría sistemática de la estructura y dinámica de la familia. Partiendo de una teoría de la familia como campo dinámico generador de una identidad grupal, hemos tomado los parámetros de identidad, estabilidad, normas roles, y mensajes.

b) Los diferentes parámetros deben correlacionarse, dando lugar a categorías complejas.

c) Deben encontrarse datos clínicos observables que funcionen como indicadores de las distintas categorías.

2. Proponemos clasificar las familias en cuatro categorías, definidas según las variaciones en los parámetros mencionados:

a) *Agglutinadas*: 1) Tendencia a la aglutinación; intentos de individuación accesorios. 2) Estereotipia en la interacción. 3) Absolutismo del rol materno y exageración de las normas maternas. 4) Predominio de mensajes concretos y de intensa carga emocional.

b) *Uniformadas*: 1) Tendencia a la uniformidad; intentos de individuación agresivos controlados. 2) Estereotipia en la interacción. 3) Absolutismo del rol paterno y exageración de las normas paternas. 4) Mensajes concretos y abstractos, con carga emocional controlable.

c) *Aisladas*: 1) Tendencia al aislamiento; exceso de individuación. 2) Estereotipia y escasa interacción. 3) Ausencia de roles familiares; roles individuales adquiridos. 4) No es relevante el grado de abstracción; mensajes sin carga emocional.

d) *Integradas*: 1) Equilibrio entre la identidad individual y la grupal; aceptación de la individuación. 2) Estabilidad y flexibilidad. 3) Equilibrio entre los roles y normas; discusión explícita de las normas. 4) Mensajes concretos y abstractos, con carga emocional instrumentable.

3. Creemos importante incluir la variable satisfacción-insatisfacción, porque cumple con los requisitos propuestos:

a) Puede incluirse en la teoría.

b) las *normas exageradas* indican que el rol correspondiente está compensando la ausencia de otro. Veamos cómo se distribuyen los roles y normas en cada tipo de familia.

1. En la familia *aglutinada* observamos un absolutismo del rol materno y exageración de las normas maternas.

2. En la familia *uniformada* observamos absolutismo del rol paterno y exageración de las normas paternas.

3. En la familia *aislada* encontramos que los roles asignados están diferenciados, lo que dificulta la asunción de los mismos. Esta "ausencia" de todos los roles crea la necesidad de adquirir roles individuales independientes de la estructura familiar. Las normas correspondientes a cada rol no están en relación con el funcionamiento familiar, es decir que no hay normas familiares.

4. En la familia *integrada* encontramos un equilibrio entre los distintos roles asignados y asumidos, y discusión abierta de las normas filiales y parentales, sin preponderancia exagerada de ninguna de ellas.

IV. *Mensajes*. Hemos tomado en consideración dos aspectos. Uno de ellos es el grado de abstracción de los mensajes: éstos pueden referirse sólo al objeto concreto o a la abstracción y conceptualización del objeto. El otro aspecto es la carga emocional de los mensajes. No creemos que estos dos aspectos tengan la misma importancia para definir las distintas categorías.

1. En la familia *aglutinada* predominan los mensajes concretos y de intensa carga emocional.

2. En la familia *uniformada* encontramos una mayor proporción de mensajes abstractos, y con carga emocional controlada.

3. En la familia *aislada* no es relevante el grado de abstracción, pero sí la ausencia de carga emocional en los mensajes.

4. En la familia *integrada* hay un equilibrio relativo entre mensajes concretos y abstractos, y éstos tienen una carga emocional instrumentable.

Grados de patología familiar. La clasificación de Jackson implica grados de patología que van de la familia estable —satisfactoria a la estable— insatisfactoria pasando por las inestables. Nuestra clasificación también puede ordenarse según grados de patología, que irían de la familia integrada a la aislada, pasando por las aglutinadas y uniformadas que coincidirían con las inestables de Jackson. Queremos clarar que esta clasificación es esquemática y que sirve para señalar tanto estructuras predominantes en la familia, como tendencias que pueden surgir en una familia ante una situación de crisis.

Siguiendo esta correlación entre ambas clasificaciones, pensamos que un índice de patología es el pasaje de una relación satisfactoria

a una insatisfactoria. Luego, sería conveniente incluir este parámetro en nuestra clasificación, puesto que polariza nuestras categorías en normales y patológicas, del mismo modo que la variable estereotipia-flexibilidad.

El pasaje de una relación estable a una inestable, por el contrario, no indica patología sino una situación de crisis que puede ser resuelta favorablemente.

Conclusiones.

1. Creemos que una clasificación de familias tiene que cumplir los siguientes requisitos:

a) los parámetros deben extraerse de una teoría sistemática de la estructura y dinámica de la familia. Partiendo de una teoría de la familia como campo dinámico generador de una identidad grupal, hemos tomado los parámetros de identidad, estabilidad, normas roles, y mensajes.

b) Los diferentes parámetros deben correlacionarse, dando lugar a categorías complejas.

c) Deben encontrarse datos clínicos observables que funcionen como indicadores de las distintas categorías.

2. Proponemos clasificar las familias en cuatro categorías, definidas según las variaciones en los parámetros mencionados:

a) *Agglutinadas*: 1) Tendencia a la aglutinación; intentos de individuación accesionales. 2) Estereotipia en la interacción. 3) Absolutismo del rol materno y exageración de las normas maternas. 4) Predominio de mensajes concretos y de intensa carga emocional.

b) *Uniformada*: 1) Tendencia a la uniformidad; intentos de individuación agresivos controlados. 2) Estereotipia en la interacción. 3) Absolutismo del rol paterno y exageración de las normas paternas. 4) Mensajes concretos y abstractos, con carga emocional controlable.

c) *Aisladas*: 1) Tendencia al aislamiento; exceso de individuación. 2) Estereotipia y escasa interacción. 3) Ausencia de roles familiares; roles individuales adquiridos. 4) No es relevante el grado de abstracción; mensajes sin carga emocional.

d) *Integradas*: 1) Equilibrio entre la identidad individual y la grupal; aceptación de la individuación. 2) Estabilidad y flexibilidad. 3) Equilibrio entre los roles y normas; discusión explícita de las normas. 4) Mensajes concretos y abstractos, con carga emocional instrumentable.

3. Creemos importante incluir la variable satisfacción-insatisfacción, porque cumple con los requisitos propuestos:

a) Puede incluirse en la teoría.

- b) Se puede correlacionar con las otras variables.
- c) Puede detectarse mediante índices clínicos: acuerdo o desacuerdo en la definición de la situación, es decir, con respecto a los roles y normas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACKERMAN N. W. — *Diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares*. Buenos Aires, Hormé, 1961.
- BLEGER J. y BLEGER L. — Grupo familiar, psicología y psicopatología, en L. GRINBERG, M. LANGER y E. RODRIGUÉ: *El grupo psicológico*. Buenos Aires, Nova, 1959.
- FERNÁNDEZ MOUJÁN O. — *Seminario para residentes del Servicio de Psicopatología del Policlínico "Aráoz Alfaro"*, Lanús, 1966.
- FERNÁNDEZ MOUJÁN O., ILEYASOF R., RUBARTH G. y TUBERT S. — *Intentos suicidas juveniles*. Trabajos presentados en el Primer Congreso Argentino de Psicopatología Infanto-Juvenil, Buenos Aires, 1969.
- FERNÁNDEZ MOUJÁN O., ILEYASOF R. y TUBERT DE PEYROU S. — *Grupo familiar e intentos suicidas en la adolescencia*. Trabajo presentado en el Primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, Buenos Aires, 1970.
- JACKSON D. D. — Family Interaction, Family Homeostasis and some Implications for Conjoint Family Psychotherapy, en J. H. MASSERMAN: *Individual and Familial Dynamics*. New York, Grune and Stratton, 1959.
- LEWIN K. — *Teoría del campo*, ficha del Departamento de Psicología de la U. B. A.
- PIAGET J. — *Seis estudios de psicología*. Barcelona, Seix Barral, 1967.
- PICHON RIVIÈRE E. — *Curso dictado en la Escuela de Psicología Social*. Buenos Aires, 1965.

Un principio homeostático de la interacción

La variable orden-desorden en los grupos familiares¹

CARLOS E. SLUZKI *
ALEJANDRO TARNOPOLSKY
DIANA VALDEMARIN

En el curso de una investigación comparativa sobre pautas de interacción en familias de esquizofrénicos y familias sin patología, hemos detectado lo que podría ser una regla general de toda interacción grupal. Se trata de una modalidad dinámica de regulación del flujo de la información, o del ritmo de la interacción al servicio de un intercambio adecuado de información, cuya aparición en nuestros datos fue un hallazgo no previsto por nosotros. Este fenómeno se observó por igual en ambas muestras estudiadas y puede ser considerado un punto de partida para el estudio de una dimensión nueva de procesos de comunicación grupales, dado lo factible de su verificación experimental.

El nivel de análisis adoptado en nuestra investigación es el denominado transaccional, es decir, el de la relación que se establece entre cada mensaje y el mensaje que le sucede. Por lo tanto, cada categoría de cada una de las múltiples variables analizadas se define por esta relación entre mensajes sucesivos.

En este informe haremos referencia a ciertos resultados obtenidos en el análisis de una variable simple, a saber: la "mecánica" de la secuencia del discurso. La consideramos simple, aclaremos, en razón de la claridad de los observables, pero, con todo, el conjunto de decisiones que implica cada uno de éstos es bastante complejo y el monto de información que transmite en la interacción es grande. Ejemplifiquemos.

¹ Este trabajo pertenece a la serie de informes sobre la investigación "interacción familiar y esquizofrenia", que se desarrolla bajo la coordinación del primer autor, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas del Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico "Prof. Dr. G. Aráoz Alfaro" de Lanús. Integran el equipo de trabajo, además de los firmantes de este informe, el profesor Eliseo Verón y la licenciada Susana G. Kaufman. Esta investigación cuenta con un subsidio del Foundations' Fund for Research in Psychiatry.

* Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico "Prof. G. Aráoz Alfaro", Lanús, Prov. de Buenos Aires.

Cuando un miembro del grupo está hablando, a cada uno de los otros miembros del grupo le cabe dos opciones: hablar o callarse. Si se desea hablar, puede a su vez esperar que el anterior termine o puede comenzar a hablar intentando interrumpir al anterior². Esta decisión depende de múltiples variables, entre las que se cuenta el monto de información que se transmite. En un diálogo, el silencio del receptor, o los monosílabos aprobatorios de éste, indican al emisor que la información que transmite está siendo recibida. Otro tipo de intervención, una tentativa de interrupción, por ejemplo, indica al emisor anterior que la información emitida es considerada suficiente. Ahora bien, si un participante comienza una frase cuando el emisor previo aún está hablando, a éste le quedan dos opciones, a saber, interrumpir su propio discurso, es decir, ceder el canal, o bien continuar, pese a que el otro está ya hablando, hasta terminar su propia idea. Se puede agregar a esta secuencia de decisiones un paso previo aún, a saber, que quien está hablando en primer lugar puede optar por tener o no en cuenta claves implícitas o explícitas de pedido de palabra por parte de los otros participantes, y seguir adelante o no con su propio discurso, lo que afecta la probabilidad de que los otros participantes tiendan a interrumpirlo. Ahora bien, este sistema de opciones ocurre en cada transacción —es decir, en cada secuencia de dos participaciones sucesivas cualesquiera de una interacción—. Entiéndase entonces que este sistema se ve afectado por el de la transacción previa y afecta al de la subsiguiente, y así sucesivamente, lo que permite conceptualizar a una interacción grupal como una cadena de decisiones —a este nivel, a más de muchos otros— que van afectándose sucesivamente. Dicho de otra manera, estas decisiones integran el “paquete” comunicacional en tanto informan a cada uno de los interactores de las decisiones tomadas por los otros. El hecho de que una persona haya elegido interrumpir —o bien, elegido no interrumpir— a otro nivel transmite información al destinatario acerca de cómo conceptualiza esa persona la relación, y por ende, la posición relativa de los participantes, el énfasis y la importancia que da a lo que se dice, el monto y la calidad de los afectos movilizados por el tema, etcétera. Y esa multiplicidad posible de significados es parte ineludible de cada una y todas las decisiones tomadas a este nivel así llamado “mecánico”. aclaremos que lo denominamos “mecánico” porque para la codificación no tenemos en cuenta el contenido de lo que se dice (con una excepción, que comentaremos más abajo), sino sólo el hecho de que se esté ocupando el canal verbal. Ejemplificando nuevamente, se puede definir y observar la relación de interrupción entre dos mensajes sucesivos —o una no interrupción, para el caso— independientemente de qué es lo que se esté diciendo.

² Cabe acotar que hay indicadores verbales y no verbales de pedido de palabra de uso corriente en la interacción: cuando una persona que está escuchando a otra abre la boca —emitiendo sonidos de tipo *ehh* o en silencio— e inicia un gesto, está indicando al interlocutor que quiere hablar.

En este nivel de análisis es posible discriminar las siguientes categorías de secuencia del discurso (cf. fig. I):

Contigüidad: El participante *B* comienza su mensaje después que el anterior, *A*, haya terminado de hablar.

Interrupción: *B* inicia su mensaje cuando *A* aún está hablando, y *A* se detiene antes que *B*, dejando su frase gramaticalmente incompleta.

Superposición parcial: *B* inicia su mensaje cuando *A* aún está hablando, pero *A* continúa hasta completar gramaticalmente su frase. *B*, por su parte, continúa con su intervención y termina *después* que *A*.

Superposición total: *B* inicia su mensaje mientras *A* está hablando, ambos se superponen durante un lapso variable, y *B* se detiene antes o al mismo tiempo que *A*. Según el *contenido* del mensaje de *B*, este fenómeno configura dos categorías diferentes, a saber: *Superposición total no disruptiva*, en que el mensaje de *B* es una intervención corta, gramaticalmente completa, cuyo significado es de acuerdo, asentimiento, o bien indicador metalingüístico de recepción (“ajá, mhm”), y *Superposición total disruptiva*, en que el mensaje de *B* afecta a la sintaxis del de *A*, o bien posee contenidos que habitualmente tienen ese efecto (desacuerdos, líneas argumentales paralelas, etcétera).

Para el análisis que comentaremos aquí hemos procedido a agrupar todas estas categorías en dos subconjuntos, de acuerdo al *orden* o al *desorden* que introduce este tipo de intervención en la secuencia interactiva. Resulta claro que este nivel de análisis dista mucho de tener en cuenta la totalidad de factores que contribuyen a lograr una comunicación “adecuada” o “inadecuada”. Nos provee, con todo, indicadores claros de fenómenos que sin duda intervienen en tal sentido: las categorías agrupadas en el subconjunto *ORDEN* (contigüidad, superposición parcial y superposición total no disruptiva) suponen una mayor probabilidad de recepción clara del mensaje primero. Las categorías agrupadas en *DESORDEN* (interrupción, y superposición total disruptiva) constituyen, por definición, secuencias más perturbadas, donde la probabilidad de que el mensaje haya sido adecuadamente recibido es menor.

En cuanto a las características de la muestra estudiada, éstas han sido detalladas en una publicación previa acerca de esta misma investigación (Sluzki *et al.*, 1969). Recordemos, con todo, que la muestra experimental consta de 12 entrevistas y la muestra control —de familias sin patología— de 7. El material consiste en la transcripción escrita de la interacción entre padre, madre e hijo, ocurrida en el curso de entrevistas semiestructuradas en que se les solicita lleguen a una respuesta única en común para un problema que se les presentaba verbalmente³.

³ La muestra analizada corresponde a un proyecto que intenta no sólo correlacionar pautas interaccionales con patologías presentes en el grupo sino determinar

Pasemos a comentar los resultados de nuestro análisis⁴. Aclaremos ante todo que los diferentes miembros de la familia participan en forma igualitaria en ambas muestras. Tampoco se encuentran variaciones significativas en el monto de participaciones cuando se analiza la muestra por díadas, es decir, estudiando por separado las intervenciones de madre, cuando habla después de padre y cuando habla después de hijo, y de cada uno de los otros cuando habla después de los restantes miembros.

Sumando las intervenciones de los tres participantes, se observa que en ambas muestras existe un monto similar de orden y desorden: 74 % de orden y 26 % de desorden. Cabría plantear que esta proporción corresponde a un nivel óptimo de orden para que la comunicación sea efectiva en la triada —dada una situación de conversación sobre un tema neutro en un setting no neutro—. Tal vez un grado mayor de orden genere una cuota elevada de redundancia, cosa que también atentaría contra una interacción fluida. De hecho, resulta evidente que en esta proporción no incide la patología presente en uno de los grupos (o al menos en un miembro de uno de esos grupos).

El paso siguiente es responder al interrogante de si todos los miembros de cada grupo aportan por igual a esta proporción. Efectuado el correspondiente análisis, comprobamos que el predominio de orden sobre desorden varía entre miembros. Podemos así describir dos roles o funciones o modalidades de intervención: la modalidad *ordenadora*, que califica al miembro que efectúa comparativamente más intervenciones ordenadas, y la *desordenadora*, que califica al miembro que aporta comparativamente más al desorden⁵.

En ambas muestras encontramos un miembro que responde a la modalidad ordenadora, uno que responde a la desordenadora, y un miembro tercero o restante que ocupa una posición intermedia⁶.

Puede plantearse ahora el interrogante de qué pasa cuando habla cada uno de esos miembros. ¿Reciben algún "tratamiento" especial

cuáles pautas son invariantes y cuáles dependen del medio cultural. Por esto, se compara una muestra de familias norteamericanas, amablemente cedida por Elliot G. Mishler, con otra de familias argentinas. Los datos aquí presentados corresponden al análisis de la muestra de Mishler, provista cuando la nuestra aún estaba en proceso de recolección.

⁴ Por pruebas de significación, ver Apéndice.

⁵ Hablaremos de *modalidad ordenadora* cuando un participante reúna las siguientes características: a) Mayor predominio de orden sobre desorden con respecto a los demás miembros de la familia, dentro de cada submuestra (Cuadro 1); b) Aportes proporcionalmente mayores al orden total que al desorden total familiar, de un mismo miembro (Cuadro 2). Características inversas califican la *modalidad desordenadora*. No se establecen comparaciones entre miembros correspondientes de ambas muestras.

⁶ El *miembro restante*, en ambas muestras, cumple con la primera característica de la modalidad ordenadora pero no con la segunda; sus aportes al orden y al desorden familiar son proporcionalmente iguales.

por parte de quien habla después de ellos que permita decir que esa modalidad es detectada? Efectuado este análisis, se encuentra que el miembro desordenador es seguido por intervenciones más ordenadas que los otros, el ordenador es seguido por una proporción orden-desorden semejante al promedio general de las muestras, y el restante es seguido por un predominio orden-desorden ligeramente inferior al promedio, es decir, con más desorden.⁷ Esta observación se da por igual, otra vez, en ambas muestras.

La pregunta que cabe hacer ahora es si estas modalidades son expresión de un fenómeno estático —en el sentido de que cada miembro se comporta en toda ocasión como igualmente ordenador o desordenador— o si se trata de un fenómeno dinámico dentro de la interacción —en el sentido de que la modalidad es, por decir así, selectiva—. Para responderla efectuamos el análisis discriminando en cada muestra secuencias diádicas (i. e., la suma de todas las veces en que el ordenador habló después del desordenador, el desordenador después del ordenador, y así las seis posibles combinaciones secuenciales en cada muestra). Una vez obtenidas las proporciones orden-desorden de cada diada, las ordenamos en un continuo de mayor a menor predominio de orden sobre desorden. Nos encontramos entonces con el sorprendente hecho de que en ambas muestras el ordenamiento es el mismo: en el extremo de máximo orden encontramos al ordenador cuando habla después del desordenador, luego las diadas ordenador-restante, desordenador-restante, restante-ordenador, ordenador-desordenador, para finalmente hallar en el extremo de máximo desorden, al desordenador cuando habla después del restante. En ambas muestras, pues, el ordenador es más ordenado cuando habla después del desordenador que cuando sigue al restante; el desordenador es seguido en forma más ordenada por el ordenador que por el restante.

La amplitud de la variación es mayor en la muestra experimental que en la muestra testigo (Exp.: 63,2 % a 89 %; Tes.: 67,5 % a 84,6 %)

⁷ Si comparamos ambas muestras, no encontramos diferencias significativas en el monto de emisiones que siguen a cada uno de los miembros de la familia.

⁸ Se comparan las participaciones que siguen a un determinado miembro en forma semejante a la usada en la definición de modalidades, o sea: mayor o menor predominio del orden sobre el desorden, con respecto a las emisiones que siguen a los demás miembros de la familia, y aportes proporcionalmente mayores, iguales o menores al orden que al desorden total familiar, de las emisiones que siguen a determinado miembro. (Cuadros 3 y 4.)

Así encontramos que: a) El *miembro desordenador* recibe mayor predominio de orden sobre desorden que los otros dos miembros y menor proporción del desorden total familiar que del orden; b) El *miembro ordenador* es seguido por un menor predominio de orden sobre desorden que el miembro desordenador y por igual proporción de orden y de desorden totales familiares; c) El *miembro restante* es seguido por un menor predominio de orden sobre desorden que el miembro desordenador y por igual proporción de orden y de desorden sobre los totales familiares correspondientes. Sólo en la muestra esquizofrénica encontramos que el miembro ordenador es seguido con mayor predominio de orden sobre desorden que el miembro restante.

pero el carácter general de la observación se mantiene punto por punto.⁹

Del análisis de estos datos hemos extraído una hipótesis, la de que al nivel de orden-desorden se detecta la expresión de un sistema de regulación inherente a los procesos de interacción grupal, integrante del conjunto de leyes anti-entrópicas que regulan los procesos de comunicación, y que probablemente esté asociada a otra ley anti-entrópica, la que establece una cuota óptima entre información y redundancia en la comunicación.

Esta hipótesis es pasible de estudio experimental, ya que no sólo la replicación de este análisis en diferentes grupos triádicos o de otro número de participantes permitirá estudiar su consistencia, sino que, por una parte, se puede variar las características del entorno o de la temática para estudiar de qué manera afectan a este sistema, y, por la otra, se puede estudiar las variaciones en la cuota orden-desorden de los miembros mediante la incorporación de un participante con el que reservadamente se haya convenido que actúe con intervenciones ordenadoras en parte de la interacción, y con intervenciones desordenadoras en otra parte. Las estrategias propuestas permitirán poner a prueba esta hipótesis, así como estudiar sus implicaciones como parte de los múltiples fenómenos que regulan la comunicación en grupos preformados y espontáneos.

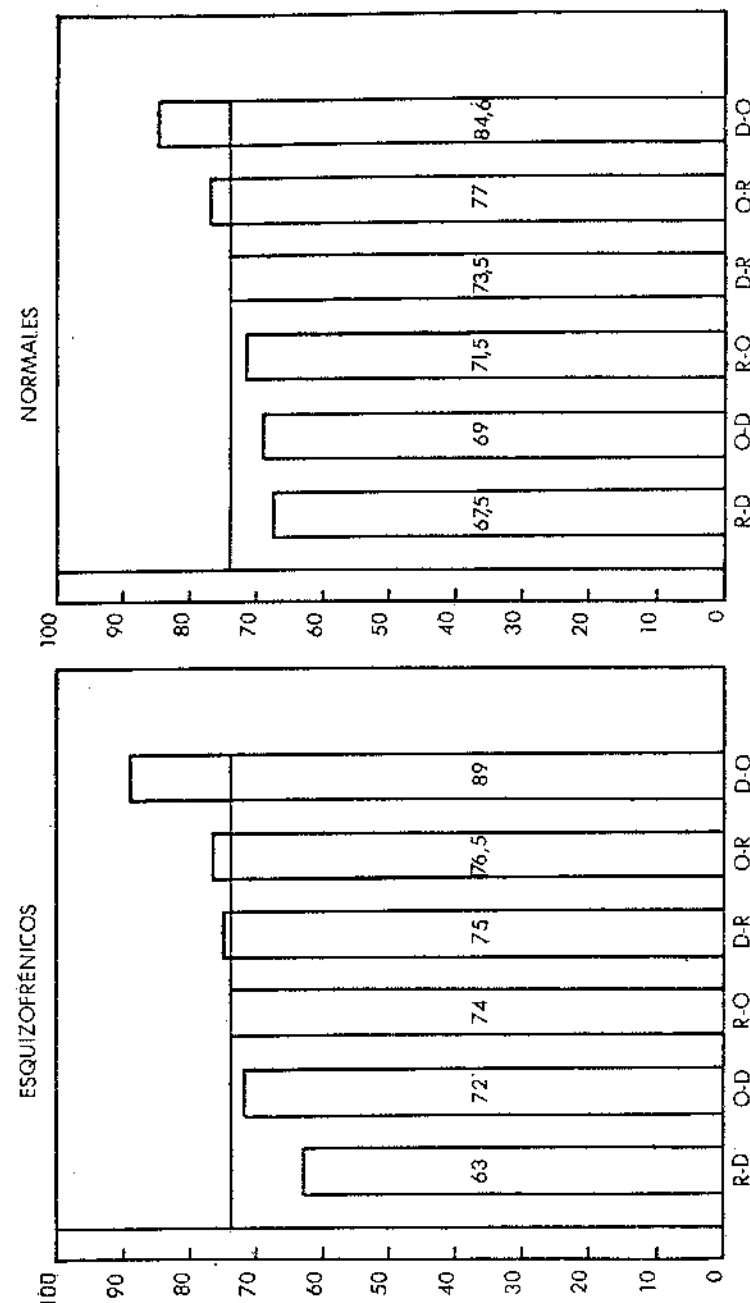
Si bien la médula de esta presentación es la descripción de ese aparente fenómeno homeostático, la información queda incompleta a menos que se responda al interrogante ¿quiénes son, en cada muestra, los ordenadores, los desordenadores y los restantes?

⁹ Si comparamos entre sí las diadas en las que un determinado miembro sigue a los otros dos, en cada muestra por separado, observamos que (Cuadro 5): a) El *miembro ordenador* sigue al miembro desordenador con mayor predominio de orden sobre desorden que cuando sigue al miembro restante; b) El *miembro restante* sigue a cada uno de los otros dos con igual predominio de orden sobre desorden; c) Sólo en la muestra esquizofrénica, el *miembro desordenador* presenta un comportamiento diferencial: sigue al miembro restante con menor predominio de orden sobre desorden que cuando sigue al miembro ordenador.

Cuando comparamos entre sí las diadas en las que un determinado miembro es seguido por los otros dos, en cada muestra por separado, encontramos que: a) El *miembro ordenador* es seguido por igual predominio de orden sobre desorden que los otros dos miembros; b) El *miembro desordenador* es seguido con un mayor predominio de orden sobre desorden por el miembro ordenador que por el miembro restante; c) Sólo en la muestra esquizofrénica, el *miembro restante* es seguido con un menor predominio de orden sobre desorden por el miembro desordenador que por el miembro ordenador.

Al comparar entre sí las diadas recíprocas (o sea, todas las emisiones de un miembro cuando sigue a otro con las de éste cuando sigue al primero), observamos que: a) El *miembro ordenador* y el *restante* mantienen relaciones recíprocas: el primero sigue al segundo con igual predominio de orden sobre desorden que cuando éste sigue a aquél; b) El *miembro ordenador* sigue con mayor predominio de orden sobre desorden al *miembro desordenador* que éste al primero; c) Sólo en la muestra esquizofrénica, el *miembro restante* sigue con mayor predominio de orden sobre desorden al *miembro desordenador* que éste a aquél.

GRÁFICO 1



Y si en términos de roles, o funciones, ambas muestras no se diferenciaban, en términos de miembros la diferencia es tajante: en la muestra esquizofrénica el ordenador es el hijo y el desordenador es la madre, y en la muestra control el ordenador es la madre y el desordenador el hijo. En ambos casos, el restante es el padre. La matriz establecida por el cruce de modalidades entre madre e hijo cuando se compara ambas muestras se abre a múltiples interpretaciones, que postergaremos por ser el centro del trabajo las secciones precedentes.

CUADRO 1

Categorías orden-desorden: participaciones de los distintos miembros, en la muestra de familias esquizofrénicas y en la de familias normales.

ESQUIZOFRÉNICOS										NORMALES									
		Padre		Madre		Hijo		TOTAL				Padre		Madre		Hijo		TOTAL	
		%	N	%	N	%	N	%	N			%	N	%	N	%	N	%	N
ORDEN		76	178	68	162	80	164	74	504	76	188	78	183	68	147	74	518		
DESORDEN		24	57	32	77	20	40	26	174	24	61	22	52	32	68	26	181		
TOTAL		235		239		204		678		249		235		215		699			

CUADRO 2

Categorías orden-desorden: Aportes de cada miembro al orden y al desorden de su grupo familiar, en cada una de las muestras.

ESQUIZOFRÉNICOS							NORMALES						
	Orden		Desorden		TOTAL			Orden		Desorden		TOTAL	
	%	N	%	N	%	N		%	N	%	N	%	N
PADRE	35	178	33	57	35	235	36	188	33	61	36	249	
MADRE	32	162	44	77	35	239	35	183	28	52	33	235	
HIJO	33	164	23	40	30	204	28	147	37	68	31	215	
TOTAL		504		174		678		518		181		699	

CUADRO 3

Categorías orden-desorden: mensajes que siguen a los distintos miembros, en cada una de las muestras.

ESQUIZOFRÉNICOS										NORMALES									
		Padre		Madre		Hijo		TOTAL				Padre		Madre		Hijo		TOTAL	
		%	N	%	N	%	N	%	N			%	N	%	N	%	N	%	N
ORDEN		68	162	81	174	74	168	74	504	70	168	74	170	79	180	74	518		
DESORDEN		32	75	19	41	26	58	26	174	30	73	26	60	21	48	26	181		
TOTAL		237		215		226		678		241		230		228		699			

CUADRO 4

Categorías orden-desorden: Aportes de los mensajes que siguen a cada miembro al orden y al desorden de su grupo familiar, en cada una de las muestras.

ESQUIZOFRÉNICOS						NORMALES							
Orden		Desorden		TOTAL		Orden		Desorden		TOTAL			
%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N		
PADRE	32	162	43	75	35	237	32	168	40	73	34	241	
MADRE	35	174	24	41	32	215	33	170	33	60	33	230	
Hijo	33	168	33	58	33	226	36	180	27	48	33	228	
TOTAL		504		174		678		518		181		699	

CUADRO 5

Categorías orden-desorden: diadas, en cada una de las muestras.

ESQUIZOFRÉNICOS														
	Pa-Ma		Hi-Ma		Pa-Hi		Ma-Pa		Hi-Pa		Ma-Hi		TOTAL	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
ORDEN	63	79	72	83	74	83	75	93	77	85	89	81	74	504
DESORDEN	37	46	28	32	26	29	25	31	23	26	11	10	26	174
TOTAL	125		115		112		124		111		91		678	

NORMALES														
	Pa-Hi		Ma-Hi		Pa-Ma		Hi-Pa		Ma-Pa		Hi-Ma		TOTAL	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
ORDEN	68	79	69	68	72	89	74	86	77	102	85	94	74	518
DESORDEN	32	38	31	30	28	35	26	31	23	30	15	17	26	181
TOTAL	117		98		124		117		132		111		699	

Enfoque patogenético en la alteración de la personalidad de la familia

(Versión abreviada)

HECTOR J. VÁZQUEZ *
SUSANA CALERO
JUAN J. VÁZQUEZ

La práctica diaria nos pone en muchas circunstancias frente a sujetos cuyos conflictos actuales son engendrados predominantemente en o por su núcleo familiar. El incremento que adquiere esta situación en los últimos tiempos, la atribuimos no sólo a la mayor amplitud y la forma más dinámica con que se hace el enfoque psicopatológico, sino también al hecho de que en la sociedad actual, la familia está dejando de ser un factor de aseguramiento en el sujeto, transformándose muchas veces en un campo de competición, disociante, nocivo. La etapa de transición que nos toca vivir afecta en distinto grado, pero a todos sin excepción, los miembros del grupo familiar.

La imagen que proyecta el núcleo familiar, trasuntada por sus características propias e individuales, en el manejo de sus miembros entre sí y del grupo frente a los demás, hace que nos atrevamos a hablar de una *personalidad de la familia*, definiéndola, inspirados en el concepto de personalidad de Allport, como la organización dinámica resultante de la interacción de las conductas de sus miembros, que determinan para cada grupo familiar sus modos habituales de reacción a las circunstancias.

Usamos el término organización con el concepto de organismo (todos los miembros influyen y son influidos por el grupo familiar). Esta organización es dinámica en cuanto la misma sufre continuas modificaciones, progresivas o regresivas. Los modos habituales de reacción a las circunstancias, es decir, sus conductas predominantes, permitirán valorar si la personalidad de la familia es sana o enferma, según se manifiesten como plásticas o rígidas.

Al integrarse un núcleo familiar, sus miembros primarios sufren modificaciones en la dinámica de su personalidad, principalmente ori-

ginadas en la nueva relación con el no-yo; por un lado la relación yo-tú original y por otro por la relación yo-mundo modificada por la nueva ecuación yo-tú-mundo.

Con la incorporación de los hijos al grupo, los comportamientos de los mismos, consecuencia y causa de la conducta de los padres, obviamente tienen una influencia fundamental que modifican los esquemas de conducta del grupo primario.

De la interacción de esta serie de vectores, a veces convergentes, otras divergentes, resulta un nuevo modo de reacción frente a las circunstancias absolutamente individual en cada grupo familiar. Este es el esquema básico que conforma evolutivamente lo que llamamos *personalidad de la familia*.

Partiendo del núcleo familiar primario (padre-madre), su relación puede funcionar como complementaria, suplementaria o simétrica.

Cuando es simétrica (normas, formas de conducta, mutuamente dictadas y aceptadas), no pueden surgir conflictos. Distinta es la situación cuando la relación es complementaria (uno de los miembros es el que dicta las normas), pues si bien cuando el núcleo es sano puede funcionar armónicamente, cuando uno de los miembros es enfermo, adopte éste el rol complementario o suplementario, dará lugar a desajustes y conflictos con el miembro sano y con los hijos, es decir se ve comprometida la personalidad de la familia.

No detallaremos aquí las variantes que se pueden dar en la situación señalada; sólo destacamos que la influencia directa del conflicto en los hijos, muchas se ve reforzada por ser convertidos en instrumento por el miembro enfermo del conflicto con su pareja.

* Bacacay 2316, 1º-B, Capital Federal.

**Pathology and terapy
of the family group**

Summary of the first four papers

Schizophrenics and their families: orientations and findings of recent investigations.

Official report of the First Argentine Congress of Psychopathology of the family group, Buenos Aires, June 18, 1970.

LYMAN C. WYNNE

The author starts by emphasizing that in his studies about the origin, development and perpetuation of schizophrenic disorders, considerations about the role and importance of the family can be found. There is a wide range of agreement as yet not recognised, as regards to this point. This factor opens a new point of reference for future investigations. The introduction of new methods of investigation in family studies implies the possibility that as a consequence of these works, a revision of the conceptualisation of the nature of schizophrenic disorders may take place and maybe also that of other forms of disturbance in behaviour.

The importance of the family's role in relation to schizophrenic disorders is accepted in genetic hypothesis as well as in dynamic ones. He dedicates the first two units of his work to pointing out how each of the two forms of hypothesis include this concept.

In the first one: "Intensive studies on family dynamics", the author points out how until little more than a decade ago investigations in the families of schizophrenics were reduced to establishing relationships between diagnosis of other members of the family, based on the hypothesis of inheritance. But since then, studies of a different type were carried out in families of schizophrenics. Psychotherapeutical and investigation relationships were established with all the members of the family, sometimes in the midst of treatments which lasted years. Later on, the author introduced methods for tests of different types to be able to make systematic and "blind" comparisons between families, in the National Institute of Mental Health's program. The purpose was to detect family patterns in that way within a therapeutical perspective, studying specially family complications which seemed to sustain symphomatology.

Some basic conclusions resulted which turned out to be similar to those of genetic investigators: 1) Traditional studies underestimated the frequency of psychological disturbances in non-patient members of the families of schizophrenics. 2) The quality of the psychiatric disturbances of the members of a schizophrenic's family did not lend itself to conventional classification. 3) We are faced with the problem of whether the concept of schizophrenia should be limited (to exclude border-line members of the family), widened (to include them) or reformulated in different terms.

In the second unit: "Genetic investigations with the families of schizophrenics", the author points out that in spite of the variety in methodological uncertainties, recent studies confirm the concept that something is transmitted genetically, at least in the case of some persons diagnosed as schizophrenics. Nevertheless, the genetic factor appears to be less important than it was supposed.

On the other hand, it is necessary to improve standardised methods to make synthomatic and diagnosis evaluations for family studies. Still, the author says to be unsatisfied with the traditional worrying about the agreement between the family members' diagnosis. That is due to: 1) If a narrow concept for the diagnosis of schizophrenia is used, generally no proofs of concordance are found. The investigation, lacking empirical facts, must turn to ad-hoc hypothesis. 2) The most recent findings are more compatible with a wide concept of schizophrenia. Nevertheless diagnosis facts which could help to clear the nature of genetic or non-genetic contributions to the illness, could not be found in this way either. Besides, with this extension, methodological problems about the trustworthy definition of the limits of the concept, are increased. On the other hand, if the hypothesis of a few "schizophrenic genotypes" underlying to clinical diversity is adopted, one will run into enormous gaps in the understanding of the phenomenon. 3) Based on these considerations, concepts sustained in a polygenic hypothesis have been developed, which, though it seems very plausible, it still has not been explored in its empirical consequences. Besides, problems related to the interaction of polygenic and non-genetic factors have been disregarded. In this polygenic theory, a concept of schizophrenia must be adopted which would imply a series of quantitative variations from the most serious cases to "normality". In this sense, the concept of a spectrum of disorders or sicknesses has been suggested and, as an alternative formulation, the concept of dimensions, or series of specific underlyings with intermediate variables between genes and synthomatic signs. According to this approach, the facts could be ordered systematically at the level of the intermediate variables, not at that of the clinically recognised illnesses. Nevertheless, no concept of the kind could be evaluated adequately with actual diagnosis methods, which aim to distinguish qualitatively "all or nothing". Besides, there is a different type of classificatory diagnosis or evalua-

tion, referring to families and groups as units, with properties of a social system.

Finally, in a third unit, the author refers to "enviromental similarities and differences". He points out that more attention must be paid to the problem of specific enviroment conditions in order to evaluate genetic factors, and vice-versa.

The supposition that a shared family enviroment always favours psychological similarities totally lacks foundation. The psychosocial theory of role, and intensive family studies point out that expectations and different roles within a family encourage differences between its members. Undoubtedly, in certain dimensions, similarities also spring up. To draw conclusions about the shared psychological experience and the enviromental similarities for the members of a family in particular is a tough job, even having abundant information derived from intensive study of relationships within the family. The problem of how to interpret the influence of extra-family factors from the wider social enviroment and culture, is very important.

The author points out his disagreement with the hypothesis that communication, learning and experience patterns which may cause systematic difficulties are more common in the living conditions of the lower social classes. He proposes, rather, that the investigation of schizophrenic families be oriented towards intermediate variables between genetic dotation and the appearance of the synthomatic picture, taking two variables into consideration: 1) the dispositions to response, which are experimentally defined aspects of "temperament" and 2) the transactional processes, specially intrafamily communication.

The dispositions to response consist in a series of dimensions which characterise the way in which an individual receives, regulates and modifies enviromental and internal stimuli. Although they are constructed starting with inborn tendencies, response patterns are elaborated and modified widely through the development during the processes of learning which take place specially in the midst of the family. Genetic and biological determinants are interwoven with transactional and communication processes.

Lasting groups, including families, function as small social systems. Its members' roles, behaviour and experience are reciprocal or complementary, not equal. Based on this conception, the author and other researchers developed the possibility of precise prediction of the characteristics of a member of the family, including the schizophrenic descendant, starting from the characteristics of the other members of that some family. A series of grading systems were specified, to be applied to examples of communication of family members studies individually as well as in a group.

The author describes the evaluation method using the individual answers to Rorschach's test, considered as examples of communication obtained in a relatively standardised situation. "Disorders in thought"

in the parents themselves were not evaluated, but rather the influence which hypothetically important forms of communication could have on a listener, particularly on a child during his growing period.

In whole families it was found that the frequency of deviations in communication between the parents was significantly related to the seriousness of the child's psychiatric illness.

In this sense, couples with a schizophrenic child, with a borderline child and with a neurotic or normal child, could be distinguished clearly. Also, differences were found between relatives of remitting schizophrenics and non-remitting schizophrenics, which suggests that they could be different illnesses.

The "adjustment", either adaptative or not, was detected between the members of the family, when the parents act together or counter-act against each other. In this case of schizophrenics, generally none of the two members of the couple gave signs of a potential corrective capacity.

The author formulates the hypothesis that the genetic contribution to schizophrenia is indirect, not in the form of a specific genotype. The number of people vulnerable to schizophrenia is larger than those who ever get to show clinical evidences. Non genetic factors can explain this fact.

The double bind as universal pathogenic situation

CARLOS E. SLUZKI

The analysis of a case history is the introduction of this paper, which aims at reformulating the scope of the communicational theory known as *double bind*, originally described by Gregory Bateson and his co-workers as related to the pathogenesis of schizophrenia. It is proposed in this paper that the double bind is a universal pathogenic model, and this proposition is specified by reconstructing the double-binding situations that can be related to the genesis of three neuroses: phobic, hysteric and obsessive-compulsive, respectively.

This body of hypotheses as been developed jointly by the author of this paper, a psychiatrist, and Eliseo Verón, a sociologist, in the course of a research project on communicational patterns of neurotic patients. Taking as point of departure the study of the rules of interaction presented by these three type of patients, the way in which they conceive the world can be deduced, and the socialization situations that in turn produce these weltanschauungs can be inferred.

The approach utilized is rooted both in (pragmatic) communicational theory and in the propositions made by Ronald Fairbairn about the early stages of human psychic development. Both the levels of the *content* and of the *rules* implicit in the organization of learning situations are taken into consideration for the description of the type of dilemmas embodied in the first stages of the learning processes, with special emphasis placed in conflicts at the latter level, conceptualized by Bateson as that of "deutero-learning".

The contradiction —between levels as within each one— contained in the original learning situations it is proposed, will make the child respond in a way which to him will seem the most successful and will eventually lead to a specific set of rules for dealing with the outside world. Once these rules are established he will "recognize" over and over again in new situations the familiar structure of the contradiction contained in his early learning experiences and, finally, he will provoke in others those behaviors which will reinforce and "justify" his own interpersonal conduct.

These considerations are then specified by defining those contradictions inherent to the specific learning experiences which eventually generate hysteric, phobic and obsessive-compulsive behaviors respectively.

The specific contradictory learning situation is described for each of the three types of behavior—a description that cannot be detailed in this summary due to the multiplicity of correlated elements composing them—and a formula is described as the ultimate abstract of the contradiction embodied in each learning pattern: "take initiatives as long as you remember that it is forbidden to take initiative" corresponding to hysteria, "be independent by depending on me" being the paradoxical injunction leading into phobias, and "be independent although, of course, you are incapable of it" underlying learning situations producing obsessive-compulsive behavior.

The numerous variables impinging on the process of socialization are specified as well as the many ways through which these contradictory rules are transmitted. The elements of the proposed learning models, when analyzed, correspond strictly to each of the ingredients considered essential of the double bind situation.

The proposition is made, hence, that the double bind theory is not specific to the etiology of schizophrenia but, rather, defines a universal pathogenic situation. It is suggested that the approach described in respect to certain forms of neuroses could be applied to any psychopathological disorder in the sense that intermediate steps must be found between the double bind theory and each clinical picture, establishing rigorous connections between the original paradox and the ensuing pathology.

Family and family structure. Clinical, theoretical and technical considerations (synthesis)

ISIDORO BERENSTEIN

This work contains nine items and one annex. The former can be grouped into two categories.

The clinical part contains material from a family group session (item 2) and considerations on theory of techniques (item 3). The theoretical part includes a declaration of principles (item 1) and the study of various configurations with which I try to construct a regulating system for the relationships of the family group in question but, at another level of abstraction, such as to indicate the possibility of a generalization. The configurations are: the length of the session (item 3), the system of denominations (item 4), the religious system (item 5), money circulation (item 6) and the occupation system (item 7). As an annex, there is a fragment of family file, such as I use for family diagnosis. In its theoretical aspect I am based on the structural method as developed by Lévi-Strauss. In the clinical aspect, I lean on the psychoanalytic theory applied to family groups. Both contain the consideration in phenomena at a manifest and at a latent level. They include the notion of an unconscious applied by psychoanalysis, to widen the significance of individual mental phenomena, and by the structural method to think collective mental products, such as rules and others.

Family structure is the regulating pattern for the totality of latent relationships of the members of the family group. It is necessarily reconstructed by the observer, starting from the substance provided by the family relationships, expressed by the various units of observation.

In other words: I refer to the configurations as that which is immediately perceivable and to the structure as a construction by the observer.

The members' ideas about their functioning may be at a larger or smaller distance, but always at some distance from the real functioning. It is frequent to observe serious distortions in a family group

and yet to see its members under the impression of a coherent and harmonious functioning. To define the family I think it is necessary to separate two levels:

a) The family as in reality including the present members such as they present themselves for their treatment (perceptive level). Facts are taken according to the clinical method: Thorough and detailed observation based on the treatment of the family group's members as a whole.

b) The family as it is thought of including the family relationship system and its characteristic of being a social factor (concept level). A system of kinship exists only in men's consciousness, it is an arbitrary system of representations and not the spontaneous development of a real situation (Lévi-Strauss).

The family, then, is a pre-formed group of individuals which has a functioning and also patterns to explain the functioning. The patterns can be conscious or unconscious. The former pass through the members' consciousness and are applied to perpetuate the type of relationship rather than (to be) exposed for questioning. They are "rules" and they are poorly explanatory. The unconscious pattern is not known by the members. It is the result of a reconstruction. It is what I tried to do by analysing the different systems mentioned in items 3 to 7. By means of them we opened the meaning of a member's mental illness. To do it, we redefined the mental patient's family as a dualist organisation, polarised through a health-sickness axis. In this way a series of contradictory systems with a certain appearance of order and coherence is organised: that of mental illness.

The system of denominations includes that of the actual names and that of the denominations of family relationship.

When studying the denominations as a system of significance we widened the family structure to include the maternal family, which existed in the members' consciousness only by their names, hidden by a conscious pattern (rules about the assignment of names) and far from the systematic significance underlying in the unconscious.

When considering the religious system of the family in question, I show a transformation table to understand the unconscious solution which this family group achieved when the alliances (marriage) with people from an opposite religion took place and in this way I reproduce the type of adjustment between the father and the maternal family. When considering the system of money circulation we managed to construct the road through which the "maternal" category changed into the "jewish" category and understand the determining of choices of a mate. Money circulation was described as vertical (natural) in the paternal branch and horizontal (social) in the maternal branch, because it passed to other family groups. At the sanctioned members'

level, two functioning patterns opposed each other: a conscious one which regulated the successory distribution, natural, in conflict with a second pattern, indicating an exogamic exchange, cultural.

As to the theory of techniques, I mention some specifications of the approach emphasising that my activity is almost exclusively interpretative. I exclude advice, dictating other rules than those of the approach, and direct intervention in the family's daily life. A characteristic of the approach, I mention stable instability as opposed to the unstable stability of the family group's set-up I hold the sessions with at least two persons, regardless of the number of members involved in the therapy. The treatment is without a definite duration.

In the family group's psychotherapy I use the transference-countertransference concept redefined as follows: a process by means of which in the actual situation of the session, the members of the family group reproduce a series of relationships existing in the past or in the present, but out of the session, trying to confirm the validity of this construction through the members' behaviour, creating conditions for the therapist to feel and function as another member of the family, either in the past or in the present. This process is set off to convalidate the pattern of relationships proposed by the family and disregard the natural difference between the therapist and the family. I think the therapist is included permanently in the group's interaction. I disagree with Jackson's and Weaklands' enunciation as regards to the concept of transference when they say: "if the interaction is administered with ability, it will take place mainly between members of the family and not with the therapist".

The mental illness of a member can be thought as part of a whole, separated when it can't contain certain undesirable ideas and emotions, denied and surging again when the group is actualised in the time and space of the session.

Why both sons chose jewish women, just as the whole group chose a therapist with a jewish name would turn out to be enigmatic unless we include the enigma in a general exchange system where, as we saw, the families providing women received money in exchange, respecting the reciprocity principle basically established between the paternal family and the maternal family, continued in its subrogates: the family of the eldest son's fiancée and that of the youngest son's wife. "The history tends to the system."

To be treated by me implies the possibility of establishing a mediation at a different level from that achieved through the mental illness.

Family therapy - A radical change

JAY HALEY

Family therapy introduces a new approach into the field of psychotherapy which differs from psychodynamic therapies as well as from those based on conditioning because it is not focused on the individual but on a dyad or more complex units. This shift in the approach took place about the 50's prompted apparently by various factors: discontent with the diagnostic systems of the time and the therapeutic results achieved through the traditional methods centered on the individual, the fact that therapists became aware of the change that occurred in the other members of the family when their patients in individual therapy changed and most of all the increasing emphasis on the need to take into account the social units in which individuals are immersed so as to understand their behaviour.

A first step in the shift from the individual towards the family was taken in connection with schizophrenia. In 1948 Frieda Fromm-Reichmann coined the expression "schizophrenogenic mother" to point out the influence the mother may have on the schizophrenic child. Thus schizophrenia was no longer conceived as caused by something that occurred exclusively "within" the patient but as resulting from family interaction. In the same manner various symptoms started to be described as responses to or different kinds of communication with the other persons. To give an example, a woman suffering from a phobia who cannot leave the house alone, in terms of individual psychology could be described as being held by internal fear whereas according to family psychology her symptom can be understood as an arrangement of the marital pair about the geographic limits of the wife's behaviour.

As many clinicians began to grasp the idea of a dyad, and as social scientists focused upon the relationship between two people, the unit of analysis began to shift to a larger one. When an attempt was made to explain why a mother and child behaved as they did, the description seemed incomplete if the father was not included. With this shift to a unit of three, it became clear that a child could be not only responding

to mother or father but to the relationship between his parents even if he was not present at the moment. A new language to talk about the new units of analysis became then necessary. With a triad, for example, one could talk about coalitions of two against one, which was not possible with an individual or dyadic description. Ideas from Games Theory began to enter the field along with concepts from Role Theory, Information Theory, and Communication Theory.

Example of the family approach. To communicate how diagnosis changes if one thinks in different units, an example can be offered. Let us say that an adolescent commits some delinquent act, such as stealing a car. Should the investigator make his description in terms of three people, he would describe the act as part of a triangular interchange. For example, many family therapists say that when a marital couple is about to break up and seek a divorce, their child will get in difficulty in some way. The parents pull back together to deal with the problem child and the marriage stabilizes. From this view the behaviour of the child is explained in terms of the whole family interaction and not of his inner conflicts. This new understanding of the child's delinquent behaviour will lead to a fresh therapeutic strategy aimed at modifying the whole family since the child's pathology is a product of the family.

The larger unit. The 1960's have been a time of considering the social context of the family, much as the 1950's considered the family context of the individual. There has been an increasing awareness that the family is but one of multiple social groups which must be taken into account in therapy. For example, in the case of a child with school phobia, the problem might reside in the family or in the school or at the interface of the family and school. As a consequence the street, the job, or the home might be the setting in which a therapist works, and therapists dealing with mobile young people with drug problems will even do therapy in the park where networks of young people gather. Therapists are moving out of their offices into the community with consequences to their practices and to their theoretical framework.

Premises of family therapists. Some of the premises held in common by family therapists can be described as they appear in the ways a family therapist gathers information, makes a diagnosis and intervenes to bring about change.

a) *Gathering information:* When a family therapist interviews he wishes to find out what is happening in people's lives right now. Since he assumes that psychopathology is a response to a current situation, he does little review of history or examination of the past. When gathering information, he wants to observe the family members dealing with one another. He does not take what family members say as merely a report

about their inner states or their perception but is concerned with the function of the statement in the situation. The "third ear" of the family therapist is listening to the effect of a person's statements on the other people.

b) *Family diagnosis*: Most family therapists have become reluctant to think of an individual as normal, neurotic or psychotic and with that change they abandon most individual diagnosis. It is assumed that a person who is called neurotic or psychotic is behaving in a way different from the person defined as normal because he is responding to a different situation. When a situation is seen as psychotic, rather than a person, the inevitable question raised is whether or not a normal person placed in a psychotic situation would be diagnosed as psychotic. The diagnostic question is then what sort of situation is provoking the specific behaviour the so-called patient is showing.

The diagnostic unit for the family therapist is no longer the individual, but it is also not the family. Such a therapist assumes that the way the family is behaving is influenced by the ways he deals with them and therefore he includes himself in the diagnostic unit.

Perhaps the most important premise about diagnosis for the family therapist is his concern with how changeable a family is. He is interested in diagnosing how the family responds to his therapeutic interventions. Since the diagnostic concern is how the family responds to the therapist, diagnosis can only occur as a result of therapeutic action.

c) *How to change*: In family therapy the communicative sequence between intimates is the focus of change. With this focus ideas about lifting repression, expressing emotion when alone with the therapist, or becoming aware of how one deals with the other people are peripheral matters. The family therapist does not share the view that insight into the unconscious processes within a transference framework causes change. The family therapist tends to see the change occur because of the ways he has introduced himself into a person's intimate network.

A radical departure from many previous premises about therapeutic techniques is illustrated by the assumption of most family therapists that bringing out hostility or exploring unsavory behaviour in the family can prevent, rather than encourage, change. There is an emphasis upon creating a positive framework within which family members can be motivated to deal with each other differently.

The effect on the professions. Traditionally a psychiatric problem was thought of as medical. When the unit shifts from one person to two or more, the medical framework must be abandoned. Psychiatric problems become defined as social dilemmas and as the unit of treatment changes and the problem is re-defined, inevitably the professions must change. An example is the fact that in a child treatment facility today the child psychiatrist treats the whole family, the social worker

treats the whole family and the psychologist treats the whole family. Since none of the professions have shown superior skill or better training in family treatment, none of them should have better salary than the others. A family therapist is now being judged on his merit—the success of his treatment—not upon his professional background. Perhaps that is the most radical change introduced into the field by family therapy.

Autores

AHLIN, Gisela G. de
ALAZRAQUI, Beatriz
ARROYO, Valentín

BARANCHUK, Fanny Levinton de
BARREIRO, Isabel
BERGER, Beatriz B. de
BENDERSKY, Susana M.
BERENSTEIN, Isidoro
BERENSTEIN, Sara P. de
BLANCO, Susana M. E.
BLEICHMAR, Hugo B.
BLEICHMAR, Emilce Dio de
BURN, Mabel M. de

CALEHO, Susana
CANESTRI, Jorge
CANEVARO, A. A.
CZERTOK, O.

DEVRIES, Osvaldo

FERNÁNDEZ MΟΥJÁN, Octavio
FERSCHTUT, Guillermo
FISHER, Lilian
FUKS, Mario

GARCÍA BADARACCO, J. E.
GARCÍA CASAL, B.
GIUNIPERO, Luis
GLOER, Florinda S. de
GOLDIN, Alberto
GOOLISHIAN, Harold A.
GUITER, Juana B. de
GURVICH, Javier Horacio

HALEY, Jay
HAMMOND, Harold A.
HOSNE, Carol D. de
HULER, Susana

ILLEYASOF, Roberto

JIMÉNEZ DE ASÚA, Stella M. A. de
JURI, Luis J.

KORNBLIT, Ana Lía
KOZIOL, Silvia
KRYNSKI, Samuel
KUSMIN, Pedro
KUTEN, José

LERNER, Diana
LERMAN, Martha F. de
LUXARDO, Eduardo
LYGO, Helena

MAC DOUGALL, Horacio C.
MADANES SOJIT, Cloë
MALDONADO ALLENDE, Ignacio
MANDELBAUM, Eduardo
MARINO, Elisa
MARTICORENA, Alberto G.
MARUCCO, Norberto C.
MÉNDEZ ELIZALDE, Miguel
MOISIN, F. E.
MORE, María R.
MORENO, Beatriz A. F.

NOCETTI, Juan C.

PEYROU, Silvia T. de
PICHON RIVIÈRE, Enrique J.

AUTORES

PODETTI, Ruth
PONTORIERO, E. H.
PROVERBIO, N.
PUGET, Janine
PUNTA, María I.

RAVASCHINO, Lidia K. de
RESNICOFF, Graciela F. de
RODRÍGUEZ, Leonardo

SARÁCHAGA, Dora V. de
SCHEJTER, Virginia
SCHWARTZ, Norma
SCHUGURENSKY, María L. L. de
SLUZKI, Carlos E.
SMOLA, Gloria

SOIFER, Raquel
SOTO, Miciades
SWARTSTEIN, Jaime S.

TARNOPOLSKY, Alejandro

VALDEMARÍN, Diana
VÁZQUEZ, Héctor J.
VÁZQUEZ, Juan J.

WASERMAN, Mario
WEINGIERMAN, Silvia
WYNNE, Lyman C.

ZEIGNER, Silvia
ZIMMERMAN, Edmundo